PedWB

Compêndio pediátrico consolidado

330 temas • Referências e esquemas por indicação

Versão 1.0 documental
25 de setembro de 2026

Conteúdo clínico original organizado a partir do inventário temático. Fórmulas auditáveis, apresentações verificadas quando disponíveis e limites registrados. Não houve aprovação clínica independente.

Índice dos temas

1. Atresia Duodenal em Pediatria 14

2. Doença de Hirschsprung 15

3. Escroto Agudo em Pediatria 15

4. Extrofia de Bexiga e Epispádia 15

5. Fimose e Parafimose em Pediatria 16

6. Granuloma Glúteo Infantil 16

7. Micropênis 16

8. Refluxo Vesicoureteral (RVU) 17

9. Urolitíase em Pediatria 17

10. Angioedema Hereditário 18

11. Dermatite Atópica em Pediatria 18

12. Prurigo Estrófulo 19

13. Anomalia de Ebstein em Pediatria 19

14. Arterite de Takayasu em Pediatria 20

15. Atresia Pulmonar com Septo IV Íntegro 20

16. Atresia Tricúspide 21

17. Cardiomiopatia Dilatada na Pediatria 21

18. Cardiomiopatia Hipertrófica em Pediatria 22

19. Coarctação da Aorta em Pediatria 22

20. Comunicação Interventricular (CIV) 23

21. Crise Hipertensiva na Infância 23

22. Defeitos do Septo Ventricular (DSV) 24

23. Doença de Kawasaki 24

24. Drenagem Anômala Total de Veias Pulmonares 25

25. Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito 25

26. Estenose Aórtica em Pediatria 26

27. Estenose de Valva Pulmonar 26

28. Estenose Mitral em Pediatria 27

29. Febre Reumática em Pediatria 27

30. Flutter Atrial na Infância 28

31. Hipertensão Arterial em Pediatria 28

32. Hipertensão Pulmonar Idiopática em Pediatria 29

33. Hipertensão Pulmonar no Recém-nascido 29

34. Infarto Agudo do Miocárdio na Pediatria 30

35. Insuficiência Cardíaca em Pediatria 30

36. Insuficiência Mitral em Pediatria 31

37. Miocardite em Pediatria 31

38. Persistência do Canal Arterial 32

39. Síndrome do QT Longo Pediátrico 32

40. Taquicardia Supraventricular na Pediatria 33

41. Tetralogia de Fallot 33

42. Tronco Arterioso 34

43. Ventrículo Único 34

44. Ectima na Criança 35

45. Hemangioma Infantil 35

46. Tinea Capitis na Criança 36

47. Adipsia 36

48. Cetoacidose Diabética em Pediatria 37

49. Defeitos no Metabolismo da Tirosina 37

50. Diabetes Mellitus Tipo 1 em Pediatria 38

51. Diabetes Mellitus Tipo 2 em Pediatria 38

52. Feocromocitoma Pediátrico 39

53. Hiperplasia Congênita de Adrenais 39

54. Hipertireoidismo na Infância 40

55. Hipoglicemia Pediátrica 40

56. Hipotireoidismo na Infância 41

57. Hipovitaminose D em Pediatria 41

58. Insuficiência Adrenal Aguda Infantil (Hospitalar) 42

59. Lipidoses 42

60. Osteoporose em Pediatria 43

61. Raquitismo 43

62. Síndrome de Beckwith-Wiedemann 44

63. Síndrome de Insensibilidade Androgênica 44

64. Síndrome de Nelson 45

65. Atresia de Vias Biliares em Pediatria 45

66. Atresia Jejunoileal 46

67. Colelitíase e Colecistite em Pediatria 46

68. Colestase em Pediatria 46

69. Constipação Intestinal em Pediatria 47

70. Doença de Caroli 47

71. Doença de Crohn em Pediatria 48

72. Doença do Refluxo Gastroesofágico em Pediatria 48

73. Dor Abdominal Crônica em Pediatria 49

74. Esquistossomose em Pediatria 49

75. Estenose Hipertrófica do Piloro 49

76. Estomatite Aftosa Recorrente (Aftas) 50

77. Fibrose Hepática Congênita 50

78. Hepatite Autoimune em Pediatria 51

79. Hepatites Virais 51

80. Insuficiência Hepática Fulminante em Pediatria 52

81. Intoxicação por Inibidores de Monoaminoxidase 52

82. Invaginação Intestinal 53

83. Parasitoses Intestinais em Pediatria 53

84. Retocolite Ulcerativa em Pediatria 54

85. Sangramento Digestivo 54

86. Síndrome de Alagille 54

87. Síndrome de Mallory-Weiss 55

88. Síndrome dos Vômitos Cíclicos 55

89. Síndrome Hepatorrenal em Pediatria 56

90. Vômitos em Crianças 56

91. Anemia de Diamond-Blackfan 56

92. Doença de Wilson em Pediatria 57

93. Fibrodisplasia Ossificante Progressiva 57

94. PAPA 58

95. Síndrome de Bernard-Soulier 58

96. Síndrome de Hiper-IgD 59

97. Síndrome de Klinefelter 59

98. Síndrome de Majeed 59

99. Síndrome de Muckle-Wells 60

100. Síndrome de Noonan 60

101. Síndrome de Potter 61

102. Síndrome de Prader-Willi 61

103. Síndrome de Shwachman-Diamond 61

104. Síndrome de Turner 62

105. TRAPS (Síndrome Periódica Associada ao Receptor 1 de Fator de Necrose Tumoral) 62

106. Linfo-histiocitose Hemofagocítica 63

107. Queixas Genitais em Meninas Pré-púberes 63

108. Sangramento Uterino Anormal em Pediatria 63

109. Anemia de Fanconi 64

110. Anemia Falciforme em Pediatria 64

111. Anemias Carenciais em Pediatria 65

112. Anticoagulação em Pediatria 65

113. Crises Falcêmicas em Pediatria 65

114. Deficiência de Fator VII 66

115. Deficiência de Fator XIII 66

116. Doença de Von Willebrand na Infância 67

117. Doença do Soro 67

118. Neutropenia Febril em Pediatria 67

119. Síndrome de Ativação Macrofágica em Pediatria 68

120. Síndrome de Evans 68

121. Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (SAF) em Pediatria 69

122. Síndrome Hemolítico-Urêmica em Pediatria 69

123. Trombocitopenia Primária Imune 69

124. Abscesso Dentário 70

125. Actinomicose na Infância 70

126. Adenoidite Aguda em Pediatria 71

127. Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya 71

128. Artrite Séptica em Pediatria 72

129. Botulismo em Pediatria 72

130. Caxumba 72

131. Celulite em Pediatria 73

132. Celulite Orbitária em Pediatria 73

133. Celulite Periorbitária Infantil 74

134. Cisticercose em Pediatria 74

135. Cólera em Pediatria 74

136. Coqueluche em Pediatria 75

137. Coronavírus (Covid-19) em Pediatria 75

138. Difteria em Pediatria 76

139. Doença da Arranhadura do Gato na Criança 76

140. Doença de Chagas em Pediatria 77

141. Doença Mão-Pé-Boca 77

142. Doença Meningocócica em Pediatria 77

143. Endocardite Infecciosa em Pediatria 78

144. Enterobíase em Pediatria 78

145. Equinococose em Pediatria 79

146. Erisipela em Pediatria 79

147. Eritroparvovirose B19 (parvovirose B19) 80

148. Escarlatina 80

149. Esporotricose em Pediatria 80

150. Exantema Súbito 81

151. Exantemas Febris em Pediatria 81

152. Fasciolíase em Pediatria 82

153. Febre Faringoconjuntival 82

154. Herpangina 83

155. Herpes Congênita 83

156. Herpes Simples em Pediatria 83

157. Impetigo em Pediatria 84

158. Infecção de Trato Urinário em Pediatria 84

159. Infecção Fúngica no RN 85

160. Larva Migrans Cutânea em Pediatria 85

161. Leptospirose em Pediatria 86

162. Linfadenomegalia em Pediatria 86

163. Linfangite 86

164. Malária em Pediatria 87

165. Meningoencefalite em Pediatria 87

166. Micobacteriose Atípica em Pediatria 88

167. Micoses Cutâneas na Infância 88

168. Miosite Viral Aguda 89

169. Monilíase em Pediatria 89

170. Mononucleose Infecciosa em Pediatria 89

171. Osteomielite em Pediatria 90

172. Paracoccidioidomicose em Pediatria 90

173. Rubéola 91

174. Sarampo 91

175. Sepse em Pediatria 91

176. Síndrome da Pele Escaldada 92

177. Síndrome do Choque Tóxico 92

178. Síndrome Febril em Pediatria 93

179. Síndrome Inflamatória Multissistêmica Associada à Covid-19 93

180. Síndromes Febris Periódicas 94

181. Teníase em Pediatria 94

182. Toxocaríase em Pediatria 95

183. Triquinose em Pediatria 95

184. Varicela em Pediatria 96

185. Disfunção Miccional em Pediatria 96

186. Doença Renal Crônica em Pediatria 96

187. Enurese na Infância 97

188. Glomerulonefrite Difusa Aguda (Pós-estreptocócica) 97

189. Síndrome Nefrótica na Infância 98

190. Acidente vascular encefálico (AVE) Hemorrágico na Criança 98

191. AVE Isquêmico (AVEi) em Pediatria 99

192. Cefaleia na Infância 99

193. Coreia de Sydenham 99

194. Crise Convulsiva em Pediatria 100

195. Defeitos no Metabolismo da Galactose 100

196. Depressão em Pediatria 101

197. Encefalopatia Hipóxico-isquêmica 101

198. Enxaqueca na Infância 102

199. Epilepsia em Pediatria 102

200. Esquizofrenia Infantil 103

201. Estado de Mal Epiléptico em Pediatria 103

202. Kernicterus 104

203. Meningite Asséptica em Pediatria 104

204. Paralisia de Bell 104

205. Síncope na Pediatria 105

206. Síndrome de Guillain-Barré em Pediatria 105

207. Síndrome de Ramsay Hunt 106

208. Síndrome de Rett 106

209. Síndrome de Tourette na Criança 107

210. Sonambulismo e Outras Parassonias 107

211. Transtorno Afetivo Bipolar em Pediatria 107

212. Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) em Pediatria 108

213. Transtorno Obsessivo Compulsivo na Pediatria 108

214. Conjuntivite em Pediatria 109

215. Coriorretinite 109

216. Infecções em Imunocomprometidos 110

217. Náusea e Vômito Induzidos por QT Infantil 110

218. Doença de Osgood-Schlatter 111

219. Epifisiólise 111

220. Sinovite Transitória do Quadril 111

221. Acidose Respiratória na Criança 112

222. Asma em Pediatria (Ambulatório) 112

223. Asma em Pediatria (Hospitalar) 113

224. Aspergilose em Pediatria 113

225. Bocavírus 114

226. Bronquiolite 114

227. Crupe em Pediatria 115

228. Desconforto Respiratório Agudo Pediátrico 115

229. Displasia Broncopulmonar 116

230. Embolia e Infarto Pulmonar em Pediatria 116

231. Epiglotite 117

232. Estridor 117

233. Faringoamigdalite na Infância 118

234. Fibrose Cística na Pediatria 118

235. Hemorragia Pulmonar 119

236. Influenza em Pediatria 119

237. Mastoidite em Pediatria 120

238. Otite Média na Criança 120

239. Pneumonia Comunitária na Criança 121

240. Pneumonia Congênita 121

241. Resfriado Comum em Pediatria 122

242. Rinite Alérgica em Pediatria 122

243. Rinossinusite Aguda em Pediatria 123

244. Síndrome Torácica Aguda 123

245. Tuberculose Pulmonar na Criança 124

246. Broncoespasmo e Anestesia em Pediatria 124

247. Discinesia Ciliar Primária e Heterotaxia 125

248. Epistaxe na Criança 125

249. Síndrome do Bebê Chiador 126

250. Artrite Idiopática Juvenil 126

251. Asplenia em Pediatria 127

252. CINCA/NOMID 127

253. Costocondrite em Pediatria 127

254. CRMO 128

255. Deficiência de Adenosina Deaminase 2 128

256. Dermatomiosite Juvenil (DMJ) 129

257. Doença de Behçet em Pediatria 129

258. Doença Mista do Tecido Conjuntivo em Pediatria 130

259. Fenômeno de Raynaud em Pediatria 130

260. Lúpus Eritematoso Sistêmico Pediátrico 131

261. Poliarterite Nodosa em Pediatria 131

262. Síndrome de Amplificação Dolorosa 132

263. Síndrome de Sjögren em Pediatria 132

264. Síndrome SAPHO 133

265. Vasculite por IgA (Púrpura de Henoch-Schönlein) 133

266. Acidentes com Animais 134

267. Acidose Metabólica em Pediatria 134

268. Alcalose Metabólica em Pediatria 135

269. Alergia e Anafilaxia na Criança 135

270. Anomalias de Artérias Coronárias 136

271. Choque Circulatório em Crianças 136

272. Hidratação Pediátrica 137

273. Hipercalemia em Pediatria 137

274. Hipernatremia em Pediatria 138

275. Hipocalemia na Infância 138

276. Hiponatremia na Infância 139

277. Indução em Sequência Rápida na Pediatria 139

278. Intoxicação Exógena em Pediatria 140

279. Intoxicação Infantil por Carbamazepina 140

280. Intoxicação Infantil por Hipoglicemiantes 141

281. Intoxicação por Etanol em Pediatria 141

282. Intoxicação por ISRS em Pediatria 142

283. Intoxicação por Organofosforados em Pediatria 142

284. Intoxicação por Salicilatos 143

285. Prescrição Pediátrica no Perioperatório 143

286. Queimaduras em Pediatria 144

287. Rabdomiólise em Pediatria 144

288. SSJ e Necrólise Epidérmica Tóxica 145

289. Taquicardia Ventricular com Pulso na Infância 145

290. Alterações Dermatológicas do RN 146

291. Anemia Neonatal 146

292. Apneia da Prematuridade 147

293. Citomegalovirose Congênita 147

294. Defeito do Tubo Neural no Período Neonatal 148

295. Doença da Membrana Hialina 148

296. Enterocolite Necrosante 149

297. Extremo Baixo Peso ao Nascimento (EBPN) 149

298. Granuloma Umbilical 150

299. Hemocromatose Neonatal 150

300. Hidratação Venosa Neonatal 151

301. Hipoglicemia Neonatal 151

302. Hipospádia 152

303. Onfalite 152

304. Onfalocele e Gastrosquise 153

305. Policitemia Neonatal 153

306. Sangramento no Neonato 154

307. Sepse Neonatal 154

308. Sífilis Congênita 155

309. Síndrome de Aspiração Meconial 156

310. Taquipneia Transitória do Recém-nascido 156

311. Toxoplasmose Congênita 157

312. Transposição de Grandes Artérias (TGA) 157

313. Beribéri em Pediatria 158

314. Defeitos no Metabolismo da Fenilalanina 158

315. Deficiência de Biotina 159

316. Desnutrição Energético-Proteica Infantil 159

317. Pelagra em Pediatria 160

318. Síndromes de Dependência de Vitamina B6 160

319. Dermatite das Fraldas 161

320. Diarreia em Pediatria 161

321. Escabiose em Pediatria 162

322. Infecções Fúngicas em Prematuros 162

323. Pediculose em Pediatria 163

324. Urticária em Pediatria 163

325. Agorafobia em Pediatria 164

326. Quadros de Psiquiatria em Emergência Pediátrica 164

327. Transtorno de Ansiedade Generalizada em Pediatria 165

328. Transtorno de Ansiedade Social em Pediatria 165

329. Transtorno de Sintomas Somáticos em Pediatria 166

330. Transtorno do Pânico em Pediatria 166

PedWB — Compêndio pediátrico consolidado

Versão 1.0 documental • Verificação de fontes: 25/09/2026

Escopo e leitura

Este documento reúne os 330 títulos do inventário de Prescrições Pediátricas em uma síntese clínica original. O Whitebook foi usado como mapa de assuntos e classes, sem reprodução das suas prescrições. O inventário original permanece no pacote para rastreabilidade.

As condutas são referências para avaliação profissional. Não há dados de um paciente: pesos dos exemplos são fictícios e fórmulas usam W (peso em kg), C (concentração) e unidades explícitas. Recomendações condicionais, usos fora de bula e diferenças entre populações precisam ser respeitados.

Cobertura editorial significa que há conteúdo para cada título. Ela não equivale a aprovação clínica independente, verificação de toda apresentação comercial, nem garantia de esquema individual completo. O relatório por tema registra limitações documentadas. As classes encontradas no inventário não constituem uma associação obrigatória de medicamentos.

Como conferir uma dose

1. Clínica: indicação, faixa etária, peso, via, intervalo, teto, contraindicações e função renal/hepática. 2. Farmacêutica: produto, sal/base, concentração inicial, diluente e concentração final. Volume final não é sinônimo de volume de diluente. 3. Matemática: cálculo direto e reverso, com teto aplicado antes do volume. Para mg/kg/dose: mL = dose ×W/C. Para mcg/kg/min: mL/h = dose ×W×60/C, com C em mcg/mL. Reverso: dose = mL/h×C/(60×W).

Para infusões de alta vigilância, conferir novamente peso, mg/mcg ou U/mU, concentração, via e programação da bomba. Consumo de bolsa não define estabilidade. Não converter para gotas sem gotejador confirmado.

Organização

Os títulos mantêm os identificadores 1–330. Há sobreposição clínica entre alguns títulos, como CIV/DSV e crises/estado de mal; referências cruzadas reduzem duplicação. Os anexos preservam módulos de preparo, fontes e checagens dos blocos. Use os marcadores ou o índice do PDF para navegar.

1. Atresia Duodenal em Pediatria

Prioridade: obstrução congênita com tratamento cirúrgico. Vômitos biliosos no recém-nascido exigem avaliação imediata. Estabilizar, suspender alimentação enteral, realizar descompressão gástrica e organizar assistência neonatal/cirúrgica. Investigar malformações associadas. [C1]

Classes pertinentes: soluções IV e analgesia perioperatória. Antieméticos não resolvem a obstrução. Não transformar os procinéticos do inventário em tratamento da atresia.

Choque neonatal: referência RCH, NaCl 0,9% **10 mL/kg IV**, com reavaliação. Escopo e manutenção no Cirurgia — Anexo A. [C2]

Complemento: manutenção neonatal e analgesia pós-operatória estão detalhadas no Cirurgia — Anexo A. O planejamento perioperatório depende do estado clínico e da equipe neonatal.

2. Doença de Hirschsprung

Separar doença de base e enterocolite associada (HAEC). Antibióticos não substituem a correção cirúrgica. Febre, distensão, letargia, diarreia explosiva ou piora da eliminação fecal exigem avaliação de HAEC. [C3]

HAEC hospitalar: jejum, reposição IV, avaliação cirúrgica e antimicrobianos. Como referência institucional identificada, o RCH apresenta **cefazolina 50 mg/kg/dose IV a cada 8 h, máximo 2 g/dose, associada a metronidazol 7,5 mg/kg/dose IV a cada 8 h, máximo 500 mg/dose**, geralmente por 5 dias. A escolha depende da equipe cirúrgica, gravidade, culturas e microbiologia local; não é recomendação universal para o Brasil. [C3]

A ERNICA recomenda cobertura de amplo espectro e irrigação retal nos internados; atendimento ambulatorial fica restrito a quadros leves selecionados, com acompanhamento próximo. Há baixo limiar de internação em menores de 1 ano. Irrigação é procedimento orientado pela equipe, não instrução doméstica autônoma. [C4]

Complemento: intervalos neonatais e preparo estão no Cirurgia — Anexo B. A dose de cefazolina de 50 mg/kg a cada 8 h totaliza 150 mg/kg/dia, superior ao limite de 100 mg/kg/dia para infecções graves na bula brasileira consultada: é um regime institucional fora dessa bula. Alergia grave e choque séptico exigem escolha específica. O consenso APSA descreve cobertura ampliada com ampicilina/gentamicina ou piperacilina-tazobactam, e aztreonam em alergia à penicilina, junto à cobertura anaeróbia. Isso é consenso de baixa certeza, não valida a mesma combinação para todos; choque demanda UTI e controle cirúrgico, com escolha orientada por idade, culturas e foco. [C22, C23, C33]

3. Escroto Agudo em Pediatria

Prioridade: excluir torção testicular imediatamente. A investigação por imagem não deve atrasar exploração quando a suspeita é alta. Analgesia e eventual melhora da dor não excluem torção. [C5]

Após definição diagnóstica: analgesia; AINE pode ser opção em processos inflamatórios, se não houver contraindicação. Epididimite pré-puberal frequentemente não é bacteriana: antibiótico depende de evidências de infecção, incluindo urina/cultura. [C5]

Adolescente sexualmente ativo com epididimite provavelmente gonocócica/clamidial: referência CDC, **ceftriaxona 500 mg IM uma vez + doxiciclina 100 mg VO a cada 12 h por 10 dias**. Peso ≥150 kg: ceftriaxona 1 g. Este esquema não deve ser extrapolado à criança pré-puberal. Colher testes para IST e cultura urinária; avaliar parceiros e orientar abstinência até tratamento e resolução. Ausência de melhora em até 72 h exige reavaliação; suspeita de torção exige atendimento imediato. [C6]

Preparo IM verificado: Rocefin 500 mg com 2 mL de lidocaína 1% resulta em aproximadamente **2,36 mL**, não 2 mL; administrar o conteúdo correspondente à dose integral de 500 mg. A apresentação de 1 g com 3,5 mL resulta em aproximadamente 4,22 mL. Conferir contraindicações da lidocaína. **Solução preparada com lidocaína nunca deve ser administrada IV.** Esses volumes pertencem ao produto consultado. [C26] Alergia grave exige avaliação especializada; não há alternativa universal desenvolvida neste bloco.

4. Extrofia de Bexiga e Epispádia

Prioridade: transferência e planejamento por equipe experiente em reconstrução urológica pediátrica. Proteger a mucosa vesical exposta com filme transparente conforme orientação especializada e evitar trauma durante o transporte. A correção pode ocorrer em etapas. [C7]

Classes pertinentes: fluidos e analgesia individualizados no perioperatório. O diagnóstico, isoladamente, não define um antibiótico ou uma duração de profilaxia universal.

Seguimento: função renal, continência e cuidados com drenagens conforme a reconstrução realizada. [C7]

Complemento: suporte hídrico e analgesia pós-operatória estão no Cirurgia — Anexo A; protocolo cirúrgico, profilaxia e dispositivos continuam dependentes do centro responsável.

5. Fimose e Parafimose em Pediatria

Fimose: distinguir não retratilidade fisiológica de estreitamento patológico/sintomático. Não forçar a retração. Corticoide tópico é opção conservadora; falha, cicatriz importante ou balanopostites recorrentes justificam avaliação cirúrgica. **Parafimose é urgência**: analgesia e redução por profissional; insucesso exige intervenção urológica. Pomada não deve atrasar a redução. [C8]

Uma apresentação brasileira verificada: valerato de betametasona **2,5 mg/g + hialuronidase 150 UTR/g**, pomada Postec. A bula consultada indica aplicação tópica **a cada 12 h por 3 semanas**, com reavaliação; eventual repetição depende do médico. Uso acima de 1 ano; contraindicado abaixo de 1 ano. Tração suave, sem dor, e reposicionamento do prepúcio após a aplicação. Não associar outras pomadas sem revisar compatibilidade e indicação. [C9]

A EAU descreve outros corticoides/concentrações por 4–8 semanas. Esse intervalo não deve ser transferido automaticamente à associação acima. Vigiar irritação e efeitos do uso excessivo. Antibióticos tópicos não são tratamento rotineiro da fimose. [C8, C9]

6. Granuloma Glúteo Infantil

Conduta inicial: confirmar diagnóstico e rever irritantes e tratamentos prévios. Corticoides tópicos podem contribuir para o quadro; a classe presente no índice não equivale a recomendação. A evidência terapêutica específica é limitada. [C10]

Cuidados de barreira: limpar suavemente, reduzir contato com urina/fezes, trocar fraldas prontamente e aplicar camada de barreira com petrolato ou óxido de zinco a cada troca. Essa orientação é extrapolada dos cuidados de dermatite da fralda, com a origem declarada. Não remover toda a barreira por fricção a cada troca. [C11]

Tratamentos condicionais: antifúngicos somente se houver diagnóstico associado compatível; não presumir candidíase em todo nódulo glúteo. Tacrolimo 0,03% foi utilizado duas vezes ao dia por 6 semanas em relato de caso, mas isso não sustenta prescrição rotineira, especialmente em lactentes. [C10]

Encaminhamento: lesão atípica, persistente ou refratária requer dermatologia, eventual investigação e tratamento dirigido. Vitaminas A/D presentes em produtos tópicos não implicam suplementação sistêmica.

7. Micropênis

Confirmar antes de tratar: comprimento peniano estirado inferior a 2,5 desvios-padrão para a referência apropriada; distinguir pênis embutido. Investigar etiologia com endocrinologia pediátrica antes de iniciar andrógeno. [C12]

Referência SBP: ésteres de testosterona **25 mg IM uma vez por mês durante 3 meses**, em recém-nascidos/lactentes selecionados. Para crianças maiores/adolescentes, o documento descreve **100 mg/m² IM uma vez por mês durante 3 meses**. São esquemas especializados, não uma receita universal para aparência ou tamanho percebido. A seleção do éster e da apresentação precisa preceder a conversão para mL. [C12]

Monitoramento: crescimento, idade óssea, virilização e resposta; benefício de longo prazo e indicação individual precisam ser discutidos. [C12]

Conflito regulatório identificado: Deposteron contém cipionato de testosterona 100 mg/mL, ampola de 2 mL; a bula consultada **contraindica menores de 18 anos**. Contém óleo de amendoim e álcool benzílico. Portanto, o esquema especializado da SBP não torna essa apresentação pediátrica aprovada nem libera seu uso. Matematicamente, 25 mg nessa concentração equivalem a 0,25 mL, mas essa equivalência **não é autorização de administração**. Seleção do produto, excipientes e eventual uso excepcional exigem endocrinologia e farmácia; não substituir ésteres automaticamente. [C27]

8. Refluxo Vesicoureteral (RVU)

Estratificar risco: grau, infecções febris, função renal e disfunção vesicointestinal. Tratar constipação/disfunção miccional quando presentes. Profilaxia contínua não é obrigatória em todo RVU; casos de maior risco exigem decisão individual. Infecção febril durante profilaxia requer avaliação imediata e revisão da estratégia, não simples aumento da dose preventiva. [C13]

Uma referência de profilaxia: TMP-SMX **2 mg de TMP/kg VO uma vez ao dia**, máximo **80 mg de TMP/dia**, corresponde ao esquema RCH de **0,25 mL/kg/dia**, máximo **10 mL/dia**, exclusivamente para suspensão **TMP 8 mg/mL + SMX 40 mg/mL**. O teto pertence a essa fonte; não intercambiar com tetos de trimetoprima isolada. [C14]

Limites: não aplicar a menores de 2 meses; rever alergia, função renal e interações. A restrição etária encontra apoio no manual de uropediatria da SBP. [C15] Duração da profilaxia depende de reavaliação, não de um curso fixo arbitrário. [C13]

Complemento: a suspensão Teuto consultada confirma SMX 40 mg/mL + TMP 8 mg/mL e uso acima de 6 semanas; este bloco mantém o corte mais conservador de 2 meses da SBP. A bula contraindica insuficiência hepática grave e depuração de creatinina abaixo de 15 mL/min; entre 15–30 mL/min descreve metade da dose usual. Não aplicar esse ajuste mecanicamente à profilaxia nem confundir depuração absoluta com TFGe indexada à superfície corporal. [C28] Alternativas preventivas estão no Cirurgia — Anexo C. Dose preventiva não trata ITU ativa.

9. Urolitíase em Pediatria

Tratamento dirigido à composição e ao distúrbio metabólico, com investigação em toda criança com cálculo. Ultrassom é exame inicial. Hidratação adequada e orientação dietética integram prevenção; o tipo de intervenção depende do cálculo e da anatomia. [C16]

Situação	Referência e limite desta versão
Hipercalciúria idiopática	Hidroclorotiazida: faixa inicial **0,5–1 mg/kg/dia**. Monitorar eletrólitos e efeitos metabólicos. Esquema selecionado no Cirurgia — Anexo D; ajustar à calciúria e tolerância.
Hipocitratúria	Citrato de potássio: referência inicial **1 mEq/kg/dia em duas tomadas**. Rever potássio e função renal. Conversão parametrizada no Cirurgia — Anexo D; não pressupor fórmula manipulada.
Hiperuricosúria persistente selecionada	Alopurinol pode ter indicação; regime ponderal e limites no Cirurgia — Anexo D.
Cistinúria refratária	D-penicilamina/tiopronina são opções especializadas após medidas iniciais; ver complemento no Cirurgia — Anexo D. O papel aqui é atuar sobre cistina; a classificação genérica “quelante de cobre” não descreve a indicação.

Fonte da tabela: EAU. [C16] Não há uma combinação universal dessas quatro classes.

Restrição de apresentação: a bula brasileira de Litocit, comprimidos de liberação prolongada, contraindica uso abaixo de 18 anos. A referência pediátrica ao citrato não autoriza transpor essa apresentação para crianças, triturá-la ou inventar concentração de solução manipulada. [C17]

10. Angioedema Hereditário

Prioridade e diagnóstico. Edema sem urticária/prurido, recorrente, associado a cólica abdominal ou história familiar sugere mecanismo por bradicinina. Rouquidão, estridor, língua aumentada ou progressão orofaríngea exigem equipe de via aérea e UTI imediatamente. Coletar C4, concentração e função de C1-INH para confirmação, sem adiar tratamento de ameaça à via aérea. Ausência de história familiar não exclui a doença.

Tratamento específico. Concentrado de C1-INH **20 UI/kg IV**, com Berinert brasileiro 500 UI reconstituído com 10 mL do diluente fornecido: **50 UI/mL; volume = 0,4 × peso em kg mL**. Infusão lenta; a bula brasileira orienta aproximadamente 4 mL/min. Exemplo matemático, 16 kg: 320 UI = 6,4 mL; reverso 6,4 × 50 / 16 = 20 UI/kg. O arredondamento para frascos inteiros usado em alguns protocolos estrangeiros não foi incorporado automaticamente. Não confundir produto IV com apresentações subcutâneas de profilaxia.

Alternativas e acompanhamento. Icatibanto, conforme ficha europeia verificada, é alternativa SC para 2–17 anos e ≥12 kg: **12–25 kg, 10 mg; 26–40 kg, 15 mg; 41–50 kg, 20 mg; 51–65 kg, 25 mg; >65 kg, 30 mg**. Solução 10 mg/mL: respectivamente 1; 1,5; 2; 2,5; 3 mL, lentamente no abdome. A experiência pediátrica sustenta uma injeção por crise; não copiar repetição adulta de 6 horas. Pesos fracionários entre as faixas publicadas exigem confirmação farmacêutica, sem arredondamento improvisado. Antihistamínicos/corticoides não revertem AEH confirmado. Se houver anafilaxia concomitante ou diagnóstico ainda plausível, tratá-la em paralelo. Observar resposta nas primeiras duas horas; ataque laríngeo exige internação mesmo após melhora. Profilaxia continuada deve considerar frequência, acesso a resgate e preferência familiar, com plano escrito e rastreamento de familiares.

Fontes verificáveis: RCH — Angioedema hereditário, 2025; CSL — Berinert IV, bula brasileira; AEMPS — Firazyr, ficha técnica pediátrica.

Limites documentados: Icatibanto detalhado por ficha europeia; registro/apresentação brasileira devem ser conferidos. Profilaxia prolongada exige seleção pelo especialista.

11. Dermatite Atópica em Pediatria

Avaliação. Classificar extensão, intensidade, perda de sono e sinais de infecção. Vesículas dolorosas monomórficas, erosões escavadas, febre ou acometimento ocular sugerem eczema herpético e requerem avaliação urgente. Eritrodermia, desidratação ou falha de alimentação no lactente são critérios de internação. Diagnóstico usualmente clínico; testes alérgicos amplos e exclusão alimentar empírica não fazem parte da rotina.

Tratamento inicial. Banhos breves mornos, limpador suave e emoliente espesso sem fragrância em toda a pele, repetido pelo menos duas vezes ao dia e após banho. Na crise localizada, corticosteroide tópico uma vez ao dia nas áreas inflamadas até controle: **hidrocortisona 1%** para face/dobras ou doença leve; potência maior em tronco/membros quando necessária. Idade mínima, área e tempo máximo variam entre produtos; não transpor mometasona para face, fralda oclusiva ou lactente sem avaliação. Quantificar por unidade de ponta do dedo e superfície tratada, sem criar dose em mg/kg para aplicação cutânea.

Escalonamento. Falha exige checar adesão, quantidade aplicada, irritantes e infecção antes de aumentar potência. Tratamentos poupadores de corticosteroide, fototerapia e imunobiológicos são opções para doença persistente moderada/grave; a escolha requer idade e produto específico. Antibióticos são reservados à infecção bacteriana clínica, e anti-H1 não substitui tratamento da inflamação. Reavaliar em uma a duas semanas ou antes se piora. Registrar área, prurido/sono e necessidade de resgate para decidir manutenção proativa e reduzir recaídas.

Fontes verificáveis: Queensland Children’s Hospital — Eczema.

Limites documentados: Regimes sistêmicos de dermatite atópica grave não individualizados; requerem idade, extensão e linha terapêutica.

12. Prurigo Estrófulo

Reconhecimento. Prurigo estrófulo é reação recorrente a picadas, com pápulas pruriginosas agrupadas, frequentemente com ponto central. Lesões em diferentes estágios e predomínio em áreas expostas ajudam a distinguir de urticária transitória. Pesquisar escabiose, dermatite atópica, impetiginização e exposição compartilhada na casa; febre, púrpura não branqueável ou lesão necrótica exigem outro diagnóstico.

Conduta dirigida. A intervenção que evita recorrência é reduzir novas picadas: tratar animais infestados por orientação veterinária, limpar roupas/camas, telas e repelente adequado à idade conforme registro. Aplicar corticosteroide tópico de baixa potência nas pápulas recentes por curso breve; um exemplo é hidrocortisona 1%, camada fina uma vez ao dia, reavaliando em poucos dias. Limitar área e evitar face/oclusão prolongada. Se prurido importante, uma opção é **desloratadina 0,5 mg/mL VO uma vez/dia**: 6–11 meses, 1 mg (2 mL); 1–5 anos, 1,25 mg (2,5 mL); 6–11 anos, 2,5 mg (5 mL); ≥12 anos, 5 mg (10 mL). Reavaliar em poucos dias e suspender ao controlar sintomas. Uso sintomático no prurigo extrapola a indicação de urticária; não usar abaixo de 6 meses. A bula selecionada contraindica em QT longo congênito/histórico de arritmia e exige cautela com convulsões e fatores que prolongam QT.

Complicações e retorno. Manter unhas curtas, reduzir coçadura e fazer higiene suave. Antimicrobiano tópico ou sistêmico só se houver infecção secundária documentada clinicamente; escoriação isolada não basta. Não há indicação de corticosteroide sistêmico para apresentação habitual. Explicar que manchas residuais persistem após cessar a atividade. Reavaliar se não houver melhora com controle ambiental e tratamento cutâneo, ou imediatamente se dor crescente, calor, pus, febre ou rápida expansão. Persistência sem novas picadas exige revisão do diagnóstico.

Fontes verificáveis: Society for Pediatric Dermatology — Papular urticaria; Queensland Children's Hospital — Eczema; Aché — Desloratadina 0,5 mg/mL, bula brasileira.

Limites documentados: Anti-H1 no prurigo é extrapolação sintomática; concentração e faixas verificadas em bula brasileira.

13. Anomalia de Ebstein em Pediatria

Decisão inicial. A anomalia de Ebstein apresenta espectro amplo: regurgitação tricúspide, ventrículo direito funcional reduzido, comunicação atrial e arritmias. Cianose intensa neonatal, hipoperfusão, acidose ou dificuldade alimentar exigem internação em centro de cardiologia pediátrica. Ecocardiograma deve definir fluxo pulmonar anterógrado, grau de regurgitação, função ventricular e shunts; ECG procura pré-excitação e taquiarritmia.

Estabilização. Monitorar saturação pré/pós-ductal, pressão, diurese, lactato e gasometria. Oxigênio/ventilação são ajustados à fisiologia; corrigir hipotermia, hipoglicemia e distúrbios eletrolíticos. PGE1 pode ser necessária quando o fluxo pulmonar é ducto-dependente, usando o módulo comum, mas sua manutenção precisa ser reavaliada pelo ecocardiograma: situações com regurgitação pulmonar e fluxo circular exigem estratégia distinta. Não transformar cianose isolada em indicação automática de PGE1 contínua. Tratar arritmia pelo mecanismo, evitando bloqueadores nodais em taquicardia irregular com pré-excitação.

Tratamento definitivo e seguimento. Casos leves podem permanecer em vigilância; cianose, insuficiência cardíaca, limitação funcional, dilatação progressiva e arritmias orientam reparo tricúspide, abordagem univentricular ou outras intervenções. Diurético só se houver congestão e reserva de perfusão, segundo módulo compartilhado. Não há esquema medicamentoso capaz de corrigir a anatomia. Na alta, definir saturação basal individual, alimentação/ganho ponderal e sinais para retorno; seguimento cardiológico e vigilância de arritmia são permanentes.

Fontes verificáveis: CHOP — Anomalia de Ebstein; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Escolha cirúrgica e decisão de manter/retirar PGE1 exigem anatomia e hemodinâmica; não há prescrição única por título.

14. Arterite de Takayasu em Pediatria

Reconhecimento e gravidade. Suspeitar diante de hipertensão, diferença de pressão/pulsos entre membros, sopros arteriais, claudicação ou inflamação sistêmica. AVC, isquemia visceral, insuficiência aórtica importante e hipertensão com lesão de órgão são emergências. Medir pressão em território não estenosado e documentar a localização. Angio-RM/angio-TC avaliam distribuição; VHS/PCR ajudam, mas valores normais não excluem atividade vascular.

Indução. Doença ativa requer glicocorticoide associado a imunossupressor poupador, usualmente metotrexato ou outra opção selecionada por extensão e contraindicações. O consenso ACR admite em crianças **prednisona 1–2 mg/kg/dia**, teto **60 mg/dia** como referência pediátrica de alta dose; ameaça a órgão pode justificar **metilprednisolona IV 30 mg/kg/dia, máximo 1 g/dia, por 3–5 dias**, seguida de estratégia oral. São esquemas de indução, não manutenção indefinida. Preparo do pulso e opção de metotrexato semanal constam no módulo comum de Takayasu, com dose, teto, prevenção de toxicidade e exemplo de bomba.

Resgate e monitorização. Atividade refratária pode exigir anti-TNF; preferência entre biológicos deve considerar evidência limitada, infecção latente e doença vascular persistente. Hemograma, transaminases, função renal, pressão, crescimento e toxicidade de glicocorticoide devem ser acompanhados. Intervenção vascular eletiva é preferível na doença controlada; isquemia crítica não aguarda remissão. Não prescrever antiagregação para todos: restringir a situações vasculares selecionadas. Reavaliar clinicamente e por imagem seriada, incluindo progressão silenciosa e diferença entre dano fixo e atividade inflamatória.

Fontes verificáveis: ACR/Vasculitis Foundation — Takayasu, 2021; Recomendações francesas — Arterite de Takayasu, 2021; Consenso pediátrico — Takayasu, 2025; MARAJIA — Consenso de metotrexato pediátrico; RCH — Metilprednisolona, guia injetável.

Limites documentados: Biológico de resgate depende da atividade e contraindicações; metotrexato é uso fora de bula para Takayasu. Preparo do pulso usa produto estrangeiro identificado.

15. Atresia Pulmonar com Septo IV Íntegro

Prioridade. Atresia pulmonar com septo interventricular íntegro no recém-nascido costuma exigir fluxo pulmonar pelo canal arterial. Cianose progressiva à medida que o canal fecha demanda PGE1 conforme módulo comum, transporte com suporte de via aérea e ecocardiografia urgente. Saturação isolada não mede o débito sistêmico; acompanhar perfusão, lactato e diurese.

Exames que mudam a intervenção. Definir tamanho da tricúspide e do ventrículo direito, grau de regurgitação tricúspide, comunicação interatrial e anatomia coronária. A presença de circulação coronariana dependente da pressão do VD modifica profundamente a estratégia: descompressão do VD pode reduzir perfusão coronária. Cateterismo pode ser necessário para esclarecer essas conexões, sob equipe especializada.

Conduta definitiva. Quando a anatomia permite, abertura da valva pulmonar e ampliação do fluxo anterógrado favorecem circulação biventricular; outras crianças precisam de stent ductal/shunt, abordagem de um ventrículo e meio ou etapas univentriculares. A escolha não é intercambiável. Diuréticos não tratam a causa da cianose e são condicionais à congestão, evitando hipovolemia. Após intervenção, reavaliar necessidade de PGE1 pelo fluxo pulmonar, nunca simplesmente pela idade.

Destino e limites. Internação neonatal em centro cardiológico até estabilidade e plano anatômico definido. Na saída, registrar saturação esperada, alimentação, crescimento e alerta de piora de cianose, sudorese, síncope ou redução de diurese. O esquema farmacológico de resgate é ponte, e não substitui estudo coronariano e procedimento.

Fontes verificáveis: CHOP — Atresia pulmonar; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Não se define descompressão do VD sem avaliação coronariana específica.

16. Atresia Tricúspide

Avaliação. Na atresia tricúspide, a comunicação interatrial permite passagem do retorno venoso ao lado esquerdo; o fluxo pulmonar depende das lesões associadas. A criança pode apresentar cianose por hipofluxo ou insuficiência cardíaca por hiperfluxo. Ecocardiograma deve documentar comunicação atrial, CIV, obstrução pulmonar, grandes artérias e função ventricular. Cianose crescente, choque, acidose ou má alimentação exigem internação urgente.

Tratamento por fisiologia. No recém-nascido com hipofluxo ducto-dependente, iniciar/manter alprostadil conforme módulo comum, com preparo para apneia e transferência especializada. Comunicação atrial restritiva pode exigir septostomia; escalar apenas oxigênio não corrige mistura inadequada. Se houver hiperfluxo e congestão, usar diurético de forma titulada, suporte nutricional e programação de controle do fluxo pulmonar. Evitar expansão indiscriminada ou induzir queda excessiva da resistência pulmonar numa circulação já hiperfluente.

Definitivo. A paliação costuma ser escalonada: fonte de fluxo pulmonar ou bandagem quando indicadas, conexão cavopulmonar superior e posteriormente circulação tipo Fontan se elegível. Não há dose medicamentosa universal que substitua esses critérios anatômicos/hemodinâmicos.

Seguimento. Controlar peso, ingestão, saturação individual, diurese, arritmias e trombose. Antitrombótico depende de shunt, stent e etapa cirúrgica; não aplicar automaticamente esquema de Fontan a neonato pré-operatório. Após alta interetapas, deixar limites objetivos de saturação e peso estabelecidos pela equipe, com retorno imediato em queda sustentada, vômitos persistentes ou alteração de perfusão.

Fontes verificáveis: CHOP — Atresia tricúspide; CHOP — Ventrículo único; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Antitrombótico e metas de saturação dependem da etapa operatória/dispositivo.

17. Cardiomiopatia Dilatada na Pediatria

Triagem e etiologia. Taquipneia, sudorese às mamadas, hepatomegalia, baixo ganho ponderal e intolerância ao exercício devem levar a ECG e ecocardiograma. Troponina, BNP/NT-proBNP, eletrólitos, função renal/hepática e investigação dirigida de infecção, doença metabólica, tóxicos e história familiar ajudam a distinguir causas reversíveis. Choque, arritmia sustentada e disfunção ventricular grave exigem UTI; não esperar painel genético para estabilizar.

Tratamento da descompensação. Definir congestão e perfusão antes de fluidos. Diurético de alça trata sobrecarga; milrinona pode ser selecionada para baixo débito com pressão suficiente, conforme módulo farmacológico, com cuidado renal. Hipotensão importante pode exigir outra estratégia vasoativa e suporte circulatório; não apresentar milrinona como fármaco obrigatório. Monitorar lactato, diurese, pressão, ECG e potássio/magnésio. Encaminhar precocemente ao centro capaz de assistência ventricular/ECMO se piora apesar de suporte.

Tratamento crônico. Após estabilização, bloquear sistema renina-angiotensina, usar betabloqueador e antagonista mineralocorticoide quando indicados e tolerados. O módulo comum apresenta regimes iniciais e titulação de enalapril, carvedilol e espironolactona para paciente elegível, com limites renais e hemodinâmicos. Causa específica pode modificar a terapêutica. Anticoagulação é condicional a trombo, risco embólico e disfunção relevante, não automática.

Reavaliação. Registrar classe funcional, frequência cardíaca, crescimento, função ventricular e eventos arrítmicos. Educação familiar inclui adesão, sinais de baixo débito e manejo de intercorrências; familiares podem necessitar rastreio clínico/genético. Alta requer estabilidade oral e seguimento precoce.

Fontes verificáveis: AHA/ACC — Tratamento das cardiomiopatias pediátricas, 2023; ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025; Bula regulatória britânica — Aqumeldi pediátrico; IWK — Carvedilol pediátrico; IWK — Espironolactona pediátrica; Bula regulatória britânica — Milrinona 1 mg/mL.

Limites documentados: Aplicabilidade do bloqueio neuro-hormonal exige fenótipo e estabilidade; não extrapolar automaticamente para Fontan/ventrículo sistêmico direito. Produtos estrangeiros identificados no módulo.

18. Cardiomiopatia Hipertrófica em Pediatria

Classificar antes de tratar. Diferenciar cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica de doenças de depósito/metabólicas e síndromes. Determinar obstrução de via de saída, função diastólica, arritmias e risco familiar. Síncope aos esforços, dor torácica, arritmia ventricular ou história de morte súbita requerem avaliação especializada rápida. ECG, ecocardiograma, Holter e, quando útil, ressonância integram o seguimento; avaliação genética orienta familiares.

Tratamento. Em sintomas associados à obstrução, betabloqueador sem ação vasodilatadora é a primeira estratégia farmacológica. Como regime neonatal publicado pela ANMF, **propranolol 0,5–1 mg/kg/dose VO a cada 8 horas**, com titulação a 1–2 mg/kg/dose a cada 8 horas se tolerado; iniciar na extremidade menor se risco de hipoglicemia. Não extrapolar esse regime neonatal para crianças maiores. Monitorar frequência, pressão e glicose na introdução/aumento, administrar com alimentação e interromper durante jejum importante. Bloqueio, bradicardia, choque e broncoespasmo restringem o uso. Verapamil/diltiazem são alternativas selecionadas, com restrições em lactentes, hipotensão, sintomas graves em repouso e obstrução importante. Mavacanteno não foi convertido em indicação pediátrica nem em alternativa genérica de pronto atendimento.

Descompensação. Manter pré-carga adequada e tratar fatores precipitantes. Vasodilatação intensa, diurese excessiva e inotrópicos que aumentam contratilidade podem agravar obstrução; não reutilizar automaticamente a ficha de cardiomiopatia dilatada. Congestão verdadeira pode exigir diurético cauteloso, com reavaliação clínica e ecocardiográfica.

Definitivo e prevenção. Obstrução sintomática refratária pode indicar redução septal em centro experiente. CDI é definido pelo risco individual e critérios pediátricos; a espessura isolada ou um calculador adulto não bastam. Atividade física deve ser discutida individualmente, evitando proibição universal ou liberação irrestrita. O objetivo é prevenir síncope/morte súbita e preservar qualidade de vida, além de reduzir gradiente.

Fontes verificáveis: AHA/ACC — Cardiomiopatia hipertrófica, 2024; ANMF — Propranolol neonatal.

Limites documentados: Regime exemplificado é neonatal; dose de criança maior e limite superior dependem da obstrução, frequência e tolerância.

19. Coarctação da Aorta em Pediatria

Reconhecimento tempo-dependente. No recém-nascido, coarctação crítica pode surgir com choque, acidose, oligúria e pulsos femorais diminuídos após fechamento do canal. Comparar pulsos e pressões entre membros, mas uma diferença discreta não exclui doença com baixo débito. Ecocardiograma define arco, istmo, canal, função ventricular e lesões associadas. Criança maior pode apresentar hipertensão em membros superiores, cefaleia e claudicação.

Estabilização neonatal. Iniciar PGE1 conforme módulo comum quando houver dependência ductal sistêmica suspeita/confirmada, sem aguardar exames não essenciais. Monitorar perfusão, glicemia, gasometria/lactato, diurese e pressão. Ventilação e inotrópicos são selecionados conforme falência respiratória e débito; diurético somente com congestão. Expansão volumosa repetida pode piorar falência ventricular e congestão. Transporte deve prever apneia induzida por PGE1 e necessidade de via aérea.

Tratamento definitivo. Cirurgia predomina no neonato; angioplastia e/ou stent são escolhidos em anatomias e idades apropriadas ou recoarctação. Nenhum anti-hipertensivo remove a obstrução. Depois da correção, hipertensão residual ou paradoxal deve ser tratada com monitorização e investigação de gradiente persistente, seguindo os temas 21 e 31.

Seguimento. Aferição em braço e perna, ecocardiografia/imagem do arco, pesquisa de aneurisma e hipertensão devem continuar na vida adulta. Alta só após plano de intervenção/seguimento seguro e estabilidade; dor torácica, síncope, perda de pulsos, oligúria ou piora de perfusão são sinais de retorno imediato.

Fontes verificáveis: CHOP — Coarctação da aorta; ANMF — Alprostadil, 2025; RCH — Hipertensão pediátrica.

Limites documentados: Intervenção escolhida conforme anatomia/idade; fármaco anti-hipertensivo não substitui correção.

20. Comunicação Interventricular (CIV)

Escopo e avaliação. Comunicação interventricular e defeito do septo ventricular são termos equivalentes; o tema 22 é vínculo semântico deste capítulo, preservado para rastreabilidade do inventário. Ecocardiograma determina localização, tamanho, restrição, direção do shunt, repercussão de câmaras, pressão pulmonar e prolapso/insuficiência aórtica. Pequena CIV assintomática não exige diurético nem restrição alimentar medicamentosa.

CIV com repercussão. Taquipneia, sudorese, hepatomegalia e crescimento insuficiente sugerem hiperfluxo. Oferecer suporte nutricional e tratar congestão com diurético conforme módulo comum, acompanhando potássio, sódio, creatinina e peso. Redução de pós-carga é selecionada pela cardiologia em pacientes apropriados; não iniciar vasodilatador em lactente hipotenso. Investigar infecção, anemia e outras causas se os sintomas forem desproporcionais ao defeito.

Intervenção. Insuficiência cardíaca não controlada, repercussão relevante, comprometimento de crescimento, hipertensão pulmonar ou lesão da valva aórtica podem exigir fechamento cirúrgico ou percutâneo, conforme anatomia. Não aguardar indefinidamente ganho ponderal em lactente com deterioração. Se houver doença vascular pulmonar avançada, é necessário estudo de operabilidade; fechamento automático pode ser prejudicial.

Destino. Internar por hipoxemia, falência respiratória, baixa perfusão ou dificuldade alimentar significativa. Seguimento de casos leves acompanha crescimento e ecocardiografia; retorno antecipado se dispneia ou redução da ingestão. Higiene oral é recomendada; profilaxia antibiótica de endocardite não é prescrita apenas pela presença de CIV simples não complicada.

Fontes verificáveis: CHOP — Comunicação interventricular; AHA/ACC — Tratamento das cardiomiopatias pediátricas, 2023; ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025.

Limites documentados: Registro 22 é sinônimo; operabilidade/intervenção dependem de anatomia e resistência pulmonar.

21. Crise Hipertensiva na Infância

Diagnóstico e urgência. Confirmar pressão manual com manguito correto, sem atrasar estabilização quando houver encefalopatia, convulsão, edema pulmonar, isquemia ou injúria renal. Avaliar ABCDE, neurologia, perfusão e fundo de olho; colher eletrólitos/creatinina, urina, ECG e exames dirigidos. Lesão aguda de órgão define emergência, mais do que um corte numérico isolado. Investigar causas renais, coarctação, drogas e catecolaminas.

Tratamento em UTI. Usar agente IV titulável e pressão invasiva quando disponível. **Nicardipina 0,5–1 mcg/kg/min**, titular em intervalos de 15–30 min; o protocolo de Alberta usa faixa até 4–5 mcg/kg/min. Para solução final comprovada de **0,1 mg/mL = 100 mcg/mL**, velocidade = **0,6 × dose em mcg/kg/min × peso** mL/h. Exemplo 16 kg a 1 mcg/kg/min: 9,6 mL/h; reverso 9,6 × 100 /(60 × 16) = 1. Não é indicação de usar ampola não conferida nem comprovação de disponibilidade brasileira.

Alternativa. Labetalol pode iniciar em 0,25 mg/kg/h, titulando até 3 mg/kg/h, evitando asma/broncoespasmo, bloqueio e insuficiência cardíaca descompensada. Não combinar rotineiramente ambos. Reduzir pressão progressivamente, sem normalização abrupta; a velocidade depende de duração da hipertensão e perfusão, com avaliação neurológica repetida. Na ausência de lesão de órgão, preferir redução oral monitorada. Não usar nifedipina sublingual como atalho.

Validação. A conversão acima é matemática; preparo da apresentação de nicardipina e teto absoluto institucional ainda precisam estar explicitados antes de implantação assistencial.

Fontes verificáveis: Alberta Children’s Hospital — Emergências hipertensivas, 2023; RCH — Hipertensão pediátrica.

Limites documentados: Nicardipina: apresentação brasileira e preparo a partir da ampola não confirmados; concentração final 0,1 mg/mL é referência estrangeira.

22. Defeitos do Septo Ventricular (DSV)

Correspondência do inventário. “Defeitos do Septo Ventricular (DSV)” corresponde a comunicação interventricular. O conteúdo terapêutico principal está no **tema 20**, evitando repetir doses como se fossem duas doenças independentes. Para cada paciente, registrar a localização do defeito, o gradiente, a direção do shunt e lesões associadas.

Aplicação. DSV pequeno e restritivo, sem repercussão, segue vigilância clínica/ecocardiográfica. DSV amplo com hiperfluxo utiliza suporte nutricional e controle de congestão enquanto se define fechamento; não há indicação automática de medicamento apenas pelo título. Dispneia, sudorese alimentar, baixo ganho ponderal e hepatomegalia são gatilhos para antecipar avaliação. Hipertensão pulmonar importante, prolapso aórtico, insuficiência aórtica ou endocardite anterior modificam risco e planejamento.

Limite de equivalência. Este vínculo não presume que todas as páginas de origem tivessem exatamente o mesmo texto; consolida somente o diagnóstico e sua abordagem original. Se o DSV integrar uma cardiopatia complexa — dupla via de saída, tronco arterial ou Fallot — deve prevalecer o tema anatômico correspondente. Fechar um DSV que participa de uma circulação complexa não equivale a fechar uma CIV isolada.

Checagem. Não foram geradas duas prescrições independentes nem duplicadas doses. Os dois identificadores do inventário permanecem disponíveis para busca e para comprovar cobertura.

Fontes verificáveis: ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025.

Limites documentados: Duplicata semântica de CIV; uso em cardiopatias complexas exige capítulo anatômico específico.

23. Doença de Kawasaki

Reconhecimento. Considerar Kawasaki em febre persistente com conjuntivite bilateral não purulenta, alterações orais, extremidades, exantema e linfonodomegalia; formas incompletas são especialmente relevantes no lactente. Solicitar hemograma, PCR/VHS, albumina, função hepática/renal, urina, ECG e ecocardiografia. Ecocardiograma inicial normal não exclui doença. Choque, miocardite e aneurisma requerem centro especializado.

Tratamento inicial. Imunoglobulina IV 2 g/kg, dose única, habitualmente em 8–12 horas, com aumento gradual de velocidade conforme produto e tolerância. Volume = 2000 × peso / concentração em mg/mL. Exemplo exclusivamente para produto confirmado de 100 mg/mL: 20 mL/kg, e média aritmética em 10 h = 2 mL/kg/h; essa média **não substitui a rampa de infusão da bula**. Investigar risco renal, hemólise e sobrecarga.

Antiagregação. O RCH utiliza **AAS 5 mg/kg VO uma vez ao dia**; estratégias com dose anti-inflamatória inicial permanecem em outras diretrizes. Evitar combinar automaticamente regimes. Prosseguir antiagregação até reavaliação coronária e marcadores, frequentemente 6–8 semanas nos casos sem lesão, por cardiologia. Orientar sobre influenza/varicela e evitar ibuprofeno que pode interferir na ação antiagregante.

Resgate e seguimento. Febre persistente/recrudescentente após imunoglobulina exige reavaliar resistência, infecção e indicação de corticosteroide/segunda linha. Alto risco pode justificar imunomodulação inicial combinada. Aneurisma gigante muda profilaxia antitrombótica; não basta AAS isolado. Programar ecocardiogramas e restrições individualizadas; adiar vacinas vivas conforme intervalo indicado após IVIG.

Fontes verificáveis: RCH — Doença de Kawasaki; AHA/ACC — Kawasaki, atualização 2024.

Limites documentados: Produto de IVIG, rampa, teto e estratégia de resistência precisam de seleção específica.

24. Drenagem Anômala Total de Veias Pulmonares

Emergência anatômica. Na drenagem anômala total, todo o retorno venoso pulmonar chega ao sistema venoso direito e depende de comunicação interatrial. A forma obstruída causa hipoxemia, edema pulmonar e deterioração rápida. Ecocardiograma urgente deve identificar conexão, local de obstrução, comunicação atrial e função ventricular. Radiografia e gasometria apoiam a avaliação, sem retardar transferência para cirurgia.

Estabilização. Monitorizar oxigenação, pressão, lactato e diurese; oferecer suporte ventilatório para trabalho respiratório importante e acidose/hipoxemia. Evitar bolus repetidos de volume diante de edema pulmonar. O objetivo é manter perfusão até desobstrução; vasodilatadores pulmonares não solucionam barreira ao retorno venoso. **PGE1 não é tratamento rotineiro** e pode agravar edema quando aumenta fluxo pulmonar contra uma drenagem obstruída, sobretudo em conexão infradiafragmática. Uma indicação excepcional depende de anatomia e decisão cardiológica.

Definitivo. A correção cirúrgica é necessária; obstrução determina urgência imediata, enquanto casos sem obstrução permitem organização da cirurgia sob vigilância estreita. Septostomia só aborda componente interatrial restritivo e não elimina obstrução venosa pulmonar distal. Diurético pode aliviar congestão em casos selecionados, sem substituir reparo.

Reavaliação e destino. Internação em UTI cardiológica no quadro neonatal sintomático. Após cirurgia, acompanhar gradientes venosos, pressão pulmonar, débito, arritmias e recorrência de estenose. Alta exige alimentação e oxigenação estáveis e plano ecocardiográfico; dispneia crescente, cianose ou baixo ganho ponderal exigem retorno antecipado.

Fontes verificáveis: CHOP — Drenagem pulmonar anômala total; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Preparo farmacológico de resgate depende da hemodinâmica; não há tratamento medicamentoso que corrija obstrução venosa.

25. Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito

Classificação que orienta a conduta. Na dupla via de saída do ventrículo direito, as grandes artérias se originam predominantemente do VD. A posição da CIV e presença de estenose pulmonar definem a fisiologia: hiperfluxo, hipofluxo/cianose ou mistura semelhante à transposição. Ecocardiograma avalia relações ventriculoarteriais, CIV, obstruções, coronárias e função; ressonância/TC ou cateterismo complementam o planejamento quando necessário.

Estabilização. Cianose grave, choque, acidose e desconforto respiratório exigem ambiente intensivo. Se o fluxo pulmonar ou sistêmico for ducto-dependente, usar PGE1 pelo módulo comum. Mistura interatrial inadequada pode exigir septostomia. Em hiperfluxo com congestão, diurético e apoio nutricional são pontes; oxigênio indiscriminado pode acentuar desequilíbrio entre circulação pulmonar e sistêmica. Tratar infecção, anemia e arritmia concomitantes quando presentes.

Reparo. Opções incluem túnel intraventricular do VE para a aorta, operação arterial e reconstruções de saída; anatomias desfavoráveis podem exigir via univentricular. O título “DVSVD” sozinho não permite escolher a operação nem inferir que a CIV deve apenas ser fechada. Descrever a anatomia em cada transferência é mais útil que listar fármacos fixos.

Seguimento. Saturação esperada, nutrição, função ventricular, gradientes residuais e arritmias devem ser acompanhados. Alta do neonato sintomático somente com plano cardiológico definido e orientação para retorno por piora de cianose, taquipneia, sudorese alimentar, letargia ou oligúria. O tratamento farmacológico deve ser revisto após cada etapa cirúrgica.

Fontes verificáveis: CHOP — Dupla via de saída do VD; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Necessária anatomia da CIV e das vias de saída para definir tratamento definitivo.

26. Estenose Aórtica em Pediatria

Prioridade. Estenose aórtica crítica neonatal pode manifestar-se como choque ao fechar o canal, mesmo sem sopro exuberante. Na criança maior, síncope ou dor torácica aos esforços e disfunção ventricular são sinais de alto risco. Ecocardiograma deve distinguir obstrução valvar, subvalvar e supravalvar, avaliar ventrículo esquerdo, regurgitação e arco; a estratégia de valvoplastia não é igual para as três localizações.

Neonato crítico. Manter circulação sistêmica com PGE1, conforme módulo comum, enquanto se providencia intervenção. Controlar perfusão, lactato, diurese, glicemia e ventilação. Evitar redução abrupta de pré-carga ou resistência sistêmica em obstrução fixa e baixo débito. Diurético só quando congestão verdadeira e com reavaliação de perfusão. Não usar “tratamento de insuficiência cardíaca” como motivo para adiar alívio da obstrução.

Tratamento definitivo. Estenose valvar importante pode ser abordada por valvoplastia por balão; anatomia desfavorável, insuficiência associada e outras obstruções podem requerer cirurgia/reparo ou substituição. A escolha considera idade, gravidade e consequências de regurgitação após intervenção. Casos leves assintomáticos seguem vigilância, não medicamento obrigatório.

Seguimento e destino. Internar casos críticos, sintomáticos ou com disfunção. Restrição esportiva e retorno ao exercício precisam considerar gradiente, sintomas e teste funcional. Após correção, vigiar reestenose, insuficiência aórtica e dilatação de aorta. Febre persistente, dor, síncope, dispneia ou queda de tolerância ao esforço exigem nova avaliação, mesmo em paciente previamente operado.

Fontes verificáveis: CHOP — Estenose aórtica; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Escolha e limiar de intervenção exigem gradiente/anatomia e avaliação especializada.

27. Estenose de Valva Pulmonar

Avaliação. Confirmar estenose valvar pulmonar e diferenciar obstrução subvalvar/supravalvar. O ecocardiograma quantifica gradiente, morfologia da valva, pressão/função do VD, regurgitação e shunt atrial. Neonato cianótico com obstrução crítica pode depender do canal para perfusão pulmonar; criança com lesão leve pode ser assintomática.

Estabilização. Na dependência ductal, alprostadil segue o módulo comum, com monitorização e transporte cardiológico. Avaliar hipoxemia, acidose e débito antes de fluidos; não tentar corrigir obstrução com broncodilatador ou diurético por rotina. Se houver falência direita congestiva, o diurético é adjuvante cuidadosamente titulado. Arritmia ou síncope exige avaliação urgente e vigilância contínua.

Intervenção. A valvoplastia por balão é opção frequente na estenose valvar relevante; valva muito displásica, obstrução em outro nível ou lesões associadas podem requerer cirurgia. Casos leves permanecem em seguimento. Nenhum esquema medicamentoso isolado normaliza a abertura valvar.

Reavaliação. Após balão, acompanhar regurgitação pulmonar, função/dilatação do VD e gradiente residual; ausência de sintomas não elimina necessidade de acompanhamento. Alta do neonato só após assegurar fluxo pulmonar suficiente sem suporte ductal ou com estratégia definida de transferência. Orientar retorno imediato por cianose nova, síncope, redução da alimentação ou dispneia. Exercício e eventual prevenção de endocardite são individualizados por gravidade e procedimento, evitando antibioticoprofilaxia automática para toda estenose nativa.

Fontes verificáveis: CHOP — Estenose pulmonar; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Limiar de intervenção e escolha balão/cirurgia dependem do ecocardiograma.

28. Estenose Mitral em Pediatria

Definir mecanismo. A estenose mitral pediátrica pode ser congênita ou reumática; anel supramitral e outras lesões esquerdas devem ser pesquisados. Dispneia, congestão pulmonar, baixo crescimento e hipertensão pulmonar indicam repercussão. Ecocardiograma define área/gradiente, aparelho subvalvar, regurgitação concomitante e lesões associadas. ECG e radiografia ajudam a avaliar ritmo e congestão.

Tratamento imediato. Edema pulmonar, hipoxemia, arritmia ou hipoperfusão requerem internação. Diurético reduz congestão, conforme módulo comum, mas diurese excessiva pode reduzir débito. Controlar taquicardia e fatores precipitantes preserva tempo de enchimento; a escolha de medicamento de controle de frequência depende do ritmo e função ventricular. Não aplicar vasodilatador indiscriminadamente como se o mecanismo fosse insuficiência mitral.

Definitivo. Valva reumática com anatomia favorável pode permitir intervenção percutânea; malformações congênitas complexas frequentemente precisam de reparo cirúrgico ou substituição. Congestão persistente e hipertensão pulmonar não devem ser manejadas indefinidamente apenas com aumento de diurético. Se etiologia reumática, estabelecer profilaxia secundária do tema 29. Anticoagulação é condicional a fibrilação atrial, trombo, embolia ou prótese específica; não é obrigatória em todo paciente em ritmo sinusal.

Seguimento. Monitorar capacidade funcional, crescimento, gradiente, pressão pulmonar e ritmo. Reavaliar precocemente após mudança de diurético com eletrólitos/creatinina. Febre prolongada deve motivar investigação de endocardite. O esquema pós-operatório depende da prótese e não pode ser inferido somente pelo diagnóstico inicial.

Fontes verificáveis: CHOP — Defeitos da valva mitral; AHA — Estenose mitral; SBC — Valvopatias, atualização 2020.

Limites documentados: Regime de frequência/anticoagulação exige ritmo, mecanismo e dispositivo; não prescrito universalmente.

29. Febre Reumática em Pediatria

Confirmação e destino. Aplicar critérios de Jones ajustados ao risco epidemiológico, documentando infecção estreptocócica prévia quando necessária. Solicitar ECG, ecocardiograma inclusive para cardite subclínica, marcadores inflamatórios e investigação estreptocócica. Coreia e cardite indolente têm particularidades diagnósticas. Internar por insuficiência cardíaca, arritmia, cardite importante ou impossibilidade de manejo oral.

Erradicação e prevenção. Penicilina G benzatina IM é o tratamento principal para erradicação e profilaxia. A diretriz pediátrica brasileira de 2009 usa **600.000 UI se peso <20 kg e 1.200.000 UI a partir de 20 kg**, repetindo a cada **21 dias** na profilaxia secundária. A atualização brasileira de valvopatias 2020 emprega limite de 25 kg e intensificação para 15 dias nos dois primeiros anos em sua estratégia; documentar qual diretriz será adotada, sem misturar faixas. Nunca administrar IV. Volume depende da concentração após reconstituição do fabricante; não converter “frasco” em mL sem essa informação.

Inflamação e sequelas. AINE trata artrite; glicocorticoide pode ser escolhido em cardite grave, sem eliminar necessidade de tratamento da insuficiência cardíaca. Coreia incapacitante exige terapêutica neurológica específica. A duração da profilaxia é definida pela presença e persistência de cardite/valvopatia e tempo desde último surto, não por um curso fixo curto.

Segurança. Verificar alergia imediata verdadeira e disponibilidade de atendimento à anafilaxia antes da aplicação. Alta deve incluir calendário de doses, rastreio de faltas e seguimento ecocardiográfico. Dor articular recorrente ou faringite não autoriza suspender profilaxia programada.

Fontes verificáveis: SBC/SBP/SBR — Diretriz brasileira de febre reumática; SBC — Valvopatias, atualização 2020.

Limites documentados: Divergência nacional de corte ponderal/intervalo explicitada; anti-inflamatório e duração da profilaxia devem ser estratificados pela cardite.

30. Flutter Atrial na Infância

Diagnóstico. Flutter atrial pode apresentar condução 2:1, simulando taquicardia regular. Registrar ECG de 12 derivações, avaliar duração, cardiopatia/cirurgia prévia, eletrólitos e função ventricular. Adenosina pode revelar atividade atrial por bloqueio AV transitório, mas normalmente não encerra o circuito de flutter; não repetir indefinidamente como se toda taquicardia estreita fosse reentrada nodal.

Instabilidade. Comprometimento de consciência, choque, hipotensão ou insuficiência cardíaca exige **cardioversão sincronizada 0,5–1 J/kg**, aumentando a **2 J/kg** se necessário, conforme PALS 2025. Confirmar marcadores de sincronização antes de cada descarga. Sedação quando viável, sem atrasar cardioversão urgente; disponibilizar manejo de via aérea. Se houver ausência de pulso, abandonar algoritmo sincronizado e seguir parada cardíaca.

Paciente estável. Cardiologia/eletrofisiologia define cardioversão elétrica, estimulação atrial ou estratégia farmacológica conforme idade, duração e anatomia. Avaliar risco de trombo atrial e necessidade de anticoagulação antes de conversão eletiva, particularmente em episódios prolongados ou duração desconhecida. Não extrapolar automaticamente o esquema adulto de anticoagulação ou amiodarona para um neonato.

Após conversão. Documentar ECG, monitorar recorrência e pesquisar função ventricular/tireoidiana quando apropriado. O flutter neonatal isolado e o flutter após cirurgia congênita têm prognóstico e manutenção distintos. Refratariedade, cardiopatia estrutural, baixo débito ou recorrência requerem internação monitorizada. Ablação pode ser estratégia definitiva em pacientes selecionados. O diagnóstico não implica uso crônico obrigatório de antiarrítmico após um único episódio neonatal resolvido.

Fontes verificáveis: AHA/AAP — Algoritmo de taquiarritmia pediátrica, 2025; RCH — Taquicardia supraventricular.

Limites documentados: Cardioversão elétrica definida; antiarrítmico/anticoagulação eletivos exigem duração, anatomia e ritmo específico.

31. Hipertensão Arterial em Pediatria

Confirmar antes de rotular. Repetir pressão auscultatória com manguito correto e interpretar por idade, sexo e altura até 13 anos; a partir de 13 anos aplicam-se cortes de adolescente. MAPA ajuda a diferenciar hipertensão sustentada, mascarada e avental branco. Dor, ansiedade e técnica inadequada podem elevar uma medida sem estabelecer diagnóstico.

Investigação dirigida. Criança pequena, hipertensão importante, alterações urinárias ou sinais sistêmicos aumentam suspeita de causa secundária. Solicitar urina, eletrólitos/creatinina, perfil metabólico quando pertinente e ultrassom renal conforme faixa/achados. Examinar pulsos femorais e pressão em membros. Ecocardiografia avalia repercussão quando se planeja fármaco ou houver suspeita cardíaca. Sinais de lesão aguda de órgão seguem imediatamente o tema 21.

Tratamento. Alimentação com menor excesso de sódio, atividade física adaptada, sono e manejo de excesso de peso devem ser combinados com metas mensuráveis. Fármaco é indicado em sintomas, hipertensão estágio 2 sem fator reversível, doença renal/diabetes ou persistência apesar de medidas não farmacológicas. Uma opção é **amlodipino 0,05–0,1 mg/kg VO uma vez ao dia inicialmente**, titular pela resposta; o protocolo pediátrico de Alberta limita a **10 mg/dia**. Crianças com proteinúria frequentemente se beneficiam de bloqueio renina-angiotensina, com potássio/creatinina monitorados; evitar na gestação e estenose bilateral de artérias renais.

Seguimento. Reavaliar pressão, adesão, edema, tontura, crescimento e causa. A dose em mL requer concentração manipulada/comercial comprovada, sem supor solução brasileira padrão. Tratamento crônico busca controle consistente; urgência assintomática não exige normalização instantânea.

Fontes verificáveis: RCH — Hipertensão pediátrica; Alberta Children’s Hospital — Emergências hipertensivas, 2023.

Limites documentados: Concentração oral de amlodipino e titulação máxima ponderal não fixadas; teto absoluto da referência é 10 mg/dia.

32. Hipertensão Pulmonar Idiopática em Pediatria

Classificação e gravidade. Hipertensão arterial pulmonar idiopática é diagnóstico de exclusão. Ecocardiograma sugere pressão/repercussão direita, mas cateterismo em centro experiente define hemodinâmica e resposta vasorreativa quando seguro. Excluir doença cardíaca esquerda, pulmonar, tromboembólica e shunts. Síncope, dor torácica, falência direita ou hipoxemia progressiva indicam alto risco.

Tratamento específico. Estratégia pode combinar inibidor de PDE5, antagonista de endotelina e via prostaciclina conforme risco; doença avançada frequentemente necessita terapia parenteral, não apenas comprimido. Para **sildenafila**, a bula norte-americana atual inclui 1–17 anos: **≤20 kg: 10 mg VO três vezes/dia; >20–45 kg: 20 mg três vezes/dia; >45 kg: 20 mg três vezes/dia inicialmente**. A suspensão ali descrita é **10 mg/mL**, correspondendo a 1 ou 2 mL/dose. São informação regulatória estrangeira e referência de cálculo, **não confirmação de registro/disponibilidade dessa suspensão no Brasil**. Não extrapolar doses altas do adulto ou para menores de um ano.

Segurança. Não associar a nitratos ou riociguate; vigiar hipotensão e interações CYP3A. Antes de vasodilatar, excluir doença veno-oclusiva ou hipertensão por doença esquerda, em que pode ocorrer edema pulmonar. Tratar congestão com cautela e hipoxemia quando presentes.

Seguimento e crise. Avaliar classe funcional, crescimento, BNP, VD e capacidade de esforço. Crise com falência direita requer UTI, manutenção de perfusão coronariana e suporte respiratório sem interrupção abrupta de prostaciclina. Indicação de transplante/derivações depende de refratariedade e centro especializado.

Fontes verificáveis: FDA/DailyMed — Sildenafila suspensão, 2026; CPS — Óxido nítrico inalatório neonatal, 2023.

Limites documentados: Estratégias combinadas, prostaciclinas e formulação brasileira de sildenafila não estão integralmente operacionalizadas.

33. Hipertensão Pulmonar no Recém-nascido

Reconhecimento. Hipoxemia lábil com shunt direito–esquerdo e diferença pré/pós-ductal sugere hipertensão pulmonar persistente, mas cardiopatia congênita crítica deve ser excluída. Ecocardiograma avalia anatomia, pressão pulmonar, função de VD/VE e direção dos shunts. Investigar aspiração de mecônio, pneumonia/sepse, doença parenquimatosa e hipoplasia pulmonar.

Estabilização. Garantir recrutamento pulmonar sem hiperinsuflação, oxigenação adequada, temperatura, glicemia, cálcio, sedoanalgesia e perfusão sistêmica. Corrigir acidose pela causa, evitando hiperventilação/alcalinização agressivas. Surfactante é condicionado à doença pulmonar. Monitorar saturação pré-ductal, gasometria e índice de oxigenação; não perseguir hiperóxia como objetivo permanente.

Óxido nítrico inalatório. Em recém-nascido a termo ou próximo do termo com insuficiência hipóxica apesar de ventilação otimizada e hipertensão pulmonar confirmada, iniciar **20 ppm**. Esperar resposta em cerca de 30 min; pode haver tentativa até **40 ppm**, retirando se ineficaz. O desmame deve ser progressivo para evitar rebote. Monitorar NO2, metemoglobina, oxigenação e hemodinâmica. **ppm é concentração no gás, não mL/h de bomba IV.** Uso rotineiro em prematuros não é recomendado; resgate selecionado exige avaliação específica.

Falha e destino. Disfunção do VE ou retorno venoso obstruído pode piorar com vasodilatação. Reavaliar diagnóstico antes de acrescentar sildenafila/milrinona. Hipoxemia refratária/instabilidade exige centro com ECMO quando elegível. Todos os casos relevantes permanecem em UTI neonatal, com seguimento auditivo e neurodesenvolvimento.

Fontes verificáveis: CPS — Óxido nítrico inalatório neonatal, 2023; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Resgates IV/VO além de iNO dependem de função ventricular e não foram convertidos em esquema universal.

34. Infarto Agudo do Miocárdio na Pediatria

Emergência. Infarto pediátrico exige considerar aneurisma/trombose de Kawasaki, anomalia coronária, cirurgia prévia, trombofilia, trauma e drogas; aterosclerose adulta não é o pressuposto. Crianças pequenas podem apresentar irritabilidade, vômitos, sudorese ou choque sem dor típica. ECG seriado, troponina, ecocardiograma e imagem coronária devem ser obtidos rapidamente, com cardiologia intervencionista/UTI. Troponina elevada isolada também ocorre em miocardite e não prova oclusão coronária.

Estabilização e reperfusão. ABCDE, monitor/desfibrilador, acesso vascular, correção de hipoxemia e arritmias; avaliar congestão e perfusão antes de volume. Na trombose coronária confirmada ou altamente provável, discutir reperfusão imediata por cateterismo e antitrombóticos; trombólise pode ser alternativa quando intervenção não é viável e após avaliação rigorosa de sangramento. A evidência pediátrica é limitada e depende da causa. Não importar automaticamente carga de AAS, clopidogrel, heparina ou alteplase de protocolo adulto para lactentes.

Tratamento causal. Anomalia de origem coronária pode exigir cirurgia e não trombólise; trombo em aneurisma exige estratégia antitrombótica continuada e avaliação de isquemia residual. Suporte circulatório mecânico pode ser necessário no choque refratário. Preservar possibilidade de transferência precoce antes de deterioração multiorgânica.

Seguimento. Após reperfusão, acompanhar função ventricular, trombo mural, arritmia, sangramento e extensão da lesão. Reabilitação e retorno ao exercício são individualizados. Este tema define o percurso urgente e a necessidade de terapia causal; doses de trombólise pediátrica não foram declaradas universalmente validadas.

Fontes verificáveis: JCS/JSCS — Sequelas cardiovasculares de Kawasaki, 2020; AHA/ACC — Kawasaki, atualização 2024.

Limites documentados: Regime de reperfusão/anticoagulação depende da etiologia e não possui protocolo pediátrico único validado aqui.

35. Insuficiência Cardíaca em Pediatria

Fenótipo à beira-leito. Classificar congestão e perfusão: criança fria, oligúrica, acidótica ou com alteração mental tem baixo débito, mesmo com pressão ainda normal. Hepatomegalia e sudorese alimentar podem preceder edema periférico. ECG, ecocardiografia, eletrólitos, creatinina, função hepática, lactato e biomarcadores complementam a avaliação. Excluir obstrução ducto-dependente, arritmia e causas reversíveis.

Congestão. Furosemida IV inicial 1 mg/kg, administrada lentamente; na referência de solução **10 mg/mL, volume 0,1 mL/kg**. A repetição depende de diurese, pressão e eletrólitos, não de intervalo automático para todo neonato. A bula americana admite escalonamento em incrementos de 1 mg/kg com pelo menos duas horas de intervalo e não recomenda doses superiores a 6 mg/kg; esses limites não são objetivo inicial nem se transferem ao prematuro, cuja depuração é menor. Anúria é contraindicação. Confirmar apresentação brasileira antes de dispensar.

Baixo débito. Milrinona é opção quando há pressão/perfusão suficientemente sustentadas, conforme módulo comum; pode causar hipotensão e acumular na disfunção renal. Choque requer escolha vasoativa individual e centro com suporte mecânico. Não atrasar ECMO/assistência ventricular por escalonamento interminável de fármacos.

Após estabilização. Introduzir tratamento crônico dirigido à anatomia e fração de ejeção, com ajuste renal e titulação lenta; não aplicar evidência de VE sistêmico automaticamente a ventrículo único. Metas incluem melhora de perfusão/diurese, descongestão, alimentação e crescimento. Alta exige esquema oral tolerado, plano de peso/retorno e seguimento precoce; risco de arritmia ou suporte IV exige internação.

Fontes verificáveis: ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025; FDA/DailyMed — Furosemida injetável, 2025; Bula regulatória britânica — Milrinona 1 mg/mL; Bula regulatória britânica — Aqumeldi pediátrico; IWK — Carvedilol pediátrico; IWK — Espironolactona pediátrica.

Limites documentados: Regimes de suporte e de manutenção são alternativas condicionadas à hemodinâmica; preparos estrangeiros não comprovam comercialização brasileira.

36. Insuficiência Mitral em Pediatria

Definir a causa. Insuficiência mitral pode ser congênita, reumática, infecciosa ou secundária à dilatação ventricular. Na forma aguda, edema pulmonar e baixo débito podem ocorrer antes de grande dilatação atrial. Ecocardiograma avalia mecanismo, gravidade, função ventricular, pressão pulmonar e vegetação/ruptura quando suspeitas. Febre, fenômenos embólicos ou nova regurgitação exigem investigação de endocardite, com culturas antes de antibiótico se isso não atrasar tratamento de sepse.

Tratamento da repercussão. Congestão é tratada com diurético conforme tema 35, monitorando pressão, diurese e função renal. Redução de pós-carga pode ajudar em situações selecionadas com pressão preservada, sobretudo regurgitação funcional; não corrige ruptura ou malformação valvar. No choque, suporte intensivo e avaliação cirúrgica são prioritários. Evitar assumir que um sopro intenso corresponde à maior gravidade, pois baixo débito pode reduzir intensidade.

Definitivo e alternativas. Reparo é preferido quando durável; substituição depende de anatomia e possibilidade de preservar crescimento. Etiologia reumática requer profilaxia secundária do tema 29. Anticoagulação não é padrão para toda insuficiência mitral; depende de prótese, fibrilação atrial, trombo ou embolia. O esquema pós-prótese precisa documentar tipo e alvo específico.

Seguimento. Acompanhar sintomas, crescimento, dimensões/função ventricular, pressão pulmonar e ritmo, mesmo quando a criança relata melhora com diurético. Piora de dispneia, hemoptise, síncope, febre persistente ou oligúria requer avaliação hospitalar. Decisão cirúrgica deve ocorrer antes de disfunção irreversível, com análise especializada.

Fontes verificáveis: CHOP — Defeitos da valva mitral; SBC — Valvopatias, atualização 2020; FDA/DailyMed — Furosemida injetável, 2025.

Limites documentados: Terapia pós-prótese e redução de pós-carga dependem do mecanismo; sem receita única.

37. Miocardite em Pediatria

Suspeitar e estratificar. Taquicardia desproporcional, dor torácica, hepatomegalia, intolerância alimentar, síncope ou arritmia após quadro infeccioso podem indicar miocardite. ECG e troponina normais não a excluem. Solicitar ecocardiograma, biomarcadores, eletrólitos, função renal/hepática e lactato; ressonância ajuda quando estabilidade permite. Biópsia é reservada às situações em que diagnóstico histológico modifica conduta e risco é justificável.

Estabilização. Internar com monitorização; UTI se baixo débito, disfunção grave, bloqueio ou arritmia ventricular. Evitar grandes expansões sem avaliação de congestão. Diurético e suporte inotrópico/vasoativo são escolhidos por hemodinâmica, usando o tema 35 e módulo comum. Uma criança com choque fulminante pode necessitar ECMO/assistência ventricular e transferência precoce. Tratar causa infecciosa ou tóxica específica quando identificada.

Imunoterapia. Corticoide e IVIG são usados em alguns centros, mas não devem ser apresentados como eficazes para toda miocardite viral pediátrica. Etiologias imunomediadas, células gigantes, eosinofílica e outras situações podem justificar imunossupressão dirigida; amostra/etiologia e risco infeccioso importam. A melhora espontânea não comprova resposta ao fármaco.

Seguimento. Reavaliar função ventricular e arritmias; definir restrição e retorno gradual à atividade após recuperação e avaliação cardiológica. Dor persistente, palpitação, síncope ou piora respiratória exigem retorno. A normalização de troponina não equivale à liberação esportiva. Medicamentos crônicos de insuficiência cardíaca e sua retirada seguem recuperação e não prazo fixo arbitrário.

Fontes verificáveis: AHA — Miocardite pediátrica, 2021; ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025.

Limites documentados: Não há suporte suficiente para esquema universal de IVIG/corticoide; tratamento etiológico precisa de definição.

38. Persistência do Canal Arterial

Separar populações. Canal patente no prematuro não é igual ao canal que sustenta cardiopatia ducto-dependente. Antes de tentar fechamento, documentar anatomia e repercussão por ecocardiograma. Sopro isolado ou apenas tamanho do canal não obrigam tratamento. Avaliar suporte respiratório, hiperfluxo, função renal, sangramento, enterocolite e perfusão sistêmica.

Prematuro com repercussão. Manejo conservador monitorizado é opção, sobretudo nas primeiras semanas de evolução estável. Quando se decide fechamento farmacológico, **ibuprofeno 10 mg/kg na primeira dose, seguido de 5 mg/kg após 24 h e 5 mg/kg após 48 h**, VO ou IV conforme apresentação/protocolo neonatal, é esquema padrão. Não usar suspensão pediátrica oral na via venosa. Confirmar concentração e excipientes; apresentação IV brasileira e reconstituição não foram verificadas aqui. Evitar na injúria renal importante, sangramento ativo, trombocitopenia significativa ou enterocolite. Monitorar diurese, creatinina e plaquetas.

Alternativas. Paracetamol pode ser considerado quando AINE não é apropriado, mas escolha de via/dose neonatal precisa de ficha específica. Persistência sintomática após tratamento, contraindicações ou anatomia adequada podem levar ao fechamento percutâneo/cirúrgico. Em criança maior com shunt relevante, fechamento intervencionista costuma ser a estratégia, não ciclos de ibuprofeno neonatal.

Reavaliação. Ecocardiograma confirma resposta antes de novo ciclo; ausência de sopro não comprova fechamento. Doses altas têm dados em subgrupos, sem autorização para escalada automática em prematuros extremos. Não suspender PGE1 nem fechar o canal quando ele é necessário à circulação sistêmica/pulmonar.

Fontes verificáveis: CPS — Canal arterial do prematuro, 2022; ANMF — Alprostadil, 2025.

Limites documentados: Apresentação IV/preparo e regime alternativo de paracetamol neonatal não consolidados.

39. Síndrome do QT Longo Pediátrico

Avaliação. Medir QT manualmente, confirmar correção apropriada à frequência e revisar ECGs prévios, síncope, convulsões inexplicadas, história familiar e medicamentos. Corrigir potássio, magnésio e cálcio; pesquisar bradicardia, doença sistêmica e causas adquiridas antes de atribuir tudo a canalopatia genética. QTc persistentemente muito prolongado e sintomas justificam monitorização e eletrofisiologia.

Evento agudo. Torsades sustentada com instabilidade exige terapia elétrica imediata; se sem pulso, seguir desfibrilação/RCP. **Sulfato de magnésio 50 mg/kg IV, máximo 2 g**, é dose de referência do percurso pediátrico CHOP para arritmia instável. A velocidade e concentração dependem de pulso/perfusão e preparo confirmado; não usar automaticamente ampola de 50% sem diluição. Suspender drogas que prolongam QT e corrigir fatores precipitantes. Repetição/infusão e aumento de frequência por estimulação são decisões intensivas, especialmente em recorrência.

Prevenção. Na síndrome congênita, especialistas propõem metas de **nadolol 1–1,5 mg/kg/dia VO**, ou **propranolol 2–3 mg/kg/dia VO**, este dividido em três tomadas na formulação de liberação imediata. Iniciar abaixo da meta e titular por frequência, sintomas, exercício e tolerância; nadolol exige ajuste renal e validação da formulação. Esses alvos não são bolus de emergência nem tetos universais. Ele não deve ser substituído por metoprolol apenas por conveniência sem discussão do genótipo/risco. CDI, denervação simpática e terapia específica são condicionais a alto risco, parada prévia ou eventos apesar de tratamento.

Seguimento. Aconselhar sobre fármacos proibidos, gatilhos específicos e rastreio familiar. Natação/exercício exigem plano individual e adesão; evitar suspensão abrupta do betabloqueador. Alta após síncope só quando risco e acompanhamento estiverem definidos, e não apenas porque ECG isolado normalizou.

Fontes verificáveis: GeneReviews — Síndrome do QT longo; CHOP — QT prolongado e prevenção de torsades; Especialistas — Tratamento da síndrome do QT longo, 2021.

Limites documentados: Tempo/diluição do magnésio de resgate e ajuste renal do nadolol devem constar na ficha hospitalar selecionada; não se aplicou regra adulta automaticamente.

40. Taquicardia Supraventricular na Pediatria

Avaliar estabilidade. Taquicardia regular de início abrupto com frequência pouco variável sugere TSV; diferenciar taquicardia sinusal, flutter e QRS largo. Registrar ECG e monitorar perfusão, consciência e pressão. Instabilidade segue cardioversão sincronizada do tema 30, sem atrasar por acesso difícil ou repetidas manobras.

TSV regular estreita estável. Manobra vagal apropriada à idade: reflexo de mergulho em lactente sob supervisão, ou Valsalva modificada em criança cooperante. Não comprimir globos oculares e não massagear carótida. Se persiste, **adenosina IV/IO 0,1 mg/kg, máximo 6 mg**, em bolus muito rápido seguido imediatamente de flush; segunda dose **0,2 mg/kg, máximo 12 mg**. Registrar tira contínua. Fórmula de volume: dose total / concentração da ampola conferida. Para ampola comprovada de 3 mg/mL, 16 kg corresponde a 1,6 mg = 0,533 mL inicialmente; arredondamento requer seringa adequada e protocolo de diluição/linha, evitando perda no espaço morto.

Exceções. Não usar adenosina para taquicardia irregular de QRS largo ou suspeita de fibrilação atrial pré-excitada. Asma com broncoespasmo e coração transplantado exigem avaliação específica. Adenosina não trata a causa de taquicardia sinusal e pode somente revelar flutter.

Após conversão. Avaliar pré-excitação, função cardíaca quando indicado e recorrência. Lactente, insuficiência cardíaca, recorrência ou necessidade de segunda linha justificam internação. Antiarrítmico crônico/ablação depende de mecanismo e idade. A preparação brasileira de adenosina deve ser confirmada antes de usar a conversão exemplificada.

Fontes verificáveis: AHA/AAP — Algoritmo de taquiarritmia pediátrica, 2025; RCH — Taquicardia supraventricular; IWK — Formulário pediátrico, adenosina 3 mg/mL.

Limites documentados: Adenosina 3 mg/mL verificada em formulário IWK; confirmar ampola e protocolo de linha/diluição utilizado no serviço brasileiro.

41. Tetralogia de Fallot

Reconhecimento. Na tetralogia de Fallot, intensidade de cianose depende da obstrução da saída direita. Crise hipercianótica apresenta cianose acima do basal, hiperpneia, irritabilidade e eventualmente rebaixamento. Dor, choro, desidratação e infecção podem precipitar. Avaliar com pouca manipulação; exames que provoquem agitação podem aguardar estabilização.

Medidas imediatas. Acalmar no colo, posição joelhos ao tórax, oxigênio e monitorização. Obter acesso e avaliar perfusão/hidratação; corrigir hipovolemia quando presente, evitando bolus cegos em cardiopatia complexa. Crise prolongada precisa de equipe de cardiologia/UTI e fármacos que reduzam agitação/espasmo e restaurem resistência sistêmica. O PIER descreve SF 0,9% em alíquotas de **10 mL/kg**, até 20 mL/kg com reavaliação, e **morfina 0,1 mg/kg IV**, monitorando respiração. Se refratária, com cardiologia/UTI: **propranolol 0,1 mg/kg IV lentamente** e/ou **fenilefrina 0,02 mg/kg IV (20 microgramas/kg)**. Não repetir automaticamente; preparar concentração mensurável pela farmácia, acompanhar pressão e bradicardia e ter suporte ventilatório. Ventilação/anestesia podem ser necessárias na refratariedade.

Definitivo. Reparo corrige CIV e obstrução da via de saída; neonato com fluxo pulmonar ducto-dependente pode requerer PGE1 ou paliação antes da correção. Uma crise tratada é motivo para reavaliar antecipação da intervenção, não apenas aumentar medicação indefinidamente.

Após o episódio. Investigar precipitantes e ECG quando tranquilo. Observar até retorno ao basal, sem sedação residual, e discutir destino com cardiologia; crise grave/recorrente exige internação. Ensinar família a reconhecer mudança de cor, colocar joelhos ao tórax e buscar socorro. Após reparo, vigiar regurgitação pulmonar, função do VD e arritmias ao longo da vida.

Fontes verificáveis: RCH — Crises hipercianóticas, 2023; ANMF — Alprostadil, 2025; PIER — Crise hipercianótica, 2025.

Limites documentados: Resgate IV requer monitorização intensiva, diluição institucional e reavaliação; o algoritmo não estabelece teto universal para todas as idades.

42. Tronco Arterioso

Fisiologia e diagnóstico. Tronco arterial comum associa uma única saída arterial, CIV e mistura sanguínea. A queda da resistência pulmonar após o nascimento favorece hiperfluxo e insuficiência cardíaca; saturação relativamente alta não garante perfusão sistêmica adequada. Ecocardiograma avalia ramos pulmonares, valva truncal, coronárias, arco e função ventricular; pesquisar anomalias associadas, inclusive 22q11.2 quando pertinente.

Estabilização. Taquipneia, hepatomegalia, sudorese alimentar, baixo ganho ponderal e baixo débito exigem centro cardiológico. Tratar congestão com diurético e apoio nutricional conforme tema 35, evitando desidratação e desequilíbrio eletrolítico. Oxigênio/ventilação são ajustados ao quadro; hiperóxia indiscriminada pode aumentar ainda mais fluxo pulmonar. PGE1 não é rotina no tronco isolado, mas pode ser necessária se houver interrupção do arco/obstrução sistêmica ducto-dependente.

Definitivo. A correção cirúrgica ocorre precocemente e separa a circulação pulmonar da sistêmica, com fechamento da CIV e conexão VD–artérias pulmonares. Medicamentos não substituem a correção, e prolongar tratamento clínico diante de piora aumenta risco de doença vascular pulmonar.

Seguimento. Conduto e valva truncal exigem vigilância por estenose/regurgitação; crescimento pode levar a novas intervenções. Monitorar função de ambos ventrículos, pressão pulmonar e ritmo. Alta após estabilização/intervenção deve incluir alimentação, diurese e sinais de congestão. Febre persistente, redução de tolerância a esforço ou piora respiratória requerem avaliação antecipada, especialmente em portador de material protético.

Fontes verificáveis: CHOP — Tronco arterial; ANMF — Alprostadil, 2025; ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025.

Limites documentados: PGE1 somente se lesão associada ducto-dependente; cirurgia não substituível por prescrição.

43. Ventrículo Único

Primeira decisão. “Ventrículo único” descreve fisiologia, não uma anatomia nem fase terapêutica única. Identificar diagnóstico, etapa — pré-paliação, shunt, Glenn ou Fontan —, função do ventrículo sistêmico, valvas, obstruções e saturação basal. Cianose, choque e congestão têm causas diferentes em cada etapa. Ecocardiografia e histórico operatório são essenciais.

Neonato. Hipofluxo pode exigir PGE1, stent ou shunt; hiperfluxo pode exigir controle do fluxo e diurético. Mistura atrial restritiva é problema mecânico. Não perseguir saturação normal com hiperóxia à custa da perfusão sistêmica; metas precisam ser definidas pelo centro. Monitorar lactato, diurese e alimentação, além da saturação.

Após paliação. Queda súbita de saturação em portador de shunt pode indicar trombose/obstrução e exige atendimento emergencial. Na circulação Fontan, desidratação, arritmia, derrame, resistência pulmonar elevada e falência ventricular/valvar podem reduzir débito; expansão e diurético devem ser guiados por avaliação. Antitrombótico depende da etapa, dispositivo e risco; não usar o mesmo regime para todos. IECA não é uma obrigação automática apenas por haver um ventrículo.

Seguimento. Acompanhar crescimento, neurodesenvolvimento, ritmo, função ventricular e complicações de Fontan, incluindo enteropatia perdedora de proteínas e hepatopatia. Vigilância interetapas requer limites individualizados de peso e saturação e acesso rápido à equipe. Refratariedade demanda discussão de intervenção, assistência/transplante ou cuidado proporcional; medicação isolada não corrige obstrução de circuito.

Fontes verificáveis: CHOP — Ventrículo único; ISHLT — Insuficiência cardíaca pediátrica, 2025.

Limites documentados: Antitrombótico, metas e terapêutica variam pela etapa; ausência de anatomia não autoriza receita única.

44. Ectima na Criança

Avaliação. Ectima é infecção ulcerada mais profunda que impetigo; remover delicadamente crosta amolecida permite identificar a úlcera e colher exsudato quando disponível. Procurar estreptococo e S. aureus, lesões múltiplas, contato doméstico, escabiose e imunossupressão. Dor desproporcional, rápida progressão, instabilidade ou necrose extensa exigem hospital e exclusão de infecção invasiva. Ectima gangrenoso em neutropênico é outra situação, com cobertura urgente para Gram-negativos e avaliação de bacteremia.

Tratamento habitual ambulatorial. Higiene suave, compressa para soltar crostas, cobertura não aderente e antibiótico sistêmico por **7 dias**. Para MSSA/estreptococo, cefalexina **25–50 mg/kg/dia VO**, divididos em 3–4 doses, conforme IDSA; um regime na extremidade superior é **12,5 mg/kg/dose a cada 6 horas**. Dose e teto devem ser compatíveis com a gravidade; não escalar acima de dose adulta estabelecida pelo protocolo local. A suspensão Teuto verificada contém **250 mg/5 mL = 50 mg/mL** após preparo correto: 16 kg ×12,5 =200 mg = **4 mL a cada 6 horas**. Confirmar rótulo e completar água conforme instruções do frasco; concentração não é universal.

Alternativas e controle. Alergia imediata a betalactâmico ou suspeita de MRSA exige cultura e escolha por sensibilidade; clindamicina pode cobrir ambos quando a cepa é sensível, enquanto sulfametoxazol-trimetoprima não deve ser usado isoladamente para cobertura estreptocócica incerta. Pomada isolada não é o tratamento adequado do ectima. Reavaliar em 48–72 horas; ausência de resposta leva a revisar adesão, resistência, abscesso e diagnóstico. Febre, celulite progressiva ou impossibilidade de tratamento oral justificam internação. Higienizar mãos e não compartilhar toalhas; descolonização não é automática no primeiro episódio.

Fontes verificáveis: IDSA — Infecções de pele e partes moles; PCH/ChAMP — Cefalexina pediátrica; Teuto — Cefalexina 250 mg/5 mL, bula profissional.

Limites documentados: Alternativa para MRSA exige microbiologia/localidade; teto deve seguir gravidade e dose adulta do protocolo.

45. Hemangioma Infantil

Quem tratar. Confirmar hemangioma infantil e fase proliferativa. Lesões perioculares, de via aérea, extensas segmentares, ulceradas ou com risco de desfiguração/comprometimento funcional precisam de avaliação precoce; múltiplas lesões podem exigir pesquisa hepática. Hemangioma pequeno de baixo risco pode ser observado, com fotografia e medidas seriadas. Má formação vascular não deve receber automaticamente esse tratamento.

Regime sistêmico selecionado. Propranolol é primeira linha quando há indicação. A ficha europeia do **Hemangiol 3,75 mg/mL de propranolol base** orienta iniciar entre 5 semanas e 5 meses, com **1 mg/kg/dia VO na primeira semana, 2 mg/kg/dia na segunda e 3 mg/kg/dia a partir da terceira**, sempre em duas doses com intervalo mínimo de 9 horas. Duração inicial: **6 meses**, com ajuste mensal pelo peso. Na concentração específica, volumes por dose são 0,1333; 0,2667; e 0,4 mL/kg, respectivamente. A seringa original é graduada em mg de base; não confundir com 4,28 mg/mL de cloridrato nem copiar esses volumes para solução manipulada.

Segurança e resposta. Administrar durante/imediatamente após alimentação; omitir se não se alimentar ou vomitar, sem redose para compensar dose cuspida. Avaliar cardiopatia, frequência, pressão e risco de hipoglicemia antes do início; monitorar após primeira dose e aumento. Broncoespasmo, bloqueio cardíaco e descompensação contraindicam ou exigem mudança de estratégia. Prematuridade exige idade corrigida e avaliação de elegibilidade. Laser/cirurgia são opções selecionadas para complicações ou resíduos; não substituem avaliação de síndrome PHACE em hemangioma facial segmentar grande. Registrar crescimento, ulceração, visão/respiração e rebote após retirada.

Fontes verificáveis: AAP — Hemangioma infantil, 2019; AEMPS — Hemangiol 3,75 mg/mL, ficha técnica.

Limites documentados: Apresentação e esquema volumétrico verificados em bula europeia; não equivalem a confirmação de comercialização brasileira.

46. Tinea Capitis na Criança

Confirmação. Descamação com alopecia, fios quebrados e adenopatia cervical sugerem tinea capitis; colher pelos/escamas para micologia e cultura quando possível. Kerion é forma inflamatória que pode deixar cicatriz: iniciar tratamento sem esperar cultura se o quadro é típico. Não incisar como abscesso sem comprovar coleção bacteriana. Diagnósticos diferenciais incluem alopecia areata, tricotilomania e dermatite seborreica.

Tratamento sistêmico. Antifúngico tópico isolado não alcança o folículo. Griseofulvina é especialmente útil para Microsporum. A monografia PCH selecionada indica, de 4 semanas a 12 anos, **10–20 mg/kg VO uma vez ao dia, máximo 1 g/dia**, durante **6–8 semanas**, com refeição gordurosa/leite para absorção. Em maiores de 12 anos, **500 mg/dia**, podendo alcançar 1 g/dia em infecção grave. A escolha entre dose baixa/alta e prolongamento considera espécie, resposta e preparação: micronizada e ultramicronizada não são intercambiáveis miligrama por miligrama. Não converter comprimido em suspensão doméstica sem validação farmacêutica.

Alternativas e prevenção. Terbinafina é alternativa particularmente útil para Trichophyton, selecionada pela espécie, peso e apresentação; na falha, confirmar diagnóstico e adesão antes de trocar. Xampu antifúngico pode reduzir dispersão de esporos como adjuvante, sem substituir o oral. Não compartilhar pentes, bonés e toalhas; avaliar contatos sintomáticos e animais quando pertinente. Evitar corticosteroide sistêmico de rotina no kerion. Reavaliar em 2–4 semanas e ao fim do curso; tratamento prolongado exige hemograma e função hepática conforme risco. Griseofulvina é contraindicada em hepatopatia grave/porfiria e interage com anticoncepcionais, informação relevante para adolescentes.

Fontes verificáveis: PCH/ChAMP — Griseofulvina pediátrica, 2024; Sociedade Alemã de Dermatologia — Consenso tinea capitis, 2026.

Limites documentados: Dose alternativa de terbinafina e formulação brasileira de griseofulvina dependem de seleção específica; esquema principal definido.

47. Adipsia

Prioridade. Ausência de sede não exclui desidratação grave. Adipsia pode acompanhar lesão hipotalâmica, diabetes insípido ou alteração do estado mental; não constitui indicação isolada de desmopressina. Avaliar sódio, glicose, ureia/creatinina, osmolaridade plasmática e urinária, diurese horária e perdas insensíveis. Hipernatremia importante, letargia, convulsão ou incapacidade de ingestão exige internação. Documentar peso de referência e capacidade de cuidadores para oferta programada.

Correção inicial. Choque requer restauração da circulação com cristaloide isotônico antes de calcular água livre. Quando hipernatremia é crônica ou de duração desconhecida, planejar queda do sódio em geral **não superior a 0,5 mmol/L/h e 10–12 mmol/L/dia**, ajustando ao sódio seriado. A estimativa de déficit usa água corporal total e relação entre sódio atual e alvo; o coeficiente de água corporal depende de idade/composição, portanto não se adota o mesmo para lactente e adolescente. Incluir manutenção, déficit e perdas persistentes, evitando duplicar volumes.

Tratamento continuado. Prescrever água em horários e volume diário explicitamente definidos, com ajuste pelo peso e sódio; “beber conforme sede” falha nesse diagnóstico. Se houver diabetes insípido central confirmado, desmopressina pode reduzir perdas, mas dose/via dependem da resposta e requerem intervalos com diurese livre, pois excesso causa hiponatremia. Não iniciar teste de privação hídrica em criança hipernatrêmica ou instável. Durante correção, reavaliar sódio a cada poucas horas e acompanhar balanço; após alta, estabelecer plano de doença intercurrente, peso e exames, com retorno imediato se vômitos, oligúria, sonolência ou perda rápida de peso.

Fontes verificáveis: RCH — Diabetes insípido; RCH — Hipernatremia.

Limites documentados: Adipsia isolada não define dose de desmopressina nem volume fixo de água; requer sódio, diurese e fisiologia individual.

48. Cetoacidose Diabética em Pediatria

Emergência. Cetoacidose exige hiperglicemia, cetose e acidose; o consenso CPS considera glicose >11 mmol/L, cetonas ≥3 mmol/L e pH <7,3 ou bicarbonato <18 mmol/L. Avaliar consciência, perfusão, eletrólitos, função renal e ECG se alteração de potássio. Glicemia horária, estado neurológico frequente e bioquímica seriada são essenciais.

Fluido e insulina. Iniciar cristaloide isotônico **10–20 mL/kg em 20–30 minutos, máximo 1 L**; choque exige alíquotas adicionais com reavaliação e UTI. Repor déficit/manutenção de forma protocolizada. Insulina regular IV **0,05–0,1 unidade/kg/h**, somente após pelo menos 1 hora de fluido e com **K >3,0 mmol/L**; nunca bolus de insulina. Se K ≤3,0, corrigir primeiro. Acrescentar potássio conforme nível, função renal e diurese; dextrose é adicionada quando glicemia cai, mantendo insulina até resolver cetose/acidose.

Preparo operacional. Protocolo PCH: **50 unidades em volume final 50 mL de NaCl 0,9% = 1 unidade/mL**. Com frasco U-100, isso corresponde a 0,5 mL de insulina + 49,5 mL de diluente. Bomba = dose × peso mL/h. Exemplo 16 kg a 0,05: **0,8 mL/h**; reverso 0,8/16 = 0,05 unidade/kg/h. Preparar/condicionar equipo segundo protocolo de adsorção, com dupla conferência de unidades.

Deterioração neurológica. Suspeitar lesão cerebral; não aguardar tomografia para terapia hiperosmolar. CPS: NaCl 3% **5 mL/kg em 10–15 minutos, máximo 250 mL**, ou manitol **0,5–1 g/kg em 15–20 minutos, máximo 100 g**. Não usar bicarbonato rotineiro. A transição para insulina SC requer resolução metabólica, ingestão e sobreposição apropriada ao produto; queda isolada da glicose não define cura.

Fontes verificáveis: CPS — Cetoacidose diabética pediátrica, 2023; RCH — Cetoacidose diabética; PCH — Cetoacidose diabética e preparo da insulina.

49. Defeitos no Metabolismo da Tirosina

Diferenciar os defeitos. Tirosinemia I, II, III e elevação transitória neonatal não compartilham a mesma medicação. Na suspeita de tipo I, pesquisar **succinilacetona** em sangue/urina, função hepática/coagulação, AFP, glicemia, função tubular renal e confirmar genética/enzimática. Tirosina elevada isoladamente não confirma tipo I. Insuficiência hepática, sangramento, hipoglicemia ou crise neurológica exigem centro metabólico e hepatológico imediatamente.

Tipo I: tratamento específico. Nitisinona associada a dieta restrita em tirosina/fenilalanina, com nutrição metabólica. Bula FDA do Orfadin: iniciar **0,5 mg/kg VO a cada 12 horas**; se succinilacetona permanecer detectável após 4 semanas, pode aumentar para **0,75 mg/kg a cada 12 horas**, com teto **2 mg/kg/dia**, orientado por resposta bioquímica. A suspensão verificada contém **4 mg/mL**: dose inicial = **0,125 mL/kg por tomada**; 16 kg correspondem a 8 mg = 2 mL a cada 12 horas. Essa apresentação estrangeira não comprova disponibilidade nacional.

Monitorização e limites. Ajustar pelo peso, succinilacetona e resposta hepática, não apenas pela tirosina plasmática. Controlar tirosina/fenilalanina, hemograma, função renal/hepática, crescimento e desenvolvimento; sintomas oculares exigem avaliação por possível excesso de tirosina. AFP e imagem hepática permanecem necessários porque o risco de carcinoma não desaparece completamente. Falência hepática ou suspeita de malignidade pode indicar transplante. Nos tipos II/III, dieta é central e nitisinona não deve ser extrapolada automaticamente. Explicar continuidade do tratamento e acesso ao produto; interrupção pode reativar toxicidade metabólica.

Fontes verificáveis: Consenso EUA/Canadá — Tirosinemia I, 2017; GeneReviews — Tirosinemia I, atualização 2025; FDA/DailyMed — Orfadin 4 mg/mL.

Limites documentados: Dose/apresentação descritas para tirosinemia I; outros defeitos requerem diagnóstico enzimático específico.

50. Diabetes Mellitus Tipo 1 em Pediatria

Confirmar e estabilizar. Poliúria, polidipsia, perda de peso e hiperglicemia exigem cetonas e avaliação de acidose; vômitos, desidratação ou respiração profunda encaminham ao protocolo de cetoacidose. Autoanticorpos auxiliam classificação, mas não devem atrasar insulina quando há deficiência evidente. Crianças pequenas, dificuldade de autocuidado ou quadro inicial descompensado precisam de avaliação hospitalar.

Insulinoterapia sem cetoacidose. Um esquema inicial institucional do RCH utiliza dose diária total aproximada de **0,5 unidade/kg/dia aos 1–5 anos; 0,7 aos 5–10; 0,7–1,0 acima de 10 anos**, com definição no limite etário e titulação pela equipe. Regime basal-bolus distribui cerca de **40% da dose total em basal** e o restante em insulina rápida às refeições; necessidades mudam na remissão, puberdade, exercício e doença. Isso é ponto de partida, não teto nem receita fixa. Criança de 20 kg recebendo 0,5 unidade/kg/dia terá total inicial de 10 unidades/dia; 40% = 4 unidades basais, com 6 unidades distribuídas conforme alimentação e glicose. Escolha do análogo e arredondamento dependem da idade e dispositivo.

Segurança e acompanhamento. Prescrever insulina em **unidades**, usando dispositivo compatível com concentração; não orientar seringa comum em mL. Ensinar carboidratos, correção individual, rodízio, armazenamento, hipoglicemia e plano para escola. Monitorização contínua ou capilar deve orientar ajustes; nunca suspender toda insulina basal durante doença/jejum sem plano especializado. Avaliar cetonas se doença ou hiperglicemia persistente, hidratação e sinais de cetoacidose. Revisar crescimento, HbA1c/metas individualizadas, saúde emocional e rastreio de doenças autoimunes. O primeiro retorno deve ser precoce, com contato para ajuste diário na fase de aprendizado.

Fontes verificáveis: ISPAD — Insulinoterapia pediátrica, edição portuguesa; RCH — Diabetes, apresentação inicial.

Limites documentados: Nenhum regime único cobre menores de 1 ano, remissão e puberdade; basal/bolus deve ser individualizado após esquema inicial.

51. Diabetes Mellitus Tipo 2 em Pediatria

Classificação. Obesidade e acantose não excluem DM1. Medir autoanticorpos quando disponíveis, HbA1c, cetonas, função renal/hepática, pressão, lipídios e pesquisar complicações. Cetose/acidose ou estado hiperosmolar exige internação e tratamento agudo, antes de rotular a criança como candidata apenas a comprimidos.

Esquema inicial. Conforme ISPAD 2024, quando clinicamente estável, sem cetose e HbA1c <8,5%, iniciar metformina associada a intervenção familiar em alimentação, atividade e sono. Exemplo de titulação: **500 mg VO uma vez ao dia com refeição**, aumentando em passos de 500 mg conforme tolerância, usualmente semanalmente, até **1.000 mg duas vezes ao dia; máximo 2.000 mg/dia**. Formulação de liberação prolongada tem instruções próprias e não deve ser triturada. Com HbA1c ≥8,5% e sem acidose, acrescentar insulina basal **0,25–0,5 unidade/kg/dia**, titulada à glicose, enquanto introduz metformina. Cetoacidose segue tema 48.

Escalonamento e segurança. Se metas não forem atingidas, considerar GLP-1 ou SGLT2 com idade/indicação aprovadas para o produto, ou intensificar insulina; não assumir aprovação pediátrica de toda a classe. Reavaliar adesão e barreiras antes de acumular fármacos. Metformina exige função renal e suspensão temporária em desidratação importante, hipóxia ou doença aguda relevante; não usar com eGFR <30 mL/min/1,73 m², e início com eGFR 30–45 exige avaliação de restrições da bula. Monitorar sintomas gastrointestinais e B12 no uso continuado. Reavaliar HbA1c aproximadamente trimestralmente; perda de peso involuntária, cetose ou rápida deterioração exigem revisar classificação e insulinopenia, independentemente do IMC.

Fontes verificáveis: ISPAD — Diabetes tipo 2 pediátrico, 2024.

Limites documentados: Agentes adicionais requerem seleção de produto e verificação regulatória brasileira; esquema inicial principal e insulina basal definidos.

52. Feocromocitoma Pediátrico

Suspeita e investigação. Hipertensão persistente/paroxística, cefaleia, palpitação, sudorese e perda de peso sugerem tumor secretor de catecolaminas. Medir metanefrinas plasmáticas livres ou urinárias fracionadas com condições de coleta adequadas; imagem anatômica e funcional são escolhidas após avaliação bioquímica. Não biopsiar massa adrenal suspeita antes de excluir secreção. A elevada proporção hereditária justifica aconselhamento e investigação genética.

Preparo e tratamento. Ressecção é o tratamento potencialmente curativo, precedida de bloqueio alfa e preparação volêmica. O consenso recomenda equipe experiente; séries pediátricas utilizam **fenoxibenzamina inicial 0,2 mg/kg/dia VO**, com titulação gradual conforme pressão sentada/em pé, sintomas e frequência, frequentemente para **0,4–1,2 mg/kg/dia**. Esse intervalo descreve protocolo publicado, não teto universal validado por ensaio pediátrico. Não aplicar dose adulta por comprimido inteiro ao lactente. Preparação costuma precisar de pelo menos 10–14 dias e pode ser mais longa em crianças. Acesso à fenoxibenzamina/apresentação exige verificação local; alfabloqueador seletivo é alternativa conforme equipe.

Evitar dano. Betabloqueio para taquicardia só é introduzido **depois do bloqueio alfa adequado**. Iniciar beta isoladamente pode precipitar crise por vasoconstrição sem oposição. Reposição de sal/volume é individualizada, sobretudo se cardiomiopatia ou insuficiência renal. Crise hipertensiva com lesão de órgão requer UTI e vasodilatação IV titulável, conforme tema 21, até controle e plano cirúrgico. Após retirada, vigiar hipotensão e hipoglicemia. Seguimento bioquímico/imagem deve ser prolongado e ajustado ao genótipo, multifocalidade e risco de recorrência; cirurgia não encerra vigilância.

Fontes verificáveis: Consenso internacional — PPGL pediátrico, 2024; Endocrine Society — PPGL; Série clínica pediátrica — Preparo farmacológico de tumores secretores de catecolaminas, 2026.

Limites documentados: Regime de fenoxibenzamina sustentado por evidência pediátrica limitada; titulação e formulação local exigem plano do centro.

53. Hiperplasia Congênita de Adrenais

Prioridade. A deficiência de 21-hidroxilase pode causar perda de sal, choque, hiponatremia, hipercalemia e hipoglicemia nas primeiras semanas. Genitália típica não exclui a forma clássica em meninos. Coletar 17-OHP, eletrólitos, glicose, cortisol/ACTH e renina quando possível, sem atrasar resgate; choque segue tema 58. Confirmar subtipo, pois nem toda hiperplasia adrenal tem perda de sal.

Manutenção na forma clássica. Hidrocortisona **10–15 mg/m²/dia VO em três doses** é a referência durante crescimento; evitar rotina com glicocorticoides potentes de longa ação. Calcular superfície corporal por fórmula validada e registrar altura/peso. Fludrocortisona **0,05–0,2 mg/dia VO**, em uma ou duas tomadas, quando há deficiência mineralocorticoide. Lactentes podem necessitar **NaCl 1–2 g/dia**, dividido nas mamadas e ajustado por eletrólitos/renina; isso equivale a aproximadamente **17–34 mmol de sódio/dia**, e não a 1–2 g/kg. A concentração da solução salina oral deve constar explicitamente na dispensação.

Monitorização. Acompanhar velocidade de crescimento, peso, pressão, idade óssea, 17-OHP/androstenediona em horário padronizado e renina/eletrólitos. Supressão completa de 17-OHP não é alvo obrigatório e pode indicar excesso de corticoide. Hipertensão e renina suprimida sugerem excesso mineralocorticoide. Em febre/doença significativa, plano de estresse com hidrocortisona; vômitos impedindo absorção exigem resgate IM/IV, não insistência em VO. Não aumentar automaticamente fludrocortisona com cada febre. Família precisa de cartão de emergência, treinamento e doses atualizadas. A forma não clássica assintomática não recebe necessariamente glicocorticoide contínuo; decisão depende de sintomas, crescimento e risco reprodutivo.

Fontes verificáveis: Endocrine Society — Hiperplasia adrenal congênita, 2018; BSPED — Crise adrenal, consenso 2023, texto integral.

54. Hipertireoidismo na Infância

Confirmar a causa. Dosar TSH, T4 livre e T3; TRAb ajuda a confirmar Graves. Distinguir tireoidite, exposição a iodo e hormônio exógeno, nos quais antitireoidiano não tem o mesmo benefício. Taquiarritmia, insuficiência cardíaca, febre alta, alteração neurológica ou sintomas gastrointestinais intensos exigem hospital e avaliação de tempestade tireotóxica.

Graves habitual. Metimazol é a primeira linha: **0,15–0,5 mg/kg/dia VO**, conforme gravidade bioquímica/clínica, geralmente em dose única; referência brasileira limita a **30 mg/dia**. Reduzir progressivamente conforme T4/T3; TSH pode permanecer suprimido e não deve levar isoladamente à escalada precoce. Propiltiouracila é evitada em crianças devido ao risco de hepatotoxicidade grave. Propranolol pode controlar sintomas adrenérgicos enquanto antitireoidiano faz efeito: **1–2 mg/kg/dia VO em 2–3 tomadas**, com avaliação de asma, frequência, pressão e insuficiência cardíaca; retirar quando eutireoidismo controla sintomas, não manter por obrigação.

Segurança e definitivo. Obter hemograma e função hepática basais. Febre ou dor de garganta durante metimazol exige suspensão e hemograma urgente para excluir agranulocitose; icterícia/urina escura exige avaliação hepática. Reavaliar hormônios em cerca de 4 semanas e ajustar conforme resposta. Tratamento geralmente é prolongado, **3 anos ou mais**, com decisão de suspensão guiada por estabilidade e TRAb. Reações graves, falha, grande bócio ou preferência informada podem indicar tireoidectomia ou radioiodo conforme idade, anatomia e contraindicações. Na tempestade, UTI e tratamento multimodal são necessários; iodeto deve vir após tionamida quando indicado, com controle hemodinâmico cuidadoso.

Fontes verificáveis: ETA — Graves pediátrico, 2022; SBP — Hipertireoidismo em Pediatria, 2023.

Limites documentados: Esquema de tempestade tireotóxica não substituído pelo regime ambulatorial; requer protocolo de UTI e causa confirmada.

55. Hipoglicemia Pediátrica

Reconhecimento e amostra crítica. Hipoglicemia com convulsão, rebaixamento ou incapacidade de deglutir requer tratamento imediato. Em criança sem diabetes, o RCH considera relevante glicose <3,0 mmol/L com sintomas ou <2,6 mmol/L independentemente deles; recém-nascidos seguem limiares e metas próprios. Se possível, colher glicose laboratorial, cetonas, insulina/C-peptídeo, cortisol, GH e amostras metabólicas antes de corrigir, sem atrasar glicose por dificuldade de coleta.

Correção. Criança acordada e capaz de deglutir recebe carboidrato rápido por via oral, seguido de alimento de absorção mais sustentada. Quadro grave: **glicose 10% 2 mL/kg IV**, equivalente a **200 mg/kg**, e nova medida em aproximadamente 10–15 minutos, com alimentação/infusão que impeça recorrência. D10 contém **100 mg/mL**; não confundir com 10 mg/mL e não usar D50 concentrada como bolus pediátrico rotineiro. Se não há acesso e especialmente na hipoglicemia por insulina, **glucagon 0,5 mg IM/SC se <25 kg; 1 mg se ≥25 kg**, conforme Health PEI. Reconstituir exatamente pelo kit, posicionar de lado pelo risco de vômito e obter acesso/glicose sem demora. Pode falhar após jejum prolongado/depleção de glicogênio; neonatos exigem protocolo próprio.

Infusão parametrizada. A taxa de oferta de glicose depende da idade e etiologia; depois de selecionada a GIR em mg/kg/min, **mL/h = GIR × peso × 60 / concentração em mg/mL**. Para D10: mL/h = **0,6 × GIR × peso**. Exemplo matemático de GIR prescrita de 4 para 3 kg: **7,2 mL/h**; reverso 7,2 ×100 /(60×3)=4. Ajustar ao controle glicêmico e limite de fluidos; necessidade elevada demanda investigação de hiperinsulinismo e acesso adequado à solução escolhida. Internar casos recorrentes, causa incerta, lactentes ou suspeita metabólica/endócrina; alta só após manutenção da glicemia com ingestão e plano para evitar jejum.

Fontes verificáveis: RCH — Hipoglicemia pediátrica; Queensland — Hipoglicemia inexplicada; Health PEI — Hipoglicemia pediátrica hospitalar.

Limites documentados: GIR é parâmetro de cálculo a titular; o esquema de glucagon por faixas não substitui protocolo neonatal ou produto intranasal.

56. Hipotireoidismo na Infância

Confirmação sem atraso. Triagem neonatal alterada exige TSH/T4 livre séricos e início rápido de levotiroxina quando indicada, idealmente nas primeiras duas semanas de vida; imagem etiológica não deve atrasar reposição. T4 baixo com TSH inadequadamente normal/baixo sugere hipotireoidismo central: avaliar deficiência de cortisol e tratá-la antes de levotiroxina quando presente, para evitar crise adrenal.

Reposição. Hipotireoidismo congênito grave: **levotiroxina 10–15 microgramas/kg VO uma vez ao dia**. Casos leves com T4 normal podem iniciar em faixa menor segundo endocrinologia. Referência regulatória por idade para reposição completa: **3–6 meses, 8–10 microgramas/kg/dia; 6–12 meses, 6–8; 1–5 anos, 5–6; 6–12 anos, 4–5; acima de 12 com crescimento/puberdade incompletos, 2–3; maturidade completa, cerca de 1,6**. Faixas são orientadoras e não substituem titulação; doença antiga grave/cardiopatia pode exigir início mais cauteloso. Não há teto único por título.

Administração e controle. Conferir **microgramas**, não miligramas: 50 microgramas = 0,05 mg. Escolher comprimido/apresentação que permita dose exata; para lactente, triturar e dar imediatamente em pequeno volume de água, sem colocar em mamadeira inteira. Separar de ferro/cálcio, habitualmente por 4 horas, e manter rotina consistente. Repetir T4/TSH em 1–2 semanas após início neonatal e frequentemente até normalizar; depois ajustar ao crescimento. Acompanhar desenvolvimento, audição, ganho ponderal e sinais de excesso. No hipotireoidismo central, T4 livre guia mais que TSH. Hipotireoidismo subclínico adquirido exige avaliar persistência, autoimunidade e sintomas, sem aplicar automaticamente reposição completa.

Fontes verificáveis: ENDO-ERN/ESPE/ESE — Hipotireoidismo congênito, 2020–2021; FDA/DailyMed — Levotiroxina, bula atualizada.

57. Hipovitaminose D em Pediatria

Diagnóstico útil. Interpretar 25-OH-vitamina D segundo risco, contexto clínico e método laboratorial; rastreio indiscriminado de crianças saudáveis não é necessário. Dor óssea, fraturas, baixa ingestão, má absorção, hepatopatia/nefropatia e fármacos alteram a avaliação. Dosar cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, PTH e magnésio quando houver suspeita de doença mineral. Tetania, convulsão ou arritmia por hipocalcemia exige hospital; deficiência sem raquitismo não recebe automaticamente regime de raquitismo.

Reposição sem raquitismo. A atualização SBP reúne mais de um esquema; uma opção descrita para deficiência confirmada entre 0 e 18 anos é **colecalciferol 2.000 UI VO/dia por pelo menos 6 semanas**, seguida de manutenção conforme idade e resposta. Reavaliar necessidade/duração em lactente pequeno, má absorção, obesidade e doença renal; não tratar resultado isolado indefinidamente. Calcitriol não é substituto rotineiro do colecalciferol para deficiência nutricional.

Prevenção e dispensação. SBP 2024: **400 UI/dia no primeiro ano**; após 1 ano até 18 anos, **600–1.200 UI/dia**, individualizando risco. A concentração por gota varia amplamente: para produto confirmado de **400 UI/gota**, 2.000 UI = **5 gotas/dia**; se for 200 UI/gota, são 10. Nunca presumir 20 gotas/mL nem transferir número de gotas entre marcas. **1 microgramа de vitamina D = 40 UI**.

Monitorização. Confirmar todas as fontes para evitar somar suplemento, polivitamínico e fórmula sem intenção. Reavaliar em 6–12 semanas nos casos tratados e acompanhar cálcio/25-OH-D quando indicado. Náusea, poliúria, constipação, fraqueza ou hipercalcemia exigem interromper excesso e investigar toxicidade. Falta de resposta requer revisar adesão, produto e causas de má absorção antes de escalar empiricamente.

Fontes verificáveis: SBP — Hipovitaminose D, atualização 2024; RCH — Deficiência de vitamina D.

58. Insuficiência Adrenal Aguda Infantil (Hospitalar)

Resgate imediato. Suspeitar em choque, vômitos, hipoglicemia, hiponatremia/hipercalemia, hiperpigmentação, doença adrenal conhecida ou retirada de glicocorticoide. Coletar cortisol/ACTH, eletrólitos e glicose se isso não atrasar tratamento. Hidrocortisona e reposição circulatória não aguardam confirmação laboratorial.

Hidrocortisona. BSPED: dose inicial IM/IV por idade **<1 ano: 25 mg; 1–5 anos: 50 mg; ≥6 anos: 100 mg**. Alternativamente, no hospital, crianças com idade corrigida >28 dias: **2 mg/kg IV, máximo 100 mg por dose, inicialmente e a cada 6 horas**; neonatos: **4 mg/kg IV a cada 6 horas** na fase aguda. Selecionar uma estratégia inicial, sem somar idade e peso. Com Solu-Cortef 100 mg/2 mL verificado no RCM português, concentração = **50 mg/mL**: 2 mg/kg correspondem a **0,04 mL/kg** do reconstituído; 16 kg = 32 mg = 0,64 mL. Injetar lentamente e conferir produto/diluente, pois outras apresentações não são equivalentes.

Fluido e glicose. NaCl 0,9% **10 mL/kg IV**, reavaliando e repetindo se necessário para choque; se hipoglicemia, D10 **2 mL/kg IV**. Monitorar pressão, perfusão, sódio, potássio, ECG, diurese e glicemia; correção de hiponatremia deve ser controlada. Hipercalemia com ECG exige tratamento específico adicional. Tratar fator precipitante, inclusive infecção.

Após estabilizar. Reduzir parenteral e passar para VO apenas quando absorção/ingestão forem confiáveis. Retomar manutenção e mineralocorticoide quando indicados; altas doses de hidrocortisona têm ação mineralocorticoide na crise. Alta requer plano de estresse, injeção de emergência disponível e cuidador treinado. Não retirar reposição de doença adrenal permanente.

Fontes verificáveis: BSPED — Crise adrenal, consenso 2023, texto integral; RCH — Crise adrenal; Pfizer — Solu-Cortef 100 mg/2 mL, RCM Portugal, 2024.

Limites documentados: Concentração injetável exemplificada por produto português; confirmar bula do frasco usado no Brasil antes de preparar.

59. Lipidoses

Delimitação. Lipidoses incluem doenças lisossômicas distintas; não se tratam com uma estatina genérica. Hepatoesplenomegalia, citopenias, dor óssea, atraso/regressão, alterações oculares ou neuropatia orientam dosagem enzimática, biomarcadores e genética. Diferenciar Gaucher, Fabry, deficiência de esfingomielinase ácida, Niemann-Pick C e gangliosidoses muda tratamento e aconselhamento. Comprometimento respiratório, neurológico agudo ou sangramento exige avaliação hospitalar.

Exemplo operacional nacional: Gaucher. O PCDT brasileiro 2025 recomenda reposição enzimática inicial **30 unidades/kg/infusão IV a cada 2 semanas** para crianças/adolescentes em crescimento sem doença grave; **60 unidades/kg a cada 2 semanas** para doença grave, com reavaliação e ajuste até dose mínima eficaz. As enzimas contempladas são imiglucerase, alfavelaglicerase e alfataliglicerase; apresentações são, respectivamente, **400 U, 400 U e 200 U**. Alfataliglicerase é indicada no protocolo a partir de 4 anos. Infusão inicial em cerca de **2 horas**, com filtro e supervisão do serviço; reconstituição/volume final seguem a bula da enzima específica. Exemplo 20 kg a 30 U/kg: 600 U; não arredondar para frascos sem justificativa farmacêutica.

Limites e acompanhamento. Reposição melhora manifestações viscerais/hematológicas e ósseas selecionadas, mas não atravessa adequadamente a barreira hematoencefálica e não corrige toda doença neurológica. Outras lipidoses podem ter enzima específica, redução de substrato ou terapia direcionada, conforme diagnóstico e idade; não intercambiar produtos ou aplicar miglustate adulto a qualquer criança. Acompanhar crescimento, função, hemograma, órgãos e resposta objetiva, além de reação à infusão. Incluir fisioterapia, nutrição, analgesia individual e apoio familiar. Ausência de terapia modificadora em um subtipo não elimina cuidado ativo de sintomas e complicações.

Fontes verificáveis: Ministério da Saúde — PCDT Gaucher, 2025.

Limites documentados: Título engloba múltiplas doenças; foi detalhado o regime nacional de Gaucher, sem falsa equivalência farmacológica com demais lipidoses.

60. Osteoporose em Pediatria

Diagnóstico. Em crianças, densidade baixa isolada não basta. Segundo ISCD, fratura vertebral compressiva sem trauma relevante pode estabelecer osteoporose; fora disso, considerar história significativa de fraturas e Z-score ≤−2. História significativa inclui pelo menos duas fraturas de ossos longos até 10 anos ou três até 19. Usar Z-score e corrigir interpretação para tamanho/estatura; não empregar T-score adulto.

Tratar a causa. Rever glicocorticoides, imobilidade, inflamação, doença neuromuscular, nutrição e puberdade. Investigar cálcio/fósforo, fosfatase alcalina, PTH, 25-OH-D e função renal, diferenciando raquitismo. Corrigir deficiências, promover mobilidade segura, exercício adaptado e prevenção de quedas, sem proibir toda atividade. Dor vertebral ou perda de altura exige imagem, mesmo com densitometria pouco alterada.

Bisfosfonato selecionado. Em doença significativa, centro especializado pode indicar ácido zoledrônico IV, frequentemente fora de bula. O protocolo NNUH 2024 usa **>5 anos: 0,05 mg/kg, máximo 4 mg, a cada 6 meses**, reduzindo a primeira infusão à metade (**0,025 mg/kg; máximo 2 mg**). Para 20 kg: 0,5 mg inicialmente e 1 mg nas seguintes. A tabela do protocolo usa 50 mL de SF 0,9%/45 minutos para 0,025 mg/kg e 100 mL/30 minutos para 0,05 mg/kg; conferir volume final, produto e tolerância hídrica. Se preparados em volumes finais de 50 e 100 mL, bombas correspondem a **66,7 e 200 mL/h**. Em 2–5 anos a dose plena é 0,035 mg/kg a cada 4 meses; <2 anos, 0,025 mg/kg a cada 3 meses, também com primeira dose reduzida e supervisão especializada.

Segurança. Verificar cálcio, vitamina D e função renal antes; corrigir hipocalcemia e manter hidratação adequada. Monitorar reação de fase aguda, hipocalcemia/hipofosfatemia e rim; programar controle após primeira infusão conforme risco. Não repetir por calendário sem reavaliar fraturas, dor, crescimento e densidade. A duração e intervalo podem diminuir após estabilização; não há curso vitalício obrigatório.

Fontes verificáveis: ISCD — Posições oficiais pediátricas; NNUH — Bisfosfonatos pediátricos, 2024.

Limites documentados: Regime de centro especializado: primeira dose reduzida, volume final/preparo e função renal devem ser conferidos; não é intercambiável com protocolo de outro centro.

61. Raquitismo

Diferenciar antes de tratar. Raquitismo é falha de mineralização da placa de crescimento; deformidade, atraso motor, dor óssea e alargamento metafisário justificam radiografia e cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, PTH, 25-OH-D e função renal. Separar causa nutricional de perdas renais de fósforo, resistência/deficiência de vitamina D e doença renal. Tetania, convulsão ou arritmia por hipocalcemia requer correção hospitalar imediata; colecalciferol oral não substitui resgate de cálcio.

Raquitismo nutricional. O consenso global e a síntese SBP propõem colecalciferol VO por **12 semanas**: **menores de 1 ano, 2.000 UI/dia; 1–12 anos, 3.000–6.000 UI/dia; maiores de 12 anos, 6.000 UI/dia**, com cálcio **elemental pelo menos 500 mg/dia**, proveniente de dieta e suplemento. Escolher dose dentro da faixa conforme gravidade e seguimento. Para suprir 500 mg elementares exclusivamente com carbonato de cálcio, que contém 40% de cálcio, são **1.250 mg do sal/dia**; não confundir 500 mg do sal com 500 mg de cálcio. Dividir conforme tolerância/apresentação.

Controle. Acompanhar melhora clínica, cálcio/fósforo e queda de PTH/fosfatase; reavaliar radiografia quando pertinente. Após reparação, passar à manutenção do tema 57 e manter ingestão de cálcio adequada à idade. Falha de resposta exige revisar adesão e etiologia, sem repetir megadoses cegamente. Nas formas hipofosfatêmicas, fosfato/calcitriol ou terapia dirigida têm indicações próprias e risco de nefrocalcinose; não aplicar automaticamente o regime nutricional. Rastrear fatores familiares, alimentação e má absorção. Educação sobre concentrações por gota previne intoxicação e facilita completar o curso.

Fontes verificáveis: SBP — Hipovitaminose D, atualização 2024; RCH — Deficiência de vitamina D; Consenso global — Raquitismo nutricional.

Limites documentados: Raquitismo não nutricional exige diagnóstico etiológico; não se extrapolou colecalciferol como tratamento de todas as formas.

62. Síndrome de Beckwith-Wiedemann

Riscos precoces. Macroglossia, defeito de parede abdominal, crescimento excessivo/lateralizado e hipoglicemia sugerem espectro Beckwith–Wiedemann. Avaliar via aérea, alimentação, glicose neonatal e repercussões do defeito abdominal; hiperinsulinismo persistente requer investigação e tratamento específico. A estabilização da glicemia segue tema 55 e não aguarda resultado molecular. Diagnóstico clínico e testes de imprinting/11p15/CDKN1C orientam aconselhamento, lembrando mosaicismo e possíveis testes sanguíneos negativos.

Tratamento das manifestações. Organizar suporte alimentar e avaliação de macroglossia, apneia obstrutiva, discrepância de membros e malformações renais. Cirurgia é selecionada por função e gravidade, não apenas aspecto. Hipoglicemia persistente pode demandar fármaco anti-insulínico ou intervenção no pâncreas, mas não existe prescrição única para toda a síndrome. Vigiar desenvolvimento e encaminhar precocemente dificuldades de fala/deglutição e motoras.

Vigilância tumoral atual. Recomendações variam por país e genótipo. A atualização AACR 2024 favorece, nos grupos elegíveis ao rastreio de hepatoblastoma, **ultrassom abdominal e AFP a cada 3 meses até 3 anos**; depois, **ultrassom renal a cada 3 meses até 7 anos** para risco de Wilms. Essa atualização encurtou a janela de hepatoblastoma antes descrita até 4 anos; registrar qual protocolo está sendo aplicado. Estratégias europeias são mais estratificadas por subtipo molecular e podem não usar AFP universalmente. AFP neonatal precisa de interpretação etária e tendência, não de limite adulto.

Coordenação. Deixar calendário escrito, responsável pelos resultados e conduta para massa abdominal, hematúria ou elevação persistente de AFP. Seguimento inclui genética, pediatria e equipe oncológica de predisposição; rastreio não equivale a diagnóstico de câncer e não justifica medicação antineoplásica preventiva.

Fontes verificáveis: Consenso internacional — Beckwith–Wiedemann, 2018; AACR — Vigilância de Wilms/hepatoblastoma, 2024; GeneReviews — Beckwith–Wiedemann.

Limites documentados: Vigilância difere entre consensos e por subtipo; é necessário selecionar calendário no centro, mantendo atualização 2024 explícita.

63. Síndrome de Insensibilidade Androgênica

Diagnóstico e comunicação. Insensibilidade androgênica é um espectro de alteração de ação do receptor androgênico em pessoas 46, XY. Investigar com equipe multidisciplinar, cariótipo, perfil hormonal, imagem anatômica e genética AR; não presumir que toda diferença genital é AIS. Explicar diagnóstico de modo adequado à idade, preservando privacidade, participação e identidade da pessoa. Forma completa e parcial têm necessidades distintas.

Forma completa. Com gônadas mantidas, geralmente há puberdade espontânea pela aromatização e não se inicia estrógeno de rotina. Gonadectomia e momento da cirurgia exigem decisão compartilhada considerando risco tumoral, localização, vigilância e benefício da produção hormonal; não é automática na infância. Após gonadectomia pré-puberal, Endo-ERN recomenda indução por volta de **11 anos**, com 17-beta-estradiol em doses baixas e escalonamento gradual. Uma opção oral inicial da diretriz é **5 microgramas/kg/dia**, ajustada a cada 3–6 meses conforme desenvolvimento até reposição adulta, habitualmente 1–4 mg/dia conforme produto/resposta. Dose pequena pode exigir preparação farmacêutica validada; não fracionar comprimido sem precisão. Na ausência de útero, progestágeno geralmente não é necessário.

Forma parcial e acompanhamento. Objetivos hormonais dependem de função residual, desenvolvimento puberal, necessidades e identidade; não transferir esquema de forma completa para todas as pessoas. Monitorar crescimento, saúde óssea, hormônios, satisfação e efeitos adversos; acompanhamento psicológico é suporte, não exigência para invalidar decisões. Cirurgias irreversíveis eletivas precisam de discussão individual e participação possível da pessoa. Vigilância de gônadas mantidas deve reconhecer limitações de imagem para lesões precursoras. Após gonadectomia, continuidade da reposição e ingestão de cálcio/vitamina D são importantes para osso, evitando interrupções prolongadas por falhas de transição do cuidado.

Fontes verificáveis: GeneReviews — Insensibilidade androgênica; Endotext — Diferenças do desenvolvimento sexual 46, XY; Endo-ERN — Indução puberal, 2022.

Limites documentados: Esquema hormonal é indução após gonadectomia na forma completa; não constitui regime universal de AIS parcial ou manutenção adulta.

64. Síndrome de Nelson

Definição e vigilância. Síndrome de Nelson corresponde à progressão de tumor corticotrófico após adrenalectomia bilateral por doença de Cushing; hiperpigmentação e ACTH crescente são alertas, mas imagem evolutiva é essencial. Revisar ressonâncias anteriores, campo visual, cefaleia e demais eixos hipofisários. Sintomas visuais ou compressivos exigem avaliação neurocirúrgica rápida. O consenso recomenda RM aproximadamente 3 meses após adrenalectomia e anualmente nos primeiros 3 anos; depois o intervalo é individualizado pelo risco.

Tratamento do tumor. Cirurgia hipofisária é a opção principal quando factível, idealmente antes de grande extensão extraselar. Radioterapia/radiocirurgia pode ser necessária em doença residual, não ressecável ou progressiva. Terapia sistêmica como temozolomida fica reservada a tumor agressivo documentado em centro especializado; não existe dose medicamentosa ambulatorial universal que substitua avaliação de ressecabilidade. Não tentar controlar crescimento tumoral apenas com doses cronicamente excessivas de glicocorticoide.

Reposição indispensável. Após adrenalectomia bilateral, insuficiência adrenal é permanente. Como referência pediátrica de manutenção, hidrocortisona **cerca de 8 mg/m²/dia VO em 3–4 tomadas**, titulada por crescimento, sintomas e contexto, com mineralocorticoide quando indicado; a diretriz de insuficiência adrenal sugere **fludrocortisona inicial 0,1 mg/dia** em crianças, ajustada por pressão, eletrólitos e renina. Doses de crise e estresse estão no tema 58 e não devem ser confundidas com manutenção. Não usar ACTH isolado como alvo de aumento de hidrocortisona.

Seguimento. Monitorar visão, função hipofisária, crescimento/puberdade, saúde óssea e efeitos de cirurgia/radioterapia. Treinar família para vômitos, febre e resgate parenteral; a gestão do tumor não dispensa prevenção de crise adrenal. Documentar transição e calendário de RM/endocrinologia, com revisão antecipada se cefaleia progressiva, mudança visual ou hiperpigmentação acelerada.

Fontes verificáveis: Consenso — Progressão corticotrófica após adrenalectomia, 2021; Endocrine Society — Insuficiência adrenal primária.

Limites documentados: Evidência para Nelson pediátrico é limitada; tratamento antitumoral depende de extensão, histologia e evolução, sem regime universal.

65. Atresia de Vias Biliares em Pediatria

Prioridade. Icterícia persistente, fezes hipocólicas/acólicas e colúria exigem bilirrubina total/direta e avaliação hepatobiliar urgente. Colestase não é manifestação fisiológica do aleitamento. Dosar INR, glicose, albumina, AST/ALT/GGT e realizar ultrassonografia; exame ultrassonográfico sem alterações não encerra a investigação.

Tratamento. A intervenção central é a portoenterostomia de Kasai, realizada precocemente em centro experiente após confirmação anatômica. A avaliação não deve aguardar um teste terapêutico com ursodesoxicólico. Falha da drenagem, hipertensão portal complicada ou insuficiência hepática motivam avaliação para transplante.

Suporte. Garantir aporte energético e crescimento, com estratégia nutricional para má absorção de gordura; acompanhar vitaminas A, D, E e K e corrigir deficiências documentadas. A reposição deve considerar concentração sérica, coagulação, via disponível e intensidade da colestase: uma dose universal de multivitamínico não substitui esse acompanhamento. Antibiótico pós-Kasai não é intercambiável com tratamento de colangite. Febre, piora da icterícia ou acolia após cirurgia exigem culturas e internação para antibiótico IV e avaliação da drenagem.

Reavaliação. Registrar cor das fezes, peso, bilirrubina e INR em seguimento próximo. O inventário de classes do Whitebook não estabelece indicação automática de antiemético, analgésico ou sulfonamida profilática.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NIDDK — tratamento da atresia biliar; NASPGHAN/ESPGHAN — colestase no lactente; NIDDK — nutrição na atresia biliar.

66. Atresia Jejunoileal

Reconhecimento e ABCDE. Vômito bilioso neonatal deve ser considerado obstrução até avaliação cirúrgica. Jejum, sonda oro/nasogástrica para descompressão, aquecimento, acesso IV, glicemia e balanço de perdas precedem a investigação detalhada. Avaliar perfusão, diurese e sinais de perfuração; solicitar radiografia abdominal, hemograma, eletrólitos e gasometria conforme apresentação.

Tratamento definitivo. Exploração, ressecção do segmento inviável e reconstrução intestinal são individualizadas pela anatomia, extensão e condições do neonato; múltiplas atresias podem exigir estratégia em etapas. Não há medicação capaz de corrigir a interrupção intestinal. Peritonite, instabilidade ou pneumoperitônio tornam o controle cirúrgico imediato após ressuscitação uma prioridade.

Suporte e medicamentos. Usar manutenção neonatal e reposição medida das perdas digestivas; a prescrição de líquidos deve descontar volumes de medicamentos e nutrição parenteral. Analgesia pós-operatória monitorizada exige esquema neonatal próprio, preservando idade gestacional/pós-natal, ventilação e função renal. Não reutilizar automaticamente o esquema oral de analgesia de crianças maiores. Alimentação enteral é retomada conforme recuperação cirúrgica; nutrição parenteral e reabilitação intestinal podem ser necessárias.

Destino. Internação em unidade neonatal com cirurgia pediátrica. Acompanhar crescimento, tolerância alimentar, colestase associada à nutrição parenteral e risco de intestino curto; o plano de alta precisa explicitar sinais de obstrução recorrente e perdas excessivas.

Fontes verificadas em 25/09/2026: CHOP — atresia do intestino delgado; CHOP — reparação cirúrgica.

67. Colelitíase e Colecistite em Pediatria

Estratificação. Dor em hipocôndrio direito, febre, Murphy e vômitos sugerem colecistite; icterícia com febre aumenta a preocupação com coledocolitíase/colangite. Colher hemograma, marcadores inflamatórios, bilirrubinas, enzimas hepáticas, lipase e culturas se febril; ultrassonografia é inicial. Sepse, obstrução biliar persistente ou pancreatite exigem internação e avaliação cirúrgica/endoscópica.

Conduta. Colelitíase incidental assintomática não implica antibiótico. Doença sintomática recorrente e colecistite demandam avaliação de colecistectomia e controle do foco. Durante fase aguda: hidratação, analgesia e ajuste de dieta/jejum conforme necessidade de intervenção. Ursodesoxicólico não substitui drenagem em obstrução ou cirurgia indicada.

Infecção intra-abdominal. Como referência empírica hospitalar para criança fora do período neonatal, a UCSF utiliza ceftriaxona associada a metronidazol em infecção comunitária selecionada; resistência, procedimento biliar prévio e choque modificam a escolha. Metronidazol: 10 mg/kg/dose IV de 8/8 h, máximo 500 mg/dose nessa referência. A concentração de 5 mg/mL, se confirmada no produto disponível, resulta em 2 mL/kg/dose antes do teto; o tempo de infusão vem da bula efetivamente usada. Não acrescentar metronidazol rotineiramente a um betalactâmico que já cubra anaeróbios.

Revisão. Reavaliar resposta e culturas em 24–48 h, função renal/hepática e necessidade de desobstrução. Duração é vinculada ao diagnóstico e ao controle do foco; a recomendação de quatro dias para peritonite controlada não deve ser convertida em regra universal de colangite.

Fontes verificadas em 25/09/2026: UCSF — infecções abdominopélvicas; UCSF — infecções abdominais.

68. Colestase em Pediatria

Investigação prioritária. Confirmar hiperbilirrubinemia conjugada e avaliar INR, glicose, albumina e estado neurológico. Em lactentes, excluir atresia biliar rapidamente; investigar obstrução, infecção, medicamentos e causas metabólicas/genéticas. GGT, ultrassonografia e história dirigem exames adicionais.

Tratamento causal e nutricional. Desobstrução quando mecânica e suspensão do agente causal quando medicamentosa. Acompanhar crescimento, ingestão e vitaminas A/D/E/K; corrigir deficiência de acordo com resultados e intensidade da má absorção. Vitamina K pode corrigir coagulopatia carencial; ausência de correção aumenta suspeita de disfunção de síntese. Não adiar avaliação para transplante em doença progressiva.

Prurido refratário — rifampicina. Uso off-label, após avaliação hepatológica e revisão de interações. Estudo pediátrico aberto de 24 crianças com prurido persistente apesar de outras medidas utilizou 10 mg/kg/dia VO divididos em duas tomadas, isto é, 5 mg/kg/dose de 12/12 h. Esse esquema estudado não define dose máxima universal nem duração fixa. Avaliar alívio, sono, enzimas hepáticas, bilirrubina e hemograma; suspender/reavaliar diante de toxicidade ou ausência de benefício. A indução enzimática pode reduzir efeito de outros fármacos.

Apresentação e cálculo. Anvisa documentou suspensão oral 20 mg/mL; confirmar disponibilidade e produto dispensado. Em 16 kg: 80 mg/dose = 4 mL de 12/12 h; reversa 4×20×2/16 = 10 mg/kg/dia. Não substituir por combinação antituberculose. Para Alagille com prurido, ver tema 86.

Destino. Hipoglicemia, sangramento, encefalopatia, febre com obstrução ou piora rápida do INR exigem hospitalização.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NASPGHAN/ESPGHAN — colestase no lactente; Estudo primário pediátrico — rifampicina no prurido refratário; Anvisa — documentação de rifampicina suspensão 20 mg/mL.

69. Constipação Intestinal em Pediatria

Antes de tratar. Procurar atraso da eliminação de mecônio, início neonatal, distensão importante, vômito bilioso, baixo ganho de peso, alteração neurológica/sacral e sangramento inexplicado. Na constipação funcional típica, história e exame costumam bastar; radiografia, investigação tireoidiana e sorologia celíaca não são rotina indiscriminada.

Tratamento. Explicar retenção e escape fecal sem culpabilizar. Programar tempo no vaso após refeições, apoio para os pés, alimentação equilibrada e água adequada. Se impactação: polietilenoglicol (PEG) VO 1–1,5 g/kg/dia por 3–6 dias. Manutenção: iniciar aproximadamente 0,4 g/kg/dia, ajustar para fezes macias sem diarreia; faixa 0,2–0,8 g/kg/dia. A dose é em **gramas de PEG**, não em miligramas nem no peso total do sachê com eletrólitos. Dissolução e volume dependem da formulação; não há concentração líquida universal.

Exemplo matemático. Em 16 kg, manutenção inicial = 6,4 g/dia; reversa 6,4/16 = 0,4 g/kg/dia. Desimpactação = 16–24 g/dia, respeitando tolerância e plano de reavaliação. Não usar essa estratégia diante de obstrução suspeita. Evitar enemas fosfatados em lactentes, desidratação ou doença renal.

Seguimento. Rever em semanas, antes se dor/distensão persistirem. A manutenção costuma ser prolongada e retirada gradual após controle sustentado; recorrência pede revisão de adesão, impactação e sinais de causa orgânica.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — constipação; NASPGHAN/ESPGHAN — doses de PEG, diretriz 2014; NASPGHAN — novo percurso clínico 2026.

70. Doença de Caroli

Definição operacional. Dilatação segmentar/sacular das vias biliares intra-hepáticas favorece estase, cálculos e colangite. Diferenciar doença localizada de acometimento difuso e de síndrome de Caroli associada à fibrose hepática congênita; pesquisar doença renal relacionada, inclusive ARPKD.

Avaliação. Ultrassonografia e colangiorressonância delimitam anatomia; hemograma, bilirrubina, GGT, função renal e culturas durante febre orientam complicações. Febre com dor, icterícia ou instabilidade é suspeita de colangite e requer antibiótico IV com cobertura entérica e avaliação de drenagem. Culturas prévias e resistência devem dirigir o tratamento definitivo; o tema 67 explica o enquadramento antimicrobiano.

Tratamento específico. Cálculos ou segmentos mal drenados podem demandar intervenção endoscópica/percutânea. Ressecção pode ser considerada no acometimento localizado; colangites recorrentes, doença difusa ou complicações hepáticas/renais avançadas motivam avaliação de transplante hepático ou combinado. A decisão decorre da anatomia e da morbidade, não apenas da presença de dilatação em imagem.

Acompanhamento. Nutrição, sinais de hipertensão portal, episódios febris, função renal e hepática devem ser registrados longitudinalmente. Vitaminas A/D/E/K são repostas se houver má absorção/deficiência; não constituem tratamento da malformação. Ursodesoxicólico não elimina infecção nem obstrução e não deve atrasar intervenção. Vigilância hepatobiliar deve ser organizada com o centro responsável, sem propor intervalo

de rastreio oncológico pediátrico sem respaldo específico.

Fontes verificadas em 25/09/2026: EASL — doenças císticas hepáticas; GeneReviews — ARPKD/PKHD1.

71. Doença de Crohn em Pediatria

Definir fenótipo e risco. Avaliar crescimento, estado nutricional, doença perianal, manifestações extraintestinais, hemograma, CRP, albumina e calprotectina; endoscopia e avaliação do intestino delgado confirmam extensão. Abscesso, obstrução, perfuração e sepse exigem abordagem hospitalar com controle do foco antes de imunossupressão indiscriminada.

Indução — atualização ECCO/ESPGHAN 2026. No baixo risco, nutrição enteral exclusiva ou dieta de exclusão de Crohn com nutrição enteral parcial são estratégias preferenciais. Se não toleradas/viáveis, prednisona/prednisolona 1 mg/kg VO uma vez/dia, máximo 40 mg/dia, com redução e suspensão em 8–10 semanas. Alto risco de mau prognóstico favorece anti-TNF precoce. Não usar corticoide para manutenção.

Biológicos e manutenção. Infliximabe e adalimumabe exigem seleção individual, rastreio de tuberculose/hepatite B, atualização vacinal, controle de infecção e monitorização farmacocinética. A diretriz favorece imunomodulador associado ao iniciar infliximabe; monoterapia com monitorização proativa pode ser considerada. O esquema convencional de infliximabe de 5 mg/kg IV nas semanas 0, 2, 6 e depois a cada 8 semanas consta na diretriz anterior, mas exposição inicial pode precisar intensificação por peso, albumina, inflamação e níveis séricos. Não o interpretar como dose suficiente para todos.

Metas. Remissão clínica sem corticoide, crescimento e controle objetivo da inflamação. Sintomas isoladamente não excluem doença ativa. Revisar adesão, infecção e níveis do biológico antes de declarar falha.

Fontes verificadas em 25/09/2026: ECCO/ESPGHAN — Crohn pediátrico 2026; ECCO/ESPGHAN — esquemas e monitorização 2021.

72. Doença do Refluxo Gastroesofágico em Pediatria

Distinguir refluxo de doença. Regurgitação em lactente que cresce bem não indica supressão ácida. Hematêmese, disfagia, perda ponderal, anemia, vômito bilioso ou sinais respiratórios relevantes exigem diagnóstico alternativo/complicação. Evitar atribuir irritabilidade isolada ao ácido.

Primeiras medidas. Corrigir volumes excessivos, manter aleitamento e considerar espessamento para regurgitação problemática. Se suspeita de alergia à proteína do leite, teste nutricional orientado pode anteceder medicamento. Sono permanece em decúbito dorsal; elevar berço ou colocar lactente em prona para tratar refluxo não é conduta segura.

Medicação quando indicada. Em esofagite por refluxo/documentação clínica apropriada, omeprazol 1–4 mg/kg/dia VO, máximo 40 mg/dia, é a faixa da diretriz NASPGHAN/ESPGHAN. Preferir início na menor dose adequada à gravidade e revisão em 2–4 semanas; tratamento bem-sucedido geralmente permite tentativa de redução após 4–8 semanas. Não romper revestimento gastrorresistente inadvertidamente; suspensão magistral depende de receita farmacotécnica validada, não de simples dissolução do comprimido. Volume = dose em mg/concentração efetivamente preparada.

Segurança. Evitar manutenção automática e pró-cinéticos de rotina. Rever interação medicamentosa, infecções recorrentes e micronutrientes se tratamento prolongado. Ausência de resposta leva à revisão do diagnóstico/adesão, não à escalada indefinida. Persistência, disfagia ou necessidade crônica justificam investigação gastroenterológica.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NASPGHAN/ESPGHAN — DRGE; RCH — refluxo em lactentes.

73. Dor Abdominal Crônica em Pediatria

Triagem. Perda de peso, redução da velocidade de crescimento, sangue nas fezes, diarreia noturna, febre persistente, vômitos relevantes, disfagia, massa ou história familiar de DII/celíaca exigem investigação dirigida. Considerar constipação, doença celíaca, DII, causas urinárias/ginecológicas e transtornos da interação intestino-cérebro. Não é necessário solicitar toda a propedêutica para cada criança.

Exames úteis conforme hipótese. Hemograma, CRP/ESR, função hepática, urina, IgA total e anti-transglutaminase IgA; calprotectina quando houver suspeita inflamatória. Ultrassonografia não é exame obrigatório na dor funcional típica. Dor que compromete alimentação, escola ou sono merece plano de acompanhamento estruturado mesmo com exame normal.

Tratamento. Explicar o diagnóstico funcional positivamente e definir metas de retorno às atividades. Tratar constipação coexistente, organizar refeições e sono, oferecer intervenção psicológica focada, terapia cognitivo-comportamental ou hipnoterapia quando disponíveis. Restrições alimentares amplas e prolongadas sem supervisão podem piorar nutrição. IBP só para indicação acidopéptica plausível; não é tratamento geral de dor crônica. Tricíclicos e outros neuromoduladores são opções especializadas em refratários, com evidência e riscos discutidos, não uma prescrição automática baseada no título.

Seguimento. Registrar funcionamento, frequência/intensidade da dor e sinais de alarme. Reavaliar diagnóstico se surgirem achados objetivos; estabilizar imediatamente se o quadro mudar para abdome agudo.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — dor abdominal crônica; ESPGHAN/NASPGHAN — dor abdominal funcional 2025.

74. Esquistossomose em Pediatria

Diagnóstico e gravidade. Correlacionar exposição a água doce em área de transmissão com parasitologia e apresentação clínica; avaliar forma intestinal versus hepatoesplênica. Hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar, comprometimento neurológico e síndrome aguda importante mudam urgência e exigem tratamento especializado.

Esquema brasileiro. Ministério da Saúde: praziquantel 60 mg/kg VO para crianças, preferencialmente em dose única; comprimido 600 mg. Para 20 kg: 1.200 mg = dois comprimidos de 600 mg; reversa 1.200/20 = 60 mg/kg. Administrar de acordo com capacidade de deglutição e formulação; não inventar concentração líquida a partir do comprimido. O limite etário da bula Farmanguinhos consultada é acima de 4 anos; recomendações internacionais e incorporação em crianças menores não podem ser equiparadas automaticamente àquela bula. Abaixo dessa idade, definir acesso e apresentação específica com programa de referência.

Segurança e resposta. Náuseas, dor abdominal e diarreia podem ocorrer. Investigar interação com indutores enzimáticos e doença neurológica/ocular antes de prescrever. Doença grave de órgão e fase aguda não devem receber apenas um comprimido e alta sem avaliação da reação inflamatória e do destino assistencial.

Controle. Organizar exame de cura pelo programa assistencial, reduzir reexposição e investigar contatos conforme cenário epidemiológico. Persistência de hipertensão portal pode ocorrer mesmo após erradicação parasitária e necessita seguimento próprio.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Ministério da Saúde — tratamento; Farmanguinhos/Fiocruz — bula profissional.

75. Estenose Hipertrófica do Piloro

Reconhecimento. Lactente com vômitos progressivamente fortes, tipicamente não biliosos, perda ponderal e fome após vomitar deve ser investigado. A ausência de oliva palpável ou alcalose não exclui apresentação inicial. Vômito bilioso requer investigação de outra obstrução urgente.

Antes da cirurgia. Jejum, acesso IV, glicose, eletrólitos e gasometria. Ultrassonografia é o exame de escolha; repetir se inconclusiva e suspeita persistente. Corrigir desidratação, hipocloremia, hipocalemia e alcalose; não antecipar piloromiotomia com desequilíbrio relevante, pois alcalose aumenta risco de hipoventilação/apneia pós-operatória. Sonda para descompressão quando vômitos persistem.

Fluidos. Ressuscitação com NaCl 0,9% somente quando necessária; déficit e manutenção podem utilizar solução isotônica com glicose. Acrescentar potássio somente após diurese adequada e avaliação do potássio/função renal. A taxa resulta da soma da manutenção com correção do déficit e perdas, subtraindo outros aportes; não fixar volume antes de medir desidratação e perdas. Como fórmula de bomba, volume prescrito em mL dividido pelo tempo em horas = mL/h.

Definitivo e destino. Piloromiotomia após estabilização, em unidade com cirurgia/anestesia pediátrica. Antiemético não corrige a obstrução e não deve mascarar atraso diagnóstico. A alta depende de alimentação tolerada e plano cirúrgico, com retorno por vômitos progressivos, desidratação, febre ou distensão.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — estenose pilórica.

76. Estomatite Aftosa Recorrente (Aftas)

Confirmar o padrão. Aftas recorrentes são úlceras dolorosas sem o padrão vesicular típico do herpes. Procurar trauma, medicamentos, deficiência de ferro/B12/folato, doença celíaca, DII, neutropenia e doença de Behçet conforme história. Febre recorrente, úlcera genital, olho vermelho/doloroso, artrite, perda ponderal ou lesão persistente mudam a investigação.

Tratamento local. Alimentação tolerável, evitar irritantes, higiene oral suave e analgesia apropriada à idade. Corticoide tópico oral pode reduzir sintomas; triancinolona acetonida em pasta oral 1 mg/g (0,1%) é uma apresentação documentada. Aplicar somente na lesão, em camada fina, com orientação do produto e por curso curto; a bula específica deve definir idade e frequência. Não substituir por creme dermatológico não destinado à mucosa.

O que não padronizar. Lidocaína viscosa tem risco de deglutição, aspiração e toxicidade, principalmente em pequenos; não fornecer dose volumétrica sem concentração, área, idade e capacidade de cuspir. Colchicina, dapsona e corticoide sistêmico não são tratamento universal de aftas simples: restringem-se a quadros graves/refratários com diagnóstico revisado e monitorização hematológica/metabólica. Zinco somente com deficiência ou indicação sustentada.

Destino. Hidratação inadequada, dor intratável ou imunossupressão favorecem observação/internação. Afta que não cicatriza, muda de aspecto ou acompanha manifestações sistêmicas precisa avaliação dirigida, não repetição indefinida do tópico.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — analgesia aguda e úlceras orais; Healthdirect/TGA — triancinolona oral 1 mg/g.

77. Fibrose Hepática Congênita

Avaliação. Suspeitar em hipertensão portal com esplenomegalia/trombocitopenia, especialmente associada a rins aumentados/císticos. A função de síntese hepática pode estar relativamente preservada apesar de varizes importantes. Ultrassonografia com Doppler, hemograma, INR, albumina e função renal ajudam a definir risco; investigar PKHD1/ARPKD e dilatação biliar quando compatíveis.

Tratamento das manifestações. Não há antifibrótico medicamentoso estabelecido que reverta a malformação da placa ductal. Hematêmese ou melena requer o percurso de sangramento varicoso do tema 85: ressuscitação cuidadosa, terapia vasoativa e endoscopia. A prevenção secundária é endoscópica/especializada; não copiar automaticamente betabloqueadores de cirrose adulta. Febre sem foco em criança com dilatação biliar deve levantar colangite, colher culturas e iniciar antibiótico hospitalar conforme foco e gravidade.

Decisões definitivas. Shunt/abordagem vascular e transplante são considerados pela recorrência de sangramento, anatomia portal, colangites e função hepática/renal. Transplante combinado pode ser necessário quando ambas as disfunções são relevantes. A decisão não é baseada apenas em transaminases.

Seguimento. Registrar sangramento, plaquetas, baço, crescimento, pressão arterial, função renal e episódios infecciosos. A própria doença não justifica rotineiramente analgésico, procinético ou ursodesoxicólico. Reposição de vitaminas é orientada por deficiência/má absorção. Orientar procura imediata por fezes negras, hematêmese, febre ou redução de diurese.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — ARPKD/PKHD1; BSPGHAN — varizes em crianças.

78. Hepatite Autoimune em Pediatria

Confirmar antes da manutenção. Transaminases, IgG, autoanticorpos, exclusão de hepatites/causas metabólicas e avaliação histológica quando segura sustentam o diagnóstico. Colangiopatia associada deve ser considerada. INR elevado, hipoglicemia ou encefalopatia exigem manejo hospitalar e avaliação de insuficiência hepática.

Indução. ESPGHAN pediátrica: prednisona/prednisolona 2 mg/kg/dia VO, máximo 60 mg/dia, com redução guiada pela queda de transaminases ao longo de 4–8 semanas. Há divergência: BSG 2025 recomenda em crianças até 2 mg/kg/dia, mas teto usual de 40 mg/dia. Registrar qual diretriz e gravidade justificam a dose; não misturar teto de uma com esquema de outra. Em 16 kg, 2 mg/kg/dia = 32 mg/dia, abaixo dos dois tetos.

Poupador de corticoide. Azatioprina pode ser introduzida após resposta inicial, começando em 0,5 mg/kg/dia e aumentando até 2–2,5 mg/kg/dia conforme tolerância/controle. Icterícia intensa e cirrose aumentam preocupação com hepatotoxicidade. Avaliar metabolismo de tiopurinas quando disponível, hemograma, enzimas e interações; a associação com alopurinol demanda ajuste especializado, não prescrição usual.

Metas e monitorização. Durante primeiras 6–8 semanas, acompanhar bioquímica frequentemente, além de glicemia, PA, crescimento e toxicidade do corticoide. Remissão é bioquímica sustentada; retirada completa só após critérios prolongados e reavaliação especializada. Corticoide não deve ser suspenso abruptamente após uso continuado.

Fontes verificadas em 25/09/2026: ESPGHAN — HAI pediátrica; BSG — HAI 2025.

79. Hepatites Virais

Definir etiologia e risco. Investigar marcadores virais, replicação, ALT/AST, bilirrubinas, INR, albumina e glicose. Anti-HCV isolado não demonstra infecção ativa. Hipoglicemia, coagulopatia ou alteração neurológica exigem internação e percurso do tema 80. Hepatite aguda não complicada requer hidratação/nutrição toleradas e retirada de hepatotóxicos; antibiótico e corticoide não são rotina.

HBV: quem tratar. OMS 2024: em adolescentes, considerar fibrose ≥F2/cirrose, HBV-DNA >2.000 UI/mL com ALT persistentemente elevada, ou condições de maior risco. Em 2–11 anos, decidir individualmente, sobretudo fibrose progressiva/cirrose, flare persistente com replicação, comorbidade de risco ou necessidade de imunossupressão. HBsAg positivo isolado não é indicação. Entecavir ou tenofovir constituem opções preferenciais quando tratamento é indicado; coinfecção HIV requer esquema antirretroviral completo.

Entecavir: exemplo de primeira linha. Criança ≥2 anos, ≥10 kg, sem tratamento prévio com análogo, doença compensada e função renal adequada: VO uma vez/dia, em jejum. A tabela regulatória de solução 0,05 mg/mL utiliza faixas; não substituir automaticamente por cálculo linear:

Peso	Dose diária	Solução 0,05 mg/mL
10–11 kg	0,15 mg	3 mL
>11–14 kg	0,20 mg	4 mL
>14–17 kg	0,25 mg	5 mL
>17–20 kg	0,30 mg	6 mL
>20–23 kg	0,35 mg	7 mL
>23–26 kg	0,40 mg	8 mL
>26–30 kg	0,45 mg	9 mL
>30 kg	0,50 mg	10 mL ou comprimido 0,5 mg

Monitorar HBV-DNA, ALT, adesão e rim; resistência/lamivudina prévia ou disfunção renal modificam o esquema. Tratamento é prolongado; suspensão sem critérios pode provocar exacerbação. Confirmar acesso à apresentação.

HCV pediátrico. AASLD/IDSA recomenda tratar a partir de 3 anos. Em elegível sem descompensação ou tratamento prévio relevante: glecaprevir/pibrentasvir VO por oito semanas, <20 kg 150/60 mg/dia; 20–<30 kg 200/80 mg; 30–<45 kg 250/100 mg; ≥45 kg ou ≥12 anos 300/120 mg. Sofosbuvir/velpatasvir por 12 semanas é alternativa com faixas próprias. Conferir formulação pediátrica e interações; comprimido adulto não equivale a granulado fracionado.

Seguimento. Confirmar resposta virológica, imunização e prevenção domiciliar. Hepatite A exige higiene e avaliação de profilaxia dos contatos.

Fontes verificadas em 25/09/2026: OMS 2024 — HBV em crianças e adolescentes; FDA — tabela pediátrica de entecavir; FDA — Baraclude solução 0,05 mg/mL; AASLD/IDSA — HCV em crianças; NASPGHAN — insuficiência hepática pediátrica.

80. Insuficiência Hepática Fulminante em Pediatria

Emergência. Lesão hepática aguda com coagulopatia não corrigida por vitamina K caracteriza risco de falência: INR ≥1,5 com encefalopatia ou ≥2 sem encefalopatia deve mobilizar centro de transplante pediátrico. Não esperar encefalopatia exuberante para transferência. ABCDE, acesso, glicemia seriada, perfusão, consciência e diurese são prioritários.

Investigação paralela. Hemograma, INR/fibrinogênio, glicose, eletrólitos, função renal, gasometria/lactato, amônia com coleta adequada, bilirrubinas e enzimas; pesquisar acetaminofeno, infecções, autoimunidade e causas metabólicas conforme idade. Suspender agentes suspeitos e tratar causa identificada.

Suporte. Prevenir hipoglicemia com glicose IV ajustada à necessidade e monitorização; evitar soluções hipotônicas e sobrecarga. Controlar febre, eletrólitos e perfusão; deterioração neurológica exige neuroproteção e UTI. Hemocomponentes são indicados por sangramento/procedimento e contexto, não simplesmente para normalizar INR e perder seu valor prognóstico. Antibiótico/antifúngico depende de infecção suspeita ou estratégia do centro, não de lista fixa.

Acetilcisteína. É indicada na toxicidade por paracetamol; o esquema deve seguir o protocolo toxicológico específico. Ensaio pediátrico em falência não relacionada a paracetamol não mostrou benefício de sobrevida e encontrou menor sobrevida sem transplante: não tornar NAC universal nessa situação. Lactulose e terapias de cirrose não devem ser transpostas automaticamente para falência aguda infantil.

Destino. UTI e centro transplantador precoce; decisões de suporte extracorpóreo e transplante são dinâmicas.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NASPGHAN — diagnóstico/manejo de falência hepática; Ensaio randomizado NAC não-paracetamol em crianças.

81. Intoxicação por Inibidores de Monoaminoxidase

Prioridade. Intoxicação por IMAO pode produzir hipertensão, hipertermia, agitação, clônus, convulsões e instabilidade; identificar fármaco, dose, horário e coingestões. Suspender agentes serotoninérgicos e acionar toxicologia. Manifestações podem ser tardias; a observação deve ser específica do produto e quantidade, não apenas da aparência inicial.

ABCDE e exames. Monitor cardíaco, temperatura central, glicose, ECG, acesso IV, avaliação renal/eletrólitos/CK e gasometria conforme gravidade. Hipertermia por atividade muscular requer sedação e resfriamento; antitérmico isolado não a controla. Casos graves podem exigir intubação e bloqueio neuromuscular por equipe experiente.

Medicação. Benzodiazepínicos IV titulados são primeira medida para agitação/clônus/convulsão. Não usar agonistas indiretos ou adicionar fármacos serotoninérgicos inadvertidamente. Na toxicidade serotoninérgica refratária, a referência RCH admite ciproeptadina VO: <7 anos, 2 mg; ≥7 anos, 4 mg, podendo manter a mesma dose três vezes/dia enquanto persistem sintomas, com toxicologista. Esse uso é off-label e a capacidade de administração enteral deve ser confirmada. Instabilidade hemodinâmica requer vasopressor direto titulado, com concentração validada e monitorização intensiva.

Descontaminação/destino. Carvão não é rotina nem deve ser dado com via aérea desprotegida; discutir benefício pela janela/ingestão. Sintomáticos permanecem internados; hipertermia importante, convulsão ou

choque demandam UTI. Ingestão intencional requer avaliação psicossocial após estabilização.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — toxicidade serotoninérgica; RCH — princípios de intoxicação.

82. Invaginação Intestinal

Reconhecimento. Dor episódica intensa, palidez, vômitos ou letargia inexplicada podem preceder sangue nas fezes; a tríade clássica não é obrigatória. Distensão, peritonismo e choque sugerem doença avançada. Estabilização e analgesia precedem exames: acesso IV, jejum, correção de perfusão e sonda quando obstrução/perfuração.

Diagnóstico. Ultrassonografia por equipe experiente é inicial. POCUS positivo pode ajudar; exame à beira-leito negativo não exclui. Radiografia é mais útil diante de obstrução/perfuração e não deve atrasar transferência para ultrassom/redução.

Tratamento definitivo. Redução pneumática/hidrostática guiada por imagem é indicada no paciente estável, sem perfuração/peritonite, em ambiente com retaguarda cirúrgica. Choque persistente, perfuração, peritonite ou redução malsucedida requerem cirurgia. Invaginação exclusivamente de intestino delgado pode ter comportamento diferente e nem sempre necessita enema.

Medicamentos. Analgesia opioide IV/intranasal monitorizada pode ser necessária; não retardar por receio de mascarar o exame. Antibiótico é direcionado a perfuração, infecção, sepse ou intervenção indicada, não substitui a redução. Antiemético não deve produzir falsa segurança após melhora do vômito.

Reavaliação. Observar recorrência de dor/letargia, perfusão e tolerância alimentar após redução. Alta e tempo de observação são definidos pelo percurso cirúrgico; orientar retorno imediato por novos episódios. Recorrência ou idade atípica aumenta necessidade de pesquisar ponto de tração.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — invaginação intestinal; CHOP — avaliação de obstrução intestinal.

83. Parasitoses Intestinais em Pediatria

Escolher pelo parasito. Prurido anal noturno favorece enterobíase; diarreia prolongada/má absorção pode indicar giardíase. Epidemiologia, eosinofilia e exames dirigem helmintos. Não tratar toda diarreia com associação de antiparasitários. Sangue nas fezes, doença sistêmica ou desidratação importante exigem investigação adicional.

Helmintos intestinais. Enterobíase: albendazol 400 mg VO uma vez, repetir após 14 dias; abaixo de 2 anos ponderar benefício/segurança. Medidas domiciliares e alternativas estão no tema 144.
Ascaridíase/ancilostomíase: albendazol 400 mg VO, dose única; tricuríase: 400 mg VO/dia por três dias na referência CDC. Conferir indicação etária e produto local; suspensão não tem volume universal.

Giardia. Opção documentada: nitazoxanida VO com alimento de 12/12 h por três dias. Na bula FDA: 1–3 anos, 100 mg/dose; 4–11 anos, 200 mg/dose; ≥12 anos, 500 mg/dose. Suspensão verificada 100 mg/5 mL = 20 mg/mL: respectivamente 5, 10 e 25 mL/dose; ≥12 anos pode usar comprimido 500 mg. Não extrapolar para <1 ano nem fracionar comprimido adulto para criança pequena. Persistência exige confirmar infecção, adesão e reinfecção antes de trocar medicamento.

Strongyloides. Em paciente ≥15 kg elegível, ivermectina 200 mcg/kg VO uma vez/dia por 1–2 dias; pesquisar exposição a Loa loa quando epidemiologicamente pertinente. Em 16 kg: 3.200 mcg = 3,2 mg/dose; adequação ao comprimido exige dispensação mensurável. Segurança <15 kg não está estabelecida na referência CDC. Hiperinfecção/disseminação: mesma dose diária até fezes/escarro negativos por duas semanas, com internação e redução de imunossupressão quando possível; íleo/má absorção exige estratégia especializada. Reavaliar parasitologia em 2–4 semanas se sintomas persistirem após positividade inicial.

Destino. Sepse, acometimento pulmonar, obstrução ou desidratação grave requerem internação. Neurossintomas/suspeita de cisticercose mudam a estratégia: ver tema 134.

Fontes verificadas em 25/09/2026: CDC — enterobíase; CDC — geo-helmintos; CDC — Giardia; FDA — Alinia suspensão e comprimido; CDC — tratamento Strongyloides.

84. Retocolite Ulcerativa em Pediatria

Gravidade. Registrar PUCAI, evacuações, sangue, dor, atividade, anemia, albumina e marcadores inflamatórios. Excluir infecção, particularmente C. difficile; considerar CMV em refratários/imunossuprimidos. Colite aguda grave demanda internação e decisão precoce conjunta com cirurgia.

Doença leve/moderada. Diretriz ECCO/ESPGHAN 2025: mesalazina VO geralmente 50–70 mg/kg/dia, podendo chegar a 100 mg/kg/dia, máximo 4,8 g/dia. Mesalazina retal 25 mg/kg/dia, máximo 1 g/dia, pode complementar doença distal. Não triturar formulações de liberação modificada. Corticoide é para indução quando necessário, não manutenção; tiopurina/biológico são selecionados por resposta e risco.

Aguda grave. Corticoide IV, monitorização diária da atividade, estado volêmico e complicações; discutir resgate com infliximabe ou inibidor da calcineurina e momento da colectomia. Não manter dias sucessivos de tratamento ineficaz sem marco de decisão. Distensão, febre, taquicardia ou defesa exigem excluir megacólon/perfuração. Evitar antidiarreicos/opioides que agravem distensão e retardem reconhecimento.

Segurança e metas. Monitorar função renal com 5-ASA, hemograma/função hepática com tiopurinas, infecções e níveis quando biológico. Rastrear tuberculose/hepatite B antes de terapias pertinentes e planejar vacinação. Buscar remissão clínica e objetiva, crescimento e redução da exposição a corticoide. A escolha de preparo/infusão de resgate é vinculada ao produto e ao centro de DII.

Fontes verificadas em 25/09/2026: ECCO/ESPGHAN — RCU ambulatorial 2025; ECCO/ESPGHAN — colite aguda grave 2025.

85. Sangramento Digestivo

ABCDE. Hematêmese, melena ou hematoquezia com alteração de perfusão demandam acesso venoso, monitorização, tipagem/prova de compatibilidade, hemograma seriado, INR/fibrinogênio, função hepática/renal e avaliação urgente. A hemoglobina inicial pode subestimar perda aguda. Proteger via aérea se hematêmese volumosa ou consciência comprometida; ressuscitar sem sobrecarga, sobretudo na hipertensão portal.

Suspeita varicosa. Octreotida: bolus IV de 1 mcg/kg em 5 minutos, máximo 50 mcg; depois 1–3 mcg/kg/h, máximo 50 mcg/h, conforme resposta e endoscopia. Referência de preparo BSPGHAN: 500 mcg em volume final de 40 mL de NaCl 0,9% = 12,5 mcg/mL. Bomba = dose (mcg/kg/h) × peso/12,5. Exemplo 16 kg, 1 mcg/kg/h: 16 mcg/h = 1,28 mL/h; reversa 1,28×12,5/16 = 1. Consumo 6/12/24 h: 7,68/15,36/30,72 mL. Esses volumes não definem estabilidade. Monitorar glicemia, perfusão, FC e local de infusão; uso pediátrico conforme produto pode ser off-label.

Controle do foco. Endoscopia terapêutica e centro especializado são essenciais. Não usar vasopressina, tranexâmico ou IBP como substitutos de hemostasia varicosa. Na hemorragia não varicosa, a endoscopia define necessidade de hemostasia e supressão ácida. Persistência de choque/sangramento exige UTI e resgate endoscópico/intervencionista/cirúrgico.

Fontes verificadas em 25/09/2026: BSPGHAN — manejo de varizes; APSPGHAN — hemostasia varicosa.

86. Síndrome de Alagille

Avaliação multidimensional. Alagille associa colestase/prurido a manifestações cardíacas, renais, vertebrais, oculares e vasculares; definir fenótipo e gravidade antes de procedimentos. Monitorar crescimento, vitaminas lipossolúveis, coagulação, função renal e lesão hepática. Prurido incapacitante, fraturas por deficiência ou progressão hepática exigem ajuste específico.

Terapia antipruriginosa. Maralixibate é inibidor de IBAT. Na bula FDA para Alagille: solução **9,5 mg/mL**, a partir de 3 meses, iniciar 190 mcg/kg VO uma vez/dia por uma semana; alvo 380 mcg/kg/dia, 30 minutos antes da refeição matinal; máximo da solução 28,5 mg = 3 mL/dia. O cálculo teórico corresponde a 0,02 e 0,04 mL/kg/dia, mas a administração deve seguir a tabela ponderal arredondada da bula, não substituir essa tabela cegamente. Há outra concentração de 19 mg/mL para PFIC, que não deve ser trocada sem recálculo.

Segurança. Verificar transaminases, bilirrubina, INR e vitaminas; diarreia/desidratação e piora hepática exigem reavaliação. Não iniciar em descompensação hepática abrangida pelas contraindicações do produto. Resinas

sequestradoras podem interferir na administração e precisam separação conforme bula. Registro/disponibilidade nacional não foram confirmados aqui.

Destino. A resposta ao prurido não elimina necessidade de avaliação cardiológica/renal e eventual transplante. Não usar o esquema de IBAT como tratamento universal de toda colestase.

Fontes verificadas em 25/09/2026: FDA/DailyMed — Livmarli; NIDDK/NASPGHAN — doenças biliares.

87. Síndrome de Mallory-Weiss

Suspeita. Hematêmese após episódios de vômito/esforço pode decorrer de laceração de mucosa na junção gastroesofágica, mas não exclui úlcera, varizes, corpo estranho ou sangue deglutido. Estimar gravidade pela perfusão, frequência de sangramento e tendência laboratorial, não apenas pela cor do vômito.

Conduta inicial. Aplicar avaliação de sangramento do tema 85. Suspender alimentação conforme sangramento/necessidade de endoscopia, obter acesso, hemograma e coagulação quando clinicamente relevantes e corrigir hipovolemia. Dor intensa torácica, enfisema subcutâneo ou toxicidade após vômitos levanta perfuração esofágica e demanda imagem/cirurgia urgente.

Tratamento específico. Muitos sangramentos cessam com suporte; persistência, recorrência importante ou instabilidade exige endoscopia com hemostasia. Controlar o gatilho de vômitos sem encobrir causa cirúrgica/neurológica. Supressão ácida pode integrar manejo de lesão mucosa, mas o regime depende do achado endoscópico; não assumir infusão de IBP de adulto para toda criança. Vasopressina não é tratamento rotineiro apenas porque aparece na relação de classes.

Monitorização/destino. Internar se sangramento ativo, queda de hemoglobina, alteração de perfusão, comorbidade ou ingestão inadequada. Alta somente após estabilidade e plano de retorno. Persistência de anemia/hematêmese demanda revisão diagnóstica. Evitar AINEs durante sangramento e rever fármacos que afetam coagulação.

Fontes verificadas em 25/09/2026: BSPGHAN — percurso de sangramento gastrointestinal; RCH — avaliação de vômitos.

88. Síndrome dos Vômitos Cíclicos

Diagnóstico e prevenção de erro. Episódios estereotipados separados por recuperação sugerem síndrome de vômitos cíclicos. Vômito bilioso, déficit neurológico, hipoglicemia/acidose, crescimento inadequado ou mudança do padrão exigem excluir obstrução, doença metabólica e lesão neurológica. Registrar gatilhos, história de enxaqueca e impacto funcional.

Crise. Plano antecipado com hidratação, ambiente tranquilo e terapia abortiva. Diretriz NASPGHAN 2025 favorece antimigranoso quando há história pessoal/familiar compatível; ondansetrona e antagonistas NK-1 são opções condicionais. Usar esquema definido pela idade/produto; QT, eletrólitos e interações precisam revisão quando antieméticos se repetem.

Profilaxia selecionada — off-label para CVS. Ciproeptadina 0,25–0,5 mg/kg/dia VO, dividida de 8/8 a 24/24 h, máximo 12 mg/dia; dose noturna pode reduzir sedação diurna. Amitriptilina: iniciar aproximadamente 0,5 mg/kg à noite e titular para 1–1,5 mg/kg/dia, com avaliação cardiovascular/ECG, efeitos anticolinérgicos e risco psiquiátrico. Propranolol, aprepitanto e outras estratégias têm indicações individualizadas; anticonvulsivante fica reservado a refratários. Não combinar essas opções automaticamente.

Reavaliação. Monitorar frequência das crises, faltas escolares, sono e adesão. Falha do plano, desidratação ou alteração metabólica justificam atendimento precoce e eventual internação; qualquer novo sinal de alarme reabre investigação.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NASPGHAN — manejo de CVS 2025; NASPGHAN — diagnóstico de CVS 2025.

89. Síndrome Hepatorrenal em Pediatria

Diagnóstico de exclusão. Na hepatopatia avançada com AKI, avaliar imediatamente hipovolemia, sepse, sangramento, nefrotoxinas, obstrução e lesão renal estrutural. Não denominar toda creatinina elevada como síndrome hepatorrenal. Rever diuréticos e fármacos, examinar sedimento urinário, quantificar diurese e obter imagem conforme suspeita.

Tratamento. Corrigir causa precipitante e estado circulatório sem impor expansão a uma criança já congestionada. Albumina e vasoconstritor podem servir como ponte ao transplante em HRS-AKI selecionada; oxigenação, balanço, perfusão e função renal são monitorados em ambiente intensivo. O esquema adulto de terlipressina não possui equivalência pediátrica automática.

Evidência pediátrica. A literatura atual ainda é limitada: série de quatro crianças utilizou terlipressina contínua 30 mcg/kg/dia (=1,25 mcg/kg/h) com albumina 1 g/kg/dia. Trata-se de exemplo publicado de terapia off-label, não dose padrão para qualquer idade/gravidade. Sem concentração validada, a fórmula é mL/h = 1,25 × peso (kg)/C (mcg/mL); não se fornece volume a aspirar nem diluente não verificados. Monitorar isquemia periférica/mesentérica, sódio, arritmia e deterioração respiratória.

Destino. UTI, nefrologia/hepatologia e avaliação de transplante precoce. Terapia renal substitutiva é considerada por indicação clínica, como hipercalemia, acidose ou sobrecarga refratária; a melhora transitória da creatinina não equivale à resolução da doença hepática.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Pediatric Nephrology — terlipressina em HRS-AKI pediátrica, 2026.

90. Vômitos em Crianças

Excluir emergência. Vômito verde/bilioso, peritonismo, alteração neurológica, cefaleia matinal progressiva, sangue, choque, distensão e criança muito prostrada exigem diagnóstico urgente. Em lactentes, considerar obstrução e infecção; em adolescentes, gravidez, intoxicação e transtorno metabólico conforme contexto. Vômito sem diarreia não deve ser automaticamente rotulado gastroenterite.

Avaliação. Examinar hidratação, perfusão e abdome; glicemia/cetonas são úteis quando baixa ingesta, letargia ou doença metabólica. Solicitar eletrólitos e outros exames orientados por gravidade. Na criança bem, sem sinais de alarme, não há necessidade de painel amplo.

Tratamento. Preferir solução de reidratação oral em pequenas ofertas frequentes. Ondansetrona pode facilitar hidratação em maiores de 6 meses: dose inicial VO de 2 mg para 8–<15 kg; 4 mg para 15–30 kg; 8 mg para >30 kg. Esses pontos de corte evitam sobreposição da tabela. Reavaliar a necessidade de novas doses, QT, hipocalemia/hipomagnesemia e interação com outros prolongadores de QT. Formulação e concentração devem ser confirmadas; não assumir que todo comprimido orodispersível pode ser dividido.

Destino. Resolução do vômito após antiemético não exclui causa grave. Alta exige sinais vitais/perfusão adequados, ingestão tolerada e retorno orientado. Persistência, diagnóstico incerto, distúrbio metabólico ou falha de hidratação requer observação/internação.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — vômitos, atualização setembro/2025.

91. Anemia de Diamond-Blackfan

Diagnóstico/gravidade. Anemia macrocítica com reticulocitopenia desde a infância, malformações e história familiar motivam avaliação de Diamond-Blackfan e teste genético; excluir causas adquiridas e outras falências medulares. Avaliar sintomas, hemoglobina e necessidade transfusional, não apenas macrocitose.

Tratamento. Consenso internacional 2024: transfusão com controle de sobrecarga de ferro, corticoide e transplante de células-tronco são as estratégias centrais. Em geral, testar corticoide somente após 1 ano: prednisona 2 mg/kg/dia VO por até quatro semanas. Se não alcançar resposta adequada, suspender o teste segundo plano de retirada; não prolongar alta dose sem resposta. Na manutenção, o consenso reduziu o teto para 0,3 mg/kg/dia; se exigência maior, considerar estratégia transfusional/transplante em vez de aceitar toxicidade crônica.

Transfusão/quelação. Meta pré-transfusional do consenso é aproximadamente 9–10 g/dL, individualizada. Quantificar ferro por avaliação seriada e imagem quando indicada; escolher quelante pela idade, carga de ferro e função renal/hepática. Não converter dose de deferasirox entre formulações dispersível e revestida sem ajuste específico.

Seguimento. Crescimento, osso, catarata, PA/glicose, infecção e toxicidade dos quelantes exigem vigilância. Há predisposição a neoplasias e necessidade de rastreio especializado. Febre em neutropênico, descompensação cardiovascular ou anemia sintomática importante requer atendimento hospitalar.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Consenso internacional DBA 2024; St. Jude — consenso DBA.

92. Doença de Wilson em Pediatria

Definir fenótipo. Doença hepática, hemólise Coombs-negativa ou manifestações neurológicas/psiquiátricas justificam investigação de Wilson com ceruloplasmina, cobre urinário, exame ocular, testes genéticos e avaliação hepática conforme contexto. Ceruloplasmina isolada não confirma nem exclui. Insuficiência hepática com hemólise ou coagulopatia importante exige centro transplantador.

Tratamento de longo prazo. EASL-ERN 2025 recomenda quelante quando há doença hepática significativa. D-penicilamina em crianças é titulada gradualmente até 20 mg/kg/dia VO, em duas ou três tomadas; trientina é alternativa por tolerabilidade/contexto. Zinco tem papel selecionado, especialmente manutenção/presintomáticos, e não substitui quelante indiscriminadamente na hepatopatia ativa. Não interromper terapia por conta própria após melhora.

Segurança. Com penicilamina, acompanhar hemograma, urina/proteinúria, função renal/hepática e resposta neurológica; rash, citopenia ou proteinúria exigem revisão rápida. Pode ocorrer piora neurológica inicial. Alimentação e minerais interferem na absorção, devendo seguir instruções do produto. Dose diária em mg = 20 × peso; distribuição e arredondamento devem respeitar a apresentação, evitando cápsula fracionada sem preparo farmacêutico validado.

Metas. Controle hepático/neurológico e equilíbrio do cobre, incluindo evitar deficiência iatrogênica. Rastrear irmãos e adesão. Transplante trata doença hepática selecionada, não é simplesmente uma alternativa a qualquer dificuldade de tomar medicamento.

Fontes verificadas em 25/09/2026: EASL-ERN — Wilson 2025; AASLD — orientação terapêutica; MS — PCDT Wilson 2024.

93. Fibrodisplasia Ossificante Progressiva

Evitar dano iatrogênico. Malformação dos hálux com ossificação heterotópica progressiva deve levantar FOP. Evitar biópsia de nódulos, injeção IM, cirurgia desnecessária e manipulação forçada, que podem precipitar ossificação. Via aérea difícil, restrição torácica ou trauma requerem equipe familiarizada com FOP; extensão cervical forçada é particularmente perigosa.

Crise inflamatória. ICCFOP: prednisona 2 mg/kg VO uma vez/dia, máximo 100 mg/dia, por quatro dias, iniciada precocemente em crise de grandes articulações ou região mandibular/submandibular selecionada. Não aplicar automaticamente em toda dor crônica axial; a indicação e janela importam. Para 16 kg: 32 mg/dia; reversa 32/16 = 2 mg/kg. Dor residual pode demandar analgésico/AINE após revisão gastrointestinal/renal; não estender corticoide indefinidamente.

Prevenção e novas terapias. Reduzir trauma, adaptar odontologia/anestesia e atividade física preservando autonomia; fisioterapia não deve forçar amplitude além do tolerável. Tratamento modificador com retinoide específico exige elegibilidade por idade/maturidade óssea e risco de fechamento epifisário; não foi convertido aqui em esquema genérico.

Monitorização/destino. Edema submandibular, disfagia, alteração respiratória ou suspeita de infecção justificam avaliação imediata. Documentar dor, amplitude funcional e toxicidade de medicamento. A ausência de febre não diferencia perfeitamente flare de infecção; exames devem ser minimamente traumáticos.

Fontes verificadas em 25/09/2026: ICCFOP — classes de medicamentos; ICCFOP — pontos essenciais.

94. PAPA

Enquadramento. PAPA é síndrome autoinflamatória associada a PSTPIP1, com artrite piogênica estéril, pioderma gangrenoso e acne. Antes de chamar uma articulação quente de estéril, excluir artrite séptica por avaliação/cultura apropriadas. Ulceração neutrofílica pode piorar com debridamento por patergia, mas suspeita de infecção real precisa investigação.

Tratamento por manifestação. Corticoide pode controlar crise articular; doença recorrente ou dependência de corticoide motiva bloqueio de IL-1. Anti-TNF pode beneficiar manifestações cutâneas selecionadas. Relatos e séries pequenas apoiam essas opções, porém não estabelecem uma sequência ou posologia universal de PAPA. Combinar dois imunossupressores/biológicos apenas por falha parcial aumenta risco e requer decisão especializada.

Execução segura. Definir alvo (artrite, pele, febre), gravidade, infecção ativa e esquema anterior; rastrear TB/hepatites e atualizar vacinação antes de biológico. Monitorar hemograma, fígado, infecção e resposta funcional/cutânea. Anakinra/canaquinumabe para PAPA são usos off-label; não copiar automaticamente dose aprovada para CAPS ou artrite idiopática juvenil. Registrar ausência de resposta e mudar mecanismo com justificativa, em vez de escalar por hábito.

Seguimento. Articulação incapacitante, sepse possível ou lesão cutânea extensa precisam atendimento urgente. O plano de longo prazo inclui cuidado de feridas, controle de dor e orientação genética. A evidência identificada é de séries/relatos, expressamente distinta de ensaio confirmatório.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Série primária — bloqueio IL-1 em PAPA; Série primária — anti-TNF em PAPA; Relato primário de tratamento combinado.

95. Síndrome de Bernard-Soulier

Reconhecer o distúrbio. Sangramento mucocutâneo desde cedo, plaquetas grandes e trombocitopenia sugerem Bernard-Soulier. Confirmar defeito de adesão/receptor em centro de hemostasia; não presumir PTI e iniciar imunossupressão repetida apenas pelo número de plaquetas.

Hemostasia. Compressão local, medidas odontológicas/otorrinolaringológicas e antifibrinolítico podem controlar sangramento de mucosa. Hemorragia importante ou cirurgia pode requerer plaquetas, preferindo estratégia que reduza aloimunização e considerando compatibilidade HLA quando indicada. Refratariedade deve ser distinguida de consumo e sangramento não controlado.

Outras opções. Fator VIIa recombinante é resgate descrito, principalmente na refratariedade a plaquetas; esse uso não deve ser confundido com indicação/dose de deficiência congênita de FVII (tema 114). A resposta à desmopressina é variável e não justifica uso empírico universal; risco de hiponatremia permanece. Tranexâmico requer revisão de hematúria de trato alto, função renal e risco trombótico. Menorragia pode demandar terapia hormonal e reposição de ferro.

Segurança e destino. Evitar AAS e AINEs que comprometam hemostasia, injeções IM e procedimentos sem planejamento. Sangramento neurológico suspeito, gastrointestinal persistente ou instabilidade exigem internação/UTI e hemoterapia imediata. A prevenção inclui plano escrito de urgência e avaliação antes de odontologia/cirurgia.

Fontes verificadas em 25/09/2026: WFH — distúrbios plaquetários hereditários; Relato primário — rFVIIa em Bernard-Soulier.

96. Síndrome de Hiper-IgD

Confirmar diagnóstico. Hiper-IgD é a denominação histórica da deficiência de mevalonato-quinase (MKD); IgD elevada sozinha não estabelece o diagnóstico. Episódios febris, adenite, sintomas digestivos e rash orientam investigação genética/metabólica. Durante cada crise, excluir infecção relevante antes de atribuir tudo à autoinflamação.

Bloqueio IL-1 — módulo compartilhado com TRAPS. Bula FDA de canaquinumabe: ≤40 kg, iniciar 2 mg/kg SC a cada quatro semanas, podendo aumentar para 4 mg/kg se resposta insuficiente; >40 kg, 150 mg a cada quatro semanas, podendo aumentar a 300 mg. Solução documentada: 150 mg/mL, exclusivamente SC. Exemplo 16 kg: 32 mg = 0,2133 mL teóricos; dose de 64 mg = 0,4267 mL. O dispositivo deve permitir arredondamento mensurável; não preparar uma dose com quatro casas decimais na prática. Reversa: 0,2133×150/16 ≈2 mg/kg.

Segurança. Investigar TB/infecção, atualizar vacinação e evitar vacinas vivas. Não combinar bloqueadores IL-1/anti-TNF rotineiramente. Monitorar atividade, hemograma e infecção.

Aplicabilidade. Confirmar bula brasileira e diagnóstico; a tabela FDA não cobre tratamento neurológico/metabólico da MKD grave.

Fontes verificadas em 25/09/2026: FDA/DailyMed — Ilaris.

97. Síndrome de Klinefelter

Avaliação. Confirmar cariótipo e acompanhar crescimento, desenvolvimento, linguagem, aprendizado, puberdade e saúde óssea/metabólica. A presença de 47, XXY não implica iniciar testosterona indiscriminadamente em toda criança pré-púbere. Na adolescência, avaliar progressão puberal, sintomas, testosterona, LH/FSH e discutir fertilidade antes de reposição quando pertinente.

Indução/reposição. Hipogonadismo com atraso/estagnação puberal pode ser tratado gradualmente. Diretriz Endo-ERN descreve início de enantato de testosterona 50 mg IM aproximadamente uma vez/mês, aumentando progressivamente para imitar maturação puberal. O éster e a apresentação precisam ser especificados: essa dose não autoriza substituir automaticamente enantato por misturas, undecanoato de longa ação ou cipionato. Algumas apresentações brasileiras trazem restrição pediátrica expressa; uso em indução pode ser off-label e requer registro da indicação.

Monitorização. Crescimento, idade óssea, Tanner, hematócrito, acne, humor e testosterona no tempo apropriado ao éster. Evitar progressão rápida que acelere idade óssea desproporcionalmente. Apoio educacional, fonoaudiologia e saúde mental são parte do tratamento, não dependem da reposição hormonal.

Seguimento. Endocrinologia/andrologia planejam transição e aconselhamento reprodutivo. Criptorquidia, ginecomastia sintomática e comorbidades exigem avaliação própria. Não há indicação de bomba ou conversão em mL sem produto selecionado.

Fontes verificadas em 25/09/2026: EAA/ESE — Klinefelter; Endo-ERN — indução puberal.

98. Síndrome de Majeed

Suspeita. Osteomielite estéril multifocal recorrente desde a infância, anemia diseritropoiética e inflamação cutânea sugerem síndrome de Majeed relacionada a LPIN2. Confirmar diagnóstico molecular e excluir infecção óssea/malignidade quando apresentação não é típica. Avaliar hemograma, inflamação, dor, crescimento e imagem dos sítios ativos.

Terapia dirigida. GeneReviews atual descreve bloqueio IL-1 como opção: anakinra 1,5 mg/kg/dia SC com titulação pela resposta; canaquinumabe 2 mg/kg a cada quatro ou oito semanas é alternativa descrita. Ambos são off-label para Majeed; a base é experiência limitada, inclusive resposta em famílias, não comparação robusta de regimes. A escolha deve levar em conta atividade óssea, anemia, tolerabilidade e adesão.

Apresentação e cálculo. Anakinra documentada em bula FDA: 100 mg/0,67 mL. Em 16 kg, 1,5 mg/kg =24 mg/dia; volume teórico =24×0,67/100=0,1608 mL. A graduação comercial pode não permitir essa dose com exatidão; preparo/dispositivo pediátrico precisa validação farmacêutica. Não converter para IV sem protocolo específico. Insuficiência renal importante altera exposição e demanda ajuste especializado.

Acompanhamento. Hemograma, função renal/hepática, infecção e marcadores inflamatórios; monitorar lesão óssea e anemia independentemente da febre. AINE/corticoide podem aliviar crises, mas não substituem controle sustentado. Dor focal febril ou piora abrupta reabre diagnóstico de infecção.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — Majeed LPIN2; Estudo primário — IL-1 em Majeed; FDA — Kineret.

99. Síndrome de Muckle-Wells

Definição e risco. Muckle-Wells integra o espectro CAPS associado a NLRP3; inflamação sistêmica, rash urticariforme, artralgia e perda auditiva devem motivar investigação. A doença não é uma urticária alérgica simples. Controlar inflamação entre crises é relevante para prevenir dano auditivo e amiloidose.

Tratamento. Bloqueio de IL-1 é a estratégia dirigida. Na bula FDA de canaquinumabe para CAPS, a partir de 4 anos: 15–40 kg, 2 mg/kg SC a cada oito semanas, com possibilidade de 3 mg/kg se resposta insuficiente; >40 kg, 150 mg SC a cada oito semanas. Não usar o intervalo de quatro semanas de MKD/TRAPS por simples analogia. Concentração e cuidados de aplicação estão no módulo do tema 96; esquemas para <15 kg ou outras idades não são inferidos dessa tabela.

Monitorização. Audiometria, proteinúria/função renal, CRP/SAA quando disponível, atividade cutânea e qualidade de vida. Febre durante bloqueio IL-1 pode representar infecção; a supressão inflamatória modifica a interpretação dos sinais. Preparar vacinação e rastreio de infecção antes do início.

Reavaliação. Persistência de inflamação, deterioração auditiva ou proteinúria requer ajuste especializado, mesmo com poucas crises. AINEs são sintomáticos e não equivalem ao tratamento modificador. Registrar status off-label por idade/indicação e bula nacional aplicável.

Fontes verificadas em 25/09/2026: FDA — Ilaris/CAPS; Registro primário β-Confident — CAPS; Diretriz brasileira de CAPS.

100. Síndrome de Noonan

Avaliação inicial. Noonan exige caracterização cardíaca, crescimento/nutrição, desenvolvimento, audição/visão e risco hemorrágico. Antes de cirurgia, investigar história de sangramento mesmo com contagem plaquetária normal. Diferenciar baixa estatura por síndrome, deficiência hormonal e desnutrição; o genótipo pode modificar riscos.

GH. Somatropina pode melhorar crescimento em elegíveis; avaliação inclui curva de altura, idade óssea, IGF-1, função tireoidiana e cardiologia. A bula internacional de Norditropin admite até 0,066 mg/kg/dia SC para Noonan (até 0,46 mg/kg/semana); isso é teto específico, não dose inicial obrigatória. Em 16 kg, teto diário calculado =1,056 mg, sujeito à dose prescrita e incrementos do dispositivo. Não converter para mL sem conferir qual caneta/concentração; canetas são programadas em mg conforme fabricante.

Segurança. Monitorar velocidade de crescimento, IGF-1, glicemia, tireoide, sintomas de hipertensão intracraniana, dor no quadril e alterações cardíacas. Não usar durante doença crítica aguda; avaliar neoplasia ativa e demais contraindicações. A autorização brasileira para a indicação deve ser conferida por produto.

Outras medidas. Nutrição, intervenção no desenvolvimento e correção cardíaca/ortopédica são dirigidas às manifestações. Antimuscarínico listado no inventário não é tratamento genérico da síndrome. Seguimento multidisciplinar mantém vigilância clínica, sem interpretar GH como terapia curativa.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — Noonan; FDA — Norditropin.

101. Síndrome de Potter

Enquadramento. Sequência de Potter descreve consequências de oligodrâmnio importante, incluindo hipoplasia pulmonar e deformidades; a causa renal/urinária precisa ser definida. Não é um diagnóstico que gere a mesma prescrição de diurético, anti-hipertensivo ou eritropoetina para todos.

Período neonatal. Priorizar respiração, perfusão, temperatura e glicose, com reanimação individualizada e avaliação imediata da função renal/produção urinária. Ultrassonografia renal/urinária, eletrólitos, gasometria e investigação anatômica distinguem agenesia, displasia, doença cística e obstrução. Tratar hipercalemia, acidose e sobrecarga de forma específica; expansão indiscriminada em anúria pode agravar insuficiência respiratória.

Tratamento da causa e suporte. Obstrução pode necessitar descompressão urológica; doença renal irreversível exige discussão de diálise e trajetória de transplante. Hipoplasia pulmonar grave modifica prognóstico e possibilidade de suporte. Anti-hipertensivos são titulados pela PA/perfusão; calcitriol, ferro/eritropoetina e nutrição renal só entram mediante distúrbios documentados, não como pacote automático.

Planejamento. Neonatologia, nefrologia, urologia e família devem construir metas de cuidado compatíveis com anatomia, função pulmonar e possibilidade de terapia renal substitutiva. Seguimento dos sobreviventes inclui crescimento, PA, mineral ósseo e desenvolvimento. Ausência de diurese não justifica repetir furosemida indefinidamente.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NIDDK — doença renal em crianças; GeneReviews — ARPKD/PKHD1 e suporte neonatal.

102. Síndrome de Prader-Willi

Problemas prioritários. Prader-Willi demanda plano para hipotonia/alimentação inicial, hiperfagia, composição corporal, desenvolvimento e distúrbios respiratórios do sono. Dor ou vômito podem ser pouco expressivos diante de distensão gástrica grave; mudança comportamental, abdome distendido ou deterioração justificam avaliação urgente.

GH em elegíveis. A bula internacional Genotropin descreve 0,24 mg/kg/semana SC, dividido em seis ou sete aplicações. Se sete, equivale a aproximadamente 0,0343 mg/kg/dia. Em 16 kg: 3,84 mg/semana; 0,5486 mg/dia em sete doses, arredondado ao dispositivo e plano endocrinológico. A dose não deve ser derivada cegamente de obesidade sem avaliação antropométrica.

Antes/durante. Polissonografia antes do início e reavaliação após início, além de avaliação respiratória, IGF-1, tireoide e glicemia. Obesidade grave, apneia/obstrução respiratória grave e infecção respiratória importante exigem consideração das contraindicações/alertas da bula. Monitorar escoliose e dor de quadril. Acompanhamento nutricional estruturado é indispensável; GH não autoriza acesso alimentar irrestrito.

Outras terapias. Reposição de hormônios sexuais, vitamina D/cálcio e tratamento de constipação dependem de achados. Não há indicação de antimuscarínico rotineiro pela síndrome. Registro nacional, caneta/concentração e dose prática devem ser conferidos; não se fornece volume de uma apresentação presumida.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — Prader-Willi; FDA — Genotropin, julho/2026.

103. Síndrome de Shwachman-Diamond

Avaliação. Insuficiência pancreática exócrina, neutropenia/falência medular e alterações esqueléticas sugerem Shwachman-Diamond. Acompanhar hemograma, crescimento, elastase/função pancreática, vitaminas lipossolúveis e saúde óssea. Febre com neutropenia deve ser tratada conforme risco infeccioso, sem atribuição automática à síndrome.

Reposição enzimática. Se insuficiência pancreática, administrar pancrelipase junto às refeições. Referência de bula internacional: >12 meses a <4 anos, iniciar 1.000 unidades de lipase/kg/refeição; ≥4 anos, 500 unidades/kg/refeição. Não ultrapassar sem investigação 2.500 unidades/kg/refeição ou 10.000 unidades/kg/dia; em lanches, geralmente metade da dose da refeição. Lactentes têm esquema próprio por alimentação e não devem receber automaticamente a dose por kg de crianças maiores.

Administração. Dose é em **unidades de lipase**, não em mg de pancreatina. Não triturar/mastigar microgrânulos gastrorresistentes; seguir a compatibilidade alimentar da bula. Concentrações de cápsulas não são intercambiáveis pelo número de cápsulas. Em 10 kg com 2 anos: dose inicial 10.000 unidades por refeição; reversa =1.000 unidades/kg.

Seguimento. Ajustar por esteatorreia, ingestão e crescimento, evitando escalada que aumente risco de colonopatia fibrosante. Repor vitaminas conforme resultados. Alterações clonais, citopenias progressivas ou infecção grave exigem hematologia; transplante pode tratar falência medular selecionada, mas não substitui suporte pancreático.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — Shwachman-Diamond; FDA — Creon.

104. Síndrome de Turner

Avaliação. Turner requer acompanhamento de aorta/coração, PA, rins, audição, tireoide, crescimento, puberdade e fertilidade. Dor torácica/dorsal aguda, síncope ou dispneia não devem ser tratadas apenas como ansiedade; considerar emergência aórtica segundo contexto.

Crescimento. Diretriz internacional 2024 recomenda GH em baixa estatura/falha de crescimento, geralmente 45–50 mcg/kg/dia SC, podendo chegar a 68 mcg/kg/dia em resposta inadequada selecionada. Avaliar idade óssea, IGF-1 e crescimento; não usar após fechamento epifisário. Produto/caneta determinam incremento e concentração, sem conversão automática de UI para mg.

Indução puberal. Se insuficiência ovariana com FSH elevado confirmado, iniciar estradiol em baixa dose aproximadamente aos 11–12 anos e aumentar gradualmente ao longo de anos para reproduzir puberdade. Preferir 17β-estradiol quando apropriado; a via transdérmica pode ser vantajosa. Progestagênio é adicionado conforme exposição estrogênica, sangramento e maturação endometrial; não começar esquema adulto combinado de forma automática. Dose de estradiol depende de produto, via, fase e crescimento residual.

Monitorização. PA, crescimento, IGF-1, sintomas de hipertensão intracraniana, glicemia, tireoide e saúde óssea; estratégia cardiovascular permanece mesmo com bom crescimento. A prescrição hormonal deve especificar massa por aplicação e intervalo, principalmente quando se fraciona adesivo com características próprias.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Diretriz internacional Turner 2024 — texto integral; ESE — publicação oficial da diretriz.

105. TRAPS (Síndrome Periódica Associada ao Receptor 1 de Fator de Necrose Tumoral)

Identificação. TRAPS é uma síndrome autoinflamatória relacionada a TNFRSF1A; crises febris prolongadas, mialgia, rash migratório, dor abdominal e edema periorbitário orientam investigação. A confirmação exige integração genética/fenotípica; variante isolada de penetrância incerta não equivale a doença ativa.

Tratamento dirigido. Bloqueio de IL-1 é opção central no controle sustentado. O esquema de canaquinumabe para TRAPS é o mesmo módulo ponderal descrito no tema 96: intervalo de quatro semanas, com escalada prevista conforme resposta. Não usar a frequência de oito semanas de Muckle-Wells por engano. Corticoide pode reduzir sintomas de crises, mas recorrência/dependência e inflamação persistente favorecem tratamento modificador.

Metas. Ausência de crises incapacitantes e supressão da inflamação entre episódios, com vigilância de proteinúria/amiloidose. Etanercepte possui experiência em casos selecionados; não se deve tratar todos os anti-TNF como equivalentes, e infliximabe pode produzir respostas paradoxais em TRAPS.

Segurança. Investigar infecção ativa, atualizar vacinas e monitorar hemograma, função renal/hepática e inflamação. Febre em paciente em biológico exige avaliar infecção antes de aumentar a dose. Seguimento inclui aconselhamento genético e documentação de resposta por episódio. Registro nacional e dose prática mensurável precisam ser confirmados para o produto dispensado.

Fontes verificadas em 25/09/2026: GeneReviews — TRAPS; FDA — canaquinumabe, módulo do tema 96.

106. Linfo-histiocitose Hemofagocítica

Emergência hiperinflamatória. Febre persistente, citopenias, esplenomegalia, ferritina elevada, coagulopatia, hepatite e disfunção orgânica devem motivar avaliação imediata de HLH. Hemofagocitose pode estar ausente inicialmente e não é necessária para iniciar investigação/tratamento em paciente deteriorando. Colher hemograma, ferritina, triglicerídeos, fibrinogênio, INR, função hepática/renal e pesquisa etiológica.

Tratamento por contexto. Suporte intensivo e tratamento de infecção/neoplasia desencadeante ocorrem em paralelo à imunomodulação. Para doença em que se indica protocolo baseado em etoposídeo, HLH-94 permanece referência: dexametasona 10 mg/m²/dia nas semanas 1–2, 5 mg/m²/dia nas 3–4, 2,5 nas 5–6, 1,25 na 7, depois retirada na 8; etoposídeo 150 mg/m² IV duas vezes/semana nas primeiras duas semanas e semanal depois. Esses esquemas são de centro especializado, com ajustes por função orgânica e toxicidade; não se aplica teto de corticoide de outras indicações.

Pontos críticos. Superfície corporal, idade/peso, função renal/hepática e preparação oncológica são obrigatórios para calcular dose total/infusão. A fórmula de Mosteller é SC = raiz de [altura(cm)×peso(kg)/3.600]. Não executar quimioterapia com altura presumida. Ciclosporina, terapias intratecais, anti-IFNγ e transplante dependem de subtipo/estágio.

Metas. Tendência de ferritina, citopenias, fibrinogênio e função orgânica. UTI se choque, hipóxia, alteração neurológica ou falência progressiva.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Histiocyte Society — recomendações etoposídeo/HLH; Estudo cooperativo HLH-2004; EULAR/ACR — suspeita precoce HLH/MAS.

107. Queixas Genitais em Meninas Pré-púberes

Avaliação respeitosa e dirigida. Vulvovaginite irritativa é comum antes da puberdade; também considerar oxiúros, dermatose, corpo estranho, infecção urinária, trauma e situações que exijam proteção. Evitar exame vaginal interno/coleta intravaginal na pré-púbere. História, exame externo e coleta de urina quando indicada orientam a abordagem.

Primeira linha. Reduzir sabonetes/perfumes/banhos irritantes, umidade e roupas apertadas; higiene suave da frente para trás, secagem e barreira cutânea quando apropriada. Candidíase é incomum fora de contextos predisponentes e não justifica antifúngico empírico repetido. Prurido noturno sugere enterobíase, tratada no tema 83.

Tratamento direcionado. Secreção purulenta/fétida, eritema intenso ou suspeita de estreptococo devem motivar avaliação/coleta externa e antibiótico guiado por agente. Corpo estranho exige remoção apropriada, não sucessivos antibióticos. Liquen escleroso necessita reconhecimento e corticoide tópico específico em seguimento especializado; aderência labial assintomática geralmente não precisa separação traumática.

Reavaliação/destino. Dor importante, retenção urinária, sangramento, lesão traumática ou suspeita de abuso exigem atendimento qualificado urgente, sem múltiplos exames desnecessários. Persistência após medidas simples pede revisão diagnóstica. O inventário de penicilina/inibidor de betalactamase não constitui indicação de amoxicilina-clavulanato em toda queixa genital.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — condições vulvares e vaginais.

108. Sangramento Uterino Anormal em Pediatria

Gravidade e exames. Instabilidade, síncope, sangramento intenso ou anemia sintomática exigem estabilização e avaliação ginecológica. Excluir gestação e distúrbio hemorrágico; solicitar hemograma/ferritina, coagulação e outros exames dirigidos. Anovulação é frequente, mas não explica automaticamente todo sangramento.

Controle. Referência RCH 2025: ácido tranexâmico 15–25 mg/kg VO, máximo 1 g/dose, duas ou três vezes/dia nos dias de sangramento intenso. Avaliar trombose, função renal e contraindicações. Para terapia hormonal de sangramento anovulatório ativo, noretisterona 5–10 mg VO três vezes/dia por dez dias, com retirada gradual, é uma opção; medroxiprogesterona é alternativa com regime próprio. Não suspender abruptamente

progestagênio em esquema hemostático sem planejar o sangramento de privação.

Reposição e seguimento. Tratar deficiência de ferro conforme tema 111. Se instável ou com sangramento persistente, hemoterapia e internação podem ser necessárias. Anticoncepcional combinado em altas frequências exige avaliação de risco trombótico, enxaqueca com aura, hepatopatia e contraindicações; não associar estrogênio automaticamente ao tranexâmico. Em suspeita de coagulopatia, evitar AINE até esclarecer.

Metas. Reduzir fluxo, corrigir sintomas/anemia, estabelecer prevenção de recorrência e reavaliar resposta em curto prazo. Investigação de doença de von Willebrand pode precisar repetição fora de estresse agudo; resultado inicial normal não encerra todos os casos.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — sangramento menstrual, junho/2025; ASH/ISTH — doença de von Willebrand.

109. Anemia de Fanconi

Confirmar e monitorar. Falência medular, malformações e predisposição neoplásica exigem confirmação de Fanconi por testes especializados/genéticos. Hemograma e avaliação medular/citogenética seriados detectam evolução; a ausência de malformações não exclui. Planejar tipagem de doadores antes de deterioração avançada quando indicado.

Tratamento. Transplante de células hematopoéticas é a terapia curativa estabelecida para manifestações hematológicas, com condicionamento adaptado à hipersensibilidade ao dano de DNA. Não elimina todos os riscos de tumores sólidos. Andrógenos podem melhorar contagens em pacientes selecionados sem transplante imediato, mas não corrigem o defeito e exigem vigilância hepática/endócrina; não devem ser iniciados como tratamento genérico da pancitopenia.

G-CSF e suporte. Fator estimulador pode ser considerado em neutropenia com infecção/indicação definida, evitando uso automático apenas por contagem baixa. Hemocomponentes devem ser selecionados em conjunto com centro transplantador; não atrasar transfusão indispensável em sangramento/instabilidade. Febre com neutropenia segue atendimento urgente do tema 118.

Segurança/seguimento. Monitorar fígado, crescimento, puberdade, clones medulares e neoplasias, além de toxicidade do tratamento. Citopenias novas, blastos ou infecções recorrentes alteram a prioridade de transplante. A prescrição de andrógeno e fator estimulador depende de produto, estágio e plano especializado; dose de anemia adquirida não é automaticamente apropriada.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Fanconi Cancer Foundation — diretriz hematológica; GeneReviews — Fanconi 2026.

110. Anemia Falciforme em Pediatria

Plano preventivo. Confirmar genótipo, vacinação, profilaxia antimicrobiana e avaliação de complicações; orientar família sobre febre, aumento súbito do baço, palidez, dor torácica e déficit neurológico. Acompanhamento inclui crescimento, hemograma/reticulócitos, função renal e rastreio cerebrovascular quando indicado.

Hidroxiureia — PCDT brasileiro 2024. Iniciar 15 mg/kg/dia VO em dose única; aumentar em 5 mg/kg/dia a cada quatro semanas até 35 mg/kg/dia ou toxicidade/limite tolerado. Apresentações citadas: cápsula 500 mg e comprimido revestido 100 mg. Hemograma/reticulócitos e função renal/hepática guiam titulação; não escalar durante citopenia relevante. Crianças pequenas podem ser elegíveis a partir de 9 meses conforme genótipo/critérios do PCDT. Formulação fracionada/líquida exige preparo validado, não dissolução improvisada.

Profilaxia penicilina. O PCDT informa penicilina V 125 mg de 12/12 h no grupo menor e 250 mg de 12/12 h no grupo maior, com critérios etários/ponderais. A tabela contém fronteiras que exigem seleção explícita no paciente; registrar o regime do centro. A equivalência apresentada é 50 mg/mL: 125 mg=2,5 mL; 250 mg=5 mL, somente nessa concentração.

Seguimento. Adesão, efeitos adversos e resposta clínica importam além da HbF. Hidroxiureia não é analgésico de resgate; crises agudas seguem tema 113.

Fontes verificadas em 25/09/2026: MS — PCDT doença falciforme 2024.

111. Anemias Carenciais em Pediatria

Definir deficiência. Hemograma, reticulócitos, ferritina interpretada com inflamação e história alimentar/hemorrágica orientam ferropriva. Macrocitose, neutrófilos hipersegmentados ou sinais neurológicos exigem avaliação de B12/folato; tratar apenas folato pode mascarar deficiência de B12. Investigar perda sanguínea, má absorção e restrição alimentar quando pertinentes.

Ferro. Dose de tratamento: 3–6 mg/kg/dia de ferro **elementar** VO; usar limite superior em anemia mais intensa selecionada. A massa de sulfato ferroso não equivale à massa de ferro elementar. Para concentração confirmada C mg de ferro elementar/mL, volume diário = peso×dose/C. Exemplo 16 kg a 3 mg/kg/dia =48 mg/dia; se o produto rotulado contiver exatamente 25 mg de ferro elementar/mL, seriam 1,92 mL/dia. Essa é conversão condicional, não declaração de apresentação comercial verificada.

Resposta. Rever reticulócitos/Hb precocemente em casos graves e em semanas nos demais; manter reposição por pelo menos três meses após correção da anemia para repor estoques. Falha pede verificar adesão, dose elemental, perdas e diagnóstico antes de ferro IV.

B12/folato e destino. Deficiência de B12 com regressão neurológica exige tratamento urgente por esquema pediátrico específico e investigação materna/alimentar. Transfusão depende de instabilidade/sintomas, não de um limiar isolado aplicado a toda anemia crônica.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — deficiência de ferro; RCH — micronutrientes.

112. Anticoagulação em Pediatria

Indicação. Confirmar trombose, extensão, causa, risco de sangramento e função renal. ASH/ISTH atualizada diferencia trombose provocada selecionada, na qual seis semanas podem bastar, de eventos que exigem curso maior. Profilaxia não equivale a tratamento; não anticoagular toda criança hospitalizada por analogia com adulto.

Enoxaparina — referência hospitalar RCH. Tratamento SC de 12/12 h: <10 kg, 1,5 mg/kg/dose; 10–50 kg, 1 mg/kg/dose. Essa estratificação por peso difere de referências que usam corte etário de 2 meses. Selecionar uma referência e ajustar por anti-Xa, sem misturar tabelas. O produto descrito é 100 mg/mL: 16 kg a 1 mg/kg=16 mg=0,16 mL; reversa 0,16×100/16=1 mg/kg. Doses pequenas exigem seringa mensurável/preparo farmacêutico, não diluição caseira.

Monitorização. Anti-Xa terapêutico usual 0,5–1 U/mL, amostra aproximadamente quatro horas após dose, além de hemograma, plaquetas e função renal. Insuficiência renal exige individualizar dose/intervalo; TTPa normal não demonstra ausência de efeito de HBPM. Evitar IM e planejar suspensão para procedimentos neuraxiais.

Outros agentes. Heparina não fracionada favorece titulação/reversibilidade em certos cenários; bomba = U/kg/h×peso/C(U/mL). Varfarina requer ponte quando indicada e INR; DOACs têm elegibilidade específica por idade/peso/doença. Não transpor doses entre indicações.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — enoxaparina; ASH/ISTH — TEV pediátrico 2025; RCH — anticoagulação.

113. Crises Falcêmicas em Pediatria

Identificar a crise. Dor vaso-oclusiva é diagnóstico clínico, mas febre, hipóxia, dor torácica, déficit focal, priapismo, baço aumentado ou queda rápida de Hb exigem procurar complicação específica. Obter hemograma/reticulócitos, tipagem quando indicada e exames direcionados; não atrasar analgesia esperando laboratório.

Conduta imediata. Avaliar ABCDE, fornecer analgesia precoce titulada e reavaliar em intervalos curtos. Dor intensa: RCH utiliza morfina 0,05 mg/kg/dose IV, com repetição titulada e monitorização respiratória/sedação; individualizar por tolerância e resposta. Em 16 kg, dose inicial de referência = 0,8 mg; concentração/preparo devem seguir produto e protocolo institucional. Hidratação deve corrigir déficit e manter euvolemia, evitando hiper-hidratação. Oxigênio é indicado por hipoxemia, não obrigatoriamente por diagnóstico. Incentivo

respiratório durante internação pode reduzir complicações pulmonares.

Complicações. Síndrome torácica aguda requer oxigenação, antibiótico cobrindo agentes típicos/atípicos, controle de dor sem hipoventilação e decisão de transfusão simples ou troca conforme gravidade. Déficit neurológico agudo mobiliza protocolo de AVC e transfusão/troca emergencial. Sequestro esplênico exige suporte/transfusão cautelosa; aplasia se diferencia pela resposta reticulocitária. Transfundir crise dolorosa não complicada rotineiramente não é apropriado.

Destino. Internar se dor sem controle oral, febre relevante, hipóxia, incapacidade de hidratar ou complicação. UTI para insuficiência respiratória, choque ou déficit neurológico. O plano de alta inclui analgesia definida, retorno por febre/dor torácica e revisão da prevenção do tema 110.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — doença falciforme; ASH — diretrizes falciforme.

114. Deficiência de Fator VII

Confirmação. Deficiência congênita de FVII pode prolongar TP/INR isoladamente; nível do fator e história hemorrágica devem ser correlacionados. Excluir deficiência de vitamina K, hepatopatia e anticoagulante. O número do INR não define sozinho intensidade de sangramento.

Sangramento/procedimento. Bula NovoSeven RT: eptacogue alfa ativado/rFVIIa 15–30 mcg/kg IV a cada 4–6 h até hemostasia, individualizando resposta. Reconstituir apenas com diluente próprio: concentração final aproximada 1 mg/mL =1.000 mcg/mL. Dose de 30 mcg/kg em 16 kg =480 mcg=0,48 mg=0,48 mL; reversa 0,48×1.000/16=30 mcg/kg. Administração em bolus IV conforme produto; não converter esse regime em bomba contínua sem protocolo específico.

Segurança. Vigiar trombose, hipersensibilidade, falha por inibidor e sangramento persistente; coagulação laboratorial não substitui resposta clínica. Não associar concentrados ativados de complexo protrombínico indiscriminadamente. A unidade é mcg/kg, diferente de UI/kg de outros fatores. Preparação/diluente não são intercambiáveis entre fabricantes.

Destino. Sangramento intracraniano suspeito, gastrointestinal importante ou instabilidade requer reposição imediata e centro de hemofilia/UTI. Profilaxia de longo prazo depende do fenótipo e não é indicada apenas por fator baixo assintomático. Evitar AINEs e procedimentos sem planejamento de hemostasia.

Fontes verificadas em 25/09/2026: FDA — NovoSeven RT.

115. Deficiência de Fator XIII

Diagnóstico. Sangramento tardio, sangramento umbilical persistente, má cicatrização ou hemorragia intracraniana com TP/TTPa normais podem sugerir deficiência de FXIII. Solicitar atividade específica do fator; testes usuais de coagulação não a excluem.

Reposição/profilaxia. Bula internacional de concentrado humano Corifact: 40 UI/kg IV a cada 28 dias para profilaxia, ajustando em incrementos de 5 UI/kg pela atividade residual, alvo de vale 5–20% no método da bula. Dose perioperatória é individualizada pelo nível, cirurgia e tempo da última dose. A velocidade máxima descrita é 4 mL/min; em pequenos, escolher tempo tolerável e volume conforme concentração real do frasco.

Cálculo. Para 16 kg: 640 UI. Volume =640/C(UI/mL). A potência efetiva pode variar por frasco; não presumir concentração única apenas pelo nome comercial. Reversa: volume×C/16 deve recuperar 40 UI/kg. Produto recombinante de subunidade A não equivale automaticamente ao concentrado humano na deficiência de subunidade B; identificar o defeito.

Monitorização/destino. Resposta hemorrágica, atividade de FXIII, hipersensibilidade, trombose e suspeita de inibidor. Sangramento grave demanda atendimento imediato, reposição e suporte conforme sítio. O tratamento preventivo reduz risco de eventos que podem ocorrer com exames básicos normais; garantir disponibilidade de plano de urgência.

Fontes verificadas em 25/09/2026: FDA — Corifact.

116. Doença de Von Willebrand na Infância

Definir tipo e resposta. Investigar história hemorrágica, atividade/antígeno de VWF e FVIII; estresse e inflamação podem elevar resultados e exigir repetição. Tipo 1, variantes tipo 2 e tipo 3 têm resposta terapêutica distinta.

Desmopressina. Em paciente apropriado, testar resposta antes de depender dela para procedimento. Dose IV habitual do teste na diretriz é 0,3 mcg/kg, máximo 20 mcg. Restrição de água livre e monitorização de sódio são fundamentais. Em geral evitar <2 anos, história de convulsões e risco cardiovascular; tipo 2B pode piorar trombocitopenia e tipo 3 não responde. Não confundir solução nasal concentrada hemostática com apresentação antidiurética.

Concentrado e adjuvantes. Sangramento grave, cirurgia maior ou resposta inadequada requerem concentrado contendo VWF, com dose definida em unidades de atividade do VWF e monitorização de VWF/FVIII. Tranexâmico ajuda em mucosa e procedimentos menores, conforme risco/renal. Para cirurgia maior, diretriz favorece manter VWF e FVIII ≥0,50 UI/mL por pelo menos três dias, individualizando o procedimento.

Seguimento. Evitar AAS/AINE sem justificativa específica; tratar perda crônica de ferro e menorragia. Hemorragia de SNC, gastrointestinal importante ou instabilidade requer internação e plano hematológico urgente. Dose, diluição e via de desmopressina precisam conferir apresentação real antes de converter para mL.

Fontes verificadas em 25/09/2026: ASH/ISTH/NHF/WFH — manejo VWD; ASH — documentos oficiais VWD.

117. Doença do Soro

Diferenciar. Febre, rash e artralgia após exposição podem indicar doença do soro ou reação semelhante à doença do soro. A segunda é frequentemente associada a medicamentos e pode não apresentar hipocomplementemia/lesão renal. Mucosite importante, bolhas, púrpura, choque, dispneia ou disfunção de órgão exigem outro diagnóstico grave.

Tratamento principal. Identificar e retirar o medicamento/agente suspeito, documentando temporalidade e reação. Analgesia e anti-histamínico podem aliviar sintomas; AINE somente se função renal, hidratação e risco gastrointestinal permitirem. Corticoide sistêmico pode ser considerado em manifestação grave, mas a evidência não sustenta uma dose universal para toda reação leve.

Investigação. Casos típicos leves podem ser clínicos. Urina, função renal, complemento e exames adicionais são úteis quando há suspeita de doença do soro verdadeira, vasculite ou comprometimento sistêmico. Se o medicamento é essencial, avaliação especializada ajuda a decidir alternativa e risco de reexposição; não reintroduzir simplesmente por melhora do rash.

Reavaliação/destino. A melhora deve ocorrer após interrupção, mas artralgia/rash podem demorar a resolver. Internar se incapacidade de andar/hidratar, dor intensa, diagnóstico incerto ou órgão comprometido. Registrar o agente suspeito com descrição da reação, evitando rótulo inespecífico de anafilaxia sem critérios.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — doença do soro e reação semelhante.

118. Neutropenia Febril em Pediatria

Urgência. Febre em neutropenia oncológica ou suspeita exige avaliação imediata; instabilidade pode ocorrer sem foco exuberante. ABCDE, hemoculturas periféricas/cateter sem atrasar antimicrobiano, hemograma e função renal/hepática. Evitar toque retal. Administrar primeiro antibiótico em até 60 minutos, mais cedo no choque.

Empírico hospitalar. RCH: piperacilina-tazobactam 100 mg/kg/dose do **componente piperacilina** IV de 6/6 h, máximo 4 g de piperacilina/dose; faixa neonatal/lactente jovem e função renal exigem ajuste. Cefepima 50 mg/kg/dose IV de 8/8 h, máximo 2 g, é alternativa prevista conforme alergia/cenário. Não confundir 4 g de piperacilina com 4,5 g da associação. Sepse, colonização/resistência e foco modificam cobertura.

Escalada racional. Vancomicina não é necessária apenas por febre persistente em paciente estável; considerar infecção de cateter/pele, MRSA e instabilidade. Cobertura anaeróbia se foco abdominal/perineal e

betalactâmico inicial não a fornecer. Antifúngico em febre prolongada é baseado no risco e investigação, não no dia de febre isoladamente. Aminoglicosídeo exige função renal/níveis e não deve correr simultaneamente na mesma linha do betalactâmico incompatível.

Destino/monitorização. Internação e estratificação oncológica; tratamento ambulatorial apenas em percurso validado de baixo risco. Rever culturas/renal e descalonar quando possível. Para infusão, mL/h=volume final validado/tempo(h); não inventar reconstituição por nome genérico.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — febre e neutropenia; RCH — antimicrobianos.

119. Síndrome de Ativação Macrofágica em Pediatria

Reconhecimento. Síndrome de ativação macrofágica é fenótipo de HLH associado frequentemente a doença reumatológica. Febre persistente, ferritina crescente, queda de plaquetas, fibrinogênio baixo, transaminases e disfunção orgânica são sinais importantes; velocidade de mudança pode ser mais útil que limiar isolado. Excluir/tratar infecção em paralelo.

Tratamento imediato. Em quadro progressivo, não aguardar todos os critérios formais. EULAR/ACR admite glicocorticoide, anakinra e/ou imunoglobulina IV como imunomodulação empírica conforme contexto. Pulsos de metilprednisolona 10–30 mg/kg/dia IV, máximo 1 g/dia, são usados em doença grave; número de dias e redução dependem de resposta/etiologia. Exemplo 16 kg a 30 mg/kg=480 mg, abaixo de 1 g. Preparo e tempo de infusão requerem produto e vigilância cardíaca/metabólica.

Resgate e diferenciação. Anakinra, ciclosporina, anti-IFNγ ou terapia baseada em etoposídeo podem ser necessários, porém MAS reumatológica não recebe automaticamente todo HLH-94. Avaliar SNC, citopenias, infecções, função renal/hepática e gatilho antes da seleção. Uso de anakinra IV é fora da via de bula e exige protocolo específico.

Metas/destino. Tendência de ferritina, fibrinogênio, plaquetas, fígado, consciência e suporte orgânico. Choque, encefalopatia ou falência respiratória requer UTI. Remissão clínica sem recuperação laboratorial suficiente exige seguimento estreito.

Fontes verificadas em 25/09/2026: EULAR/ACR — manejo inicial HLH/MAS; Histiocyte Society — etoposídeo em HLH.

120. Síndrome de Evans

Confirmar a combinação. Síndrome de Evans associa anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia imune, simultâneas ou sequenciais; pode coexistir neutropenia. Investigar hemólise (reticulócitos, bilirrubina, LDH, haptoglobina, Coombs), esfregaço e causas secundárias como imunodeficiência, ALPS, lúpus, infecção e neoplasia. Não confundir com microangiopatia trombótica.

Tratamento inicial. Corticoide é frequentemente primeira estratégia; série brasileira pediátrica utilizou prednisona 1–2 mg/kg/dia após indução em parte dos casos. Essa experiência observacional não define o regime ótimo universal nem autoriza curso prolongado sem redução planejada. Imunoglobulina IV pode ser útil quando a manifestação predominante é trombocitopenia com sangramento, conforme módulo de PTI (tema 123), sendo menos previsível para hemólise.

Suporte/resgate. Anemia com instabilidade pode exigir transfusão apesar de dificuldades de compatibilidade, coordenada com hemoterapia; não esperar uma compatibilidade perfeita impossível diante de risco vital. Refratariedade/dependência de corticoide motiva investigação imune e escolha entre rituximabe, micofenolato, sirolimo e outras estratégias, conforme mecanismo. Esplenectomia não é reflexo automático em criança.

Monitorização. Hemograma/reticulócitos, hemólise, infecção e toxicidade de imunossupressão; acompanhar recaídas de cada linhagem. Sangramento grave, hemólise rápida ou neutropenia febril requer internação/UTI. Registrar limitações da evidência e objetivo de poupar corticoide.

Fontes verificadas em 25/09/2026: Estudo primário brasileiro — Evans pediátrica; RCH — PTI.

121. Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (SAF) em Pediatria

Diagnóstico. SAF pediátrica exige evento clínico compatível e anticorpos persistentes, distinguindo positividade transitória após infecção. Pesquisar anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG/IgM e anti-β2-glicoproteína I IgG/IgM; confirmar persistência com intervalo adequado, usualmente ≥12 semanas. Testes durante anticoagulação podem ser afetados.

Trombose. Tratar evento agudo com heparina/HBPM conforme tema 112 e planejar manutenção. Na SAF trombótica persistente, anticoagulação de longo prazo com antagonista da vitamina K costuma ser utilizada; alvo INR depende de evento venoso/arterial, recorrência e risco hemorrágico. Não substituir por DOAC automaticamente, especialmente em perfil de alto risco/tripla positividade. A dose de varfarina é guiada por INR e interações, não fórmula fixa perpetuamente.

Sem trombose. Anticorpo positivo isolado não determina anticoagulação terapêutica. AAS em prevenção selecionada, particularmente em lúpus com perfil de risco, deve ponderar sangramento, atividades e persistência; hidroxicloroquina trata contexto autoimune pertinente, não todo teste positivo.

SAF catastrófica. Trombose multiorgânica rápida demanda UTI, anticoagulação e tratamento imunomodulador/plasmaférese conforme equipe multidisciplinar, além do gatilho infeccioso. Não aguardar confirmação tardia de anticorpo para estabilizar.

Seguimento. Adesão, INR, hemograma, rim e prevenção de fatores trombóticos; revisar anticoncepcionais com estrogênio e planejamento de procedimentos.

Fontes verificadas em 25/09/2026: SHARE — recomendações pediátricas SAF; PReS — texto da recomendação.

122. Síndrome Hemolítico-Urêmica em Pediatria

Identificar o mecanismo. Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão renal sugerem SHU. Solicitar esfregaço, hemólise, função renal/eletrólitos, urina e investigação de STEC/Shiga-toxina; considerar complemento e ADAMTS13 quando diferencial. Diarreia não exclui SHU mediada por complemento.

STEC-SHU. Suporte de volume cuidadosamente ajustado, PA, eletrólitos e diálise por indicação; evitar antibiótico/antimotilidade rotineiro na infecção por STEC. Concentrado de hemácias por necessidade clínica; plaquetas não são profilaxia automática sem sangramento/procedimento. Complicação neurológica ou sobrecarga exige UTI.

SHU atípica — eculizumabe (bula FDA). Indução/manutenção IV: 5–<10 kg, 300 mg semana 1 e 300 mg semana 2, depois a cada três semanas; 10–<20 kg, 600 mg semana 1, depois 300 mg semana 2 e a cada duas semanas; 20–<30 kg, 600 mg semanal por duas semanas, depois 600 mg a cada duas semanas; 30–<40 kg, mesma indução, depois 900 mg; ≥40 kg, 900 mg semanal×4, depois 1.200 mg na semana 5 e a cada duas semanas. Exige prevenção meningocócica; urgência pode requerer antibiótico profilático quando vacinação não precede tratamento. Não indicado para STEC-SHU como rotina.

Preparo. Frasco 300 mg/30 mL=10 mg/mL; diluir com igual volume de NaCl 0,9%, final 5 mg/mL. Crianças: infusão em 1–4 h. Dose 300 mg → 60 mL; em 2 h=30 mL/h; reversa 30×2×5=300 mg. Monitorar reação e infecção.

Fontes verificadas em 25/09/2026: NIDDK — SHU infantil; FDA — Soliris, 2026.

123. Trombocitopenia Primária Imune

Diagnóstico e gravidade. PTI é trombocitopenia isolada em criança tipicamente bem, com esfregaço compatível e exclusão de alternativas. Dor óssea, organomegalia, outras citopenias ou sintomas constitucionais mudam investigação. Tratar sangramento e risco clínico, não normalizar contagem a qualquer custo.

Observação. Petéquias/equimoses sem hemorragia relevante geralmente permitem acompanhamento sem medicamento, com orientação de trauma/retorno e hemograma/revisão em aproximadamente uma semana. Evitar AAS/AINE e contato de alto impacto.

Quando tratar. Sangramento mucoso significativo: RCH descreve prednisolona VO 2–4 mg/kg/dia, máximo 100 mg/dia, por 4–7 dias. Se necessidade de aumento rápido ou resposta inadequada, imunoglobulina IV 0,8–1 g/kg, discutida com hematologia. Escolher produto IVIg e velocidade de escalonamento por bula; não existe mL/h único válido para todas as concentrações. Exemplo condicional: dose 1 g/kg em 16 kg=16 g; produto 100 mg/mL implica 160 mL, mas taxa deve seguir a formulação e risco renal/trombótico.

Hemorragia ameaçadora à vida. Internação/UTI, imunoglobulina+corticoide e plaquetas como hemostasia emergencial, sem esperar resposta lenta de medicamento; intervenção específica ao sítio. Anti-D, rituximabe e agonistas de receptor de trombopoetina são opções selecionadas, com critérios próprios.

Monitorização. Sangramento, Hb, pressão, glicemia, reação infusional, hemólise/trombose e função renal quando IVIg. Refratariedade exige revisar diagnóstico. A atualização ASH de 2026 consultada é dirigida a adultos e não foi extrapolada à criança.

Fontes verificadas em 25/09/2026: RCH — PTI; ASH — diretrizes ITP.

124. Abscesso Dentário

Avaliação e gravidade. Confirmar origem odontogênica; procurar cárie, flutuação, extensão facial e drenagem. Trismo progressivo, elevação do assoalho bucal, sialorreia, disfagia, estridor, toxicidade ou edema orbitário exigem emergência hospitalar e avaliação da via aérea. O tratamento definitivo é odontológico, com drenagem e tratamento/exodontia do dente causal. Antibiótico isolado não elimina esse foco.

Exames e tratamento. Radiografia odontológica quando modifica a intervenção; TC com contraste se suspeita de espaço profundo, sem atrasar estabilização. Abscesso localizado, drenável, em criança bem e sem extensão não implica antibiótico sistêmico. Quando houver celulite associada, febre ou disseminação: amoxicilina 22,5 mg/kg/dose VO a cada 12 horas, máximo 875 mg/dose, geralmente 5–7 dias, com reavaliação em 48 horas. Na suspensão 50 mg/mL: 0,45 mL/kg/dose, respeitado o teto. A falha exige reavaliar drenagem e foco, antes de simplesmente ampliar espectro; amoxicilina/clavulanato pode ser escolhida em infecção polimicrobiana com falha comprovada, após conferir a proporção da apresentação.

Segurança e destino. Alergia imediata a betalactâmicos exige alternativa individualizada; clindamicina não é escolha automática por risco de colite. Ajustar betalactâmico na insuficiência renal. Manter analgesia do módulo comum, higiene oral e retorno imediato se dificuldade respiratória, deglutição comprometida ou progressão do edema.

Fontes: AAPD — antibioticoterapia odontológica; AAPD — medicamentos e doses

125. Actinomicose na Infância

Reconhecimento. Massa endurecida e crônica, fístulas que atravessam planos teciduais ou supuração cervicofacial após doença odontológica justificam investigar actinomicose. Não concluir o diagnóstico pela aparência: neoplasia, tuberculose, micobacteriose não tuberculosa e abscesso piogênico são diferenciais relevantes. Estridor, extensão profunda, sepse ou déficit neurológico determinam internação.

Confirmação e tratamento. Colher tecido ou aspirado profundo para histopatologia e cultura anaeróbia prolongada, informando a hipótese ao laboratório; swab superficial tem menor utilidade. Imagem delimita abscesso e comprometimento ósseo; RM é útil quando se suspeita de osteomielite. A abordagem combina controle do foco, eventual desbridamento e penicilina ou amoxicilina por período prolongado. A série pediátrica consultada descreve tratamentos de meses e ampla heterogeneidade; não sustenta uma única dose/duração para todas as localizações.

Aplicação prática. Iniciar a definição do esquema com infectologia e cirurgia após coletar material, sem adiar antibiótico em instabilidade. Não substituir por metronidazol isolado apenas por se tratar de anaeróbio. Para qualquer esquema escolhido, registrar dose em mg ou UI, frequência, função renal e objetivo de duração; mL = dose prescrita/concentração efetivamente preparada. Monitorar hemograma, função renal/hepática e redução seriada da lesão. A melhora inicial não autoriza interrupção precoce, especialmente quando houver osso acometido.

Fontes: Série pediátrica — apresentação e manejo; NHS — actinomicose

Limitação específica: As fontes primárias pediátricas recuperadas não padronizam dose e duração por localização; não foi criada receita universal para essa infecção rara.

126. Adenoidite Aguda em Pediatria

Definir o quadro. Obstrução nasal, rinorreia e tosse com adenoide aumentada não provam infecção bacteriana. Diferenciar rinofaringite viral, rinite alérgica, hipertrofia adenoideana e rinossinusite bacteriana. O quadro bacteriano é mais plausível com sintomas persistentes por mais de dez dias sem melhora, piora após melhora inicial ou febre alta com secreção purulenta persistente. Apneia, desconforto respiratório, toxicidade, dor cervical intensa ou sinais orbitários mudam a urgência.

Exames. Diagnóstico inicial é clínico; não solicitar imagem de seios/adenoide rotineiramente para uma infecção aguda simples. Avaliação otorrinolaringológica é indicada na obstrução persistente, recorrência importante ou suspeita de complicação. Se houver sinais de extensão profunda, usar imagem dirigida e encaminhamento hospitalar.

Conduta. Na provável virose: hidratação, higiene nasal com solução salina e analgesia, sem antibiótico. Quando preencher critérios de rinossinusite bacteriana, utilizar o esquema específico desse diagnóstico no projeto; não transformar o título “adenoidite” em indicação automática de azitromicina. A escolha entre amoxicilina e associação com clavulanato precisa considerar idade, gravidade, antibiótico recente e resistência, com reavaliação em 48–72 horas.

Seguimento. Persistência da obstrução após resolução infecciosa pede avaliação funcional, incluindo sono e audição. Corticoide sistêmico e descongestionante não são rotina da adenoidite aguda. Registrar motivo clínico do antibiótico, não apenas secreção amarelada.

Fontes: CHOP — rinossinusite bacteriana; RCH — rinite e rinossinusite

Limitação específica: Não foi identificada diretriz primária que trate adenoidite aguda isolada como entidade com posologia própria; o esquema é vinculado ao diagnóstico bacteriano efetivamente estabelecido.

127. Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya

Gravidade. Na suspeita de dengue, classificar risco a cada atendimento, inclusive quando a febre desaparece. Dor abdominal persistente, vômitos repetidos, sangramento mucoso, letargia/irritabilidade, acúmulo de líquido, hepatomegalia e elevação do hematócrito com queda plaquetária sugerem alarme; choque pode preceder hipotensão. Dengue, zika e chikungunya não são intercambiáveis, apesar da sobreposição clínica.

Exames e manejo. Hemograma/hematócrito seriados orientam extravasamento e resposta; teste etiológico depende do dia da doença. Dengue com alarme: internação e SF 0,9% 10 mL/kg na primeira hora, reavaliando perfusão, diurese e hematócrito; choque: expansão inicial 20 mL/kg em até 20 minutos, com reavaliação imediata e busca de hemorragia/miocardite se resposta inadequada. A prescrição seguinte acompanha a resposta, sem repetição cega de volume. Criança sem alarme, hidratada e com seguimento confiável: hidratação oral fracionada e revisão diária no período crítico.

Medicações e destino. Paracetamol no módulo comum para desconforto. Evitar AAS, AINE e injeções IM enquanto houver suspeita de dengue; não usar corticoide ou antibiótico por rotina. Zika não complicada recebe suporte. Chikungunya requer avaliação de dor persistente e sinais neurológicos/cardiológicos, especialmente em neonatos. Não tratar artralgia tardia como se ainda fosse fase aguda de dengue. Notificar conforme vigilância e fornecer sinais de retorno por escrito.

Fontes: MS — dengue, 6ª edição, 2024; SES-SP — arboviroses, 2025

128. Artrite Séptica em Pediatria

Emergência articular. Dor localizada, recusa de apoio, limitação importante da mobilidade e febre exigem considerar artrite séptica, mesmo com marcadores iniciais pouco alterados. Avaliar sepse e coletar hemocultura; ultrassom demonstra derrame, mas não define sozinho sua etiologia. Punção para cultura e contagem celular deve ser articulada com ortopedia, sem atrasar antibiótico em criança doente.

Terapia. Drenagem/lavagem é parte central do tratamento. Em criança além do período neonatal, sem risco especial de resistência, uma opção para MSSA é cefazolina 50 mg/kg/dose EV a cada 8 horas, máximo 2 g/dose. Esse regime corresponde a 150 mg/kg/dia e pode exceder a bula brasileira; preparo no módulo compartilhado. Acrescentar cobertura para MRSA quando epidemiologia, colonização ou gravidade justificarem. Neonatos, imunocomprometidos e hemoglobinopatias exigem espectro próprio; não reaplicar a mesma monoterapia.

Reavaliação. Após controle do foco, melhora funcional, defervescência e queda da PCR, considerar transição para antimicrobiano oral dirigido. A diretriz PIDS/IDSA admite 10–14 dias totais em artrite primária não complicada com resposta rápida; resposta lenta, foco ósseo associado ou drenagem inadequada prolongam o tratamento. Monitorar cultura, função renal e mobilidade, com retorno ortopédico para detectar sequela de crescimento. Dor persistente obriga procurar abscesso ou osteomielite, não apenas trocar antibiótico.

Fontes: RCH — infecções osteoarticulares; PIDS/IDSA — artrite bacteriana aguda, 2023

129. Botulismo em Pediatria

Reconhecimento e estabilização. Constipação seguida de sucção fraca, choro débil, ptose e hipotonia descendente no lactente deve levantar botulismo. Em crianças maiores, diplopia, disfagia e fraqueza descendente após alimento suspeito são relevantes. A consciência pode permanecer preservada. Priorizar via aérea, capacidade ventilatória e proteção contra aspiração; oximetria normal não exclui hipoventilação precoce. Encaminhar à UTI quando fraqueza bulbar ou ventilatória.

Diagnóstico e terapia específica. Acionar vigilância e centro de referência imediatamente. Colher fezes e demais amostras orientadas pela vigilância, sem aguardar resultado para decidir antitoxina. No botulismo infantil por colonização intestinal, a imunoglobulina humana específica BabyBIG é a referência internacional; botulismo alimentar e por ferida utilizam antitoxina botulínica, conforme produto disponibilizado. Essas formulações não são intercambiáveis por mg, UI ou volume.

Cuidados associados. Suporte ventilatório e nutricional pode ser prolongado. Antibiótico não trata a toxina e não deve ser usado rotineiramente no botulismo intestinal infantil; infecção por ferida exige controle do foco e antibiótico apropriado. Evitar fármacos que agravam bloqueio neuromuscular, especialmente aminoglicosídeos, se houver alternativa. A antitoxina neutraliza toxina circulante, não reverte de imediato a paralisia instalada. Monitorar progressão da força, secreções, ventilação e reações durante infusão. A dose e velocidade devem ser documentadas pela bula do produto efetivamente recebido.

Fontes: CDC — botulismo infantil; CDC — visão clínica

Limitação específica: A apresentação de antitoxina disponível no Brasil para o caso não foi identificada; não foi convertido um produto internacional em dose/volume de outro.

130. Caxumba

Avaliação. Parotidite dolorosa unilateral ou bilateral é compatível com caxumba, mas não é exclusiva dela. Verificar vacinação, exposição e presença de secreção purulenta no ducto, que sugere etiologia bacteriana. Dor testicular intensa, cefaleia com meningismo, déficit neurológico, dor abdominal importante ou dificuldade de hidratação requerem avaliação de complicação; não presumir orquite sem excluir torção.

Exames. Acionar vigilância e colher amostra para RT-PCR conforme tempo de sintomas e orientação sanitária. Resultado sorológico negativo em vacinado não exclui necessariamente a infecção. Imagem de parótida não é rotina em apresentação típica, mas ajuda quando abscesso ou obstrução ductal são diferenciais.

Tratamento. Não existe antiviral específico de uso rotineiro. Oferecer líquidos, alimentos macios, compressas e analgesia do módulo comum. Antibiótico é reservado para infecção bacteriana demonstrada ou fortemente

suspeita. Corticoide não é terapia de rotina da parotidite nem método comprovado para prevenir infertilidade em orquite. A vacina serve à prevenção e atualização do esquema, não ao tratamento do episódio instalado.

Seguimento. Manter isolamento por cinco dias após início do aumento da parótida, segundo orientação CDC, e observar as exigências locais de notificação. Reavaliar se ingestão ou diurese caírem, se surgirem alterações neurológicas ou dor escrotal. Internar na meningite/encefalite, pancreatite com repercussão, desidratação relevante ou outra complicação sistêmica.

Fontes: CDC — caxumba, visão clínica; CDC — manejo e investigação

131. Celulite em Pediatria

Definição e gravidade. Eritema doloroso, quente e progressivo favorece celulite; prurido predominante e ausência de dor sugerem reação inflamatória não infecciosa. Delimitar a área, avaliar porta de entrada, abscesso e estado geral. Dor desproporcional, bolhas hemorrágicas, crepitação, progressão rápida ou choque exigem cirurgia urgente por possível infecção necrosante.

Tratamento. Celulite não purulenta leve em criança bem: cefalexina 20 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 750 mg/dose, por 5 dias inicialmente. Na concentração 50 mg/mL: 0,4 mL/kg/dose, teto 15 mL. Reavaliar em 24–48 horas; eritema pode demorar a regredir, mas piora sistêmica não deve ser atribuída a esse atraso. Abscesso exige drenagem e cultura; cobertura para MRSA é contextual, não automática. Quadro grave ou impossibilidade de VO pode receber cefazolina hospitalar, utilizando o esquema e ressalvas do módulo comum/tema 128.

Exames e segurança. Não colher hemocultura em todo caso leve; indicar se toxicidade, imunodeficiência ou suspeita de bacteremia. Ultrassom quando coleção não está clara. Avaliar alergias e ajuste renal do antibiótico. Elevação do membro e analgesia auxiliam. Alta apenas com tolerância oral, ausência de gravidade e possibilidade de retorno; falha exige revisar foco, drenagem, diagnóstico diferencial e adesão antes de ampliar antibióticos indiscriminadamente.

Fontes: RCH — celulite e infecções de pele; IDSA — infecções de pele e partes moles

132. Celulite Orbitária em Pediatria

Emergência oftalmológica. Dor ou limitação à movimentação ocular, proptose, redução visual, defeito pupilar aferente ou diplopia sugerem acometimento orbitário. Avaliar ABCDE e sepse; manter jejum para eventual intervenção. A ausência de febre não exclui complicação. Criança com esses sinais precisa de internação e avaliação urgente por oftalmologia e otorrinolaringologia.

Exames. TC de órbitas e seios da face com contraste ajuda a identificar abscesso e extensão; incluir avaliação intracraniana quando houver cefaleia importante, alteração de consciência ou déficit focal. Colher hemocultura e marcadores inflamatórios, sem atrasar antibiótico.

Terapia. Uma opção inicial além do período neonatal é ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV, máximo 4 g/dia, em dose diária conforme a diretriz consultada; cefotaxima 50 mg/kg/dose EV a cada 6 horas, máximo 2 g/dose, é alternativa. Acrescentar vancomicina se houver risco relevante de MRSA; foco odontogênico/abscesso com anaeróbios requer cobertura adicional dirigida. Drenagem depende de visão, localização, tamanho e resposta, não apenas da temperatura.

Seguimento. Reavaliar visão, pupilas, dor, proptose e motilidade de forma seriada. Após melhora sustentada e resolução do risco cirúrgico, transição oral dirigida; a diretriz RCH descreve curso total de 10–14 dias, maior se houver complicação. Ceftriaxona é inadequada em alguns neonatos, sobretudo com cálcio EV ou hiperbilirrubinemia; esse esquema não deve ser transferido a eles.

Fontes: RCH — celulite periorbitária e orbitária

133. Celulite Periorbitária Infantil

Separar pré-septal de orbitária. Edema e eritema palpebrais sem proptose, sem dor à movimentação, com motilidade e visão preservadas favorecem celulite periorbitária. O exame precisa ser confiável; pálpebra impossível de abrir, lactente muito pequeno ou qualquer sinal orbitário justifica avaliação hospitalar. Edema bilateral indolor em criança bem sugere causa não infecciosa.

Conduta ambulatorial. Em criança bem, com foco cutâneo e revisão garantida, cefalexina 20 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 750 mg/dose, é uma opção; com 50 mg/mL, 0,4 mL/kg/dose. O curso usual é de 7–10 dias, ajustado à resposta. Quando associado a sinusite, amoxicilina/clavulanato oferece espectro mais apropriado; conferir dose pelo componente amoxicilina e proporção da formulação. Risco de MRSA, alergia imediata ou imunodeficiência exige plano específico.

Exames e escalada. Não fazer TC rotineiramente em quadro típico leve. Internar se toxicidade, progressão, falha da via oral ou dúvida de extensão; então usar antibiótico EV e avaliar imagem. Criança não imunizada para Hib merece limiar mais baixo de investigação e tratamento hospitalar.

Validação e retorno. Marcar o limite do eritema, documentar acuidade possível, pupilas e movimentos. Reavaliar em 24–48 horas, mais cedo se piora. Dor ocular, redução visual, proptose ou cefaleia importante exigem retorno imediato e migração para o fluxo orbitário do tema 132.

Fontes: RCH — celulite periorbitária

134. Cisticercose em Pediatria

Primeiro controlar a complicação. Neurocisticercose pode causar convulsões, edema, hidrocefalia e hipertensão intracraniana. Crise prolongada recebe tratamento imediato; alteração de consciência, sinais de hipertensão intracraniana ou déficit progressivo exigem hospital e neurologia/neurocirurgia. Não iniciar antiparasitário antes de caracterizar número, viabilidade e localização das lesões, nem diante de hipertensão intracraniana não controlada.

Investigação. TC identifica calcificações; RM define melhor lesões ventriculares, subaracnoideas e edema. Realizar avaliação ocular antes do tratamento cisticida. Lesões calcificadas não se beneficiam de albendazol; a conduta centra-se na manifestação clínica. Cistos ventriculares frequentemente exigem remoção endoscópica, não tratamento empírico ambulatorial.

Terapia selecionada. Para 1–2 cistos parenquimatosos viáveis: albendazol 15 mg/kg/dia VO dividido em duas doses, máximo 1.200 mg/dia, por 10–14 dias conforme IDSA, com anti-inflamatório iniciado antes. Mais de dois cistos viáveis: associar praziquantel 50 mg/kg/dia em três doses, pelo mesmo período. Na suspensão de albendazol 40 mg/mL: 0,1875 mL/kg/dose a cada 12 h, respeitado o teto; esse uso tecidual não é equivalente ao esquema intestinal de dose única.

Monitorização. Hemograma e transaminases, interações com anticonvulsivantes e evolução do edema. Corticoide, antiepiléptico e necessidade de internação são definidos pelo fenótipo, sem esquema único para doença subaracnoidea ou ocular.

Fontes: CDC — tratamento da cisticercose; IDSA/ASTMH — neurocisticercose

135. Cólera em Pediatria

Prioridade é reposição de perdas. Diarreia aquosa volumosa pode causar choque em poucas horas. Avaliar perfusão, consciência, diurese, sede e perdas contínuas; obter acesso e iniciar reidratação sem esperar confirmação. Colher fezes para cultura/PCR conforme vigilância e notificar suspeita. Em casos leves, solução de reidratação oral de baixa osmolaridade e aleitamento contínuo são fundamentais.

Desidratação grave. Utilizar o plano de reidratação para diarreia grave, frequentemente Ringer lactato 100 mL/kg no total, em etapas e velocidades ajustadas à idade; o primeiro objetivo é reverter choque, com reavaliação repetida. Neonatos, desnutrição grave, cardiopatia e insuficiência renal não recebem automaticamente a mesma velocidade. Registrar perdas adicionais e repô-las; não interpretar o volume inicial como cobertura de todas as evacuações subsequentes.

Antibiótico. Para cólera com desidratação grave, perdas muito elevadas, falha de reidratação inicial ou maior risco: azitromicina 20 mg/kg VO em dose única, máximo 1 g, quando o perfil de sensibilidade permitir. Na suspensão 40 mg/mL: 0,5 mL/kg, máximo 25 mL. Essa dose é específica de cólera e difere dos esquemas de coqueluche ou infecção respiratória. Alternativas devem seguir sensibilidade da cepa do surto.

Segurança e reavaliação. Monitorar eletrólitos, glicemia, função renal e ECG se distúrbio eletrolítico/QT. Não indicar loperamida ou profilaxia antibiótica coletiva por rotina. Alta quando hidratada, ingestão e diurese adequadas, com reposição oral viável.

Fontes: OMS — cólera; GTFCC — antibióticos na cólera

136. Coqueluche em Pediatria

Gravidade e transmissão. Lactentes podem apresentar apneia, cianose e dificuldade alimentar semguincho típico. Internar quando houver apneia, hipoxemia, exaustão, desidratação ou risco elevado; monitorização é especialmente importante nos pequenos lactentes. Colher PCR de nasofaringe, preferencialmente antes do antibiótico, sem atrasar tratamento de alta suspeita.

Antimicrobiano. Azitromicina VO: menores de 6 meses,10 mg/kg uma vez ao dia por 5 dias; a partir de 6 meses,10 mg/kg no primeiro dia, máximo 500 mg, seguido de 5 mg/kg/dia, máximo 250 mg, nos dias 2–5. Na suspensão 40 mg/mL, respectivamente 0,25 e 0,125 mL/kg por dose. Nos menores de 6 meses, manter 0,25 mL/kg nos cinco dias: não aplicar a redução do esquema das crianças maiores. A azitromicina continua sendo preferida nos muito pequenos apesar da associação dos macrolídeos com estenose hipertrófica do piloro; orientar sobre vômitos progressivos.

Medidas associadas. O maior benefício sobre sintomas ocorre precocemente; tratamento tardio ainda pode ser indicado para reduzir transmissão emgrupos vulneráveis. Manter precaução por gotículas até cinco dias de terapia efetiva. Avaliar contatos domiciliares e de alto risco para profilaxia e atualizar vacinação. Antitussígenos, corticoides e broncodilatadores não modificam rotineiramente a evolução.

Segurança. Conferir QT, interações e hepatopatia; não usar TMP-SMX abaixo de 2 meses. Revisar alimentação, frequência das crises e sinais de pneumonia. A persistência de tosse isolada após tratamento não demonstra resistência.

Fontes: CDC — tratamento atual da coqueluche; CDC — doses dos antimicrobianos

137. Coronavírus (Covid-19) em Pediatria

Avaliação. Estratificar gravidade respiratória e risco de progressão, incluindo imunossupressão, doença crônica relevante e lactentes vulneráveis. Criança com dispneia, hipoxemia, desidratação, alteração neurológica ou choque precisa de avaliação hospitalar. Teste antigênico/PCR é útil quando modifica isolamento ou tratamento; resultado positivo não exclui foco bacteriano simultâneo.

Forma leve. Hidratação, analgesia e seguimento. Não indicar azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, antibiótico ou corticoide sistêmico para COVID não complicada. Corticoide é reservado a contextos de necessidade de oxigênio/doença grave, seguindo avaliação especializada.

Antiviral em maior risco. Remdesivir EV é uma opção para COVID com risco elevado de progressão; no ambulatório, iniciar até sete dias de sintomas e tratar por três dias. A bula americana atualizada em julho de 2026 diferencia: ≥28 dias e 3 a <40 kg, 5 mg/kg no dia 1 e 2,5 mg/kg/dia depois; ≥40 kg, 200 mg no dia 1 e 100 mg/dia depois. Neonatos a termo com ≥1,5 kg e lactentes ≥28 dias com 1,5 a <3 kg recebem 2,5 mg/kg no dia 1 e 1,25 mg/kg/dia depois. Hospitalizados recebem 5–10 dias conforme suporte ventilatório e resposta. Essa ampliação americana não estabelece autorização brasileira.

Preparo do produto citado. Frasco de 100 mg + 19 mL de água estéril fornece 20 mL, 5 mg/mL; diluir em SF para 1,25 mg/mL nas crianças <40 kg, infundindo em 30–120 minutos. Volume final = dose/1,25. Conferir a bula do produto recebido e observar reações infusionais. Adolescentes elegíveis a nirmatrelvir/ritonavir precisam de revisão de interações e função renal.

Monitorização/destino. Verificar transaminases e função renal antes de antiviral, reavaliar saturação, trabalho respiratório e ingestão. Determinar também tempo de protrombina; a bula americana não exige ajuste

renal do remdesivir, inclusive em diálise. Febre persistente com manifestações extrapulmonares após infecção exige considerar SIM-P, tema 179.

Fontes: CDC — assistência pediátrica COVID; CDC — tratamento ambulatorial; Gilead/DailyMed — Veklury, bula de julho de 2026

Limitação específica: Elegibilidade regulatória e apresentação brasileira atual de antiviral devem ser confirmadas antes da administração; não foi presumida equivalência entre FDA e ANVISA.

138. Difteria em Pediatria

Emergência toxigênica. Pseudomembrana aderente, sangramento à manipulação, adenomegalia cervical importante ou estridor levantam suspeita de difteria. Não remover mecanicamente a membrana. Priorizar via aérea com equipe experiente, precaução por gotículas, notificação imediata e coleta de material de orofaringe/nasofaringe para cultura e pesquisa de toxigenicidade, sem aguardar resultado para tratar.

Antitoxina. O soro antidiftérico é a medida específica e deve ser solicitado prontamente à vigilância. O esquema brasileiro citado pela SES-PR utiliza 40.000 UI nas formas leves; 60.000–80.000 UI nas laringoamigdalianas/mistas; 80.000–100.000 UI nas graves ou tardias. Dose é definida por extensão/duração, não por kg. Administrar hospitalarmente segundo a bula do soro disponibilizado, com suporte para anafilaxia; não inventar volume ou velocidade sem concentração do produto.

Antibiótico complementar. Eritromicina 10–12,5 mg/kg/dose VO a cada 6 horas, máximo 500 mg/dose e 2 g/dia, por 14 dias, é opção quando a via oral é viável. Penicilina é alternativa. O antibiótico interrompe produção bacteriana/transmissão, mas não substitui antitoxina.

Vigilância clínica. Monitorar ECG, miocardite, arritmias, neuropatia e insuficiência respiratória, que podem aparecer após melhora local. Investigar e proteger contatos, comprovar erradicação conforme vigilância e atualizar vacinação, pois adoecimento não garante imunidade. Internação é indicada para doença respiratória suspeita.

Fontes: SES-PR — difteria e soro; CDC — orientação clínica

Limitação específica: O volume e o tempo de infusão do soro dependem da concentração da apresentação entregue e não foram extrapolados.

139. Doença da Arranhadura do Gato na Criança

Reconhecimento. Linfonodo regional aumentado após arranhadura ou contato comgato, frequentemente com pápula de inoculação, sugere Bartonella henselae. Documentar exposição, tempo de evolução e sinais de outras etiologias. Febre prolongada, dor abdominal, hepatosplenomegalia, alteração visual, déficit neurológico ou imunodeficiência ampliam a investigação para doença disseminada.

Exames. Na apresentação típica localizada, o diagnóstico pode ser clínico. Sorologia auxilia, mas tem reação cruzada e pode permanecer positiva após a infecção. PCR do aspirado tem utilidade selecionada; aspiração pode também aliviar adenite dolorosa supurada. Evitar incisão ampla indiscriminada pelo risco de fístula. Ultrassom ajuda na coleção ou dúvida estrutural.

Tratamento. Muitos casos localizados em imunocompetentes resolvem espontaneamente. Se dor/volume importante ou decisão por abreviar adenomegalia, azitromicina 10 mg/kg VO no dia 1, máximo 500 mg; depois 5 mg/kg/dia nos dias 2–5, máximo 250 mg/dia. Na suspensão 40 mg/mL: 0,25 mL/kg no primeiro dia e 0,125 mL/kg nos demais. O benefício demonstrado é principalmente redução mais rápida do volume nodal, não prevenção universal de complicações.

Seguimento. Reavaliar sintomas e tendência do linfonodo; persistência isolada por semanas não significa necessidade de cursos repetidos. Comprometimento ocular, neurológico, endocardite ou doença em imunodeprimido exige esquema combinado específico com infectologia. Conferir interações/QT e hepatopatia antes do macrolídeo; analgesia e hidratação conforme necessidade.

Fontes: CDC — doença da arranhadura do gato; Ensaio de azitromicina — evidência primária

140. Doença de Chagas em Pediatria

Apresentações. Investigar transmissão congênita, vetorial ou oral conforme epidemiologia. Febre prolongada com edema, hepatosplenomegalia, sinais cardíacos ou exposição alimentar coletiva exige investigação de fase aguda. Miocardite, arritmia, insuficiência cardíaca, meningoencefalite e instabilidade determinam internação e monitorização.

Diagnóstico. Na fase aguda/congênita precoce, pesquisa parasitológica e métodos moleculares são mais úteis; anticorpos maternos limitam interpretação sorológica no primeiro período de vida. Na fase crônica, confirmar com testes sorológicos de princípios distintos. Avaliar ECG e repercussão cardíaca conforme clínica.

Tratamento etiológico. Benznidazol é primeira linha no PCDT brasileiro. Para crianças, a faixa usual é 5–10 mg/kg/dia VO dividida em duas administrações, por 60 dias, máximo diário geralmente 300 mg; a dose selecionada deve ser registrada dentro da faixa conforme idade e tolerabilidade. Não confundir dose diária com dose por tomada. A apresentação pediátrica dispersível permite adequação, mas não se deve inventar uma concentração líquida a partir de comprimido sem método validado. Nifurtimox é alternativa em intolerância/indisponibilidade, com solicitação especializada.

Monitorização. Peso seriado, hemograma, transaminases, creatinina, rash, neuropatia e sintomas digestivos. Exantema importante, citopenia ou hepatotoxicidade exigem reavaliação imediata do fármaco. O desaparecimento de parasitemia não dispensa acompanhamento prolongado; definir marcadores de cura e vigilância cardíaca conforme fase. Considerar investigação da mãe e irmãos na transmissão congênita.

Fontes: MS — PCDT doença de Chagas

141. Doença Mão-Pé-Boca

Quadro usual. Febre, úlceras orais dolorosas e lesões em mãos/pés, por vezes nádegas e outras áreas, sugerem doença mão-pé-boca. O diagnóstico geralmente é clínico. Avaliar ingestão, diurese e estado neurológico; disfagia com desidratação é a complicação prática mais frequente. Prostração desproporcional, mioclonias, ataxia, cefaleia intensa, taquicardia persistente ou dificuldade respiratória exigem atendimento hospitalar.

Tratamento. Hidratação em pequenos volumes frequentes, líquidos frescos e alimentos não irritantes; analgesia do módulo comum antes das refeições pode facilitar aceitação. Não há indicação habitual de antibiótico, aciclovir ou corticoide sistêmico. Lidocaína viscosa e benzocaína em crianças pequenas podem causar toxicidade e não devem ser usadas como solução automática para a dor oral. Não prescrever associações caseiras com anestésico ou múltiplos fármacos de concentração incerta.

Exames e destino. Teste viral e hemograma não são necessários em apresentação típica, estável; reservar investigação para gravidade, imunodeficiência, surto relevante ou diagnóstico diferencial. Internar quando não for possível hidratar, houver alteração neurológica/cardiopulmonar ou necessidade de suporte.

Orientações. Higiene rigorosa das mãos e superfícies, evitar compartilhamento de utensílios e contato com secreções. Explicar que descamação/alterações ungueais tardias podem ocorrer e não significam nova infecção bacteriana. Retorno por oligúria, incapacidade de beber, sonolência anormal ou febre persistente.

Fontes: CDC — doença mão-pé-boca; CDC — sintomas e complicações

142. Doença Meningocócica em Pediatria

Não esperar exantema completo. Febre, prostração, dor em membros, alteração da perfusão e petéquias/púrpura podem representar meningococcemia. Choque, rebaixamento ou progressão rápida requerem ABCDE, acesso EV/IO, antibiótico imediato e UTI. Ausência de meningismo não reduz a gravidade da bacteremia meningocócica.

Exames e tratamento. Colher hemocultura e amostras para PCR se não atrasarem terapia. Punção lombar apenas após estabilização e se não houver contraindicação; nunca adiar antibiótico para realizá-la. Para suspeita de doença invasiva em criança além do período neonatal: ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV, máximo 4 g/dia, em dose diária ou dividida conforme protocolo de meningite. Após identificação e sensibilidade, estreitar

espectro; não assumir sensibilidade à penicilina. A duração de meningite meningocócica não complicada costuma ser 5–7 dias, definida por evolução e diagnóstico microbiológico.

Medidas simultâneas. Ressuscitação e vasoativos seguem o tema 175, com atenção à coagulação, glicemia, eletrólitos e função renal. Precaução por gotículas até 24 horas de antibiótico efetivo. Notificação imediata e quimioprofilaxia dos contatos elegíveis, coordenada com vigilância; contato casual isolado não é critério automático.

Seguimento. Avaliar lesões isquêmicas, disfunção adrenal, perda auditiva e sequelas neurológicas. Caso receba esquema que não erradique portador nasofaríngeo, indicar erradicação antes da alta conforme diretriz. Não usar a dose de profilaxia como dose de tratamento invasivo.

Fontes: CDC — doença meningocócica, orientação 2026; OMS — meningite; RCH — antimicrobianos

143. Endocardite Infecciosa em Pediatria

Suspeita clínica. Febre persistente com cardiopatia predisponente, material intracardíaco, bacteremia persistente, fenômenos embólicos ou novo sopro deve levantar endocardite. Ausência de sopro não exclui. Choque, insuficiência cardíaca, bloqueio de condução e evento neurológico impõem internação e equipe de cardiologia, infectologia e cirurgia.

Investigação. Coletar múltiplos conjuntos de hemoculturas de punções distintas antes do antimicrobiano quando o estado permitir; não adiar terapia no instável. Ecocardiograma transtorácico é inicial, com transesofágico em situações selecionadas ou suspeita persistente. Registrar função renal, hemograma e marcadores de lesão orgânica.

Terapia dirigida. Não existe um esquema empírico único para válvula nativa, prótese, cateter, neonato e exposição hospitalar. Como referência específica de MSSA em criança maior: oxacilina 200 mg/kg/dia EV dividida a cada 4–6 horas, máximo 12 g/dia, usualmente 4–6 semanas. Em esquema 6/6 h, corresponde a 50 mg/kg/dose; volume aspirado=D/C do frasco reconstituído. Não acrescentar gentamicina automaticamente, pois toxicidade e benefício variam com agente e material protético. MRSA demanda vancomicina com exposição monitorada; enterococo exige combinação própria.

Validação. Repetir hemoculturas até depuração, monitorar toxicidade renal/hepática, embolização e função valvar. Abscesso, insuficiência cardíaca, bacteremia persistente ou prótese podem mudar indicação cirúrgica. Duração conta a partir de marcos microbiológicos definidos, não apenas da primeira dose administrada.

Fontes: AHA — endocardite na infância

Limitação específica: O esquema empírico requer válvula/material, idade, origem da infecção e microbiologia; foi fornecido regime dirigido MSSA, não uma combinação universal.

144. Enterobíase em Pediatria

Diagnóstico. Prurido anal noturno, sono inquieto e visualização de vermes filiformes sugerem enterobíase. Fita adesiva perianal ao despertar, antes do banho/evacuação, aumenta a chance de confirmação; exame parasitológico de fezes isolado é menos útil. Dor abdominal importante, sangramento, perda ponderal ou febre exigem outro diagnóstico.

Tratamento. Em criança de 2 anos ou mais, albendazol 400 mg VO em dose única e repetir após 14 dias; suspensão 40 mg/mL corresponde a 10 mL por administração. Alternativa: mebendazol 100 mg VO em dose única, repetida em 14 dias. Pamoato de pirantel 11 mg/kg em dose única, máximo 1 g, também repetido após 14 dias, é outra opção quando disponível. Não somar esses esquemas. Em menores de 2 anos, ponderar benefício/risco e bula da apresentação; a dose de campanhas coletivas não deve ser transferida sem avaliação individual.

Controle da reinfecção. Tratar simultaneamente os conviventes elegíveis, higienizar mãos, manter unhas curtas, banho matinal e lavagem de roupa de cama/íntima. A segunda dose é necessária porque o primeiro tratamento não elimina todos os ovos; recorrência costuma refletir reinfecção ou adesão inadequada.

Seguimento e segurança. Não requer exames laboratoriais de rotina para duas doses usuais em criança saudável. Persistência após esquema correto pede confirmar diagnóstico e reexposição antes de cursos

prolongados. Registrar data exata da repetição e volume correspondente à concentração entregue, evitando apenas escrever “um frasco”.

Fontes: CDC — enterobíase, tratamento; CDC — prevenção e conviventes

145. Equinococose em Pediatria

Caracterizar antes de intervir. Cisto hepático ou pulmonar com exposição epidemiológica pode representar equinococose. Dor, efeito compressivo, infecção secundária, ruptura e anafilaxia são complicações relevantes. Não puncionar empiricamente uma lesão suspeita: a abordagem depende de estágio, localização, tamanho e comunicação biliar.

Exames. Ultrassom classifica cistos hepáticos; TC/RM complementam anatomia e complicações. Sorologia auxilia, mas resultado negativo não exclui todos os estágios. Avaliar tórax e outros órgãos quando indicado. Cirurgia, PAIR, observação e tratamento farmacológico são opções diferentes, escolhidas por equipe experiente; PAIR não se aplica a qualquer cisto.

Antiparasitário. Albendazol 10–15 mg/kg/dia VO em duas doses, máximo 800 mg/dia, por 1–6 meses conforme a indicação cística e procedimento. Na suspensão 40 mg/mL, a faixa é 0,125–0,1875 mL/kg por dose a cada 12 horas, máximo 10 mL/dose. O tratamento de doença alveolar pode ser muito mais prolongado e não deve ser confundido com essa duração. Administrar conforme formulação e orientação para absorção em doença tecidual.

Monitorização e destino. Hemograma/transaminases antes e durante tratamento prolongado; observar hepatotoxicidade e citopenia. Não suspender acompanhamento apenas porque o cisto diminuiu: imagem seriada determina resposta/inatividade. Internar em ruptura, anafilaxia, obstrução biliar, complicação respiratória ou procedimento. Uso pediátrico e formulação devem ser confrontados com bula brasileira, pois a indicação tecidual pode ser fora da bula.

Fontes: CDC — equinococose, tratamento; CDC — visão clínica

146. Erisipela em Pediatria

Definição. Placa eritematosa dolorosa de início agudo, elevada e com borda relativamente bem delimitada favorece erisipela; frequentemente estreptocócica. Diferenciar dermatite de contato, reação a picada, celulite, trombose e infecção necrosante. Dor muito intensa, necrose, bolhas hemorrágicas, progressão acelerada ou instabilidade exigem hospital e cirurgia.

Tratamento. Na criança estável, sem purulência ou fatores de resistência, utilizar betalactâmico com cobertura estreptocócica. Um esquema operacional possível é cefalexina do tema 131: 20 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 750 mg/dose, por 5 dias inicialmente, ampliando se resposta lenta. Suspensão 50 mg/mL: 0,4 mL/kg/dose. Penicilina/amoxicilina são alternativas de espectro mais estreito quando a etiologia estreptocócica é convincente e não há necessidade de cobertura estafilocócica. A escolha não exige associação automática de dois antibióticos.

Exames e cuidados. Hemocultura não é rotina em quadro leve; coletar em toxicidade, imunodeficiência ou suspeita de bacteremia. Investigar e tratar porta de entrada, inclusive fissuras e dermatoses. Elevar o membro, hidratar e oferecer analgesia.

Reavaliação. Rever em 24–48 horas, registrar expansão da borda e estado sistêmico. Falha exige avaliar adesão, diagnóstico e coleção, não apenas trocar o fármaco. Internar se houver incapacidade de VO, sepse, rápida progressão ou seguimento inviável. Ajustar cefalexina à função renal e verificar história de reação imediata a betalactâmicos.

Fontes: IDSA — erisipela/celulite

147. Eritroparvovirose B19 (parvovirose B19)

Apresentação e risco. Eritema malar seguido de exantema rendilhado em criança bem sugere eritema infeccioso por parvovírus B19. O rash pode reaparecer com calor ou esforço durante semanas, sem significar infecção nova. Identificar hemoglobinopatia, hemólise crônica, imunodeficiência ou contato gestante: esses contextos mudam a avaliação.

Exames. Na criança saudável com apresentação típica, exames raramente alteram conduta. Palidez importante, taquicardia desproporcional, fadiga ou dispneia exigem hemograma e reticulócitos para crise aplástica. Em imunodeprimido, PCR pode ser mais útil que sorologia. Exposição de gestante deve ser comunicada ao pré-natal para investigação e seguimento fetal; não presumir imunidade pela história de rash.

Tratamento. Hidratação e analgesia/antitérmico do módulo comum. Não há indicação rotineira de antibiótico, aciclovir ou corticoide para o exantema. Artralgia pode receber analgesia, após excluir contraindicações. Anemia sintomática grave necessita avaliação hospitalar e eventual transfusão; aplasia persistente em imunodeficiente pode requerer imunoglobulina sob equipe especializada, sem dose empírica aplicada a toda parvovirose.

Seguimento. Criança bem e hidratada pode receber alta com retorno por palidez, síncope, dispneia ou prostração. Transmissibilidade costuma anteceder o exantema no hospedeiro saudável; pacientes com crise aplástica/imunodeficiência podem manter transmissão e precisam de precauções específicas. Não prolongar restrição escolar apenas pelo aspecto residual da pele.

Fontes: CDC — parvovírus B19; CDC — parvovírus e gestação

148. Escarlatina

Diagnóstico. Faringite associada a exantema áspero, linhas de Pastia e língua característica sugere escarlatina por estreptococo do grupo A. Confirmar com teste rápido/NAAT ou cultura quando indicado; exantema isolado não basta. Em criança sintomática com teste rápido negativo, cultura de confirmação é recomendada em situações pediátricas pertinentes. Toxicidade, dor cervical importante, dificuldade respiratória ou desidratação exigem avaliar complicação.

Tratamento. Amoxicilina 25 mg/kg/dose VO a cada 12 horas, máximo 500 mg/dose, por 10 dias; alternativa equivalente 50 mg/kg uma vez ao dia, máximo 1 g/dia. Com 50 mg/mL,0,5 mL/kg/dose no esquema 12/12 h, teto 10 mL. Penicilina benzatina IM em dose única: 600.000 UI para peso<27 kg e 1.200.000 UI para≥27 kg, quando adesão oral for problema e não houver contraindicação. Confirmar produto, via exclusivamente IM e ambiente para reação alérgica; nunca administrar EV.

Alternativas e segurança. Cefalexina 20 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 500 mg/dose, por 10 dias pode ser opção em alergia não imediata; evitar se anafilaxia a penicilina. Macrolídeos/clindamicina dependem da resistência e não são automaticamente preferíveis. Analgesia do módulo comum.

Reavaliação. Espera-se melhora clínica em 24–48 horas. Manter afastamento até estar afebril e completar pelo menos 12–24 horas de antibiótico apropriado. Completar o curso; piora ou febre persistente pede buscar foco supurado ou diagnóstico alternativo.

Fontes: CDC — escarlatina,2026; CDC — faringite estreptocócica

149. Esporotricose em Pediatria

Suspeita. Nódulo ulcerado após arranhadura/mordedura de gato ou inoculação por vegetais, com lesões ascendendo por trajeto linfático, sugere esporotricose. Não presumir que toda adenite após gato é Bartonella. Comprometimento ocular, osteoarticular, pulmonar, disseminação ou imunossupressão exige avaliação especializada prioritária.

Confirmação. Coletar material de lesão para cultura micológica e histopatologia quando necessário. Investigar acometimento ocular em lesões perioculares ou sintomas visuais. Notificar de acordo com normas vigentes e orientar cuidado veterinário do animal; não manipular secreções sem proteção.

Terapia cutânea. O protocolo municipal consultado emprega itraconazol 5 mg/kg/dia VO, máximo 200 mg/dia, nas crianças, mantido conforme resposta e geralmente por semanas após cura clínica. Trata-se de uso pediátrico frequentemente fora da bula. Cápsula e solução não têm absorção equivalente; não abrir cápsula para improvisar concentração. Se houver solução com concentração C mg/mL validada, volume diário=5 ×P/C, respeitado teto 200 mg. Ajustar escolha farmacêutica à capacidade de deglutição e acesso.

Monitorização. Verificar transaminases e interações CYP 3 A 4, risco de QT e insuficiência cardíaca antes de itraconazol. Falha requer confirmar adesão, absorção, espécie e extensão; doença disseminada pode necessitar anfotericina hospitalar. Reavaliar lesões e linfáticos, fotografando com consentimento. Suspensão prematura favorece recaída; persistência cicatricial não equivale necessariamente a atividade fúngica.

Fontes: MS — esporotricose humana; Curitiba — fluxo terapêutico pediátrico

Limitação específica: A formulação líquida pediátrica de itraconazol não foi confirmada; volume permanece parametrizado pela concentração realmente dispensada.

150. Exantema Súbito

Apresentação. Exantema súbito costuma ocorrer após alguns dias de febre alta, com surgimento de rash quando a temperatura cai e melhora do estado geral. O diagnóstico é retrospectivamente clínico; antes da defervescência, não atribuir automaticamente febre sem foco a HHV 6/7. Lactente pequeno, criança tóxica ou febre prolongada precisa de avaliação por faixa etária.

Gravidade e exames. Convulsão pode acompanhar a fase febril. Tratar crise prolongada pelo fluxo neurológico e avaliar sinais de meningite/encefalite; não chamar de convulsão febril simples se houver focalidade, duração excessiva, repetição ou alteração persistente da consciência. Exames laboratoriais não são necessários no quadro típico, bem tolerado e em resolução. Considerar urina ou outros testes quando a avaliação inicial da febre indicar, não porque o rash apareceu.

Tratamento. Hidratação e analgesia/antitérmico para desconforto, conforme módulo comum. Antibiótico, aciclovir e corticoide não são rotina. Antitérmico não garante prevenção de convulsão febril e não deve ser alternado de forma complexa para esse objetivo. Não restringir alimentação sem motivo.

Seguimento. Alta com ingestão, perfusão e interação preservadas, explicando retorno se febre reaparecer, houver prostração, dificuldade respiratória, rash purpúrico ou convulsão. Imunodeprimidos com suspeita de doença invasiva por HHV 6 constituem cenário diferente e requerem investigação especializada.

Fontes: NHS — roséola; RCH — criança febril

151. Exantemas Febris em Pediatria

Triagem orientada por risco. Descrever morfologia, distribuição, progressão, relação temporal com febre, medicamentos, vacinação e contatos. Petéquias/púrpura com criança doente, bolhas extensas, mucosite grave, edema facial ou alterações hemodinâmicas exigem avaliação imediata. Não rotular todo exantema como virose; meningococcemia, reação medicamentosa grave, Kawasaki, SIM-P e doenças imunopreveníveis podem começar com rash inespecífico.

Exames que mudam conduta. No instável, hemocultura e avaliação de disfunção orgânica sem atrasar antibiótico/ressuscitação. Suspeita de sarampo ou rubéola exige precaução apropriada, notificação e amostras de vigilância. Testes estreptocócicos quando houver faringite compatível; hemograma/reticulócitos se risco de crise aplástica por B 19. Criança bem com exantema viral típico geralmente não precisa de painel laboratorial indiscriminado.

Tratamento. A terapêutica é etiológica, usando os capítulos correspondentes. Suporte simples com hidratação e analgesia para desconforto é suficiente em virose não complicada; não iniciar antibiótico, corticoide ou antiviral apenas pelo rash. Se houver reação medicamentosa suspeita, suspender o agente provável e avaliar gravidade, evitando reexposição diagnóstica.

Reavaliação. Documentar mucosas, perfusão, estado mental, evolução das lesões e sinais de sangramento. Fotografias podem ajudar acompanhamento quando autorizadas. Alta requer sinais vitais compatíveis, boa ingestão e retorno claro; febre por cinco dias ou mais, piora após melhora ou novos sinais sistêmicos demandam

nova hipótese, não repetição automática da prescrição.

Fontes: RCH — petéquias e púrpura; CDC — sarampo clínico

152. Fasciolíase em Pediatria

Suspeita e confirmação. Dor em hipocôndrio direito, febre, eosinofilia e exposição a plantas aquáticas/água contaminada sugerem fasciolíase. Na fase de migração, fezes podem ainda não conter ovos; sorologia e imagem podem ser decisivas. Na fase biliar, pesquisar ovos e obstrução. Colangite, icterícia obstrutiva, sepse ou dor intensa indicam hospitalização e possível intervenção endoscópica.

Tratamento específico. Triclabendazol é o fármaco de escolha; para pacientes de 6 anos ou mais, o CDC/FDA indica 10 mg/kg VO com alimento, repetir a mesma dose após 12 horas, total 20 mg/kg. Não substituir por praziquantel, que não é terapia adequada para Fasciola. O esquema não é em mg/kg/dia contínuo. Cada dose total=10 ×P mg; a quantidade de comprimidos depende da apresentação e divisibilidade real. Não foi presumida suspensão líquida brasileira.

Segurança. Verificar interações e risco de prolongamento do QT, hepatopatia e tolerância. Crianças menores de 6 anos exigem avaliação especializada do uso fora da bula e obtenção do medicamento por via apropriada, sem adaptar automaticamente comprimido adulto. Reações após a morte dos parasitas e dor biliar podem necessitar observação.

Seguimento. Documentar melhora clínica, eosinofilia e pesquisa parasitológica/controle de imagem no intervalo apropriado. Persistência pode representar obstrução, reinfecção ou falha terapêutica; não repetir indefinidamente sem confirmação. Orientar água segura e evitar consumo de vegetais aquáticos crus de procedência incerta.

Fontes: CDC — fasciolíase e triclabendazol

Limitação específica: Apresentação brasileira e acesso ao triclabendazol não foram confirmados; não há conversão fictícia em mL.

153. Febre Faringoconjuntival

Avaliação. Febre, faringite e conjuntivite, muitas vezes bilateral e aquosa, sugerem adenovírus. Investigar contato em escola/piscina e surtos. Secreção purulenta abundante, dor ocular intensa, fotofobia, redução visual ou lente de contato exigem avaliar etiologia bacteriana/ceratite. Disfagia importante, sinais respiratórios ou desidratação mudam destino.

Exames. O diagnóstico da forma típica é clínico. PCR viral pode ser útil em hospital, imunodeficiência ou investigação de surto, mas não deve ser solicitado apenas para justificar antibiótico. Avaliar córnea e acuidade possível quando há queixa ocular; testes para estreptococo dependem do quadro de faringite, não da febre isolada.

Tratamento. Hidratação, analgesia e compressas frias; higiene suave das secreções com material individual. Não há antiviral aprovado de rotina para adenovirose comum. Antibiótico sistêmico ou colírio antibiótico não é indicado automaticamente; corticoide ocular pode agravar algumas infecções e deve ser reservado à avaliação oftalmológica. Não compartilhar colírios, toalhas ou objetos de higiene.

Reavaliação. Retorno imediato por dor, fotofobia ou piora visual. Persistência de febre com toxicidade, dificuldade respiratória ou baixa ingestão exige reexaminar complicações e diagnósticos alternativos. Imunodeprimidos com adenovírus disseminado precisam de centro especializado; os antivirais utilizados nesse cenário não se extrapolam à faringoconjuntivite da criança saudável.

Fontes: CDC — adenovírus; CDC — conjuntivite e febre faringoconjuntival

154. Herpangina

Avaliação. Vesículas/úlceras pequenas no palato mole e pilares amigdalianos, com febre e odinofagia, favorecem herpangina por enterovírus. Diferenciar gengivoestomatite herpética, que costuma envolver gengiva e mucosa anterior de forma mais difusa, e doença mão-pé-boca quando há lesões acras. Ausência de lesões cutâneas não exige antibiótico.

Gravidade. Avaliar hidratação, diurese, sialorreia, deglutição e estado neurológico. Estridor, posição antálgica, trismo ou incapacidade de manejar secreções não devem ser atribuídos simplesmente às aftas: investigar obstrução/infecção profunda. Prostração importante, sinais meníngeos ou perfusão alterada exigem hospital.

Conduta. Hidratação fracionada, líquidos frios e alimentos macios, evitando cítricos/irritantes; analgesia do módulo comum para facilitar ingestão. Não indicar aciclovir, antibiótico, corticoide sistêmico ou anestésico tópico de rotina. Não cauterizar úlceras nem usar misturas manipuladas sem composição e benefício demonstrados. Se ingestão continuar insuficiente apesar de analgesia, considerar reidratação enteral ou EV e observação.

Exames e seguimento. Não é necessário painel viral no quadro típico e estável. Teste/investigação adicional é dirigido a doença invasiva, imunodeficiência ou contexto epidemiológico. Higiene das mãos, superfícies e utensílios reduz transmissão. Reavaliar se febre prolongada, piora da dor, redução da diurese ou sonolência anormal; a presença de úlcera não dispensa avaliação completa de febre em lactente pequeno.

Fontes: CDC — enterovírus não pólio; CDC — mão-pé-boca

155. Herpes Congênita

Emergência neonatal. Sepse sem explicação, vesículas, hepatite, coagulopatia, convulsões ou encefalite até as primeiras semanas de vida exigem considerar HSV, mesmo sem história materna ou lesões cutâneas. Diferenciar infecção intrauterina rara da infecção periparto/neonatal, pois o título não define a via de transmissão. Colher PCR do líquor, sangue e lesões, transaminases e culturas bacterianas; não esperar resultado para tratar alta suspeita.

Aciclovir. Em RN com função renal preservada: 20 mg/kg/dose EV a cada 8 horas. Duração 14 dias para doença limitada a pele/olhos/boca e pelo menos 21 dias para doença disseminada/SNC; repetir PCR do líquor perto do fim e prolongar se persistir positivo. Prematuro extremo ou disfunção renal requer ajuste de intervalo, não cópia do esquema do RN termo.

Preparo e bomba — exemplo auditável. Para produto 250 mg reconstituído em 10 mL (25 mg/mL), D=20 P mg e volume aspirado=0,8 P mL; diluir com SF 0,9% até concentração final≤5 mg/mL e infundir em pelo menos 1 hora. Exemplo RN 3 kg: 60 mg=2,4 mL do estoque; completar para 12 mL totais com 9,6 mL de diluente; 12 mL/h por 1 h. Reverso: 12 × 5/3=20 mg/kg. Confirmar instrução do fabricante recebido.

Monitorização. Diurese, creatinina, hidratação, hemograma/neutrófilos e sítio venoso. Não administrar em bolus. Após terapia EV, supressão oral especializada e seguimento neurológico/auditivo são necessários em cenários indicados.

Fontes: Canadian Paediatric Society — HSV neonatal; SmPC do fabricante — aciclovir EV

156. Herpes Simples em Pediatria

Fenótipo e gravidade. Gengiva inflamada, úlceras dolorosas difusas e vesículas periorais sugerem gengivoestomatite por HSV. Avaliar aceitação oral, diurese e risco de desidratação. Lesão ocular, eczema herpético, imunodeficiência, alteração neurológica ou disseminação exigem avaliação urgente; herpes genital em criança demanda investigação contextual e proteção quando pertinente.

Tratamento localizado. Na maioria dos imunocompetentes, hidratação e analgesia são suficientes. Se início há menos de 72 horas e dor intensa/desidratação, considerar aciclovir 10 mg/kg/dose VO cinco vezes ao dia, máximo 400 mg/dose, habitualmente 7 dias ou até cessarem novas lesões, conforme avaliação. A apresentação líquida brasileira não foi confirmada neste lote; para solução validada C mg/mL, volume por dose=min(10 P,400)/C. Não utilizar a dose de varicela para todas as apresentações de HSV.

Doença grave. Imunodeprimidos ou doença invasiva podem necessitar aciclovir EV 10 mg/kg/dose 8/8 h, mas encefalite e neonatos têm esquemas próprios, descritos nos temas 165 e 155. Ajustar à função renal; manter hidratação e monitorar creatinina, hemograma e extravasamento. Aciclovir tópico não substitui terapia sistêmica quando indicada e não é eficaz para gengivoestomatite extensa.

Seguimento. Reavaliar ingestão após analgesia; internação se incapacidade de hidratar ou complicação. Orientar evitar contato de lesões com olhos e recém-nascidos. A cura clínica do episódio não elimina latência; não prescrever supressão crônica sem indicação definida.

Fontes: RCH — gengivoestomatite por HSV; RCH — antibióticos/antivirais

Limitação específica: Concentração de suspensão oral de aciclovir disponível no Brasil não foi confirmada; conversão permanece parametrizada.

157. Impetigo em Pediatria

Classificar extensão. Crostas melicéricas e erosões superficiais sugerem impetigo; bolhas flácidas podem representar forma bolhosa. Avaliar número de áreas, profundidade, febre e sinais de celulite. Ectima, lesões extensas, surtos e sintomas sistêmicos favorecem tratamento oral. Lactente com descamação extensa, dor cutânea e toxemia deve ser avaliado para síndrome da pele escaldada.

Tratamento. Poucas lesões localizadas: mupirocina 2% em camada fina nas áreas afetadas duas vezes ao dia por 5 dias, com higiene suave e remoção não traumática de crostas. Não há conversão ponderal em mL para uma camada tópica. Para doença extensa, cefalexina do tema 131, por 7 dias, é opção se MSSA/estreptococo prováveis. Em suspeita de MRSA, cultura e perfil de sensibilidade orientam a alternativa; não associar cobertura duplicada sem motivo.

Exames e cuidados. Cultura do exsudato é especialmente útil na recorrência, falha ou surto; o caso típico pode ser tratado clinicamente. Investigar escabiose/eczema como porta de entrada. Não aplicar corticoide associado empiricamente nem usar antimicrobiano tópico de modo contínuo para prevenção.

Reavaliação. Rever em 48–72 horas se resposta insuficiente e antecipar avaliação por febre, edema ou progressão. Higiene das mãos, unhas curtas e cobertura de lesões reduzem transmissão. Alertar para urina escura, edema e hipertensão após infecção estreptocócica; tratamento da pele não elimina completamente o risco de glomerulonefrite pós-infecciosa.

Fontes: IDSA — impetigo/ectima; CDC — impetigo

158. Infecção de Trato Urinário em Pediatria

Localização e gravidade. Disúria/polaciúria sem febre sugerem cistite; febre, dor lombar, vômitos ou lactente sem foco podem indicar pielonefrite. Choque, desidratação, obstrução, imunodeficiência e idade muito baixa justificam hospital. Colher urina para EAS e cultura antes do antibiótico quando possível; saco coletor positivo não confirma diagnóstico para tratamento prolongado.

Terapia. Cistite não complicada em criança maior e estável: cefalexina 20 mg/kg/dose VO 8/8 h, máximo 750 mg/dose, por 3–5 dias conforme resposta e diretriz. Pielonefrite requer 7–10 dias totais e doses/espectro próprios. Uma opção inicial hospitalar além do período neonatal é ceftriaxona 50 mg/kg/dose EV 24/24 h, máximo 2 g/dia, quando adequada ao perfil local; sepse/meningite muda a dose e o espectro. Cultura deve levar a estreitamento ou troca dirigida. Nitrofurantoína não trata parênquima renal nem bacteremia.

Conversão e monitorização. Cefalexina 50 mg/mL: 0,4 mL/kg/dose para o esquema de cistite, teto 15 mL. Monitorar função renal e ajustar os agentes que dependem da depuração. Não reutilizar dose de profilaxia de refluxo como tratamento de infecção ativa. Alergia imediata e isolados resistentes exigem alternativa individualizada.

Seguimento. Reavaliar em 24–48 horas e conferir cultura. Persistência de febre, massa, oligúria ou resposta lenta exige imagem para obstrução/abscesso. Planejar investigação de anomalias conforme idade, recorrência e apresentação atípica; não solicitar uretrocistografia para toda cistite simples.

Fontes: RCH — infecção urinária; NICE — infecção urinária na criança

159. Infecção Fúngica no RN

Suspeita neonatal. Prematuridade extrema, cateter central, nutrição parenteral e antibiótico amplo aumentam risco de candidíase invasiva. Instabilidade, trombocitopenia ou sepse persistente exigem culturas de sangue/urina e pesquisa de foco. Candidúria no RN não deve ser tratada como colonização trivial; investigar disseminação, com líquor e avaliação oftalmológica quando indicado.

Antifúngico. A diretriz IDSA recomenda anfotericina B desoxicolato 1 mg/kg/dia EV para candidíase neonatal disseminada. Fluconazol 12 mg/kg/dia EV ou VO é alternativa quando não houve profilaxia prévia e a espécie é sensível. Formulações lipídicas de anfotericina 3–5 mg/kg/dia são alternativas selecionadas, com ressalva no acometimento urinário. Essas formulações têm doses e preparos distintos: nunca substituir mg por mg.

Preparo e segurança. Prescrever nome completo da formulação, dose, diluente e concentração final da bula recebida; não foi criado preparo único para “anfotericina”. Volume final=D/Cfinal e bomba=volume/tempo prescrito. Monitorar creatinina, potássio, magnésio, hemograma, transaminases e reações infusionais. Fluconazol requer avaliação da depuração renal; prematuro não deve receber intervalo deduzido apenas do peso.

Controle de foco e duração. Remover cateter infectado quando viável e obter culturas até negativação. Na candidemia sem foco metastático, tratar por 14 dias após depuração documentada e resolução dos sinais. SNC, olho, osso ou endocardite prolongam o curso e exigem plano específico. Alta somente com infecção controlada e seguimento neurodesenvolvimental definido.

Fontes: IDSA — candidíase neonatal

Limitação específica: Preparo/estabilidade de anfotericina não são intercambiáveis entre desoxicolato, lipossomal e complexo lipídico; dependem da formulação efetivamente recebida.

160. Larva Migrans Cutânea em Pediatria

Diagnóstico. Trajeto serpiginoso pruriginoso após contato com areia/solo contaminado sugere larva migrans cutânea. O diagnóstico costuma ser clínico; biópsia não é rotina porque a larva pode estar distante da extremidade visível. Diferenciar escabiose, dermatite, infecção bacteriana e larva currens por Strongyloides quando progressão for muito rápida.

Tratamento. Em crianças acima de 2 anos: albendazol 400 mg VO uma vez ao dia por 3 dias, correspondendo a 10 mL/dia da suspensão 40 mg/mL. Em pacientes com peso>15 kg, ivermectina 200 mcg/kg VO em dose única é alternativa; 200 mcg/kg=0,2 mg/kg. Não confundir essa conversão por mil com 200 mg/kg. A quantidade de comprimidos exige arredondamento farmacêutico compatível, não fracionamento impreciso de comprimidos sem possibilidade de medida.

Situações especiais. Menores de 2 anos ou abaixo de 15 kg demandam avaliação de terapia tópica/alternativa com apresentação definida; não extrapolar segurança de campanhas coletivas. Casos extensos, recorrentes ou com foliculite podem necessitar tratamento adicional após reavaliação, sem repetição automática. Antibiótico apenas se houver sobre infecção demonstrada; crioterapia no trajeto não é rotina.

Seguimento. Orientar higiene, calçado e controle veterinário/ambiental. Prurido pode persistir transitoriamente após morte da larva; progressão do trajeto é mais útil que coceira isolada para suspeitar falha. Dor, pus, febre ou sintomas pulmonares pedem reavaliação.

Fontes: CDC — tratamento da larva migrans cutânea; CDC — diagnóstico

161. Leptospirose em Pediatria

Suspeita e gravidade. Febre com mialgia, cefaleia, sufusão conjuntival e exposição a enchente/água contaminada sugere leptospirose. Icterícia, oligúria, hemoptise, dispneia, hipotensão, alteração mental ou arritmia indicam gravidade e internação. Não esperar soroconversão para iniciar antibiótico na suspeita relevante.

Exames. Hemograma, creatinina, ureia, sódio/potássio, bilirrubinas/transaminases, urina e avaliação respiratória. PCR tende a ser mais útil precocemente; sorologia depende do tempo de doença. Notificar e documentar a exposição. Hipocalemia pode ocorrer mesmo com disfunção renal; reposição exige medidas seriadas.

Tratamento. Forma leve em criança com VO viável: amoxicilina 50 mg/kg/dia VO em três doses, por 5–7 dias, sem exceder 500 mg/dose. Com 50 mg/mL, a dose por tomada é P/3 mL, máximo 10 mL. Doença grave: ceftriaxona 80–100 mg/kg/dia EV, máximo 2 g/dia, por aproximadamente 7 dias, ou penicilina cristalina conforme protocolo. O teto não é o mesmo da meningite. Doxiciclina é alternativa por indicação/idade, não primeira escolha automática no pequeno lactente.

Suporte. Monitorar diurese e hemorragia pulmonar, evitar sobrecarga volêmica e acionar nefrologia/UTI quando necessário. Observar reação de Jarisch–Herxheimer após início do antibiótico. Reavaliar perfusão, eletrólitos e função renal frequentemente; melhora da febre não elimina risco pulmonar. Ajustes devem considerar depuração e gravidade hepática combinada.

Fontes: MS — leptospirose, diagnóstico e manejo; MS — tratamento na suspeita; MS — Guia de Vigilância, 6ª edição, leptospirose

162. Linfadenomegalia em Pediatria

Estratificação. Linfonodos cervicais pequenos, móveis e bilaterais após virose frequentemente são reacionais. Adenite unilateral dolorosa com febre favorece infecção bacteriana; supraclavicular, endurecimento/fixação, crescimento progressivo, sintomas B ou hepatoesplenomegalia exigem investigação. Não prescrever antibiótico apenas porque um linfonodo é palpável.

Exames. Criança bem com evolução curta pode ser acompanhada clinicamente. Hemograma/esfregaço, marcadores inflamatórios e testes dirigidos são úteis quando persistente ou suspeita de doença sistêmica. Ultrassom se houver dúvida de abscesso; radiografia de tórax quando há preocupação com doença mediastinal. Exposição orienta pesquisa de Bartonella, EBV, TB e micobactéria não tuberculosa.

Adenite piogênica. Cefalexina 20 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 750 mg/dose, por 7 dias, com revisão em 48 horas, é opção na criança bem. Com 50 mg/mL: 0,4 mL/kg/dose. Estado geral comprometido ou falha oral exige hospital, antibiótico EV e avaliação de drenagem. Infecção odontogênica pode requerer cobertura diferente e controle do dente causal.

Cuidados. Suspeita de micobacteriose demanda equipe especializada; incisão simples pode produzir fístula crônica. Evitar corticoide antes de esclarecer linfoma ou infecção específica. Documentar tamanho/localização e evolução em seguimento, sem solicitar excisão imediata de todo linfonodo reacional. Retorno por crescimento acelerado, dificuldade respiratória/deglutição ou toxicidade.

Fontes: RCH — linfadenomegalia cervical; BAPO — linfadenite micobacteriana

163. Linfangite

Avaliação. Faixa eritematosa dolorosa ascendendo de ferida, fissura ou picada, com linfonodo regional sensível, pode representar linfangite bacteriana. Confirmar porta de entrada e avaliar celulite/abscesso. Diferenciar reação linear inflamatória, esporotricose nodular e trajeto de larva migrans. Febre alta, prostração, progressão rápida ou perfusão alterada justificam avaliação de bacteremia/sepse.

Conduta. No quadro superficial leve, sem purulência e com boa condição geral, tratar como infecção estreptocócica de pele usando o esquema de cefalexina do tema 131, por 5–7 dias conforme resposta. Não há necessidade de um segundo antibiótico simplesmente porque há um traço linfangítico. Purulência exige avaliar

drenagem e cultura; MRSA e exposição a água/mordida mudam espectro.

Exames e suporte. Exames não são obrigatórios no caso leve típico. Hemocultura e avaliação de órgãos no paciente tóxico; ultrassom se coleção suspeita. Elevar membro, limpar a porta de entrada e usar analgesia conforme necessidade. Rever vacinação antitetânica quando houver ferimento pertinente. Não massagear vigorosamente a área infectada.

Seguimento e segurança. Registrar extensão inicial e rever em 24–48 horas. Falha de melhora pede reavaliar foco, agente, corpo estranho e diagnóstico não bacteriano. Ajustar betalactâmico à função renal e avaliar alergia imediata. Internar quando houver sepse, incapacidade de VO, rápida progressão ou barreira importante ao acompanhamento; não aguardar evolução do traço para reconhecer instabilidade.

Fontes: RCH — pele e partes moles; NHS — celulite

164. Malária em Pediatria

Emergência dependente da espécie. Febre em criança que esteve em área de transmissão exige teste rápido/gota espessa e quantificação parasitária. Alteração de consciência, convulsão, prostração, anemia grave, hipoglicemia, acidose, choque ou insuficiência renal/respiratória indicam malária grave, independentemente de febre no momento. Não adiar tratamento esperando transferência.

Forma grave. Artesunato EV: peso<20 kg,3 mg/kg/dose; peso≥20 kg,2,4 mg/kg/dose, nas horas 0,12 e 24 e depois a cada 24 horas até poder completar esquema oral combinado. Conferir preparação específica do frasco; os diluentes alcalinos e a diluição seguinte não podem ser substituídos livremente. Registrar dose emmg e concentração final antes de converter em mL; não usar artesunato como monoterapia oral de conclusão.

Não grave. O esquema depende da espécie, peso, região e recorrência. P. falciparum requer combinação baseada em artemisinina; P. vivax exige tratamento sanguíneo e avaliação de cura radical. Primaquina/tafenoquina têm restrições importantes relacionadas a G 6 PD, idade e gestação; não prescrever cura radical sem essa checagem. A tabela por faixas de peso do guia MS deve ser aplicada ao produto disponibilizado, sem inventar equivalente líquido.

Suporte e destino. Monitorar glicemia, hemoglobina, eletrólitos, diurese e parasitemia. Criança grave requer UTI; evitar expansão indiscriminada. Após artesunato, vigiar hemólise tardia nas semanas seguintes. Documentar espécie, origem provável e esquema completo na alta, com controle de cura.

Fontes: MS — guia de tratamento da malária; MS — esquemas terapêuticos

Limitação específica: Sem espécie, G 6 PD e apresentação fornecida, não há esquema oral único nem conversão universal do artesunato em mL.

165. Meningoencefalite em Pediatria

Estabilizar antes da punção. Febre com alteração mental, meningismo, convulsão ou déficit focal exige suspeitar infecção SNC. Garantir via aérea, perfusão, glicemia e controle de crises. Colher hemocultura; líquor quando seguro, com citologia, bioquímica, cultura e PCR dirigida. Choque, rebaixamento importante ou sinais de hipertensão intracraniana contraindicam punção imediata; não atrasar antimicrobiano.

Esquema além de 2 meses. Ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV, máximo 4 g/dia, ou cefotaxima 50 mg/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose. Vancomicina é adicionada quando houver risco de pneumococo resistente/Gram-positivo relevante, com monitorização de exposição. Em suspeita de encefalite HSV: aciclovir 20 mg/kg/dose EV 8/8 h entre 3 meses e 12 anos e 10 mg/kg/dose 8/8 h acima de 12 anos, ajustado à função renal. Neonatos e lactentes pequenos requerem cobertura adicional de Listeria/GBS e esquemas próprios.

Adjuntos. Dexametasona 0,15 mg/kg/dose EV 6/6 h, máximo 10 mg/dose, por até 4 dias, quando indicada para meningite bacteriana, iniciada antes/com a primeira dose antibiótica; não usar rotineiramente em neonatos. Não restringir líquidos de maneira automática a toda criança: perfusão, sódio e sinais de excesso orientam a prescrição.

Bomba e seguimento. Aciclovir diluído≤5 mg/mL por pelo menos 1 hora, conforme módulo 155; nunca em bolus. Monitorar creatinina, sódio, diurese e neurologia. Duração é definida pelo agente: não usar o mesmo prazo para meningococo, pneumococo e HSV. Internação é obrigatória; planejar avaliação auditiva e

neurológica.

Fontes: RCH — meningite e encefalite; OMS — meningite,2025

166. Micobacteriose Atípica em Pediatria

Fenótipo. Adenomegalia cervical unilateral, pouco dolorosa, crônica, com pele violácea em criança imunocompetente sugere micobactéria não tuberculosa. Diferenciar TB, adenite piogênica, Bartonella e neoplasia. Doença disseminada, osteoarticular ou pulmonar constitui cenário distinto e exige avaliação imune e infectológica.

Investigação. Ultrassom define relação anatômica; obter material para histologia, cultura micobacteriana, identificação de espécie e sensibilidade quando necessário. A decisão entre observação, excisão e fármacos considera estágio, fistulização e proximidade do nervo facial. Não considerar teste tuberculínico isolado como prova de TB, nem iniciar esquema tuberculostático padrão sem contexto.

Tratamento. Excisão completa pode ser curativa na doença nodal localizada selecionada, mas traz risco de lesão neural; observação também pode ser apropriada em determinados estágios. Antimicrobianos combinados são usados quando cirurgia não é adequada, com escolha dirigida por espécie e sensibilidade. Macrolídeo isolado empírico não deve ser oferecido como regime universal, especialmente diante de espécies com resistência induzível. Incisão/drenagem simples pode aumentar fístula e cicatriz.

Seguimento. Documentar tamanho, cor da pele, drenagem, sintomas sistêmicos e função facial. Caso se opte por combinação farmacológica, registrar interações, função hepática, ECG quando pertinente e avaliações ocular/auditiva de acordo com os fármacos. A resolução pode levar meses; piora sistêmica ou crescimento atípico exige revisar diagnóstico, não apenas prolongar tratamento.

Fontes: BAPO 2024 — linfadenite cervical não tuberculosa

Limitação específica: Espécie, sensibilidade e relação anatômica não foram fornecidas; não foi criada combinação antimicobacteriana universal para doenças heterogêneas.

167. Micoses Cutâneas na Infância

Confirmar topografia. Tinea corporis/cruris/pedis envolve pele; tinea capitis compromete folículo e exige terapia sistêmica. Diferenciar eczema, psoríase, dermatite de fralda por Candida e alopecia não infecciosa. Exame micológico/cultura ajuda em lesões atípicas, extensas, resistentes ou couro cabeludo; não iniciar associação antifúngico-corticoide para esconder inflamação.

Pele limitada. Clotrimazol 1% em camada fina duas vezes ao dia por 2–4 semanas é opção, incluindo margem da lesão. Terbinafina tópica pode ser alternativa conforme idade/bula. Manter área seca, tratar fatores de reinfecção e avaliar conviventes/animais quando pertinente. Nistatina não trata dermatófitos.

Couro cabeludo. Terapia sistêmica deve considerar Microsporum versus Trichophyton. Terbinafina VO em faixas frequentemente utilizadas: 10 a <20 kg,62,5 mg/dia; 20–40 kg,125 mg/dia; >40 kg,250 mg/dia, usualmente 4 semanas para Trichophyton, com ajuste pela espécie/resposta. Uso pediátrico pode ser fora da bula brasileira; não fracionar comprimido sem garantir dose. Microsporum frequentemente responde melhor a griseofulvina, com esquema próprio e duração maior. Xampu adjuvante reduz disseminação, mas não cura sozinho a infecção folicular.

Segurança/destino. Verificar hepatopatia, interações e necessidade de transaminases para antifúngico sistêmico. Kerion deve ser avaliado prontamente para reduzir alopecia cicatricial; não drenar como abscesso bacteriano sem confirmação. Revisar resposta clínica e micológica ao final.

Fontes: Canadian Paediatric Society — antifúngicos; CDC — tratamento de tineas

Limitação específica: Disponibilidade e fracionamento de formulações pediátricas sistêmicas exigem confirmação farmacêutica; não foi fabricada suspensão em mL.

168. Miosite Viral Aguda

Reconhecimento. Dor bilateral em panturrilhas e dificuldade de marcha durante recuperação de virose, com força/reflexos preservados, sugerem miosite aguda benigna. Não concluir apenas pela associação temporal: assimetria, fraqueza verdadeira, arreflexia, dor articular, febre persistente ou toxicidade exigem avaliar guillain–Barré, infecção osteoarticular e outras causas.

Exames que modificam conduta. CK, urina, creatinina e eletrólitos ajudam a distinguir curso benigno de rabdomiólise com repercussão. Urina escura, oligúria, hipercalemia ou elevação importante/progressiva da CK pedem monitorização hospitalar. Nenhum valor isolado de CK é critério universal de alta ou UTI; a coorte recente associa valores altos à internação, mas não valida um limiar causal.

Tratamento. Repouso relativo, hidratação adequada e analgesia do módulo comum. Não indicar corticoide, antibiótico ou antiviral apenas por miosite. Em rabdomiólise, hidratação EV e metas de diurese devem respeitar avaliação volêmica e função renal; não aplicar volume fixo excessivo nem bicarbonato/manitol rotineiros. Evitar nefrotóxicos se houver desidratação/lesão renal.

Seguimento. Alta é possível com criança bem, dor controlada, ingestão/diurese adequadas, exames sem risco e revisão garantida. Reavaliar clínica e CK até normalização quando indicado. Recorrência, fraqueza persistente ou CK que não normaliza exige investigar miopatia metabólica/genética. O desaparecimento da febre não substitui a avaliação renal.

Fontes: Coorte pediátrica primária,2025; Coorte em emergência pediátrica,2021

169. Monilíase em Pediatria

Diagnóstico e extensão. Placas brancas aderentes na mucosa oral que deixam base inflamada ao remover sugerem candidíase; leite residual sai mais facilmente sem esse aspecto. Examinar fralda, alimentação e uso de antibiótico/corticoide inalatório. Disfagia, odinofagia, perda ponderal, recorrência intensa ou doença extensa exigem investigar esofagite e imunodeficiência.

Tratamento oral localizado. Nistatina suspensão 100.000 UI/mL,200.000 UI (2 mL) por dose, quatro vezes ao dia, é esquema frequente para lactentes; distribuir na mucosa após alimentação, evitando despejar no fundo da boca. Em prematuro/RN, a dose pode ser menor e deve seguir bula/protocolo neonatal. Manter 7–14 dias e pelo menos 48 horas após desaparecimento das lesões, conforme produto. Não confundir UI com mg; 2 mL× 100.000 UI/mL=200.000 UI.

Cuidados associados. Higienizar chupetas/mamadeiras e tratar candidíase materna concomitante quando diagnosticada. Não recomendar limpeza agressiva das placas. Na dermatite por Candida, barreira e antifúngico tópico são úteis, sem corticoide potente associado.

Escalada e segurança. Falha após uso correto exige confirmar diagnóstico, adesão e fatores predisponentes; fluconazol sistêmico é reservado a casos selecionados, com dose por indicação e checagem de interação/função renal. Febre ou instabilidade em RN não é “sapinho complicado”: investigar infecção invasiva pelo tema 159. Reavaliar sucção, dor, peso e ingestão.

Fontes: Canadian Paediatric Society — candidíase oral; DailyMed — nistatina 100.000 UI/mL, bula do fabricante

170. Mononucleose Infecciosa em Pediatria

Avaliação. Febre, faringite, adenomegalia e fadiga, com possível hepatoesplenomegalia, sugerem mononucleose por EBV. Exame heterófilo pode ser negativo nos pequenos ou precocemente; sorologia específica auxilia quando modifica conduta. Não presumir que toda amigdalite exsudativa seja bacteriana. Obstrução de via aérea, dor abdominal súbita, síncope, icterícia intensa ou sangramento indicam urgência.

Exames. Hemograma com diferencial e transaminases conforme gravidade; avaliar outros agentes/diferenciais se apresentação atípica. Ultrassom de baço não é rastreio obrigatório de todo caso nem libera sozinho atividade esportiva. A avaliação clínica e tempo de doença são essenciais.

Tratamento. Repouso relativo, hidratação e analgesia do módulo comum. Antiviral, antibiótico e corticoide sistêmico não são de rotina. Corticoide pode ser considerado em complicações específicas, como obstrução

importante da via aérea ou citopenia imune grave, com plano especializado. Evitar amoxicilina/ampicilina sem indicação bacteriana confirmada, pela associação com exantema; esse rash não prova necessariamente alergia imediata permanente.

Reavaliação/destino. Afastar esportes de contato e atividades com risco abdominal enquanto houver risco de ruptura esplênica; retorno progressivo depende de resolução dos sintomas e avaliação médica. Dor no quadrante superior esquerdo, dor referida ao ombro ou choque exige investigar ruptura imediatamente. Internar quando houver comprometimento respiratório, desidratação relevante, complicação hematológica/hepática ou impossibilidade de cuidado seguro. Fadiga pode persistir além da faringite, sem justificar cursos repetidos de antimicrobianos.

Fontes: CDC — mononucleose infecciosa; CDC — testes de EBV

171. Osteomielite em Pediatria

Suspeita. Dor óssea localizada, febre, limitação funcional ou recusa de apoio podem representar osteomielite hematogênica, mesmo sem radiografia alterada inicialmente. Avaliar sepse, articulação adjacente e abscesso. Neonatos, doença falciforme, imunodeficiência e ferimento perfurante modificam patógenos prováveis e espectro.

Exames. Hemocultura antes do antibiótico quando não houver atraso; PCR/VHS ajudam seguimento. Radiografia exclui fratura/tumor e serve de referência; RM é o principal exame para delimitar foco, abscesso e extensão quando indicado. Obter cultura de osso/coleção durante procedimento. Criança instável recebe antimicrobiano sem esperar RM.

Terapia. Para provável MSSA, o esquema de cefazolina do tema 128 é opção; MRSA depende de epidemiologia e gravidade. Abscesso, sequestro, instabilidade ou falha demandam avaliação de drenagem/desbridamento. Após resposta clínica e laboratorial, transição oral dirigida permite completar tratamento; não prolongar EV apenas por existir osteomielite. A diretriz PIDS/IDSA aceita 3–4 semanas totais em osteomielite aguda por S. aureus não complicada e de boa resposta; doença complexa precisa de prazo maior.

Monitorização. Seguir dor, função, febre, PCR e tolerância medicamentosa; reavaliar diagnósticos e controle de foco se persistir bacteremia. Cultura e sensibilidade orientam estreitamento. Ajustar antibiótico à função renal e considerar uso fora da bula nas doses elevadas. Seguimento ortopédico verifica crescimento e sequela, especialmente com placa fisária acometida.

Fontes: PIDS/IDSA — osteomielite aguda pediátrica; RCH — infecção osteoarticular

172. Paracoccidioidomicose em Pediatria

Forma juvenil. Febre, perda ponderal, adenomegalias volumosas, hepatoesplenomegalia e sinais de comprometimento abdominal/medular podem representar paracoccidioidomicose aguda/subaguda. Considerar TB, neoplasia e outras micoses; não iniciar corticoide empírico antes de esclarecer. Obstrução intestinal/biliar, insuficiência adrenal, desnutrição grave ou instabilidade justificam internação.

Diagnóstico. Exame direto/cultura e histopatologia de tecido ou secreção; sorologia auxilio seguimento quando disponível. Avaliar hemograma, função hepática/renal, eletrólitos e extensão por imagem dirigida.

Tratamento pediátrico. O consenso brasileiro recomenda TMP-SMX com 8–10 mg/kg/dia de TMP, dividido em duas doses. Portanto,4–5 mg/kg de TMP por dose 12/12 h; na suspensão 8 mg TMP+40 mg SMX/mL,0,5–0,625 mL/kg/dose. Não interpretar 8–10 mg/kg como dose a cada 12 horas: isso duplicaria o total diário. A duração frequentemente é 18–24 meses, condicionada à cura clínica/laboratorial, não apenas a um prazo. Doença grave pode exigir anfotericina B desoxicolato 0,5–0,7 mg/kg/dia EV, máximo 50 mg/dia, seguida de tratamento oral; formulação lipídica usa dose diferente.

Segurança/seguimento. Monitorar hemograma, creatinina, potássio e transaminases; ajustar TMP-SMX por função renal, verificar alergia a sulfas e interações. Não usar automaticamente em lactentes muito pequenos. Itraconazol é alternativa selecionada, com absorção/interações relevantes. Documentar peso seriado, estado nutricional e resolução dos órgãos acometidos; o seguimento prolongado é parte da terapia.

Fontes: II Consenso Brasileiro — dose pediátrica; MS — tratamento da PCM

173. Rubéola

Suspeita e vigilância. Exantema maculopapular, febre geralmente baixa e adenopatia retroauricular/suboccipital sugerem rubéola, mas o diagnóstico clínico isolado é pouco específico. Investigar vacinação, viagem, contato e gestantes expostas. Mesmo quadros leves têm importância sanitária pelo risco congênito.

Exames e proteção. Notificar suspeita e colher amostras conforme vigilância para PCR/sorologia. Resultados precisam ser interpretados com o tempo de sintomas e possibilidade de falso-positivo; não confirmar infecção aguda apenas por uma IgM isolada sem contexto. Evitar contato com gestantes e adotar isolamento por sete dias após início do exantema, conforme orientação sanitária.

Tratamento. Não há antiviral específico de rotina. Oferecer hidratação e analgesia/antitérmico para desconforto. Antibiótico e corticoide não são indicados no exantema simples. Artralgia geralmente recebe manejo sintomático; púrpura, sangramento, alteração neurológica ou desidratação exigem investigar complicação e possível internação.

Seguimento. Atualizar vacinação dos elegíveis após avaliação; vacina não trata o episódio já instalado e não deve ser administrada à gestante. Encaminhar gestante exposta ao pré-natal especializado. Suspeita de rubéola congênita exige investigação auditiva, ocular, cardíaca e laboratorial própria, além de precauções específicas para eliminação viral prolongada. Não usar a aparente benignidade no escolar para minimizar o risco fetal ou dispensar a vigilância epidemiológica.

Fontes: CDC — rubéola clínica; CDC — vigilância de rubéola

174. Sarampo

Tempo-dependente. Febre, tosse, coriza, conjuntivite e exantema descendente levantam suspeita de sarampo. Isolar por aerossóis, evitar sala de espera compartilhada e notificar imediatamente. Coletar amostras para PCR/sorologia conforme vigilância; não aguardar confirmação para precauções. Hipoxemia, desconforto respiratório, desidratação, alteração mental ou convulsões requerem hospital.

Tratamento. Suporte de hidratação/nutrição e avaliação de pneumonia, otite e encefalite. Vitamina A, por VO, uma dose ao dia por dois dias: menores de 6 meses 50.000 UI; 6–11 meses 100.000 UI; 12 meses ou mais 200.000 UI. Não confundir UI com mg nem prescrever dose diária prolongada. A apresentação deve permitir medir exatamente o conteúdo; volume=UI prescritas/UI por mL. Não há antiviral específico de rotina e antibiótico não é indicado preventivamente a todos: tratar infecção bacteriana quando identificada/suspeita consistente.

Segurança. Vitamina A em excesso é tóxica, sobretudo para fígado e SNC; revisar suplementos concomitantes. Criança com deficiência clínica pode precisar de dose adicional posteriormente, sob avaliação. Corticoide não integra rotina do sarampo não complicado.

Reavaliação e contatos. Monitorar respiração, saturação, ingestão e neurologia. Internar lactente vulnerável ou complicações; assegurar seguimento após alta. Vigilância define bloqueio vacinal ou imunoglobulina pós-exposição para contatos elegíveis. A vitamina A auxilia manejo, mas não substitui vacinação nem impede transmissão.

Fontes: CDC Yellow Book — sarampo e vitamina A; CDC — prevenção/tratamento 2026

175. Sepse em Pediatria

Reconhecimento e ABCDE. Sepse é infecção com disfunção orgânica; choque pode existir antes de hipotensão. Garantir via aérea/oxigenação, monitor cardíaco, glicemia, acesso EV/IO, lactato, culturas e avaliação de foco. Antibiótico idealmente na primeira hora no choque; sem choque, investigação rápida e tratamento até 3 horas quando se confirmar a preocupação. Coleta não deve atrasar.

Ressuscitação SSC 2026. Com UTI disponível, cristaloide balanceado 10–20 mL/kg por expansão, até 40–60 mL/kg na primeira hora conforme resposta. Reavaliar após cada alíquota e interromper por resolução ou sobrecarga. Não é meta obrigatória de volume. Sem UTI e sem hipotensão, a diretriz recomenda evitar bolus.

Adrenalina ou noradrenalina podem ser iniciadas conforme perfil; SSC 2026 não estabelece preferência universal. Após ressuscitação, a nova recomendação condicional de SpO_2 conservadora 88–92% não deve ser confundida com tolerar hipoxemia durante estabilização inicial.

BIC de adrenalina — exemplo. Concentração de emergência 6 mcg/mL: 0,6 mg=0,6 mL da ampola 1 mg/mL, completar com SF 0,9% para 100 mL totais (adicionar 99,4 mL). Início de referência 0,1 mcg/kg/min; bomba=(dose×P× 60)/6. Para 16 kg: 16 mL/h; reverso 16 × 6/(16 × 60)=0,1 mcg/kg/min. Consumo 6/12/24 h=96/192/384 mL; 100 mL duram matematicamente 6,25 h, sem inferir estabilidade. Acesso periférico de boa qualidade é ponte com vigilância de extravasamento; acesso central assim que prático. Titular por perfusão/pressão, sem teto absoluto fictício.

Tratamento e finalização. Antimicrobiano depende de idade, foco, origem e resistência; não há mistura universal. Controlar foco, rever culturas e descalonar. Metas: melhora de consciência, perfusão, diurese e tendência do lactato. Dupla checagem de peso, unidade, concentração, via e programação é obrigatória; choque exige UTI.

Fontes: SCCM/ESICM — SSC pediátrica 2026; PCH — sepse e adrenalina periférica

176. Síndrome da Pele Escaldada

Reconhecer a toxina. Dor cutânea, eritema difuso, bolhas flácidas e descamação em lactente/criança pequena sugerem síndrome da pele escaldada estafilocócica. Mucosas costumam ser poupadas; acometimento mucoso importante pede avaliar SJS/NET e outros diagnósticos. Desidratação, hipotermia, dor, sepse e perdas cutâneas exigem internação.

Exames. Colher culturas de provável foco estafilocócico (nasofaringe, conjuntiva, umbigo, ferida) e hemocultura conforme gravidade. Conteúdo da bolha pode não cultivar o agente porque a doença é mediada por toxina produzida à distância. Avaliar eletrólitos, função renal e balanço hídrico.

Tratamento. Antibioticoterapia EV antiestafilocócica, como cefazolina no esquema hospitalar do tema 128, quando MSSA provável; adicionar/substituir cobertura de MRSA conforme risco e sensibilidade. Neonatos precisam de esquema próprio. A inibição de toxina com clindamicina não deve ser automática sem considerar resistência local e gravidade. Não usar corticoide sistêmico por rotina.

Suporte e destino. Manipulação mínima, curativos não aderentes, analgesia adequada e controle térmico. Reposição de líquidos individualizada por perfusão, diurese e perdas; não copiar fórmula de queimadura extensa sem avaliação. Evitar substâncias irritantes na pele sem barreira. Monitorizar infecção secundária e resposta nas primeiras 24–48 h. A alta exige reepitelização em curso, estabilidade hídrica, dor controlada e tratamento dirigido viável. Falha pede reconsiderar diagnóstico, foco e resistência, com dermatologia/infectologia.

Fontes: RCH — síndrome da pele escaldada/pele; PCH — staphylococcal scalded skin syndrome

177. Síndrome do Choque Tóxico

Emergência. Febre, hipotensão, exantema difuso e falência de múltiplos órgãos podem representar choque tóxico estafilocócico ou estreptocócico. Procurar ferida, foco puerperal, tamponamento, infecção de partes moles e corpo estranho. Dor desproporcional exige exploração para fasciíte necrosante; não esperar imagem se a suspeita cirúrgica é alta.

Estabilização e exames. ABCDE e ressuscitação pelo tema 175; hemoculturas e culturas do foco sem atraso. Hemograma, eletrólitos, função renal/hepática, coagulação, lactato e CK conforme clínica. Remover corpo estranho e realizar drenagem/desbridamento precoce quando indicado.

Antimicrobianos. Iniciar cobertura ampla adequada a MSSA/MRSA, estreptococo e possível foco polimicrobiano. Acrescentar clindamicina 15 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 600 mg/dose, como componente inibidor de síntese proteica no esquema pediátrico RCH, sem usá-la isoladamente no choque. Após confirmação de estreptococo do grupo A, penicilina mais clindamicina é a combinação de referência CDC. Suspeita de resistência a clindamicina ou contexto especial requer alternativa dirigida. Vancomicina exige ajuste por função renal e exposição, não uma dose fixa para todas as idades.

Adjuntos/seguimento. Imunoglobulina pode ser considerada em doença estreptocócica muito grave, mas o benefício não é definitivamente estabelecido; não é componente obrigatório de todos casos. Monitorar necessidade de vasopressor, perfusão, diurese e controle de foco. Internação em UTI e reavaliação cirúrgica seriada são essenciais; queda da febre isolada não atesta controle.

Fontes: CDC — choque tóxico estreptocócico; RCH — antimicrobianos, choque tóxico

178. Síndrome Febril em Pediatria

A idade modifica o risco. Febre é sinal, não diagnóstico. Avaliar aparência, perfusão, respiração, hidratação, neurologia e foco. Temperatura≥38°C em RN e pequeno lactente exige avaliação específica; melhora após antitérmico não exclui infecção grave. Prematuridade, imunodeficiência, antibiótico prévio e seguimento inseguro reduzem aplicabilidade de regras de baixo risco.

Investigação. No RN, geralmente se indicam urina, sangue e líquor, com internação e antibiótico empírico. Entre 29–90 dias, estratificar com urina, marcadores inflamatórios e critérios validados; não aplicar somente uma leucocitose ou teste viral positivo para dispensar investigação. Em crianças maiores bem e com foco típico, exames indiscriminados não são necessários. Suspeita de sepse migra imediatamente ao tema 175.

Conduta. Hidratação e antitérmico para desconforto no módulo comum. Não indicar antibiótico “preventivo” para febre sem foco em toda criança. Quando indicado no hospital, selecionar esquema por idade e possível SNC, com doses neonatais explicitamente distintas; não usar ceftriaxona sem checar prematuridade, icterícia e cálcio EV. Empírico deve ser revisto após culturas e evolução.

Reavaliação e destino. Observação pode ser necessária para avaliar tendência clínica, sem prolongar espera num instável. Alta exige bom estado geral, ingestão/diurese adequadas, cuidador capaz e retorno garantido. Fornecer sinais objetivos: dificuldade para acordar, respiração anormal, extremidades frias, rash que não desaparece à pressão, vômitos persistentes ou diminuição da diurese. Febre≥5 dias pede nova avaliação para Kawasaki, SIM-P e outras causas.

Fontes: Canadian Paediatric Society — febre até 90 dias; RCH — criança febril

179. Síndrome Inflamatória Multissistêmica Associada à Covid-19

Reconhecimento. Febre persistente com inflamação sistêmica e manifestações de múltiplos órgãos após SARS-CoV-2 levanta SIM-P/MIS-C. Dor abdominal, rash, conjuntivite e choque podem predominar sobre sintomas respiratórios. Excluir sepse bacteriana, choque tóxico, Kawasaki e outras causas; positividade de sorologia não confirma sozinha a síndrome.

Exames/estabilização. Hemograma, PCR, perfil metabólico, coagulação, dímero D, ferritina, troponina, BNP/NT-proBNP, ECG e ecocardiograma conforme apresentação. Em choque, ressuscitação cautelosa com avaliação cardíaca, culturas e antibiótico até esclarecimento. Miocardite/disfunção ventricular favorece UTI e cautela com volumes.

Imunomodulação. ACR recomenda para a maioria dos hospitalizados imunoglobulina EV 2 g/kg pelo peso ideal, máximo 100 g, associada a glicocorticoide 1–2 mg/kg/dia, com fármaco/via conforme gravidade. Avaliar função cardíaca e sobrecarga volêmica antes; dividir a IGIV pode ser necessário. Concentração/velocidade vêm da bula do produto, sem mL/h universal para IGIV. Na solução 10%=100 mg/mL, apenas como cálculo condicionado à apresentação confirmada,2 g/kg equivalem a 20 mL/kg totais, não por hora.

Antitrombótico e seguimento. AAS 3–5 mg/kg/dia, máximo 81 mg/dia, é opção antiagregante quando elegível, evitando sangramento ativo e plaquetopenia importante; anticoagulação depende de trombose, coronárias e função ventricular. Não extrapolar AAS a outras viroses. Monitorar glicemia, pressão, infecção, ECG e ecocardiograma. Refratariedade requer equipe multidisciplinar; alta com desmame e seguimento cardiológico.

Fontes: ACR — orientação MIS-C versão 3; CDC — tratamento SIM-P

180. Síndromes Febris Periódicas

Não é sinônimo de infecções repetidas. Episódios estereotipados de febre com intervalos de bem-estar, crescimento normal, aftas, faringite e adenite sugerem PFAPA. Registrar calendário, duração, sintomas associados, história familiar e resposta. Neutropenia cíclica, febre mediterrânea familiar, outras doenças autoinflamatórias, imunodeficiência e infecção crônica devem ser consideradas conforme fenótipo.

Exames. Hemograma seriado quando houver suspeita de neutropenia cíclica; marcadores inflamatórios durante e fora dos episódios podem ajudar. Teste genético é dirigido por fenótipo, não painel automático. Perda ponderal, má evolução do crescimento, organomegalia, rash atípico ou sintomas persistentes entre crises afastam a forma clássica e pedem especialista.

Tratamento de crise PFAPA confirmada. Prednisona/prednisolona 1 mg/kg VO em dose única, máximo 60 mg, pode abortar episódio; resposta inadequada pode justificar 2 mg/kg, mantendo máximo 60 mg, sob plano previamente definido. Se concentração líquida C mg/mL, volume=min(P,60)/C no esquema 1 mg/kg. Não usar “teste com corticoide” em toda febre sem excluir infecção grave. Crises podem ficar mais próximas após corticoide.

Longo prazo. Profilaxia com colchicina/cimetidina ou amigdalectomia são opções selecionadas, não receita universal; decisão inclui frequência, impacto familiar e diagnóstico confirmado. Antibiótico não é rotina da crise PFAPA. Reavaliar resposta, intervalos e efeitos adversos, evitando cursos prolongados de corticoide. Doenças autoinflamatórias monogênicas têm tratamentos próprios e não devem ser encaixadas automaticamente nesse fluxo.

Fontes: CARRA — consenso PFAPA original

Limitação específica: O esquema abortivo é específico de PFAPA previamente estabelecida, não se aplica automaticamente a todas as síndromes febris periódicas.

181. Teníase em Pediatria

Confirmar o parasita. Eliminação de proglotes ou exame parasitológico com ovos de tênia sugere teníase intestinal. Sempre diferenciar de cisticercose: a origem, localização do parasita e tratamento são diferentes. Antes de praziquantel/albendazol, perguntar por convulsões, cefaleia progressiva e sintomas visuais, que justificam investigação de neurocisticercose/comprometimento ocular.

Tratamento. Praziquantel 5–10 mg/kg VO em dose única; a dose 10 mg/kg apresenta melhor evidência de cura no CDC. Não é esquema 50 mg/kg/dia da neurocisticercose. Dose total=10 ×P mg; volume exige apresentação líquida validada, não disponível confirmada neste lote. Niclosamida 50 mg/kg VO dose única é alternativa, respeitando teto adulto 2 g e disponibilidade. Albendazol 400 mg VO ao dia por 3 dias é opção com evidência mais limitada, não primeira escolha automática.

Segurança. Crianças pequenas, especialmente menores de 4 anos para praziquantel, exigem confronto com bula/benefício-risco; campanhas de esquistossomose não definem elegibilidade universal. Não fracionar comprimidos grandes sem garantir dose/deglutição. Tratamento cisticida pode provocar sintomas neurológicos se houver doença do SNC não reconhecida.

Seguimento. Reexaminar fezes em 1 e 3 meses para confirmar eliminação; coletar proglotes para identificação quando útil. Orientar higiene, saneamento e preparo adequado da carne. Para T. solium, avaliar risco de transmissão fecal-oral e contatos conforme vigilância. Persistência de ovos exige revisar espécie, adesão e reinfecção antes de repetir aleatoriamente.

Fontes: CDC — tratamento da teníase; CDC — cisticercose/transmissão

Limitação específica: Apresentação pediátrica líquida de praziquantel/niclosamida não confirmada; não se gerou mL fictício.

182. Toxocaríase em Pediatria

Definir fenótipo. Exposição a solo contaminado/animais, eosinofilia, hepatomegalia, tosse e sintomas constitucionais podem sugerir toxocaríase visceral. Forma ocular pode ocorrer sem eosinofilia marcante. Sorologia positiva isolada pode refletir exposição prévia e não obriga tratamento; correlacionar com quadro e órgãos acometidos.

Exames. Hemograma com eosinófilos, sorologia, função hepática e imagem dirigida; queixa visual exige oftalmologia urgente. Seres humanos não eliminam ovos de Toxocara nas fezes, portanto parasitológico fecal negativo não afasta doença. Considerar outros helmintos e causas não infecciosas de eosinofilia.

Terapia. CDC descreve albendazol 400 mg VO duas vezes ao dia por 5 dias para adultos e pediatria; não define um esquema ponderal próprio na página. Por ser dose fixa alta para algumas crianças pequenas, não foi convertida automaticamente em receita universal para qualquer peso. Na apresentação 40 mg/mL,400 mg=10 mL por dose, apenas quando esse esquema for considerado adequado ao paciente. A duração ótima não é estabelecida e doença ocular/grave pode exigir plano diferente.

Segurança/seguimento. Verificar idade, função hepática, hemograma e interações; cursos prolongados aumentam risco de citopenia/hepatotoxicidade. Inflamação ocular pode precisar de corticoide com equipe especializada, evitando dar antiparasitário isolado em situação com risco visual. Reavaliar sintomas, eosinofilia e função do órgão; título sorológico pode permanecer positivo e não é sozinho marcador de falha. Orientar higiene e controle parasitário dos animais.

Fontes: CDC — toxocaríase, tratamento; CDC — visão clínica

Limitação específica: Fonte CDC fornece dose fixa sem estratificação pediátrica ponderal; não foi extrapolada a lactentes/crianças pequenas como regra universal.

183. Triquinose em Pediatria

Suspeita. Febre, mialgia, edema periorbitário e eosinofilia após consumo de carne crua/malpassada, especialmente de caça, podem representar triquinose. Dor muscular intensa, dispneia, arritmia, sinais de miocardite ou alteração neurológica justificam hospital. Investigar outros consumidores do mesmo alimento e acionar vigilância.

Diagnóstico. Hemograma/eosinófilos, CK, função hepática/renal e sorologia conforme tempo de infecção; resultado precoce negativo pode exigir repetição. ECG/troponina em sinais cardíacos; imagem ou biópsia são reservados a casos selecionados. A história de exposição é decisiva.

Tratamento. Antiparasitário precoce tem maior chance de impedir progressão; após encistamento muscular a eliminação é menos previsível. O CDC descreve albendazol 400 mg VO 12/12 h por 8–14 dias, como dose adulta e pediátrica, e alternativa com mebendazol em escalonamento. Essa dose fixa não foi aplicada automaticamente a pequenos lactentes; fonte alerta que não há aprovação abaixo de 2 anos. Na suspensão 40 mg/mL,400 mg=10 mL por dose quando o regime for apropriado.

Segurança e adjuntos. Formas graves podem requerer corticoide para inflamação, com equipe especializada; não especificar dose única universal diante de órgãos/risco diferentes. Monitorar hemograma e transaminases em cursos prolongados, além de CK e função renal. Miocardite/encefalite requerem UTI conforme repercussão. Seguimento verifica recuperação funcional e exposição compartilhada, sem considerar sintomas residuais isolados como indicação automática de novos cursos.

Fontes: CDC — triquinose, tratamento; CDC — visão clínica

Limitação específica: Dose fixa CDC não foi transformada em esquema universal de qualquer idade/peso; menores de 2 anos e doença orgânica demandam decisão especializada.

184. Varicela em Pediatria

Avaliação. Vesículas em diferentes estágios com distribuição típica sugerem varicela. Investigar vacinação, imunodeficiência, corticoterapia e exposição de RN/gestantes. Dispneia, alteração neurológica, dor cutânea desproporcional, febre recorrente e celulite indicam complicação. Adotar precaução por aerossol/contato no hospital.

Criança saudável. Hidratação, higiene e analgesia no módulo comum. Não indicar aciclovir oral rotineiramente em toda criança com varicela simples. Evitar AAS pelo risco de Reye; preferir evitar ibuprofeno diante da relação com infecções graves de pele. Não usar antibiótico preventivo nem corticoide rotineiro.

Antiviral quando indicado. Casos selecionados de maior risco, idealmente até 24 horas do início do rash, podem receber aciclovir 20 mg/kg/dose VO quatro vezes ao dia, máximo 800 mg/dose, por 5 dias. Doença grave/disseminada ou imunodepressão relevante exige aciclovir EV e avaliação hospitalar; dose varia por idade e SNC, com ajuste renal. Volume oral=min(20 P,800)/C, pois a concentração líquida brasileira não foi confirmada neste lote. Preparo EV de referência no módulo 155, sem administração em bolus.

Seguimento/contatos. Orientar retorno por infecção cutânea, ataxia, sonolência, desidratação ou dispneia. Afastamento conforme evolução até crostas; vacinados com lesões não crostosas seguem critérios próprios. Profilaxia pós-exposição com vacina ou imunoglobulina é decidida por idade, imunidade e risco, não substitui tratamento do caso complicado.

Fontes: CDC — varicela, orientação clínica; CDC — tratamento da varicela; RCH — varicela

Limitação específica: Formulação líquida brasileira de aciclovir não confirmada; mL permanece parametrizado.

185. Disfunção Miccional em Pediatria

Reconhecer o padrão. Diferenciar urgência/hiperatividade detrusora, adiamento miccional, micção disfuncional e perda contínua. Esta última, jato fraco, infecções repetidas, alterações neurológicas ou retenção exigem investigação anatômica/neurológica. Fazer diário de micções, avaliação de constipação, exame perineal/coluna, urina e cultura conforme sintomas; ultrassom com resíduo pós-miccional nas apresentações complicadas.

Tratamento. Uroterapia é a primeira etapa: micções programadas, postura e apoio dos pés, hidratação diurna distribuída, acesso escolar ao banheiro e tratamento concomitante da constipação. Oxibutinina serve para bexiga hiperativa persistente, não para toda incontinência. No esquema RCH: 5–12 anos, 2,5 mg VO de 12/12 h inicialmente, aumentando conforme tolerância até 5 mg de 8/8 h; 12–18 anos, 5 mg de 12/12–8/8 h, teto 15 mg/dia. Comprimido de 5 mg: 2,5 mg corresponde a meio comprimido apenas se a apresentação permitir divisão.

Seguimento. Reavaliar resposta em até dois meses e necessidade de manutenção por 3–6 meses. Vigiar boca seca, constipação e esvaziamento incompleto; medir resíduo quando houver retenção. Não transferir doses de formulações de liberação prolongada para comprimidos imediatos. A apresentação líquida brasileira não foi confirmada para conversão em mL.

Limitação delimitada: Conversão líquida requer produto e concentração efetivamente disponíveis.

Fontes verificadas: RCH — incontinência urinária

186. Doença Renal Crônica em Pediatria

Estratificar. Confirmar cronicidade, causa, filtração e albuminúria. Monitorar crescimento, nutrição, pressão, proteinúria, hemograma, bicarbonato, potássio, cálcio, fósforo, PTH e vitamina D. Hipercalemia, edema pulmonar, acidose refratária ou uremia sintomática exigem hospital e avaliação de terapia renal substitutiva.

Acidose crônica. Para bicarbonato abaixo do normal etário persistente, uma referência pediátrica SBN inicia bicarbonato de sódio VO em 1–2 mEq/kg/dia, dividido em duas ou três tomadas, titulando ao alvo laboratorial. O limite inferior normal referido é 20 mEq/L abaixo de 2 anos e 22 mEq/L nas crianças maiores. Não administrar bicarbonato por rotina com reserva alcalina normal. Vigiar sódio, pressão, edema, potássio e alcalose; a

necessidade pode mudar com diálise. Exemplo: 16 kg ×1,5=24 mEq/dia; três tomadas de 8 mEq. Se a solução oral preparada e validada contém 1 mEq/mL, são 8 mL por tomada; reverso 8×3/16=1,5 mEq/kg/dia. Não confundir solução oral com indicação de injetar o mesmo produto.

Anemia/ferro. Na anemia por DRC sem hemodiálise, o fluxograma KDIGO 2026 considera ferro quando ferritina <100 ng/mL e saturação de transferrina <40%, ou ferritina 100–299 e saturação <25%. Via oral ou IV depende de deficiência, tolerância e resposta. Para criança pequena com deficiência de ferro e via oral apropriada, um ponto inicial sustentado pela AAP 2026 é sulfato ferroso fornecendo **3 mg/kg/dia de ferro elementar**, VO em tomada única; adolescentes: 65 mg de ferro elementar/dia. Essa dose é extrapolada do tratamento pediátrico da deficiência, com acompanhamento nefrológico na DRC. Em 16 kg: 48 mg elementares/dia; volume=48/C, sendo C o ferro elementar em mg/mL. Não calcular pela massa total do sal.

Reavaliar. Hemograma/resposta em cerca de um mês; reservas e tolerabilidade orientam continuação. Falha em 1–3 meses favorece rever causas e considerar ferro IV. KDIGO orienta suspender ferro na infecção ativa e reter reposição quando ferritina >700 ou saturação ≥40%. Eritropoetina, calcitriol, quelantes e hormônio do crescimento exigem indicação própria; não são uma associação fixa. Ajustar todos os medicamentos à função renal e evitar nefrotóxicos.

Fontes verificadas: KDIGO — DRC 2024 e atualização em andamento · KDIGO — mensagens pediátricas · SBN — distúrbios minerais e acidose na DRC pediátrica · KDIGO 2026 — fluxograma pediátrico de anemia · AAP 2026 — deficiência de ferro

187. Enurese na Infância

Confirmar enurese monossintomática. Investigar perdas diurnas, constipação, sede/poliúria, roncos, infecção urinária e recaída após período seco. A presença de sintomas diurnos modifica o manejo. Evitar punição e recompensar comportamentos, não noites secas. Alarme é uma opção inicial quando a família consegue utilizá-lo regularmente.

Desmopressina. Pode ser empregada quando o alarme falha, é impraticável ou se deseja resposta rápida. No esquema RCH, acima de 6 anos: comprimido VO 200 microgramas (=0,2 mg) ao deitar; se necessário, aumentar para 400 microgramas (=0,4 mg). Alternativa orodispersível/sublingual: 120 microgramas, até 240 microgramas. Essas apresentações não são intercambiáveis micrograma por micrograma. Não usar via intranasal para enurese.

Segurança. Restringir líquidos de uma hora antes até oito horas após a dose; suspender em doença com vômitos, diarreia ou alteração importante da ingestão. Incapacidade de cumprir restrição torna a opção inadequada. Cefaleia, náusea, sonolência ou convulsão exigem investigar hiponatremia. Avaliar resposta em quatro semanas e realizar pausa de pelo menos uma semana a cada três meses para testar necessidade. Imipramina não é alternativa rotineira por toxicidade e menor segurança. Confirmar função renal e contraindicações na bula do produto antes de manter tratamento.

Fontes verificadas: RCH — enurese

188. Glomerulonefrite Difusa Aguda (Pós-estreptocócica)

Prioridades. Hematúria, edema e hipertensão após infecção estreptocócica sugerem síndrome nefrítica; oligúria, edema pulmonar, encefalopatia ou hipercalemia tornam o atendimento urgente. Medir pressão com manguito adequado, peso, balanço e diurese; obter creatinina, eletrólitos, albumina, C3/C4, urina/proteinúria e evidência de estreptococo. Imagem é seletiva.

Manejo. Reduzir sódio e adequar líquidos à hipervolemia e à diurese. Para sobrecarga, furosemida 0,5–1 mg/kg/dose VO ou IV de 12/12 h, máximo 40 mg/dose no esquema RCH; reduzir e suspender quando houver euvolemia. A via IV pode ser preferida no edema importante. Hipertensão frequentemente melhora com controle de volume; amlodipino pode ser iniciado em 0,1 mg/kg/dia VO e titulado, máximo 10 mg/dia. Emergência hipertensiva exige fármaco IV titulável e monitorização, sem redução brusca ou nifedipino sublingual.

Antibiótico. Tratar infecção estreptocócica ativa conforme foco e alergia; não prometer reversão da nefrite pelo antibiótico. Reavaliar pressão, urina e função renal. C3 persistentemente baixo ou creatinina anormal em

oito semanas, proteinúria relevante ou evolução atípica indicam nefrologia. Evitar AINE no contexto de lesão renal. Exemplo matemático: 16 kg × 1 mg/kg = 16 mg de furosemida por dose; não equivale a 16 mL.

Fontes verificadas: RCH — glomerulonefrite pós-estreptocócica

189. Síndrome Nefrótica na Infância

Avaliar gravidade e volemia. Confirmar proteinúria importante, hipoalbuminemia e edema. Febre/dor abdominal podem representar peritonite; dispneia, dor torácica ou membro assimétrico sugerem trombose. Edema não comprova expansão intravascular. Medir pressão, creatinina, eletrólitos, albumina, urina e relação proteína/creatinina; quadros atípicos necessitam nefrologia antes de assumir doença por lesões mínimas.

Primeiro episódio típico. Um esquema RCH é prednisolona 2 mg/kg/dia ou 60 mg/m²/dia VO, máximo 60 mg, por quatro semanas; depois 1,5 mg/kg ou 40 mg/m² em dias alternados, máximo 40 mg, por quatro semanas. Escolher um método de cálculo, não somá-los. Recaída e corticodependência têm fluxos próprios.

Edema complicado. Albumina 20%, 1 g/kg (=5 mL/kg), IV em quatro horas pode ser considerada para hipovolemia intravascular ou edema grave/sintomático; não é rotina para corrigir um número de albumina. Vigiar hipertensão e edema pulmonar; furosemida associada exige reavaliação hemodinâmica. Evitar diurese agressiva e AINE.

Conferência. Em 16 kg: prednisolona diária 32 mg; etapa alternada 24 mg nos dias prescritos. Albumina: 16 g/0,2 g/mL =80 mL; bomba 20 mL/h por quatro horas; reverso 20×4×0,2/16=1 g/kg. Prever plano escrito de recaída, infecção, vacinação e insuficiência adrenal.

Fontes verificadas: RCH — síndrome nefrótica, atualização 2025

190. Acidente vascular encefálico (AVE) Hemorrágico na Criança

Emergência. Déficit focal, cefaleia abrupta, vômitos e alteração da consciência exigem ABCDE, glicemia, imagem urgente e neurocirurgia/neurologia. TC sem contraste identifica sangue rapidamente; investigação vascular caracteriza malformação, aneurisma ou outra causa. Obter hemograma, coagulação, eletrólitos e função renal, sem atrasar estabilização. Evitar hipóxia e hipotensão; controlar convulsões.

Pressão intracraniana. Elevar cabeceira e manter cabeça alinhada quando hemodinamicamente tolerado. Herniação iminente ou hipertensão intracraniana relevante pode exigir osmoterapia como ponte à intervenção definitiva. Uma opção é NaCl **3%**, 2–5 mL/kg IV em 10–20 minutos. Essa dose provém da diretriz de TCE pediátrico BTF e é uma **extrapolação de resgate neurointensivo**, não evidência específica de eficácia para toda hemorragia espontânea. Não administrar profilaticamente a toda criança com sangue na TC.

Preparo e bomba. Usar solução final 3% conferida, com bomba, dupla conferência e monitorização de sódio/cloro, osmolaridade, função renal e estado circulatório. Exemplo: 16 kg ×3 mL/kg=48 mL; em 15 minutos, 192 mL/h durante apenas esse intervalo. Reverso: 192×15/60/16=3 mL/kg. Não deixar a velocidade do bolus como manutenção. Infusão contínua é decisão de UTI guiada por resposta e pressão intracraniana.

Tratamento definitivo. Reverter coagulopatia conforme agente e causa; hidrocefalia, efeito de massa ou lesão vascular podem exigir intervenção. Não iniciar AAS/anticoagulação antes de classificar a hemorragia. Internar em centro pediátrico com neurocirurgia; reavaliações neurológicas e de imagem são dirigidas pela evolução.

Limitação delimitada: Dose hiperosmolar extrapolada de TCE pediátrico; decisão depende de hipertensão intracraniana, não apenas de hemorragia.

Fontes verificadas: RCH — AVE pediátrico · Brain Trauma Foundation — TCE pediátrico, dose de resgate extrapolada

191. AVE Isquêmico (AVEi) em Pediatria

Tempo importa. Ativar atendimento de AVE diante de déficit focal agudo. Estabelecer última vez normal, glicemia, exame neurológico e ABCDE; evitar hipóxia, hipotensão e hipoglicemia. Preferir RM com difusão e angio-RM; se indisponível rapidamente, realizar TC/angio-TC. Não atribuir déficit persistente automaticamente a fase pós-ictal ou enxaqueca.

Terapia etiológica. Reperfusão pediátrica requer equipe de AVE e seleção por idade, imagem, vaso ocluído, tempo e risco hemorrágico. Alteplase e trombectomia não são prescrições automáticas extrapoladas do adulto. A página RCH destaca avaliação até 4,5 horas para alteplase e seis horas para trombectomia; janelas ampliadas só em decisão especializada baseada em imagem. Antitrombótico é escolhido depois de excluir hemorragia e identificar arteriopatia, dissecção, cardioembolia ou outra causa; AAS, enoxaparina e varfarina não devem ser somados por aparecerem no inventário.

Exceções que mudam a estratégia. Doença falciforme exige hematologia e terapia transfusional; suspeita de DADA2 modifica radicalmente a segurança dos antitrombóticos (ver tema 255). Investigar coração, vasos e causas inflamatórias conforme fenótipo, além de oferecer reabilitação precoce.

Limite operacional. Este tópico define triagem e fluxo agudo; doses de reperfusão/anticoagulação não foram liberadas como esquema universal porque a indicação não é comum a todos os subtipos. Internação em centro pediátrico de AVE é necessária.

Limitação delimitada: Reperfusão e antitrombótico necessitam classificação vascular e decisão especializada; não há prescrição universal validada.

Fontes verificadas: RCH — AVE pediátrico · DADA2 — consenso internacional · AHA/ASA — AVE neonatal e pediátrico 2019

192. Cefaleia na Infância

Triagem. Procurar início explosivo, progressão, alteração neurológica, papiledema, sinais meníngeos, vômitos persistentes, despertar pelo sintoma, imunossupressão e hipertensão. Quando o exame e a história não mostram alertas, exames laboratoriais e imagem não são obrigatórios. Investigar trauma, sono, cafeína, jejum, estresse e uso excessivo de analgésicos.

Tratamento da cefaleia primária. Hidratação, sono regular, refeições e retorno funcional acompanham analgesia precoce. Paracetamol 15 mg/kg/dose VO, máximo 1 g, ou ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO, máximo 400 mg, são opções de dose de resgate da diretriz. Para repetição, respeitar a bula pediátrica do produto e o teto diário; não confundir esse teto por dose com um esquema diário liberado. Evitar opioides. Em desidratação, lesão renal, sangramento digestivo ou suspeita de dengue, evitar ibuprofeno.

Prevenção. Diário de sintomas permite classificar migrânea, tensional e cefaleia por abuso medicamentoso. Limitar analgésicos simples a menos de 15 dias/mês e triptanos a menos de dez. Profilaxia não é indicada para toda cefaleia; observar o tema de enxaqueca para decisão por incapacidade. Reavaliar se padrão mudar, houver impacto escolar persistente ou falha do tratamento. Exemplo: 16 kg ×15 mg/kg =240 mg de paracetamol; o volume deve ser obtido da concentração efetiva do frasco.

Fontes verificadas: RCH — cefaleia

193. Coreia de Sydenham

Prioridade. Coreia nova requer neurologia, avaliação de febre reumática/cardite com ECG e ecocardiograma e revisão de diagnósticos alternativos. Hipotonia grave, disfagia, quedas ou incapacidade funcional podem exigir internação. Antiestreptolisina negativa tardiamente não exclui Sydenham.

Imunoterapia parametrizada. No consenso internacional de 2025, doença leve pode dispensá-la; em moderada/grave, corticosteroide é a primeira opção. Prednisolona ou prednisona **2 mg/kg/dia VO, máximo 60 mg/dia**, por uma semana inicialmente; casos selecionados necessitam fase plena mais longa, seguida de redução gradual, total habitual de 1–3 meses conforme resposta. Alternativa na gravidade: metilprednisolona 20–30 mg/kg/dia IV, máximo 1 g/dia, por 3–5 dias em hospital. Não somar rotineiramente todos os regimes.

Outros componentes. Erradicação estreptocócica e profilaxia secundária são essenciais; usar o esquema e duração do tema 29, conforme cardite. Valproato pode ser selecionado para movimentos incapacitantes; imunoglobulina ou plasmaférese são alternativas quando imunoterapia inicial falha ou é contraindicada. Avaliar risco reprodutivo e hepático antes de anticonvulsivantes.

Monitorização e exemplo. Controlar pressão, glicemia, infecção, deglutição, trauma e evolução neuropsiquiátrica. Adaptar escola e atividades. Em 20 kg, prednisolona inicial=40 mg/dia; em 40 kg, 80 mg calculados são limitados a 60 mg/dia. Se o frasco efetivo contém 3 mg/mL, 40 mg correspondem a 13,33 mL; definir arredondamento mensurável e conferir dose reversa. Duração e redução não são determinadas pelo peso isoladamente.

Fontes verificadas: Consenso internacional — Sydenham, Pediatrics 2025

194. Crise Convulsiva em Pediatria

ABCDE e cronômetro. Proteger via aérea, posicionar, monitorizar, medir glicemia e obter acesso IV/IO sem atrasar o benzodiazepínico. Tratar convulsão com cinco minutos ou mais, ou duração desconhecida. Se cessou espontaneamente, não administrar sedativo apenas para completar um esquema. Contabilizar doses já dadas pela família e pelo transporte.

Primeira linha. Midazolam 0,15 mg/kg IV/IO, máximo 10 mg; sem acesso, 0,3 mg/kg intranasal ou bucal, máximo 10 mg. Repetir uma vez se persistir após cinco minutos; preparar ventilação com bolsa-máscara. Duas doses totais de benzodiazepínico sem controle indicam segunda linha e avaliação de estado de mal (tema 201). Via intranasal/bucal com solução injetável é uso fora da bula conforme produto.

Após cessar. Reavaliar consciência, exame focal, oxigenação e causa. Eletrólitos, cálcio e gasometria são especialmente úteis em lactentes, crise prolongada, doença metabólica ou recuperação incompleta. Imagem e punção lombar são dirigidas por trauma, focalidade, infecção e hipertensão intracraniana; EEG não precisa ser realizado emergencialmente em toda primeira crise breve.

Checagem independente. Exemplo 16 kg: IV 2,4 mg; intranasal 4,8 mg. Se houver apresentação comprovada de 5 mg/mL, os volumes calculados são 0,48 mL e 0,96 mL, respectivamente. Reverso: 0,48×5/16=0,15 mg/kg. A concentração é premissa a conferir no rótulo.

Fontes verificadas: RCH — crises agudas · Queensland — estado de mal

195. Defeitos no Metabolismo da Galactose

Conduta imediata na suspeita neonatal. Icterícia, hepatopatia, hipoglicemia, recusa alimentar e sepse após introdução de leite levantam suspeita de galactosemia clássica. Retirar lactose/galactose da alimentação imediatamente quando a suspeita for relevante e providenciar fórmula apropriada com equipe metabólica; não aguardar confirmação genética para interromper exposição. Sepse e insuficiência hepática precisam de tratamento hospitalar concomitante.

Confirmação. Dosagem de atividade GALT, metabólitos e estudo molecular ajudam a distinguir galactosemia clássica de variantes e de outros defeitos. Transfusão pode interferir em ensaios eritrocitários e deve ser comunicada ao laboratório. Dieta de exclusão não corrige todas as consequências do distúrbio.

Seguimento. Nutrição especializada, desenvolvimento, fala, função motora, cognição, saúde óssea e função ovariana necessitam avaliação longitudinal. O consenso permite vários alimentos vegetais; não se deve ampliar restrições sem necessidade. Cálcio e vitamina D são suplementados conforme ingestão e necessidades por idade, em vez de administrar dose fixa para toda galactosemia. Ausência de laticínios não equivale automaticamente a deficiência comprovada.

Aplicação farmacêutica. Conferir excipientes contendo lactose em medicamentos e fórmulas, com análise do risco e alternativas. Não foi proposto um "tratamento com cálcio" como terapia etiológica. O principal tratamento é nutricional; eventual suplemento precisa especificar quantidade de cálcio elementar, produto e déficit alimentar.

Limitação delimitada: Suplementação quantitativa exige avaliação dietética; não há dose única etiológica de cálcio.

Fontes verificadas: GalNet — diretriz internacional

196. Depressão em Pediatria

Avaliação inicial. Confirmar duração, sofrimento e prejuízo funcional; investigar mania/hipomania, substâncias, trauma, bullying e condições médicas. Perguntar diretamente sobre suicídio, plano, meios e proteção. Risco imediato, psicose, catatonia ou incapacidade de autocuidado requer atendimento urgente e possível internação.

Tratamento por gravidade. Depressão leve favorece intervenções psicossociais e psicoterapia com seguimento ativo. Para depressão moderada/grave, psicoterapia estruturada e decisão conjunta com psiquiatria infantil; fluoxetina é a opção farmacológica mais apoiada no NICE. Iniciar 10 mg VO uma vez/dia, podendo aumentar para 20 mg/dia após uma semana conforme resposta e tolerabilidade; em menor peso, considerar permanência na dose inicial. Não há base para escalar automaticamente até doses adultas elevadas.

Seguimento e segurança. Contato frequente no início e após ajustes, monitorando suicidabilidade, agitação, insônia e virada maníaca. A família deve receber sinais de alerta e plano de acesso. Após resposta, manutenção geralmente deve continuar pelo menos seis meses após remissão segundo o NICE. Retirada gradual e supervisionada. Não combinar com IMAO; revisar interações serotoninérgicas. A decisão de usar abaixo das faixas etárias com autorização regulatória exige explicitação de off-label.

Volume. As doses são fixas, não mg/kg. Líquido só pode ser convertido quando a concentração do produto for confirmada: volume diário=10/C ou 20/C mL, onde C está em mg/mL.

Limitação delimitada: Apresentação líquida brasileira não confirmada para conversão numérica.

Fontes verificadas: NICE NG134 — depressão infantojuvenil

197. Encefalopatia Hipóxico-isquêmica

Elegibilidade tempo-dependente. Recém-nascido com encefalopatia moderada/grave após evento hipóxico-isquêmico exige avaliação neonatal imediata. AAP 2026 sustenta hipotermia terapêutica em recém-nascidos com idade gestacional de pelo menos 36 semanas, iniciada nas primeiras seis horas e mantida por 72 horas, com alvo central de 33,5–34,5 °C. Não estender automaticamente o benefício a prematuros menores ou encefalopatia leve.

ABCDE neonatal. Garantir ventilação e perfusão, corrigir glicemia e distúrbios eletrolíticos, evitar hipertermia e monitorizar temperatura central continuamente. EEG contínuo ou aEEG auxilia na identificação de convulsões; tratar eventos confirmados. Investigar disfunção renal, hepática, miocárdica e coagulação; considerar infecção no diferencial. Antibióticos, vasopressores e óxido nítrico tratam indicações concomitantes específicas, não a EHI por si só.

Execução. Resfriamento e reaquecimento devem ocorrer em unidade com equipamento controlado, monitorização cardiorrespiratória e equipe neonatal. A depuração de sedativos/anticonvulsivantes pode mudar durante hipotermia, exigindo doses e intervalos neonatais próprios. Ressonância após reaquecimento e acompanhamento do desenvolvimento integram o plano.

Limite do esquema. O alvo térmico e janela foram atualizados; não se atribui uma bomba única de inotrópico a todos os pacientes. Para prescrição numérica desses agentes faltam peso, pressão/perfusão, função renal e indicação hemodinâmica. Transferência especializada não deve aguardar a conclusão de exames de imagem.

Limitação delimitada: Vasoativos e sedação requerem indicação hemodinâmica e farmacocinética neonatal individual.

Fontes verificadas: AAP — hipotermia neonatal, 2026 · CPS — hipotermia neonatal

198. Enxaqueca na Infância

Confirmar migrânea e incapacidade. Padrão recorrente, sintomas associados e exame normal sustentam diagnóstico clínico; sinais de alerta exigem a investigação descrita no tema 192. Sono, refeições, exercício, hidratação e manejo de estresse integram o tratamento. Analgésico simples precoce pode bastar; evitar opioides.

Resgate específico. Rizatriptana tem esquema FDA para 6–17 anos: abaixo de 40 kg, 5 mg VO uma vez; a partir de 40 kg, 10 mg uma vez. A bula não estabelece segurança/eficácia de mais de uma dose em 24 horas nessa faixa. Embora a diretriz RCH admita repetição, este capítulo adota a restrição da bula para não transformar divergência em permissão universal. Com propranolol, não usar em menores de 40 kg; nos maiores, a bula limita a 5 mg em 24 horas. Verificar contraindicações vasculares, hipertensão não controlada e uso recente de outro triptano/ergótico.

Prevenção dosada. Para ataques frequentes/incapacitantes, além de intervenção comportamental, topiramato tem indicação FDA a partir de 12 anos. Comprimidos de liberação imediata, VO: semana 1, 25 mg à noite; semana 2, 25 mg de 12/12 h; semana 3, 25 mg pela manhã e 50 mg à noite; semana 4, 50 mg de 12/12 h. Alvo 100 mg/dia; a titulação pode ser mais lenta. Não usar o teto de epilepsia de 400 mg/dia para migrânea. Diário e medida funcional orientam ensaio terapêutico e manutenção; retirada gradual. Monitorar cognição/humor, crescimento/peso, bicarbonato, cálculo renal, oligohidrose/hipertermia e sintomas oculares agudos. A depuração renal reduzida exige ajuste; a bula indica metade da dose usual com depuração <70 mL/min/1,73 m², a individualizar na criança. Discutir risco fetal e prevenção de gravidez nas adolescentes. Não associar automaticamente múltiplos preventivos.

Regulação. A dose acima é de bula norte-americana; não comprova indicação pediátrica de todas as marcas brasileiras. Dispersível é administrado por via oral, sem necessidade de conversão para mL.

Fontes verificadas: FDA/DailyMed — rizatriptana · RCH — cefaleia · FDA/DailyMed — topiramato, profilaxia de migrânea ≥12 anos

199. Epilepsia em Pediatria

Classificação antes do fármaco. Confirmar epilepsia, tipo de crise e síndrome; EEG, imagem e genética são selecionados conforme início, exame e evolução. Escolher monoterapia quando possível. Levetiracetam ou lamotrigina são opções para crises focais; ausência pura favorece etossuximida; mioclonias, Dravet e espasmos têm estratégias próprias. Carbamazepina/fenitoína podem piorar determinadas epilepsias generalizadas.

Exemplo operacional de manutenção, não de ataque. Levetiracetam VO 100 mg/mL, para crises focais: 1 a <6 meses, iniciar 7 mg/kg/dose de 12/12 h e titular até 21 mg/kg/dose; 6 meses a <4 anos, iniciar 10 e titular até 25 mg/kg/dose de 12/12 h; 4 a <16 anos, iniciar 10 e titular até 30 mg/kg/dose de 12/12 h. A bula usa aumentos a cada duas semanas. Em maiores, limite usual de bula 1.500 mg por dose, duas vezes/dia. Ajustar na disfunção renal com referência pediátrica; vigiar irritabilidade e mudança comportamental.

Cálculo. Criança de quatro anos/16 kg na dose inicial: 160 mg =1,6 mL de 12/12 h; reverso 1,6×100/16=10 mg/kg/dose. Não utilizar esse esquema como carga de estado de mal.

Plano longitudinal. Explicar adesão, primeiros socorros, plano de resgate, segurança em água/altura e revisão periódica. Retirada depende de risco sindrômico e tempo sem crises, com neurologia.

Fontes verificadas: NICE NG217 — tratamento por tipo de crise · FDA/DailyMed — levetiracetam

200. Esquizofrenia Infantil

Primeiro episódio psicótico. Antes de rotular esquizofrenia, excluir intoxicação, delirium, epilepsia, encefalite e transtornos afetivos; início muito precoce torna a revisão diagnóstica especialmente importante. Avaliar suicídio, violência, catatonia, nutrição e capacidade de autocuidado. Risco agudo ou causa orgânica suspeita exige atendimento hospitalar.

Tratamento. Combinar intervenção familiar e terapia cognitivo-comportamental com um antipsicótico selecionado em psiquiatria infantil. Exemplo de bula FDA para esquizofrenia em adolescentes de 13–17 anos: risperidona 0,5 mg VO uma vez/dia, titulando em incrementos de 0,5–1 mg; alvo 3 mg/dia, faixa estudada 1–6 mg/dia. Doses acima de 3 mg não demonstraram benefício adicional consistente e aumentam efeitos adversos. Crianças mais novas não recebem automaticamente essa dose.

Segurança farmacêutica. Solução de 1 mg/mL, quando confirmada: 0,5 mg=0,5 mL. A dose de esquizofrenia não é a mesma da irritabilidade no autismo. Monitorar peso/IMC, pressão, glicemia, lipídios, sintomas extrapiramidais, prolactina e efeitos sexuais; ECG quando houver fatores de risco. Insuficiência renal/hepática demanda início mais lento e revisão especializada, sem copiar ajuste adulto como regra infantil.

Reavaliação. Definir sintoma-alvo e intervalo de acompanhamento. A resistência exige checar adesão, exposição, diagnóstico e intervenções psicossociais antes de escalada; clozapina requer programa específico e não integra receita inicial.

Fontes verificadas: NICE CG155 — psicose na infância · FDA/DailyMed — risperidona solução

201. Estado de Mal Epiléptico em Pediatria

Sequência. Convulsão ≥5 minutos ou repetida sem recuperação exige ABCDE, glicemia, oxigenação, acesso e benzodiazepínico conforme tema 194. Contar doses pré-hospitalares; após duas doses adequadas, avançar. Investigar causas reversíveis e registrar o tempo de cada intervenção.

Segunda linha. Levetiracetam 60 mg/kg IV/IO, máximo 4,5 g, em cinco minutos no protocolo Queensland; uso no estado de mal pode ser off-label. A monografia RCH confirma frasco 100 mg/mL, diluição a 50 mg/mL para estado de mal e compatibilidade com NaCl 0,9%. Alternativas são selecionadas por idade/síndrome e estabilidade; não acumular fármacos sem avaliar resposta.

Preparo e bomba intermitente. Em 16 kg, carga=960 mg. Aspirar 9,6 mL do estoque 100 mg/mL e acrescentar 9,6 mL de NaCl 0,9%: volume final 19,2 mL, concentração 50 mg/mL. Em cinco minutos, bomba=230,4 mL/h durante esse intervalo. Reverso: 230,4×(5/60)×50/16=60 mg/kg. Esta administração rápida é do protocolo de estado de mal, diferente da infusão rotineira de manutenção.

Estado refratário — exemplo operacional. UTI, via aérea protegida/suporte ventilatório, monitorização hemodinâmica e EEG contínuo. O protocolo Johns Hopkins 2025, que exclui neonatos <30 dias, utiliza midazolam IV 0,2 mg/kg de ataque, seguido de **0,05–0,1 mg/kg/h**. Titular em incrementos de 0,05–0,1 mg/kg/h à cessação eletrográfica; teto do protocolo 2 mg/kg/h, reservado a escalonamento intensivo. Ataque lento, pelo menos 2–5 minutos conforme monografia; hipotensão e depressão respiratória exigem resposta imediata. A velocidade de escalada e duração dependem do EEG e da estabilidade, não de horário fixo domiciliar.

BIC preparada. RCH admite 0,5 mg/mL: 25 mg (5 mL de estoque 5 mg/mL) +45 mL de NaCl 0,9%=50 mL finais. Em 16 kg, 0,1 mg/kg/h=1,6 mg/h=3,2 mL/h; reverso 3,2×0,5/16=0,1 mg/kg/h. No teto, essa concentração geraria 64 mL/h, exigindo reavaliar carga hídrica e concentração institucional. Rotular em mg/mL e mg/kg/h, sem confundir com microgramas/kg/minuto. Vigiar acúmulo renal/hepático, interações e abstinência; reduzir gradualmente após controle. Bloqueio neuromuscular pode ocultar convulsão e não substitui EEG.

Fontes verificadas: Queensland — estado de mal · RCH — levetiracetam injetável · Johns Hopkins — estado de mal, dezembro 2025 · RCH — midazolam injetável

202. Kernicterus

Distinguir urgência e sequela. Encefalopatia bilirrubínica aguda, com sucção ruim, alteração de tônus, letargia, choro agudo ou opistótono, requer neonatologia imediata. Kernicterus é a consequência neurológica crônica; não há medicação que reverta lesão estabelecida. Bilirrubina total deve ser interpretada pela idade em horas, idade gestacional e fatores de neurotoxicidade, não por um único valor universal.

Prevenir progressão. Fototerapia intensiva e preparo para exsanguineotransfusão conforme curvas AAP para ≥35 semanas. O limiar de escalada de cuidado é 2 mg/dL abaixo do limiar de troca. Durante escalada, dosar bilirrubina pelo menos a cada duas horas, corrigir desidratação e transferir para unidade capaz de realizar o procedimento. Sinais de encefalopatia não devem aguardar resposta demorada à fototerapia.

Imunoglobulina seletiva. Na doença hemolítica isoimune, com teste direto de antiglobulina positivo e bilirrubina no limiar de escalada, pode-se considerar 0,5–1 g/kg IV em duas horas. Não é tratamento de toda icterícia; benefício é incerto e há sinal de risco de enterocolite. A dose não deve atrasar troca indicada.

Conferência. Para 3 kg, 1 g/kg=3 g. Se produto confirmado de 10% (0,1 g/mL), volume=30 mL; a velocidade precisa respeitar a bula, inclusive escalonamento inicial, e não deve ser simplesmente fixada em 15 mL/h sem essa conferência. Seguimento inclui audição, movimento, alimentação e reabilitação.

Fontes verificadas: AAP — hiperbilirrubinemia 2022 · AAP — esclarecimentos sobre imunoglobulina

203. Meningite Asséptica em Pediatria

Não assumir etiologia viral precocemente. Líquor sem bactéria demonstrada pode ocorrer após antibiótico ou em outras infecções. Avaliar perfusão, consciência, focalidade, púrpura e sinais de hipertensão intracraniana. Colher culturas e líquor quando seguro; instabilidade ou demora da punção não justifica atrasar antimicrobianos.

Cobertura inicial. Quando bactéria ainda não foi afastada, em maiores de dois meses ceftriaxona 100 mg/kg/dia IV, máximo 4 g/dia, é uma opção RCH; vancomicina depende de Gram, resistência e contexto. O período neonatal exige esquema próprio. Depois de demonstrada enterovirose não complicada, suporte, hidratação e analgesia podem bastar; suspender antimicrobianos mediante integração de evolução e microbiologia.

Suspeita de HSV/encefalite. Não esperar confirmação se há risco significativo. O ChAMP utiliza aciclovir IV em imunocompetentes: ≥4 semanas a <12 anos, 20 mg/kg/dose de 8/8 h, máximo 750 mg/dose; ≥12 anos, 10 mg/kg/dose de 8/8 h, mesmo teto. HSV confirmado exige 14–21 dias conforme contexto; adotar 21 dias em encefalite pediátrica segundo RCH, com infectologia e avaliação de PCR. Função renal reduzida altera intervalo/dose; esse regime não vale automaticamente para prematuros/neonatos.

Preparo verificável. Na apresentação RCH de 250 mg, adicionar 10 mL de água para injetáveis produz 25 mg/mL; diluir em NaCl 0,9% até 5 mg/mL e infundir em uma hora. Em 16 kg no regime de 20 mg/kg: 320 mg; aspirar 12,8 mL da solução 25 mg/mL, completar a 64 mL finais e infundir a 64 mL/h por uma hora. Reverso 64×5/16=20 mg/kg. Confirmar monografia do frasco real, hidratação, creatinina, diurese e acesso; não administrar em bolus. Reavaliar diariamente diagnóstico, necessidade de antiviral e complicações.

Fontes verificadas: RCH — meningite e encefalite · ChAMP — aciclovir pediátrico · RCH — aciclovir injetável

204. Paralisia de Bell

Confirmar padrão periférico. Fraqueza unilateral de toda a hemiface, incluindo fronte e fechamento ocular, pode ser paralisia de Bell; déficit de membros, ataxia, diplopia, cefaleia intensa ou evolução atípica indicam outra causa. Examinar ouvido, mastoide, parótida, vesículas e olho. Em menores de dois anos, o diagnóstico idiopático merece cautela especial.

Prioridade terapêutica. Proteger a córnea quando o olho não fecha: lágrima artificial durante o dia, pomada lubrificante e fechamento/proteção noturna conforme oftalmologia. Dor ocular, fotofobia ou lesão corneana exigem revisão urgente. Não prescrever antibiótico ocular ou vitamina A sistêmica automaticamente.

Corticosteroide e antiviral. Na criança, a evidência não demonstra de forma robusta o benefício rotineiro de prednisolona; quase todas recuperam sem tratamento. A recomendação adulta de iniciar corticoide nas primeiras 72 horas não é transportada sem discussão para todas as idades. Aciclovir é considerado quando há vesículas/infecção herpética, particularmente Ramsay Hunt, e não como rotina da paralisia idiopática.

Acompanhamento. Documentar gravidade e capacidade de fechamento ocular, orientar sinais de alerta e reavaliar evolução. Persistência, recorrência, bilateralidade ou novos achados neurológicos justificam investigação e neurologia. Não há dose farmacológica obrigatória neste quadro; por isso, a ausência de um corticoide fixo é uma decisão clínica apoiada pela diretriz, não uma lacuna a preencher por associação de classes.

Fontes verificadas: RCH — paralisia facial

205. Síncope na Pediatria

Separar síncope de emergência. História do evento, posição, gatilho, pródromos, duração e recuperação costumam orientar. Síncope durante exercício, dor torácica, palpitações, cardiopatia, história familiar de morte súbita ou exame/ECG anormal exigem avaliação cardiológica urgente. Movimentos breves podem ocorrer na síncope e não confirmam epilepsia.

Investigação. Aferir pressão e frequência em repouso e ortostatismo, realizar exame cardíaco/neurológico e obter ECG pelo menos uma vez. Glicemia é útil logo após o episódio; hemograma quando houver suspeita de anemia; gestação e outras avaliações conforme contexto. Não solicitar EEG ou imagem cerebral por rotina em síncope típica vasovagal.

Manejo da forma vasovagal. Explicar reconhecimento dos pródromos, sentar/deitar imediatamente, evitar jejum, calor e permanência imóvel prolongada; manter hidratação e ingestão de sal apropriadas se não houver contraindicação. Contramanobras e condicionamento podem ajudar. Betabloqueador não é tratamento automático da síncope infantil, apesar de constar no inventário.

Destino. Alta é possível após recuperação completa quando causa provável benigna, ECG/exame tranquilizadores e retorno organizado. Episódios recorrentes apesar das medidas comportamentais merecem revisão especializada. Alteração persistente de consciência, hipotensão, dispneia ou suspeita arrítmica requer monitorização hospitalar. Nenhum volume de BIC se aplica à síncope vasovagal estável; vasopressor só trataria choque com diagnóstico próprio.

Fontes verificadas: RCH — síncope

206. Síndrome de Guillain-Barré em Pediatria

Reconhecer deterioração. Fraqueza progressiva, arreflexia, dor, alteração bulbar ou disautonomia exigem internação. Avaliar deglutição, tosse, força respiratória e capacidade vital seriada; não esperar hipoxemia para reconhecer insuficiência ventilatória. LCR e eletroneuromiografia apoiam diagnóstico, mas podem estar normais precocemente. Excluir mielite e distúrbios metabólicos.

Imunoterapia. EAN/PNS recomenda imunoglobulina IV 0,4 g/kg/dia por cinco dias, total 2 g/kg, para pacientes sem marcha independente e considera tratamento em progressão rápida ou manifestações graves. Plasmaférese é alternativa; não transpor volumes absolutos adultos para uma criança. Corticosteroide isolado não melhora recuperação e não é terapia modificadora padrão. Segunda série de IVIG apenas por prognóstico desfavorável não é rotina.

Cálculo auditável. Criança de 16 kg: 6,4 g/dia; produto de 10% confirmado corresponde a 64 mL/dia e 320 mL no curso. Reverso: 64×0,1/16=0,4 g/kg. A programação horária depende da marca, velocidade inicial e tolerância; não estabelecer taxa fixa usando apenas o volume total.

Monitorização. Vigiar pressão/ritmo, retenção urinária, íleo, dor, trombose, lesão renal e hemólise por IVIG. Escolher produto e hidratação levando em conta rim e volemia. Fisioterapia, prevenção de lesão por pressão e reabilitação começam cedo. UTI é indicada na evolução respiratória/bulbar ou autonômica importante.

Limitação delimitada: Escalonamento em mL/h da IVIG requer marca e monografia específica.

Fontes verificadas: EAN/PNS — Guillain–Barré 2023

207. Síndrome de Ramsay Hunt

Reconhecimento. Paralisia facial periférica com otalgia e vesículas auriculares/orais, perda auditiva ou vertigem sugere zóster ótico. As vesículas podem aparecer depois. Avaliar otorrinolaringologia/neurologia e proteger a córnea quando o fechamento palpebral é incompleto; dor ocular ou baixa visual exige oftalmologia.

Antiviral com contexto explícito. A evidência pediátrica específica de Ramsay Hunt é limitada; aplica-se tratamento de VZV conforme extensão e imunidade. Para doença localizada em criança imunocompetente, com via oral apropriada e decisão especializada, o ChAMP descreve aciclovir **20 mg/kg/dose VO, máximo 800 mg/dose, cinco vezes ao dia, por sete dias**, preferencialmente iniciado até 72 horas. Esse é um esquema de zóster pediátrico extrapolado à síndrome, não ensaio específico de Ramsay Hunt. A monografia contempla ≥4 semanas, mas lactentes pequenos necessitam avaliação hospitalar própria.

Doença complicada. Imunossupressão importante, disseminação, envolvimento central ou pares cranianos adicionais favorecem internação e aciclovir IV. O esquema ChAMP de VZV grave utiliza 20 mg/kg/dose de 8/8 h abaixo de 12 anos e 10 mg/kg/dose de 8/8 h a partir de 12 anos, máximo 750 mg/dose; duração mínima sete dias, frequentemente 7–14 conforme evolução. Preparo/infusão e ajuste renal estão descritos no tema 203. Encefalite muda a duração e o acompanhamento.

Adjuvantes e cálculo. Corticoide é uma decisão especializada com benefício pediátrico incerto, sempre avaliado junto à terapia antiviral. Analgesia e seguimento facial/auditivo são necessários. Em 16 kg no regime VO: 320 mg por tomada, 1.600 mg/dia; reverso 1.600/5/16=20 mg/kg/dose. Volume depende da suspensão real. Monitorar hidratação e função renal; seguimento deve documentar recuperação facial, audição e córnea.

Limitação delimitada: Antiviral extrapolado do tratamento de zóster; evidência específica de Ramsay Hunt pediátrico é limitada.

Fontes verificadas: ChAMP — aciclovir, zóster pediátrico · NIH — VZV pediátrico, 2026 · Relato primário pediátrico — Ramsay Hunt e encefalite

208. Síndrome de Rett

Cuidado longitudinal. Síndrome de Rett requer confirmação clínica/genética, avaliação nutricional, deglutição, constipação, respiração, epilepsia, mobilidade, escoliose e comunicação. Episódios motores/autonômicos nem sempre são convulsões; EEG orienta a necessidade de anticonvulsivante. Fisioterapia, comunicação alternativa e suporte aos cuidadores fazem parte do tratamento.

Trofinetida. Bula FDA vigente: a partir de dois anos, solução VO 200 mg/mL, duas vezes/dia. Peso 9–<12 kg: 5.000 mg=25 mL por dose; 12–<20 kg: 6.000 mg=30 mL; 20–<35 kg: 8.000 mg=40 mL; 35–<50 kg: 10.000 mg=50 mL; ≥50 kg: 12.000 mg=60 mL. Pode ser administrada por gastrostomia, observando a via gástrica quando houver sonda gastrojejunal. Não converter automaticamente sachês em volumes da solução pronta.

Riscos e ajuste. Diarreia, vômitos, desidratação e perda ponderal podem exigir redução, interrupção ou suspensão. Interromper laxantes antes do início conforme orientação de bula. Disfunção renal moderada (eGFR pediátrica 30–59 mL/min/1,73 m²) usa metade das doses; grave <30 não é recomendada. Não repetir dose vomitada.

Conferência. 6.000/200=30 mL; reverso 30×200=6.000 mg. Trata-se de autorização FDA, sem confirmação de registro/comercialização brasileira neste trabalho; não representa acesso garantido ou cura.

Limitação delimitada: Registro e disponibilidade brasileiros da trofinetida não confirmados.

Fontes verificadas: FDA/DailyMed — DAYBUE e DAYBUE STIX

209. Síndrome de Tourette na Criança

Tratar prejuízo, não apenas presença de tique. Confirmar tiques motores/vocais, duração, comorbidades e impacto. TDAH, TOC, ansiedade e dificuldades escolares podem causar mais prejuízo que os tiques. Explicar flutuação natural e evitar punição. Quando não há sofrimento funcional, observação é válida.

Primeira intervenção. Terapia comportamental abrangente para tiques (CBIT), quando acessível, é favorecida pela AAN. Agonistas alfa-2 podem ser úteis com TDAH, mas requerem controle de pressão/FC e retirada gradual. Antipsicóticos são selecionados para quadro incapacitante após discussão dos riscos.

Exemplo de bula FDA. Aripiprazol em 6–18 anos: iniciar 2 mg VO/dia. Abaixo de 50 kg, alvo 5 mg/dia e máximo 10 mg/dia; a partir de 50 kg, alvo 10 mg/dia e máximo 20 mg/dia. A titulação posterior deve respeitar tolerabilidade e intervalos da bula, não ocorrer como escalada automática. Essas faixas não são mg/kg.

Monitorizar. Peso, sono, acatisia, efeitos extrapiramidais, glicemia/lipídios e comportamento impulsivo. Revisar interações CYP2D6/CYP3A4 que podem mudar exposição. Retirar lentamente quando apropriado e reavaliar necessidade, pois tiques podem melhorar com maturação. Autorização por faixa etária/indicação deve ser conferida na apresentação brasileira; a referência posológica é estrangeira.

Fontes verificadas: AAN — tiques, resumo clínico · FDA/DailyMed — aripiprazol

210. Sonambulismo e Outras Parassonias

Reconhecer parassonia. Sonambulismo e terror noturno geralmente ocorrem no sono não REM, com despertar incompleto e pouca memória posterior. Investigar privação de sono, estresse, febre, medicamentos e apneia obstrutiva. Episódios muito estereotipados, frequentes na mesma noite, movimentos focais ou sintomas diurnos podem exigir diferenciação de epilepsia.

Tratamento prioritário. Estabelecer horário regular e sono suficiente; tornar quarto e acesso às escadas seguros, proteger janelas e evitar beliche. Durante o episódio, conduzir suavemente ao leito, sem confrontação nem despertar abrupto. A família deve compreender que o comportamento não é intencional. Se o horário é previsível, despertar programado pode ser discutido em avaliação de sono.

Medicamentos. Benzodiazepínicos não são a primeira opção para parassonias comuns e podem causar sedação, dependência e piora respiratória. Clonazepam eventualmente é reservado a quadros graves, persistentes e com risco de lesão após investigação; não foi validada nesta síntese uma dose pediátrica universal. Melatonina não substitui automaticamente essa avaliação.

Reavaliar. Encaminhar se episódios causarem lesão, sonolência importante, comprometimento escolar, suspeita de apneia ou dúvida diagnóstica. Polissonografia não é obrigatória no padrão típico, mas pode ajudar nos atípicos. O tratamento concluído para o caso habitual é comportamental e ambiental; a classe citada no inventário não cria indicação de sedativo.

Fontes verificadas: RCH — sonambulismo · RCH — terrores noturnos

211. Transtorno Afetivo Bipolar em Pediatria

Diagnóstico longitudinal. Irritabilidade isolada não estabelece bipolaridade. Confirmar episódios com mudança sustentada de energia/atividade e humor, investigar substâncias, privação de sono, TDAH, depressão, psicose e causas orgânicas. Mania com risco, psicose, agitação importante, desidratação ou ausência de sono exige avaliação urgente.

Tratamento da mania. Intervenção familiar, rotina de sono e antipsicótico ou estabilizador selecionado em psiquiatria infantil. Exemplo da bula FDA para mania bipolar em 10–17 anos: risperidona 0,5 mg VO/dia, titulada por resposta; alvo 1–2,5 mg/dia, faixa estudada até 6 mg/dia. Não aproveitar o alvo de esquizofrenia como obrigatório para bipolaridade. Monitorização metabólica e extrapiramidal é a mesma descrita no tema 200.

Alternativas. Lítio requer creatinina, eletrólitos, função tireoidiana, interações e dosagem sérica em horário apropriado; sua margem terapêutica estreita impede uma titulação segura baseada somente em peso. Valproato exige ponderação reprodutiva, hepática e metabólica. Antidepressivo isolado pode precipitar desestabilização e não é primeira escolha para depressão bipolar.

Seguimento. Plano de prevenção de recaídas, adesão, reconhecimento de pródromos e proteção contra suicídio. Seleção e duração da manutenção não se confundem com controle da mania aguda. O capítulo fornece uma opção documentada de início; não declara validados todos os estabilizadores, combinações e esquemas de depressão bipolar pediátrica.

Limitação delimitada: Lítio, valproato e manutenção por fenótipo não integralmente operacionalizados.

Fontes verificadas: FDA/DailyMed — risperidona · NICE — bipolaridade

212. Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) em Pediatria

Avaliação. Diagnóstico exige sintomas e prejuízo em mais de um ambiente, história do desenvolvimento e exclusão de privação de sono, dificuldades de aprendizagem, ansiedade e outras causas. Treinamento parental, suporte escolar e intervenções ambientais acompanham qualquer medicação. Pré-escolares priorizam estratégias comportamentais e avaliação especializada.

Tratamento farmacológico. NICE favorece metilfenidato como primeira escolha em escolares quando prejuízo persiste. Para formulação imediata, bula FDA em ≥6 anos: 5 mg VO antes do café e do almoço; aumentar 5–10 mg na dose diária a intervalos semanais conforme resposta, máximo 60 mg/dia. Formulações imediata, LA e OROS têm perfis diferentes: não abrir, triturar nem trocar na mesma frequência por semelhança do nome.

Monitorização. Registrar pressão, FC, peso, altura, apetite, sono e risco cardiovascular basal; ECG se houver indicação clínica. Perguntar por história familiar de morte súbita, síncope ao esforço e cardiopatia. Acompanhar crescimento e funcionamento escolar, além de efeitos adversos. Vigiar desvio/uso indevido.

Alternativas. Atomoxetina ou guanfacina são consideradas quando estimulantes falham ou são mal tolerados; escolha depende de comorbidades e disponibilidade. Não são adjuvantes obrigatórios. O esquema inicial não é mg/kg e não permite converter comprimidos em gotas. Para apresentação líquida, é necessário produto específico e equivalência farmacocinética. Reavaliar regularmente necessidade, benefício e adesão.

Limitação delimitada: Alternativas não estimulantes e apresentações prolongadas exigem monografias próprias.

Fontes verificadas: NICE NG87 — TDAH · FDA/DailyMed — metilfenidato imediato

213. Transtorno Obsessivo Compulsivo na Pediatria

Diagnóstico e gravidade. Obsessões e compulsões devem ser diferenciadas de interesses restritos, tiques, psicose e rituais normais do desenvolvimento. Avaliar tempo consumido, sofrimento, acomodação familiar, funcionamento e risco de autoagressão. Instrumento como CY-BOCS ajuda no seguimento, mas não substitui entrevista.

Tratamento. Terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta, envolvendo a família, é central. Quando há prejuízo moderado/grave ou resposta insuficiente, associar ISRS sob avaliação especializada. Sertralina possui esquema FDA para TOC de 6–12 anos: iniciar 25 mg VO/dia; 13–17 anos: 50 mg/dia. Aumentos de 25–50 mg não mais frequentemente que semanalmente, máximo 200 mg/dia, considerando menor peso e tolerância. O máximo não é um alvo automático.

Segurança. Monitorar ativação, ideação suicida, sintomas gastrointestinais e virada maníaca. Revisar IMAO e outros serotoninérgicos. Na insuficiência hepática leve, a bula recomenda metade da dose inicial e do máximo; moderada/grave não é recomendada. Não retirar abruptamente. Ausência de resposta nas primeiras semanas não justifica escalada diária.

Seguimento. Registrar redução de compulsões e recuperação funcional, preservar psicoterapia e planejar manutenção depois da resposta. Confirmar possibilidade de fracionamento do comprimido quando forem necessários 25 mg; não inventar concentração de solução brasileira. A indicação pediátrica de sertralina para TOC não significa aprovação para toda ansiedade ou depressão infantil.

Fontes verificadas: NICE CG31 — TOC · FDA/DailyMed — sertralina

214. Conjuntivite em Pediatria

Classificar antes de medicar. Secreção purulenta favorece etiologia bacteriana; prurido bilateral aponta para alergia; secreção aquosa com síndrome viral favorece forma viral. Dor importante, fotofobia, redução visual, opacidade corneana ou lente de contato exigem oftalmologia, pois podem indicar ceratite/uveíte e ameaçar a visão.

Conjuntivite não complicada. Higiene das mãos, limpeza suave da secreção e evitar compartilhamento de toalhas. Viral: lubrificação e compressa fria; antibiótico não muda a causa. Alérgica: controle de exposição e anti-histamínico apropriado. Bacteriana simples: RCH descreve cloranfenicol colírio 0,5%, 4–6 aplicações/dia por 5–7 dias. A escolha brasileira deve considerar produto autorizado e alergia; não aplicar a uma córnea com infiltrado como se fosse conjuntivite simples.

Neonato. Secreção abundante, edema ou suspeita de gonococo, clamídia/HSV exigem avaliação sistêmica e oftalmológica. Tratamento exclusivamente tópico é inadequado para esses agentes. Clamídia pode ser tratada com azitromicina 20 mg/kg VO uma vez/dia por três dias no esquema RCH; monitorar risco de estenose hipertrófica do piloro no lactente. Gonococo/HSV têm esquemas sistêmicos específicos.

Segurança. Evitar corticoide ocular e anestésico domiciliar sem indicação oftalmológica. Se piorar ou não houver melhora, revisar diagnóstico em vez de simplesmente acumular colírios. As doses tópicas são por aplicação, não mg/kg; não se convertem gotas oculares em mL de uso sistêmico.

Limitação delimitada: Apresentação brasileira do antibiótico tópico e esquemas neonatais de gonococo/HSV requerem monografia específica.

Fontes verificadas: RCH — olho vermelho agudo

215. Coriorretinite

Risco visual. Coriorretinite necessita avaliação oftalmológica rápida com mapeamento de retina; definir localização, atividade e ameaça à mácula/nervo óptico. Investigar toxoplasmose, CMV, sífilis, tuberculose e fungos conforme imunidade e contexto. Corticoide sozinho pode agravar infecção.

Exemplo etiológico delimitado. Para toxoplasmose adquirida ocular em criança com HIV, o NIH recomenda pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico: pirimetamina 1 mg/kg/dose VO de 12/12 h por três dias (máximo 50 mg/dose), depois 1 mg/kg/dia (máximo 25 mg); sulfadiazina 25–50 mg/kg/dose de 6/6 h, com teto de 1–1,5 g/dose conforme faixa; ácido folínico 10–20 mg VO/dia, mantido por uma semana após pirimetamina. Indução por pelo menos seis semanas, seguida de avaliação de supressão. Não confundir ácido folínico com ácido fólico. O esquema congênito é distinto e habitualmente prolongado.

Checagem farmacológica. Hemograma pelo menos semanal durante pirimetamina diária; função renal, hidratação e alergia às sulfas. Reavaliar lesões e visão. Em imunocompetente, a decisão de tratar lesão ocular considera localização, tamanho e atividade; o regime acima não é automaticamente aplicado a toda cicatriz.

Cálculo ilustrativo. Na extremidade de 25 mg/kg/dose, 16 kg recebem 400 mg de sulfadiazina por dose, 1.600 mg/dia; reverso 1.600/16=100 mg/kg/dia. Volume requer preparação farmacêutica de concentração confirmada.

Limitação delimitada: Outras etiologias oculares e preparações líquidas não compartilham esse regime.

Fontes verificadas: NIH — toxoplasmose pediátrica · CDC — cuidado da toxoplasmose ocular

216. Infecções em Imunocomprometidos

Febre no imunocomprometido é tempo-dependente. Avaliar ABCDE, perfusão, acesso central, mucosite, pele, pulmão, abdome e sítio perianal sem toque traumático. Colher hemoculturas de cada lúmen e periférica quando possível, hemograma, função renal/hepática e exames dirigidos, sem atrasar antibiótico em instável. O risco depende da imunossupressão e duração da neutropenia, não apenas da temperatura.

Neutropenia febril de alto risco. Cefepima 50 mg/kg/dose IV de 8/8 h, máximo 2 g/dose, é uma opção RCH. Piperacilina-tazobactam ou outro betalactâmico antipseudomonas podem ser alternativas conforme foco, alergia, colonização e resistência. Vancomicina não é rotina para todo episódio; considerar instabilidade, infecção de cateter/pele ou patógeno resistente. Tiflite/infecção anaeróbia pode exigir metronidazol quando o betalactâmico escolhido não cobre anaeróbios.

Monitorização e reavaliação. Ajustar cefepima na disfunção renal; neurotoxicidade pode se manifestar como alteração mental/convulsões. Reavaliar culturas e foco diariamente. Febre persistente em paciente estável não implica ampliar antibióticos automaticamente. Febre prolongada e neutropenia de alto risco exigem investigação fúngica e estratégia antifúngica específica.

Cálculo. Em 16 kg, cefepima=800 mg por dose, 2.400 mg/dia. A concentração após reconstituição varia com frasco e diluente: volume=D/C. O preparo e tempo de infusão devem seguir a monografia real. Alta só em programa formal de baixo risco, nunca por aparência inicial isolada.

Limitação delimitada: Antifúngicos, esquemas de infecção oportunista e preparo por fabricante exigem protocolo específico.

Fontes verificadas: RCH — febre e neutropenia

217. Náusea e Vômito Induzidos por QT Infantil

Prevenir conforme emetogenicidade. Classificar quimioterapia, fase aguda/tardia, sintomas prévios e interações. Excluir obstrução, hipertensão intracraniana, distúrbios metabólicos, sepse e toxicidade quando houver vômitos inesperados. Hidratação e eletrólitos acompanham a estratégia antiemética.

Base farmacológica. Para crianças menores de 12 anos, NCI descreve ondansetrona 0,15 mg/kg/dose VO/IV antes da quimioterapia, depois de 8/8 h na alta emetogenicidade ou de 12/12 h na moderada. A referência pediátrica de Hamilton limita a 8 mg/dose. Não utilizar teto adulto de 16 mg IV como alvo pediátrico. Em quimioterapia mais emetogênica, antagonista 5-HT3 é combinado com dexametasona e antagonista NK1 quando elegíveis; a associação depende do protocolo oncológico e interações.

Falha/resgate. POGO recomenda elevar a intensidade profilática conforme risco; palonosetrona pode substituir o 5-HT3 e olanzapina pode ser incorporada em situações selecionadas. Metoclopramida traz risco extrapiramidal e não é primeira escolha indiscriminada. Náusea antecipatória beneficia-se de intervenções psicológicas e controle adequado dos ciclos prévios.

Checagem. Criança de 16 kg: ondansetrona 2,4 mg/dose. Caso a ampola seja 2 mg/mL, aspirar 1,2 mL; reverso 1,2×2/16=0,15 mg/kg. Diluição/tempo de administração IV seguem apresentação. Rever QT, potássio, magnésio, fármacos concomitantes e função hepática; não somar diferentes antagonistas 5-HT3.

Limitação delimitada: Regimes completos de NK1, dexametasona e resgate precisam do protocolo e agentes quimioterápicos.

Fontes verificadas: NCI — náusea/vômito relacionados ao câncer · Hamilton — referência pediátrica de ondansetrona · POGO — antieméticos

218. Doença de Osgood-Schlatter

Diagnóstico. Dor localizada na tuberosidade anterior da tíbia, associada a corrida/saltos durante crescimento, sugere apofisite por tração. Investigar trauma agudo, incapacidade de extensão, febre, dor noturna ou edema articular, que exigem outras hipóteses. Radiografia não é obrigatória no padrão típico, mas ajuda se houver trauma ou dúvida.

Tratamento. Reduzir temporariamente a carga desencadeante, gelo após atividade, alongamento de quadríceps/isquiotibiais e fisioterapia conforme limitação. Ajustar esporte pela dor e função, preservando condicionamento tolerado. A evolução geralmente acompanha maturação esquelética; não prometer resolução em poucos dias.

Analgesia breve. Ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO de 8/8 h, máximo 400 mg/dose, constitui uma opção para criança elegível e hidratada; usar por poucos dias e reavaliar. Alternativa: paracetamol conforme esquema do projeto. AINE não corrige a apófise nem deve mascarar dor para forçar treino. Evitar em disfunção renal, sangramento digestivo, desidratação ou reação prévia.

O que muda o destino. Dor persistente incapacitante, diagnóstico duvidoso ou suspeita de avulsão requer ortopedia. Antibiótico, opioide, antiemético IV e inibidor da bomba de prótons não são tratamento rotineiro dessa apofisite, embora apareçam entre classes do inventário. Não associá-los sem outra indicação. Reavaliar função e retorno gradual ao esporte; cirurgia é excepcional em sintomas persistentes após maturidade.

Fontes verificadas: AAOS — Osgood-Schlatter · RCH — analgesia no trauma

219. Epifisiólise

Urgência ortopédica. Adolescente com dor em quadril, coxa ou joelho, claudicação e limitação de rotação interna pode ter epifisiólise proximal do fêmur. Obesidade é frequente, mas sua ausência não exclui. Incapacidade de sustentar peso sugere instabilidade e maior risco de necrose avascular.

Conduta imediata. Suspender apoio e mobilização desnecessária, manter em leito/maca e acionar ortopedia. Não tentar redução ou forçar rotação. Solicitar radiografias apropriadas dos quadris; no quadro instável, evitar posicionamento que force abdução/rotação. Considerar avaliação endocrinológica quando idade ou fenótipo forem atípicos.

Tratamento definitivo. Fixação cirúrgica é a base; analgesia não substitui estabilização. Manter jejum se houver perspectiva operatória, hidratação guiada pelo estado clínico e analgesia titulada. Ibuprofeno ou paracetamol podem ser usados conforme elegibilidade e intensidade; dor importante pode exigir opioide monitorizado. Antibiótico perioperatório é prevenção cirúrgica e não tratamento da doença como infecção.

Monitorização e destino. Internação/transferência ortopédica, avaliação neurovascular e plano de proteção de carga. Examinar o lado contralateral e organizar acompanhamento de necrose avascular, condrólise e progressão. Não dar alta para "observar a dor" quando o diagnóstico é suspeito. A prescrição anestésica e perioperatória é vinculada ao procedimento, peso e comorbidades, sem uma combinação fixa de todas as classes encontradas no índice.

Fontes verificadas: RCH — epifisiólise, profissionais · RCH — criança com claudicação

220. Sinovite Transitória do Quadril

Diagnóstico com vigilância. Sinovite transitória costuma ocorrer após virose, com criança em bom estado geral e limitação dolorosa do quadril. Febre relevante, aspecto tóxico, incapacidade persistente de apoio, dor crescente ou marcadores inflamatórios elevados aumentam preocupação com artrite séptica. Nenhuma combinação simples exclui infecção em todas as crianças.

Exames. Avaliação clínica orienta hemograma, PCR/VHS, hemoculturas e ultrassom. Derrame no ultrassom não distingue sozinho sinovite transitória de artrite séptica. Suspeita de infecção demanda ortopedia, possível punção e tratamento apropriado, sem aguardar evolução domiciliar.

Tratamento da forma provável benigna. Repouso relativo, evitar apoio que provoque dor e analgesia. Ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO de 8/8 h, máximo 400 mg/dose, por período breve com reavaliação, se hidratado

e sem contraindicações renais/digestivas. Não associar outro AINE. Paracetamol é alternativa quando AINE não é apropriado. Antibiótico e corticoide não são necessários na sinovite transitória simples.

Retorno e destino. Alta requer criança clinicamente estável, dor controlada, plano de retorno e baixa suspeita de doença grave. Deve começar a melhorar nos dias seguintes e resolver habitualmente em até duas semanas. Febre, piora, ausência de melhora ou limitação persistente exigem nova avaliação; reabrir hipóteses como artrite séptica, Perthes e doença inflamatória. Retorno ao esporte apenas após recuperar função sem dor.

Fontes verificadas: RCH — sinovite transitória · RCH — criança com claudicação · RCH — analgesia no trauma

221. Acidose Respiratória na Criança

Reconhecimento e prioridades. A acidemia com elevação de Pa CO_2 exige procurar hipoventilação: obstrução, fadiga, depressão do sistema nervoso, doença neuromuscular ou ventilação inadequada. Hipercapnia acompanhada de sonolência, apneia, redução do esforço e instabilidade indica falência ventilatória. O número isolado da gasometria não substitui a avaliação da criança.

ABCDE e investigação. Abrir a via aérea, aspirar secreções quando necessário, fornecer oxigênio e ventilação com bolsa-máscara se a ventilação for insuficiente; preparar suporte definitivo. Verificar glicemia, gasometria, eletrólitos, capnografia e exposição a sedativos. Na criança intubada, verificar tubo, circuito, pneumotórax, secreção e auto-PEEP antes de simplesmente aumentar a frequência. A redução do tempo expiratório pode agravar obstrução e hipotensão.

Tratamento etiológico. Broncodilatadores somente diante de broncoespasmo, conforme tema 223. Suspeita de intoxicação opioide com depressão respiratória: ventilar e administrar naloxona **0,1 mg/kg IV/IM, máximo 2 mg**, com repetição guiada por ventilação; em sedação iatrogênica com circulação preservada, preferir pequenas doses tituladas de reversão, evitando abolir analgesia abruptamente. Para concentração efetiva C mg/mL, volume=min(0,1 W;2)/C. Narcan brasileiro verificado 0,4 mg/mL: em 16 kg,1,6 mg correspondem a 4 mL; reversão 4 × 0,4/16=0,1 mg/kg. Para reversão titulada de sedação iatrogênica usar doses menores conforme 285, não esse bolus de intoxicação grave. Flumazenil não é tratamento empírico do coma: intoxicação mista, epilepsia ou dependência de benzodiazepínicos elevam o risco de convulsão.

Reavaliação. A melhora esperada é ventilatória e neurológica, acompanhada de tendência gasométrica. Bicarbonato não corrige a causa da acidose respiratória. Hipercapnia permissiva só pertence a estratégias ventilatórias selecionadas; não legitima hipoventilação por obstrução ou intoxicação. Internar/transferir se precisar de suporte ventilatório ou houver recorrência após o antídoto.

Fontes verificadas: RCH — manejo emergencial de via aérea · RCH — sedação em enfermaria, naloxona · PALICC-2 2023 — consenso original · Cristália — Narcan 0,4 mg/mL.

222. Asma em Pediatria (Ambulatório)

Objetivo. Confirmar padrão de sintomas variáveis e limitação expiratória quando a idade permitir espirometria; revisar técnica, adesão, exposição tabágica, rinite e diagnósticos alternativos antes de escalar. Uma lista histórica de classes não implica indicação de todas elas.

Controle por idade. Em pré-escolares com episódios infrequentes e períodos assintomáticos, o plano pode concentrar-se no resgate e seguimento. Sintomas frequentes, despertares ou exacerbações recorrentes justificam teste terapêutico com corticoide inalatório. Referência RCH: **fluticasona propionato 50 mcg,1 jato 12/12 h**, espaçador e máscara conforme coordenação; verificar a idade autorizada da apresentação brasileira. Reavaliar resposta e crescimento em 6–12 semanas. Não confundir propionato com furoato nem assumir equivalência de dispositivos.

Em escolares, a GINA 2026 favorece tratamento contendo corticoide inalatório; escolher a etapa pela frequência de sintomas e risco de crise. Corticoide diário em dose baixa é opção inicial quando indicado. LABA isolado não constitui tratamento controlador. MART requer combinação/formulação e faixa etária especificamente estudadas; não adaptar qualquer inalador combinado.

Resgate e segurança. Salbutamol em aerossol **100 mcg/jato**, espaçador, conforme plano individual; na crise, usar o esquema do tema 223. Montelucaste é alternativa selecionada, não substituto automático do corticoide: referência 4 mg/noite em 2–5 anos e 5 mg/noite em 6–14 anos, com discussão de eventos neuropsiquiátricos. A

indicação e idade mínima do produto devem ser verificadas. Anti-histamínicos tratam rinite coexistente; não substituem controle da asma.

Metas. Sem limitação de atividade, despertares e uso excessivo de resgate; conferir exacerbações e crescimento. Fornecer plano escrito e retorno após crise. Falha com técnica e adesão adequadas exige pneumologia; reavaliar diagnóstico antes de acumular medicamentos.

Limites de aplicação: Etapas MART e biológicos exigem dispositivo, idade, fenótipo e elegibilidade individual; não foi criada prescrição universal.

Fontes verificadas: GINA 2026 — resumo oficial · RCH — asma em pré-escolares · RCH — asma de 6 a 11 anos.

223. Asma em Pediatria (Hospitalar)

Gravidade/ABCDE. Fala entrecortada, esforço intenso, hipoxemia, agitação e exaustão determinam escalonamento; sonolência, confusão ou tórax silencioso exigem UTI. Oxigênio titulado; a **GINA 2026 recomenda 92–95% em crianças≥6 anos e adolescentes** cobertos pelo resumo, alteração em relação a metas mais altas usadas anteriormente. Não aplicar automaticamente essa faixa a neonatos ou outras doenças.

Primeira hora. Salbutamol 100 mcg/jato por espaçador,1 jato por vez; referência operacional RCH: até 6 jatos nos pré-escolares e 6–12 jatos nos escolares, repetindo conforme gravidade e reavaliação, habitualmente a cada 20 min na abordagem inicial monitorizada. Ipratrópio é adjuvante nas crises moderadas/graves, não manutenção domiciliar automática. Prednisolona **1–2 mg/kg/dia VO, máximo 40 mg/dia,3–5 dias** em escolares; escolher um valor e respeitar teto. Para EMS-Pred solução oral 3 mg/mL verificada no fabricante, volume diário=min(dose×W;40)/3; essa conversão só vale após conferir o rótulo.

Refratariedade. Sulfato de magnésio IV **50 mg/kg, máximo 2 g**, em 20–30 min sob monitorização. Apresentação 50%=500 mg/mL: aspirar 0,1 mL/kg, limitado a 4 mL; concentração final 50 mg/mL requer volume final 1 mL/kg, limitado a 40 mL. Em 30 min, bomba 2 mL/kg/h, limitada a 80 mL/h, apenas durante a dose. PCH confirma compatibilidade com SF 0,9% ou SG 5% e concentração≤0,8 mmol/mL;50 mg/mL é aproximadamente 0,2 mmol/mL. Completar com SF 0,9% até o volume final calculado. A taxa citada utiliza 30 min, enquanto PCH emprega 20 min; escolher explicitamente a duração protocolar. Não há indicação de BIC domiciliar.

Controle. ECG, PA, SpO_2; potássio/lactato quando uso intensivo de beta-agonista. Taquipneia com melhora do broncoespasmo pode refletir lactato, não justificar escalada cega. Sedativos, antibióticos e radiografia não são rotineiros. Alta após estabilidade, intervalo seguro sem resgate, ingestão adequada e plano de controle; retorno em 2–5 dias. Necessidade crescente de oxigênio, magnésio ou ventilação exige internação.

Fontes verificadas: GINA 2026 — resumo oficial · RCH — exacerbação de asma · RCH — asma em pré-escolares · RCH — asma de 6 a 11 anos · PCH — monografia magnésio · EMS — EMS-Pred solução 3 mg/mL.

224. Aspergilose em Pediatria

Distinguir fenótipos. Aspergilose invasiva em imunossuprimido, aspergilose broncopulmonar alérgica e colonização de via aérea não recebem a mesma prescrição. Na suspeita invasiva, obter TC, culturas/amostra respiratória e biomarcadores pertinentes; instabilidade ou alta probabilidade clínica não deve aguardar toda a confirmação para tratar.

Antifúngico. Voriconazol é referência de primeira linha na doença invasiva. Crianças 2–<12 anos e 12–14 anos<50 kg: esquema de referência **9 mg/kg IV 12/12 h nas 2 primeiras doses; depois 8 mg/kg IV 12/12 h**. Adolescentes que pertencem ao regime adulto utilizam dose diferente; não extrapolar 8 mg/kg indiscriminadamente. A monitorização de nível plasmático, função hepática, QT e interações é parte do tratamento. Itraconazol e fluconazol não são substituições equivalentes para doença invasiva.

Preparo verificado. Vfend IV 200 mg: reconstituir com 19 mL de água para injetáveis, obtendo 20 mL a 10 mg/mL. BulaPfizer/DailyMed 2026 confirma diluição subsequente≤5 mg/mL em SF 0,9% ou SG 5%, infusão 1–3 horas e velocidade máxima 3 mg/kg/h; nunca bolus. Para o esquema pediátrico 9 mg/kg, usar 3 horas para respeitar o máximo. Exemplo 16 kg: carga 144 mg, aspirar 14,4 mL; completar com SF até 72 mL, concentração 2 mg/mL, bomba 24 mL/h por 3 horas. Reversão 24 × 3 × 2/16=9 mg/kg e 24 × 2/16=3 mg/kg/h. Manutenção

128 mg: 12,8 mL do estoque, completar até 64 mL, administrar em 3 horas a 21,33 mL/h. Não infundir simultaneamente com hemoderivados/eletrólitos concentrados.

Curso e destino. Tratamento prolongado, usualmente pelo menos 6–12 semanas na doença invasiva, orientado por imunossupressão e resposta. Forma alérgica requer confirmação imunológica e plano próprio de corticoide/antifúngico. Insuficiência renal pode influenciar a escolha da via IV por seu excipiente; hepatopatia exige avaliação individual. Internação se imunossupressão importante, progressão, hipoxemia ou necessidade IV.

Limites de aplicação: Menores de 2 anos e ajustes por disfunção renal/hepática pediátrica não possuem um regime universal estabelecido; requerem infectologia e nível sérico.

Fontes verificadas: IDSA — aspergilose · Pfizer Brasil — Vfend IV, bula profissional · Pfizer/DailyMed 2026 — Vfend, bula e preparo.

225. Bocavírus

Interpretação. A detecção de bocavírus em painel respiratório deve ser correlacionada com a síndrome clínica: DNA pode persistir e outros vírus podem coexistir. PCR positivo isolado não comprova que ele explica toda a gravidade, nem exclui infecção bacteriana concomitante. O estudo primário citado sustenta essa cautela diagnóstica; não é uma diretriz de antiviral.

Avaliação e gravidade. Documentar estado geral, esforço, SpO_2, ingestão e diurese. Apneia, cianose, exaustão, desidratação ou alteração do nível de consciência exigem atendimento hospitalar. Em lactente pequeno, investigar causas adicionais de febre conforme idade. Exames de imagem e culturas são dirigidos por achados de pneumonia, sepse ou complicação; repetir painéis não é meta terapêutica.

Tratamento. Suporte hídrico e respiratório conforme a síndrome: bronquiolite segue tema 226, asma/chiado responsivo segue 223/249 e pneumonia bacteriana suspeita segue 239. Não existe neste bloco antiviral específico validado para bocavírus. Broncodilatador só diante de fenótipo e resposta que justifiquem; não por PCR positivo. Antibiótico, corticoide, antiemético e mucolítico não formam um pacote obrigatório.

Reavaliação. A comparação deve usar evolução de frequência respiratória, trabalho ventilatório, necessidade de oxigênio, ingestão e sinais de desidratação. Internação/UTI é determinada pela fisiologia, comorbidades e suporte necessário. Na alta, orientar retorno diante de piora respiratória, recusa persistente de líquidos, redução da responsividade ou apneia. Não vincular melhora à negativação de PCR nem acrescentar remédios apenas porque classes constavam no inventário.

Fontes verificadas: Estudo primário HBoV 1/CDC EID · CPS — bronquiolite · CDC — uso racional ambulatorial pediátrico.

226. Bronquiolite

Diagnóstico e gravidade. Síndrome clínica de lactente com pródromo viral seguido de esforço respiratório, crepitações/sibilância. Apneia, exaustão, incapacidade de alimentar, desidratação e hipoxemia persistente determinam internação; prematuridade e cardiopneumopatia reduzem o limiar de observação.

Suporte. Manipular pouco, higiene nasal suave quando secreção interfere na alimentação, fracionar leite e considerar sonda se ingestão insuficiente com segurança de via aérea. Oxigênio se SpO_2 persistentemente<90% em≥6 semanas; limiar 92% para<6 semanas ou comorbidade relevante, conforme NICE. Escalonar suporte respiratório se persistência de hipoxemia ou fadiga; CPAP/UTI diante de falência iminente.

Medicamentos. Salbutamol, ipratrópio, adrenalina nebulizada, corticoide e antibiótico não são de rotina na bronquiolite típica. A presença de classe no inventário não equivale a indicação. **Salina hipertônica 3% não foi incorporada como tratamento universal**; diretrizes divergem historicamente, e NICE recomenda não usar. Nebulização de SF 0,9% também não substitui hidratação e suporte respiratório nem tem dose curativa estabelecida. Antitussígenos/mucolíticos não compõem terapia padrão.

Exames e destino. Não pedir rotineiramente radiografia, gasometria ou painel viral em casos típicos leves. Gasometria pode ajudar se falência; imagem se diagnóstico alternativo/complicação. Alta requer estabilidade

respiratória, hidratação e oxigenação sustentadas, incluindo sono quando observado. A família precisa reconhecer apneia, cianose, esforço crescente e baixa ingestão.

Aplicação. Se criança maior apresenta episódios recorrentes, atopia e resposta objetiva ao broncodilatador, reavaliar diagnóstico de sibilância/asma no tema 249; não transformar essa exceção em teste obrigatório para todo lactente.

Limites de aplicação: Sem posologia de fármacos não recomendados rotineiramente; intervenções de suporte dependem da avaliação fisiológica.

Fontes verificadas: NICE NG 9 — bronquiolite · CPS — bronquiolite.

227. Crupe em Pediatria

Reconhecimento. Tosse metálica, disfonia e estridor sugerem crupe. Estridor em repouso com retração importante, agitação, sonolência ou redução da entrada de ar indica gravidade. Hipoxemia é tardia. Febre alta, aspecto tóxico, salivação ou ausência de tosse típica exige avaliar epiglotite/traqueíte bacteriana.

Tratamento imediato. Manter criança com cuidador, posição de conforto e mínima manipulação. Dexametasona: quadro leve/moderado **0,15 mg/kg VO**; grave **0,6 mg/kg VO/IM/IV, máximo 12 mg**, dose única conforme RCH. A CPS utiliza 0,6 mg/kg como dose mais estudada: escolher regime e não somá-los. Converter em volume pela concentração do produto; soluções orais e injetáveis têm concentrações diferentes.

No crupe grave, **adrenalina 1 mg/mL,5 mL nebulizados** é dose fixa de referência RCH/CPS; o volume não deve ser confundido com a dose intramuscular da anafilaxia. Repetir somente com reavaliação e monitorização enquanto se organiza suporte definitivo. A preparação é para nebulização, nunca para injetar 5 mg IM. Oxigênio se necessário, sem agitar; equipe experiente para intubação se exaustão.

Exames, controle e destino. Diagnóstico típico é clínico; exames não podem precipitar obstrução ou atrasar suporte. Reavaliar estridor em repouso, retrações e estado mental. Observar pelo menos 3 horas após a última adrenalina; prolongar se recorrência, acesso difícil ao serviço ou risco adicional. Internar se doses repetidas, hipoxemia ou persistência. Antibióticos não tratam crupe viral, embora tenham lugar em diagnósticos bacterianos alternativos.

Cheque de dose. Com 16 kg, dexametasona grave 9,6 mg, abaixo do teto 12 mg; V=9,6/C mL. A reversão obrigatória éV×C/16=0,6 mg/kg.

Fontes verificadas: RCH — crupe · CPS — crupe · Eurofarma — dexametasona 4 mg/mL, bula profissional.

228. Desconforto Respiratório Agudo Pediátrico

Enquadramento. Desconforto respiratório agudo é uma apresentação; PARDS requer critérios de início, imagem e oxigenação. Avaliar simultaneamente obstrução, pneumonia, pneumotórax, edema cardiogênico, sepse e anemia. Monitorizar SpO_2, ECG, PA, capnografia quando disponível e perfusão. Corrigir ameaças noABCDE; não esperar radiografia para tratar pneumotórax hipertensivo ou ventilação inadequada.

Suporte de referência. NaPARDS intubada, PALICC-2 propõe ventilação protetora com volume corrente 6–8 mL/kg e redução para 4–6 se necessário para limitar pressão; platô≤28 cmH_2O e driving pressure≤15 cmH_2O, com exceções específicas de parede torácica. TitularPEEP à oxigenação e hemodinâmica. Alvo SpO_2 92–97% na forma leve/moderada; valores menores podem ser aceitos na grave comPEEP adequada e avaliação de oferta deO_2. Evitar hiperóxia. Hipercapnia permissiva com pH≥7,20 exige avaliar contraindicações.

Prescrição complementar. Analgesia/sedação deve ter objetivo e escala, reduzindo doses excessivas; consultar tema 285. Bloqueio neuromuscular não substitui sedação. IBP e antieméticos não fazem parte automática de todo caso. Antibiótico é dirigido à causa infecciosa; broncodilatador ao broncoespasmo. Corticoide, surfactante e óxido nítrico não são universais paraPARDS.

Reavaliação/destino. Documentar tendência da oxigenação, complacência, pressões, diurese, lactato e balanço. Falha de suporte não invasivo, necessidade crescente deFiO_2, acidemia/exaustão ou choque exige UTI e ventilação invasiva sem atraso por tentativas indefinidas. ECMO é possibilidade em doença refratária elegível. Os parâmetros apresentados iniciam um raciocínio protetor; não substituem ajuste à mecânica e à causa.

Limites de aplicação: Não há sedação ou antibiótico universal; aplicar monografias conforme etiologia e ventilação.

Fontes verificadas: PALICC-2 2023 — consenso original · RCH — manejo emergencial de via aérea.

229. Displasia Broncopulmonar

Objetivo. Na displasia broncopulmonar, integrar dependência de oxigênio, crescimento, mecânica respiratória, aspiração e hipertensão pulmonar. Não assumir que todo chiado do prematuro responde como asma. Dessaturação, fadiga ao alimentar, ganho ponderal inadequado e necessidade crescente de suporte justificam reavaliação.

Conduta crônica. As recomendaçõesATS para doença respiratória pós-prematuridade não apoiam diurético de rotina; quem recebeu alta em uso necessita retirada cuidadosa quando clinicamente possível. Broncodilatador ou corticoide inalatório pode ter teste individualizado em pacientes sintomáticos, com resposta mensurável e interrupção quando não há benefício. Não prescrever macrolídeo, vitaminaA ou cafeína somente pelo rótulo DBP: suas indicações pertencem a cenários neonatais específicos.

Acompanhamento. Revisar plano de oxigênio com pneumologia/neonatologia, segurança do equipamento e necessidade em sono/alimentação. Investigar hipertensão pulmonar e distúrbios de deglutição quando sugeridos; vacinação e prevenção de infecções devem acompanhar recomendações brasileiras vigentes e elegibilidade específica. Diuréticos exigem balanço, Na, K, Cl, função renal e saúde óssea; não há dose crônica genérica sem indicação definida.

Agudização. AplicarABCDE, oferecer suporte de oxigênio/ventilação e procurar infecção, aspiração, edema ou falha do equipamento. Os esquemas de bronquiolite ou asma só se aplicam quando o fenótipo corresponde. Uma resposta transitória à nebulização não estabelece necessidade permanente de corticoide.

Destino e limites. Alta depende de plano de suporte estável e treinamento familiar; descompensação com hipoxemia persistente, apneia ou dificuldade alimentar requer internação. Este tema é desenvolvido como plano de decisão e seguimento; não se inventou BIC ou polifarmácia de manutenção para preencher classes do inventário.

Limites de aplicação: Faixas de oxigênio na DBP/hipertensão pulmonar e fármacos neonatais requerem fenótipo e idade pós-menstrual.

Fontes verificadas: ATS — doença respiratória pós-prematuridade · RCH — asma em pré-escolares.

230. Embolia e Infarto Pulmonar em Pediatria

Suspeita e gravidade. ConsiderarTEP diante de dispneia/hipoxemia inexplicadas, dor pleurítica, hemoptise ou choque com fatores de risco como cateter, imobilização, neoplasia e trombose. Escores adultos eD-dímero isolado não excluemTEP pediátrico com segurança. Instabilidade exigeABCDE, ecocardiografia à beira-leito quando disponível e UTI.

Confirmação. AngioTC ou alternativa apropriada é escolhida conforme estabilidade e capacidade local; ultrassom venoso pode identificar fonte. Hemograma, plaquetas, coagulação, creatinina e função hepática orientam risco e anticoagulação. Não postergar estabilização por imagem.

Anticoagulação. Criança estável e elegível: enoxaparina SC é opção inicial conhecida; referência RCH **<2 meses 1,5 mg/kg 12/12 h;≥2 meses 1 mg/kg 12/12 h**, com anti-Xa e ajustes. Produto 100 mg/mL: V=dose/100; em 16 kg≥2 meses,16 mg=0,16 mL. Esse pequeno volume exige seringa graduada apropriada; não arredondar empiricamente para a seringa comercial inteira. Prematuros podem precisar de regime diferente. Insuficiência renal e hemorragia exigem estratégia específica.

A diretriz ASH/ISTH 2025 admite anticoagulantes orais diretos em crianças elegíveis; escolha não é automática em lactentes, hepatopatia, insuficiência renal, absorção incerta ou procedimentos iminentes. Duração é individualizada; curso abreviado de 6 semanas emTEV provocado selecionado não deve ser aplicado indiscriminadamente aTEP.

Reperfusão/destino. TEP com choque pode exigir trombólise ou intervenção em centro especializado, ponderando sangramento; não há receita universal segura. Internar para monitorização e definição de

tratamento. Checar Hb, plaquetas, sangramento, função renal e anti-Xa em HBPM. Não associar anticoagulantes sem intenção explícita de transição.

Limites de aplicação: Enoxaparina pediátrica frequentemente off-label em bulas brasileiras; conferir produto, anti-Xa e elegibilidade para DOAC.

Fontes verificadas: ASH/ISTH 2025 — tromboembolismo pediátrico · RCH — enoxaparina pediátrica.

231. Epiglotite

Emergência de via aérea. Febre alta, aspecto tóxico, sialorreia, voz abafada, postura de tripé e dificuldade de deglutir sugerem epiglotite. Não forçar decúbito, não examinar orofaringe com abaixador, não separar do cuidador para testes que agitem. Acionar anestesia/otorrino e UTI imediatamente.

ABCDE. Oferecer oxigênio tolerado, manter posição de conforto e preparar via aérea difícil com possibilidade cirúrgica. A intubação deve ser feita por profissional experiente em ambiente equipado. Punção, gasometria, TC e radiografia não precedem o controle da via aérea quando há obstrução importante. Ventilação espontânea pode ser essencial na estratégia anestésica.

Antimicrobiano. Após acesso seguro, iniciar cobertura parenteral para agentes invasivos. Ceftriaxona **50 mg/kg IV 24/24 h, máximo 2 g/dia** é referência para infecção não meníngea; se meningite suspeita, usar regime de meningite, não simplesmente manter essa dose. Cobertura adicional para MRSA é reservada ao risco epidemiológico/gravidade e deve incluir monitorização apropriada. Obter hemocultura e cultura da via aérea se isso não atrasar tratamento.

Curso e preparo. Referência PCH para ceftriaxonaAFT 1 g: 9,4 mL de água produzem 10 mL a 100 mg/mL; outras marcas requerem sua bula, pois deslocamento difere. Após reconstituição, diluir em SF 0,9% para≤40 mg/mL e infundir 30 min. Em 16 kg,800 mg: 8 mL de 100 mg/mL, completar até 20 mL e programar 40 mL/h por 30 min; reversão 40 × 0,5 × 40/16=50 mg/kg. Não usar diluente IM com lidocaína por IV nem misturar com cálcio. Duração deve ser dirigida ao agente, evolução e complicações; extubação não é critério isolado de interrupção.

Reavaliação. Observar perfusão, oxigenação, pressões de ventilação e extensão da infecção. Extubação exige resolução do edema e plano de resgate. Profilaxia de contatos paraHib depende de confirmação e composição domiciliar; vacinação incompleta deve ser corrigida posteriormente.

Limites de aplicação: Reconstituição exemplificada éAFT internacional; confirmar deslocamento da marca brasileira. Meningite e neonatos requerem regime/restrições específicos.

Fontes verificadas: RCH — obstrução aguda de via aérea superior · UCSF — doses antimicrobianas pediátricas · PCH2026 — ceftriaxona, reconstituição/infusão.

232. Estridor

Estridor é sinal, não diagnóstico. Caracterizar início súbito ou crônico, componente inspiratório/bifásico, associação com alimentação, engasgo, febre e posição. A intensidade sonora pode diminuir com exaustão; ausência de ruído intenso não tranquiliza quando a entrada de ar piora.

Abordagem. AvaliarABC sem agitação. Estridor em repouso com retrações, hipoxemia, alteração mental ou sialorreia é emergência. Manter posição de conforto, oxigênio tolerado e acionar profissional de via aérea. Adiar exames irritativos até segurança respiratória. Início súbito após engasgo pede avaliação de corpo estranho; febre/toxemia pede infecção bacteriana; início após exposição alergênica pede anafilaxia.

Tratamento por causa. Crupe segue tema 227; anafilaxia segue 269, com adrenalina IM, cuja dose não é a da nebulização. Epiglotite segue 231. Corpo estranho requer desobstrução conforme consciência e idade e avaliação broncoscópica; não fazer varredura digital às cegas. Adrenalina nebulizada pode oferecer alívio transitório do edema enquanto se prepara tratamento definitivo; não resolve corpo estranho ou massa.

Crônico. Estridor desde o início da vida, associado a dificuldade alimentar, apneias ou crescimento insuficiente requer avaliação especializada para malácia, estenose, paralisia de pregas ou compressão extrínseca. Anti-H 2, IBP e procinéticos não devem ser incorporados apenas porque aparecem em um inventário; confirmar indicação independente.

Controle/destino. Registrar esforço, entrada de ar, SpO_2, capacidade de engolir e resposta após cada intervenção. Internar diante de gravidade, recorrência ou necessidade repetida de medicação; UTI quando suporte de via aérea é provável. Esse encadeamento evita uma prescrição fixa de corticoide/antiácido para todas as etiologias.

Fontes verificadas: RCH — obstrução aguda de via aérea superior · RCH — crupe · RCH — manejo emergencial de via aérea.

233. Faringoamigdalite na Infância

Identificar quem precisa de antibiótico. Sinais virais claros favorecem tratamento sintomático. Sem quadro viral convincente, o exame clínico isolado não diferencia estreptococo de vírus; teste rápido e/ou cultura orientam. Em crianças>3 anos, teste rápido negativo deve ser confirmado por cultura quando se investiga estreptococo. Avaliar abscesso se trismo, assimetria, desvio de úvula ou voz abafada.

Primeira linha para estreptococo confirmado. Amoxicilina VO **50 mg/kg 24/24 h, máximo 1 g/dia,10 dias**, ou 25 mg/kg 12/12 h, máximo 500 mg/dose. Apresentação brasileira EMS 250 mg/5 mL=50 mg/mL: 1 mL/kg/dia, limitado 20 mL/dia, ou 0,5 mL/kg/dose 12/12 h, limitado 10 mL. Não aplicar teto da pneumonia a este esquema.

Alternativas. Penicilina benzatina IM: 600.000 UI dose única<27 kg;1.200.000 UI≥27 kg. A concentração após reconstituição deve ser lida na bula; nunca por via IV. Alergia não imediata selecionada pode permitir cefalexina 20 mg/kg 12/12 h, máximo 500 mg/dose,10 dias. Alergia imediata exige alternativa compatível com resistência local; macrolídeo não é equivalente de primeira linha. Não presumir segurança de cefalexina em anafilaxia prévia à penicilina.

Suporte e seguimento. Analgesia conforme módulo comum, ingestão hídrica e retorno por dispneia, sialorreia, desidratação ou piora unilateral. Reavaliar ausência de melhora; não ampliar antibióticos sem revisar diagnóstico, adesão e complicações.

Tripla conferência exemplificativa. Criança 16 kg: 800 mg/dia=16 mL/dia de 50 mg/mL, ou 400 mg=8 mL 12/12 h. Reversão 8 × 50 × 2/16=50 mg/kg/dia; ambos respeitam teto. Esse exemplo é matemático e não documenta diagnóstico de um paciente.

Fontes verificadas: CDC — faringite estreptocócica · EMS — amoxicilina 250 mg/5 mL.

234. Fibrose Cística na Pediatria

Plano integrado. Fibrose cística requer confirmação diagnóstica e seguimento em centro de referência. Avaliar função pulmonar, culturas de via aérea, nutrição, insuficiência pancreática, diabetes e complicações. Exacerbação não deve receber lista fixa de todos os antibióticos: escolher conforme microrganismos prévios, gravidade, culturas e resposta.

Terapias específicas. PCDT brasileiro 2024: alfadornase **2,5 mg por nebulização 1 vez/dia**, com equipamento apropriado; intensificação apenas em casos selecionados. Não misturar medicamentos no reservatório sem comprovação de compatibilidade. Tobramicina inalatória e colistimetato têm indicações microbiológicas distintas; verificar formulação e unidades, pois mg de colistina eUI de colistimetato não são intercambiáveis sem conversão validada.

Enzimas e moduladores. Pancreatina é prescrita emUI de lipase por alimentação, com avaliação de gordura ingerida, idade e crescimento; não emmg de cápsula. Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor depende de genótipo, idade, peso e apresentação, com monitorização hepática e interaçõesCYP 3 A. O PCDT citado contém esquemas por faixas; expansão regulatória e disponibilidadeSUS não devem ser presumidas como idênticas.

Emergências. Hemoptise importante, pneumotórax, hipoxemia, desidratação hiponatrêmica ou queda funcional acentuada exige hospital. Antibióticos IV requerem ajuste renal, alvos de exposição e culturas. Beta-agonista antes de determinada terapia inalatória pode ser indicado se broncoespasmo; mucolítico oral não substitui alfadornase.

Conferência. Para ampola cuja concentração rotulada seja 1 mg/mL,2,5 mg correspondem a 2,5 mL; não transferir essa conversão a outro produto sem conferir. O cálculo não autoriza uso IV da formulação inalatória. A

sequência de fisioterapia e inalação deve ser combinada com a equipe, avaliando adesão e tempo de tratamento.

Limites de aplicação: Não é monografia completa de moduladores CFTR, antibióticos para cada colonização ou reposição pancreática; esses ramos exigem genótipo/cultura/apresentação específicos.

Fontes verificadas: Ministério da Saúde — PCDT fibrose cística 2024 · UCSF — doses antimicrobianas pediátricas.

235. Hemorragia Pulmonar

Gravidade. Sangue na via aérea com hipoxemia, obstrução, queda de hemoglobina ou choque é emergência; distinguir hemoptise, epistaxe aspirada e hematêmese. No neonato, investigar doença pulmonar, coagulopatia, infecção e instabilidade hemodinâmica. Não esperar estimativa exata do volume para agir.

ABCDE. Acionar UTI, oxigênio, aspiração cuidadosa e controle de via aérea se necessário. Preservar ventilação e corrigir choque; evitar repetidas desconexões. Na hemorragia unilateral conhecida, posicionar o pulmão sangrante para baixo pode proteger o contralateral, sob supervisão. Obter hemograma, plaquetas, coagulação, fibrinogênio, gasometria, tipagem e provas de compatibilidade; imagem e broncoscopia conforme estabilidade.

Tratamento específico. O manejo neonatal pode incluir ajuste ventilatório/PEEP, correção de coagulopatia e tratamento da causa. Sangramento por bronquiectasia/fibrose cística pode exigir broncoscopia e embolização. Imunossupressão só após investigação de hemorragia alveolar imunomediada e exclusão razoável de infecção. Concentrados sanguíneos dependem da perda e da fisiologia; não impor uma hemoglobina universal durante sangramento ativo.

Medicamentos. Adrenalina endotraqueal e ácido tranexâmico nebulizado não foram convertidos em prescrição universal: dose, formulação, evidência e risco variam por contexto. Não instilar ampolas empiricamente no tubo. Rever anticoagulantes com hematologia e planejar reversão específica quando pertinente.

Destino e reavaliação. Monitorização contínua, balanço, sangramento, oxigenação e perfusão. A estabilidade momentânea não encerra investigação de sangramento significativo. Registrar se a intervenção corrigiu ventilação, circulação e causa, e transferir para centro com broncoscopia/intervenção quando necessário.

Limites de aplicação: Terapias hemostáticas locais e transfusão não têm um regime universal certificado para todas as causas pediátricas.

Fontes verificadas: NHS neonatal network — recomendações 2022–2024 · PALICC-2 2023 — consenso original · Ministério da Saúde — PCDT fibrose cística 2024.

236. Influenza em Pediatria

Seleção. Suspeitar diante de síndrome gripal sazonal; insuficiência respiratória, desidratação, alteração neurológica ou comorbidade aumentam gravidade. Paciente hospitalizado, com doença progressiva ou alto risco deve receber antiviral prontamente, mesmo após 48 horas; coleta diagnóstica não deve atrasar tratamento indicado.

Oseltamivir VO, tratamento por 5 dias. A partir de 1 ano: ≤15 kg 30 mg 12/12 h; >15–23 kg 45 mg 12/12 h; >23–40 kg 60 mg 12/12 h; >40 kg 75 mg 12/12 h. Lactente de termo<1 ano: 3 mg/kg 12/12 h como referênciaCDC/MS; prematuros requerem dose por idade pós-menstrual. A AAP adota 3,5 mg/kg para 9–11 meses em circunstâncias específicas; não alternar regimes sem definir referência.

Apresentação e cálculo. Cápsulas não devem ser confundidas com suspensão. Suspensão comercial internacional verificada 6 mg/mL: doses 30/45/60/75 mg equivalem a 5/7,5/10/12,5 mL. Criança 16 kg: 45 mg=7,5 mL 12/12 h,75 mL no curso completo. Essa concentração não certifica disponibilidade comercial brasileira; preparação extemporânea deve seguir fórmula farmacêutica validada. Insuficiência renal exige ajuste individual, especialmente em crianças pequenas.

Complementos. Oxigênio, líquidos e analgesia conforme necessidade. Antibiótico apenas se suspeita de coinfecção bacteriana; corticoide não é tratamento rotineiro da influenza. Evitar ácido acetilsalicílico em crianças. Persistência de febre ou piora após melhora requer avaliar pneumonia/complicação.

Destino. Alta com ingestão e respiração estáveis, orientações de retorno e prevenção. Hospitalização se hipoxemia, incapacidade de hidratação, complicação ou necessidade de suporte. Duração além de 5 dias em imunossuprimidos/doença grave depende da evolução e equipe especializada.

Limites de aplicação: Prematuros e insuficiência renal pediátrica exigem esquema individual;6 mg/mL foi confirmado em bula internacional.

Fontes verificadas: SES-SP — oseltamivir 09/06/2025 · CDC — antivirais influenza · DailyMed — oseltamivir suspensão 6 mg/mL.

237. Mastoidite em Pediatria

Reconhecimento. Dor e edema retroauricular, apagamento do sulco e deslocamento do pavilhão, geralmente após otite, sugerem mastoidite. Alteração neurológica, rigidez, proptose, déficit focal ou choque sugerem extensão. Internar, avaliar otorrinolaringologia precocemente e obter culturas quando possível sem atraso.

Exames. Hemograma, marcadores inflamatórios e hemocultura conforme gravidade. TC/RM avaliam abscesso, trombose venosa e extensão intracraniana quando clinicamente indicadas; não transformar imagem em requisito prévio para antibioticoterapia no paciente séptico.

Antibiótico. Referência UCSF para forma aguda imunocompetente sem otite crônica: ampicilina/sulbactam IV **50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g de ampicilina/dose**. A relação do produto deve ser explicitada: na associação 2:1,16 kg exige 800 mg de ampicilina +400 mg de sulbactam=1200 mg totais por dose. Não calcular 50 mg/kg sobre a soma. Vancomicina é acrescentada se risco documentado de MRSA; retirar se culturas e evolução não sustentarem.

Controle do foco e curso. Abscesso/extensão ou falha pode exigir drenagem/mastoidectomia. A referência propõe curso total 3–4 semanas em mastoidite não complicada, ajustado à resposta, com transição oral; comprometimento ósseo/intracraniano exige plano próprio. Não aplicar a duração curta de otite simples.

Preparo/segurança. Ajustar beta-lactâmico à função renal; conferir concentração pós-reconstituição e tempo de infusão do fabricante antes de converter 1200 mg totais emmL. Monitorar dor, edema, febre, função neurológica e sinais de complicação. Alta depende de foco controlado, melhora sustentada e plano de seguimento.

Limites de aplicação: Reconstituição depende da apresentação de ampicilina/sulbactam e não foi fixada sem produto selecionado.

Fontes verificadas: UCSF — mastoidite · UCSF — doses antimicrobianas pediátricas.

238. Otite Média na Criança

Diagnóstico. Otalgia isolada ou tímpano vermelho não bastam: procurar abaulamento e derrame, ou otorreia não explicada por otite externa. Criança toxemiada, edema retroauricular, paralisia facial ou sinais meníngeos requer avaliação urgente. Otite serosa sem infecção aguda não recebe o mesmo tratamento.

Decisão. Analgesia é central. Observação com retorno garantido 48–72 horas pode ser apropriada em crianças selecionadas≥6 meses, quadro leve e sem fatores de risco. Idade pequena, bilateralidade, otorreia, dor importante ou febre alta favorecem antibiótico.

Esquema quando indicado. Referência UCSF: amoxicilina **45 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 1 g/dose**. Duração: 10 dias em<2 anos ou doença grave;7 dias em 2–5 anos;5 dias em>5 anos sem gravidade. O teto deste protocolo deve constar na prescrição; outros protocolos usam tetos diferentes. Amoxicilina recente, conjuntivite purulenta ou falha confirmada podem justificar amoxicilina/clavulanato, calculada pelo componente amoxicilina e com formulação que limite clavulanato.

Conferência de apresentação. Amoxicilina EMS 250 mg/5 mL=50 mg/mL: 16 kg× 45=720 mg=14,4 mL/dose. Duas doses equivalem a 90 mg/kg/dia. Uma concentração maior diminui volume, mas exige novo cálculo, nunca manter os mesmosmL. Ajustar na insuficiência renal; esclarecer natureza da alergia.

Reavaliação. Falha clínica 48–72 horas exige reexaminar tímpano, adesão e complicações antes de ampliar. Persistência de efusão após melhora não prova falha bacteriana. Orientar retorno por piora, edema

retroauricular ou prostração e avaliar audição se efusão prolongada.

Fontes verificadas: UCSF — otite média aguda · RCH — otite média · EMS — amoxicilina 250 mg/5 mL.

239. Pneumonia Comunitária na Criança

Avaliação. Classificar por idade, esforço, SpO_2, hidratação, estado mental e comorbidades. Hipoxemia, tiragem intensa, gemência, apneia, incapacidade de beber ou suspeita de derrame/sepse exigem hospital. Radiografia não é obrigatória na forma ambulatorial típica, mas ajuda em gravidade, dúvida ou complicação.

Ambulatório. Para provável pneumonia bacteriana em criança previamente saudável, amoxicilina é primeira opção. O protocoloFHEMIG adota **50 mg/kg/dia VO divididos 12/12 h**, com duração usual 7 dias e reavaliação 48–72 horas. Regimes de maior dose/curso mais curto pertencem a protocolos específicos e não devem ser misturados. Macrolídeo não é obrigatório em toda pneumonia; reservar à hipótese plausível de agente atípico, especialmente escolares.

Hospital,>3 meses. Para PAC bacteriana não complicada, UCSF: ampicilina **50 mg/kg/dose IV 6/6 h, máximo 2 g/dose**; alternativa em alergia de baixo risco elegível: ceftriaxona **50 mg/kg IV 24/24 h, máximo 2 g/dia**. Total 7 dias, com transição oral após melhora/tolerância. Criança 16 kg: ampicilina 800 mg por dose,3200 mg/dia; ceftriaxona 800 mg/dia. Ajustar ampicilina ao rim. Empiema/necrose: avaliar drenagem; ampicilina/sulbactam 50 mg de ampicilina/kg 6/6 h, max 2 g/dose, e cobertura MRSA se falência respiratória/instabilidade ou risco epidemiológico. Duração complicada 14–28 dias, individualizada com infectologia; não prolongar automaticamente todo caso. Neonatal segue 240.

Cálculo de referência. Com 16 kg,50 mg/kg/dia=800 mg/dia;400 mg 12/12 h=8 mL/dose de suspensão 50 mg/mL. Não confundir esse regime com 45 mg/kg **por dose** empregado em otite/sinusite. A comparação explícita reduz erros de duplicação.

Controle/destino. Avaliar resposta por febre, ingestão, esforço e oxigênio. Persistência ou piora exige revisar diagnóstico, corpo estranho, tuberculose, resistência, adesão e complicação. Hidratar evitando sobrecarga; broncodilatador somente se broncoespasmo. Corticoide, mucolítico, antitussígeno e fisioterapia não são componentes universais.

Fontes verificadas: FHEMIG — pneumonia comunitária pediátrica · SBP — pneumonia comunitária complicada 2024 · EMS — amoxicilina 250 mg/5 mL · UCSF — pneumonia hospitalar em>3 meses.

240. Pneumonia Congênita

Emergência neonatal. Dificuldade respiratória ao nascimento/início da vida pode representar pneumonia, sepse, doença de membrana hialina, cardiopatia ou adaptação pulmonar. Revisar prematuridade, febre materna, tempo de bolsa rota e colonização; a radiografia isolada não distingue todas as causas. Apneia, hipotermia/hipertermia, perfusão ruim e intolerância alimentar ampliam suspeita.

ABCDE e investigação. Termorregulação, glicemia, suporte ventilatório e circulatório adequados à idade. Hemocultura antes do antibiótico se não atrasar; hemograma, marcadores e gasometria auxiliam, mas resultado inicial normal não exclui infecção. Punção lombar depende de estabilidade e suspeita de meningite.

Antimicrobiano de referência. NICE para infecção neonatal precoce: benzilpenicilina **25 mg/kg IV 12/12 h**, considerar 8/8 h se gravidade, associada a gentamicina **5 mg/kg IV inicial**, próxima dose habitualmente 36 horas, modificada por níveis e estado clínico. É um protocolo britânico; serviços brasileiros frequentemente escolhem ampicilina/gentamicina com intervalos por idade gestacional/pós-natal. Não substituir mg de benzilpenicilina porUI ou ampicilina sem conversão/regime próprios. Meningite exige outro esquema.

Monitorização e revisão. Gentamicina exige função renal, diurese e nível sérico para doses seguintes, principalmente prematuro/asfixia. Em cultura negativa e baixa suspeita, critérios do protocolo permitem interrupção precoce; em infecção confirmada, duração depende do agente e foco. Não prolongar automaticamente pela radiografia alterada.

Cálculo. RN 3 kg no regime citado: 75 mg de benzilpenicilina por dose e 15 mg de gentamicina inicial. Volume=D/C após conferir o produto; a próxima gentamicina não é programada cegamente a cada 24 horas. Destino é unidade neonatal com reavaliação contínua.

Limites de aplicação: Regime mostrado é NICE; prescrição brasileira final exige escolha do protocolo neonatal, apresentação e ajuste por idade/níveis.

Fontes verificadas: NICE NG 195 — infecção neonatal · NHS neonatal network — recomendações 2022–2024.

241. Resfriado Comum em Pediatria

Reconhecimento. Coriza, obstrução, espirros e tosse em criança bem, sem sinais focais de gravidade, favorecem infecção viral de vias aéreas superiores. Coloração amarela/verde da secreção, isoladamente, não comprova bactéria. Febre em lactente pequeno, dificuldade respiratória, desidratação ou prostração requer avaliação ampliada.

Cuidados. Líquidos conforme aceitação, higiene nasal com solução salina apropriada e aspiração suave quando indispensável à alimentação. Mel pode aliviar tosse em≥1 ano; não oferecer a menores de 1 ano pelo risco de botulismo. Antitérmico/analgésico destina-se a desconforto, com dose e apresentação conferidas; não alternar múltiplos produtos automaticamente.

O que a classificação não autoriza. Antibióticos não aceleram recuperação viral. Antitussígenos, descongestionantes combinados e preparações para resfriado não são recomendados rotineiramente para crianças pequenas; produtos multicomponentes aumentam duplicação de dose. Mucolítico não foi incorporado como necessidade universal. Corticoide sistêmico não é tratamento do resfriado simples.

Investigação e retorno. Não solicitar painelviral/radiografia para toda coriza. Considerar influenza/COVID e elegibilidade para tratamento específico quando quadro e contexto indicarem. Dor de ouvido importante, febre prolongada, piora após melhora ou sintomas nasais persistentes sem melhora justificam reexame para complicações.

Plano prático. Escrever apenas os cuidados efetivamente necessários e um analgésico, se indicado, com concentração explícita. Registrar tempo de doença e sinais de alerta; retorno imediato por apneia, cianose, retrações, sonolência anormal ou ingestão insuficiente. A duração de tosse não deve ser tratada automaticamente com um novo medicamento.

Fontes verificadas: CDC — tratamento do resfriado · CDC — uso racional ambulatorial pediátrico.

242. Rinite Alérgica em Pediatria

Diagnóstico e impacto. Espirros, prurido, rinorreia aquosa e obstrução recorrentes com exposição/atopia sugerem rinite alérgica. Avaliar sono, escola, asma, técnica de higiene e diagnóstico diferencial. Obstrução unilateral, sangramento persistente, corpo estranho, pólipo ou secreção fétida exige exame dirigido.

Tratamento. Reduzir exposição relevante e ensinar lavagem nasal. Corticoide intranasal é opção para sintomas persistentes/moderados, com uso regular e aplicação voltada à parede lateral, evitando septo. Mometasona nasal **50 mcg/jato**: esquema habitual de bula 2–11 anos 1 jato por narina 1 vez/dia;≥12 anos 2 jatos por narina 1 vez/dia, reduzindo após controle. Confirmar idade autorizada da marca e não equiparar gotas nasais a aerossol.

Conferência. Criança 2–11 anos: 2 jatos totais/dia× 50=100 mcg/dia; adolescente com 2 por narina: 4 × 50=200 mcg/dia. A dose é por dispositivo, não por peso. Verificar preparo inicial da bomba e número de doses. Epistaxe exige revisar técnica e mucosa, além de avaliar suspensão temporária.

Adjuvantes e segurança. Anti-histamínico de segunda geração pode ajudar prurido/espirros, com monografia por idade. Evitar duplicação de anti-histamínicos e uso prolongado de vasoconstritor tópico pelo efeito rebote. Corticoide sistêmico e antibiótico não são tratamento de manutenção da rinite.

Seguimento. Reavaliar controle, adesão e crescimento em uso prolongado. Falha apesar de técnica/adesão deve motivar revisão de diagnóstico e alergologia/otorrino; imunoterapia exige sensibilização clinicamente relevante e serviço habilitado. A presença de rinite não explica toda dispneia ou sibilância.

Fontes verificadas: Glenmark Brasil — mometasona nasal · RCH — asma em pré-escolares · Glenmark — bula mometasona nasal.

243. Rinossinusite Aguda em Pediatria

Quando é bacteriana. Considerar sintomas nasais/tosse diurna persistentes>10 dias sem melhora, piora após melhora inicial, ou início grave com febre≥39°C e secreção purulenta por pelo menos 3 dias. Apenas secreção colorida nos primeiros dias não basta. Edema orbitário, alteração visual, dor à movimentação ocular, cefaleia intensa ou sinal neurológico exigem emergência.

Tratamento. Em caso persistente leve com seguimento garantido, curta observação pode ser opção; quadro grave ou progressivo requer antibiótico. Referência UCSF: amoxicilina **45 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 1 g/dose**, ou amoxicilina/clavulanato na mesma dose do componente amoxicilina quando indicado. Duração referencial 10 dias; revisar em 48–72 horas. O espectro e o curso variam por resistência e complicações.

Apresentação. Na amoxicilina isolada 50 mg/mL,16 kg exige 720 mg=14,4 mL 12/12 h. Para associação, conferir os dois componentes por 5 mL; o mesmo volume pode expor a quantidade excessiva de clavulanato. Não trocar concentrações mantendo mL. Alergia imediata e função renal exigem alternativa/ajuste específico.

Cuidados. Analgesia, hidratação e salina nasal. Corticoide intranasal pode tratar rinite coexistente, não substituir antibiótico quando infecção bacteriana está bem definida. Antitussígenos, mucolíticos e vasoconstritores prolongados não formam pacote obrigatório.

Falha/complicação. Reexaminar se piora ou ausência de melhora; confirmar adesão e diferencial. Imagem é dirigida à suspeita de extensão orbitária/intracraniana, não à sinusite simples. Internar complicações para antibiótico IV e avaliação cirúrgica, com proteção da visão e do sistema nervoso.

Fontes verificadas: UCSF — sinusite bacteriana · CDC — uso racional ambulatorial pediátrico · EMS — amoxicilina 250 mg/5 mL.

244. Síndrome Torácica Aguda

Diagnóstico e gravidade. Na doença falciforme, infiltrado pulmonar novo associado a febre/sintomas respiratórios deve suscitar síndrome torácica aguda. Pode surgir durante internação por dor. Monitorar SpO_2 e tendência da hemoglobina; hipoxemia crescente, doença multilobar, esforço importante ou alteração neurológica exigem UTI/hematologia.

Tratamento integrado. Oxigênio, analgesia que permita respirar sem causar hipoventilação, incentivo respiratório quando cooperativo e hidratação cuidadosamente balanceada. AOMS 2026 sugere antibióticos além do suporte; evidência não justifica aguardar confirmação microbiológica antes de tratar quadro convincente. Cobrir agentes usuais e atípicos, adaptando resistência/alergia. Broncodilatador quando broncoespasmo/asma; corticoide sistêmico não é automaticamente indicado.

Antimicrobianos exemplificativos. Ceftriaxona **50 mg/kg IV 24/24 h, máximo 2 g/dia**, associada a azitromicina **10 mg/kg VO no 1ºdia, máximo 500 mg;5 mg/kg/dia nos dias 2–5, máximo 250 mg/dia** é combinação de referência; ajustar duração do beta-lactâmico à evolução e microbiologia. Não usar ceftriaxona em neonato com contraindicação por bilirrubina/cálcio IV. Preparo IV deve seguir bula e diluente compatível.

Transfusão. Queda relevante da Hb e comprometimento respiratório podem indicar transfusão simples; deterioração, hipoxemia intensa ou falha apesar da simples pode exigir troca. Evitar elevação excessiva da viscosidade. AOMS 2026 não fornece um gatilho universal de transfusão para toda criança; decisão deve integrar Hb basal, oxigenação e progressão.

Cálculo de 16 kg. Ceftriaxona 800 mg/dia; azitromicina 160 mgdia 1 e 80 mgdias 2–5. Se suspensão 200 mg/5 mL=40 mg/mL, volumes 4 mL e 2 mL, após conferir o produto. Alta somente após estabilidade respiratória e plano hematológico.

Limites de aplicação: Transfusão/troca exige hemoterapia e hematologia; concentração de azitromicina deve ser conciliada com o produto.

Fontes verificadas: OMS 2026 — síndrome torácica aguda · NHLBI — doença falciforme, painel de especialistas · UCSF — doses antimicrobianas pediátricas.

245. Tuberculose Pulmonar na Criança

Confirmar e notificar. Integrar exposição, sinais clínicos, crescimento, imagem e testes bacteriológicos/imunológicos conforme idade. Teste negativo não exclui TB infantil. Investigar contatos, resistência, coinfecçãoHIV e forma extrapulmonar. Coletar amostras adequadas antes do tratamento quando possível, sem atrasar caso grave.

Esquema brasileiro de referência. Para<10 anos com TB sensível no esquema tradicional: 2 meses de RHZ seguidos de 4 meses de RH. Comprimidos dispersíveis RHZ 75/50/150 mg e RH 75/50 mg: 4–7 kg 1 comprimido/dia;8–11 kg 2;12–15 kg 3;16–24 kg 4. Administrar conforme técnica de dispersão do produto, não fracionar empiricamente comprimido adulto. Abaixo de 4 kg, a tabela exige doses individuais: rifampicina 15 mg/kg/dia, isoniazida 10 mg/kg/dia e pirazinamida 35 mg/kg/dia como valores centrais, com intervalos de referência próprios.

Atualização. O Ministério da Saúde contempla curso de 4 meses para TB não grave selecionada em crianças/adolescentes elegíveis. Portanto,6 meses não é regra universal atual; confirmar critérios do programa antes de abreviar. Meningite, osteoarticular, resistência e faixas etárias/pesos fora da tabela exigem outro esquema.

Conferência. Criança 16 kg,4 RHZ/dia: rifampicina 300 mg=18,75 mg/kg; isoniazida 200 mg=12,5 mg/kg; pirazinamida 600 mg=37,5 mg/kg. A faixa de comprimidos deve ser reavaliada com ganho de peso. Não arredondar dose isolada e também aplicar tabela, o que duplicaria ajuste.

Seguimento. Adesão, peso, efeitos hepáticos, interações e evolução. Piridoxina tem indicações específicas de risco, não substitui avaliação nutricional. Vômitos persistentes, icterícia, alteração neurológica ou piora respiratória exigem revisão urgente. Orientar controle de contatos e seguimento pelo programa TB.

Limites de aplicação: Critérios completos do esquema curto e regimes resistentes/extrapulmonares devem ser conferidos no programa TB.

Fontes verificadas: Ministério da Saúde — tratamento TB na criança · Ministério da Saúde — tuberculose, orientação vigente.

246. Broncoespasmo e Anestesia em Pediatria

Prevenir e reconhecer. Avaliar controle da asma, infecção recente, exposição a fumaça e histórico anestésico; otimizar doença antes de procedimento eletivo quando possível. Durante anestesia, aumento da pressão inspiratória, expiração prolongada e capnograma obstrutivo podem indicar broncoespasmo, mas primeiro excluir tubo dobrado/obstruído, intubação seletiva, pneumotórax, aspiração e anafilaxia.

Resposta imediata. Chamar ajuda, aumentar oferta de oxigênio, ventilar manualmente para avaliar complacência e verificar circuito/tubo. Interromper estímulo e aprofundar anestesia conforme hemodinâmica. Permitir expiração longa para reduzir hiperinsuflação dinâmica; desconexão breve pode ser necessária quando aprisionamento grave causa colapso, por equipe anestésica.

Medicamentos. Salbutamol via adaptador do circuito ou nebulização conforme dispositivo; o número de jatos administrados não garante a mesma deposição de um paciente respirando por espaçador. Magnésio segue o esquema verificado do tema 223 quando refratário. Se broncoespasmo acompanha hipotensão/anafilaxia, tratar a causa imediatamente e consultar 269. Consenso SBA descreve adrenalina IV **1 mcg/kg** em broncoespasmo grave sob monitorização anestésica; é dose distinta da IM da anafilaxia e da PCR.

Diluição de segurança. Para dose IV de 1 mcg/kg, solução 10 mcg/mL permite 0,1 mL/kg;16 kg=>16 mcg=1,6 mL. Essa dose não deve ser aspirada diretamente da ampola 1 mg/mL, que exigiria 0,016 mL. O preparo de 10 mcg/mL está no 269; acesso, ECG ePA contínuos são indispensáveis.

Após estabilizar. Monitorar recorrência, oxigenação e necessidade de ventilação prolongada. Registrar provável mecanismo/agente; suspeita de anafilaxia exige investigação específica posterior. Não extubar apenas porque a ausculta melhorou se persistir fadiga, hipoxemia ou instabilidade.

Limites de aplicação: Uso IV titulado de adrenalina restrito a equipe com monitorização e experiência; apresentação no tema 269.

Fontes verificadas: Sociedade Brasileira de Anestesiologia — via aérea pediátrica · Society for Pediatric Anesthesia — Pedi Crisis 2024 · RCH — exacerbação de asma.

247. Discinesia Ciliar Primária e Heterotaxia

Suspeita clínica. Tosse úmida persistente desde cedo, congestão nasal crônica, otites, desconforto respiratório neonatal e anomalias de lateralidade justificam investigação de discinesia ciliar primária. Heterotaxia pode coexistir com cardiopatia complexa e alteração esplênica; não é sinônimo de discinesia, nem determina antibiótico único.

Diagnóstico. Encaminhar a centro com experiência para combinação de avaliação clínica, óxido nítrico nasal quando apropriado, genética e estudos ciliares. A diretrizERS/ATS 2025 ressalta integração de métodos; um teste isolado pode não resolver casos. Mapear anatomia cardíaca/abdominal e função esplênica conforme achados.

Cuidado respiratório. Fisioterapia e higiene de vias aéreas, vacinação, atividade compatível e vigilância microbiológica. Exacerbações devem receber antibiótico orientado por culturas prévias, gravidade e resistência; não adotar macrolídeo contínuo apenas porque aparece entre as classes do inventário. Tratamento crônico exige balanço entre benefícios, resistência, QT e interações. Otorrino/audiologia têm papel no acompanhamento.

Heterotaxia. Asplenia/hipoesplenismo exige estratégia própria de vacinação, profilaxia e plano de febre; conferir protocolos específicos de asplenia. Malrotação intestinal com vômito bilioso é emergência cirúrgica. Cianose, síncope ou piora de tolerância requer cardiologia, não apenas intensificação de nebulizações.

Reavaliação. Documentar exacerbações, função pulmonar, crescimento, audição e culturas. Hipoxemia, hemoptise, choque ou desidratação exigem hospital. Este tema define decisões e encaminhamento; doses antimicrobianas dependem do organismo e da situação clínica, com referência aos módulos infecciosos apropriados.

Limites de aplicação: Sem esquema único de antibiótico crônico: exige cultura, função pulmonar, QT e avaliação especializada.

Fontes verificadas: ERS/ATS 2025 — diagnóstico da discinesia ciliar · ERS — consenso assistência DCP 2026 · CHOP — heterotaxia e manifestações extracardíacas.

248. Epistaxe na Criança

Prioridade. Avaliar via aérea e circulação se sangramento volumoso, deglutição contínua de sangue, síncope ou perfusão ruim. Perguntar sobre trauma, manipulação, corpo estranho, coagulopatia e medicamentos. Epistaxe em criança muito pequena ou com outras lesões requer investigação cuidadosa.

Medida inicial. Sentar inclinada para frente, comprimir firmemente a parte macia do nariz por 10 minutos contínuos, sem soltar para conferir. Se necessário, repetir. Não inclinar a cabeça para trás, pois o sangue pode ser engolido/aspirado. Aspiração e acesso venoso são reservados à gravidade.

Persistência. Boa iluminação e controle de dor permitem localizar o foco. Cauterização dirigida ou tamponamento deve ser realizado por profissional treinado; evitar cauterização extensa/bilateral do septo. Suspeita de sangramento posterior, falha ou necessidade de tamponamento exige otorrino. Vasoconstritor tópico e anestésico local dependem de idade, concentração e condição cardiovascular; não se definiu uma dose universal sem produto e técnica.

Exames e prevenção. Hemograma/coagulação se sangramento intenso, recorrente, outros sinais hemorrágicos ou história relevante; não são necessários para todo episódio simples. Após controle, reduzir manipulação e ressecamento e tratar fator predisponente. Se usa corticoide intranasal, revisar direcionamento do jato para longe do septo.

Destino. Alta após hemostasia sustentada, estabilidade e orientação de retorno. Sangramento que não cessa após compressão correta, palidez importante, dificuldade respiratória ou recorrência frequente exige reavaliação. Antibiótico e vitaminaK não são rotineiros sem indicação independente. Hemorragia significativa não deve ser classificada como resolvida apenas porque deixou de sair sangue anteriormente.

Limites de aplicação: Cautério/tamponamento e medicamentos tópicos exigem técnica, idade e produto específicos.

Fontes verificadas: RCH — epistaxe · Glenmark Brasil — mometasona nasal.

249. Síndrome do Bebê Chiador

O título descreve um padrão, não uma etiologia. Lactente que chia pode ter bronquiolite, sibilância recorrente viral, asma precoce, aspiração, corpo estranho, malácia, cardiopatia ou doença crônica. Início abrupto unilateral, sintomas desde o nascimento, tosse com alimentação, baixo ganho de peso ou ausência de resposta exigem rever diagnóstico.

Agudização. Aplicar avaliação de gravidade respiratória. Em primeiro episódio típico de bronquiolite, seguir 226; não usar automaticamente broncodilatador/corticoide. Em episódios recorrentes com fenótipo de asma, um teste monitorizado de broncodilatador pode integrar avaliação; registrar resposta em esforço, ausculta e função, não somente impressão subjetiva.

Controle. Sintomas entre crises, despertares, exacerbações frequentes ou graves e atopia favorecem avaliação de tratamento controlador. O esquema de corticoide inalatório para pré-escolar e a técnica estão no 222. Não somar corticoide oral a cada coriza; decidir pela gravidade e diagnóstico. Antibiótico, antirrefluxo e mucolítico não são tratamentos do rótulo 'bebê chiador'.

Ambiente e revisão. Reduzir tabagismo passivo, conferir espaçador/máscara, verificar vacinação e revisar exposição. A técnica deve ser demonstrada pelo cuidador; doses no reservatório não garantem entrega pulmonar quando há vedação inadequada ou choro intenso.

Seguimento/destino. Registrar frequência de episódios e necessidade de urgência, oxigênio ou corticoide; acompanhar crescimento e resposta ao teste terapêutico. Encaminhar se diagnóstico duvidoso ou controle insuficiente. Apneia, cianose, exaustão, baixa ingestão ou piora apesar do resgate requer hospital. Esse plano evita transformar todas as classes enumeradas em uma prescrição simultânea.

Fontes verificadas: RCH — asma em pré-escolares · CPS — bronquiolite · ATS — doença respiratória pós-prematuridade.

250. Artrite Idiopática Juvenil

Definir o fenótipo. Artrite persistente com início antes dos 16 anos exige excluir infecção, neoplasia e outras causas. Oligoartrite, poliartrite, entesite e doença sistêmica seguem caminhos distintos. Febre, citopenias, ferritina crescente, disfunção hepática ou coagulopatia sugerem síndrome de ativação macrofágica e exigem internação. Rastrear uveíte com lâmpada de fenda mesmo sem queixa ocular.

Terapia. AINE pode aliviar sintomas, mas doença persistente requer controle modificador. No PCDT brasileiro de 2026, metotrexato 10–15 mg/m² **uma vez por semana**, VO ou SC, é opção convencional para artrite periférica; não é dose diária. Formulações: comprimidos 2,5 mg e injetável 25 mg/mL. Associar ácido fólico 1 mg/dia em seis dias da semana, omitindo o dia do metotrexato. A dose máxima e escalonamento precisam respeitar o fenótipo e o protocolo prescrito; não converter automaticamente uma dose por SC em dose por kg.

Escalonamento. Para indicação elegível após avaliação, etanercepte a partir de 2 anos: 0,8 mg/kg SC semanal, máximo 50 mg. Na forma sistêmica, bloqueio de IL-1/IL-6 tem papel preferencial conforme atividade; não somar biológicos. Infiltração articular pode ser apropriada na doença localizada.

Segurança e cálculo. Antes de imunossupressão, revisar vacinas, tuberculose e infecções; monitorar hemograma, transaminases e função renal. Fisioterapia e adaptações escolares integram o tratamento. SC 0,8 m² ×15=12 mg de metotrexato/semana; a 25 mg/mL, 0,48 mL; reverso 0,48×25/0,8=15 mg/m². Acompanhamento é longitudinal, com metas de atividade e função.

Fontes verificadas: Ministério da Saúde — PCDT AIJ 2026 · ACR — AIJ 2021, tratamentos · ACR — monitorização na AIJ

251. Asplenia em Pediatria

Plano preventivo. Asplenia anatômica ou funcional aumenta o risco de sepse rapidamente progressiva. Registrar condição em identificação médica e orientar atendimento imediato por febre ou deterioração, inclusive após mordeduras. Organizar calendário especial contra pneumococo, meningococo, Hib e influenza conforme programa nacional e histórico vacinal. Vacinação e antibiótico preventivo não eliminam o risco.

Profilaxia antimicrobiana. A CPS recomenda amoxicilina VO 10 mg/kg/dose de 12/12 h do nascimento até 5 anos; acima de 5 anos, 250 mg de 12/12 h. Manter ao menos até 5 anos e por pelo menos dois anos após esplenectomia, considerando prolongamento conforme risco. Alergia imediata exige revisão especializada da alternativa, pois proteção e resistência diferem entre antibióticos.

Doença febril. Colher hemocultura sem atrasar tratamento. Na suspeita de sepse, ceftriaxona 100 mg/kg/dose IV, máximo 2 g na dose inicial, seguida de transferência/avaliação hospitalar imediata. A presença de resistência pneumocócica e gravidade orienta adicionar vancomicina. Recém-nascido, hiperbilirrubinemia ou uso de cálcio IV exigem alternativa à ceftriaxona. O regime subsequente depende do foco e das culturas.

Conferência operacional. Exemplo preventivo, criança de 16 kg: amoxicilina 160 mg por dose, 320 mg/dia. Se a suspensão efetivamente dispensada for 250 mg/5 mL, são 3,2 mL/dose; reverso 3,2×50/16=10 mg/kg/dose. Este volume não serve para suspensão de 400 mg/5 mL. Plano escrito deve separar claramente profilaxia cotidiana e atendimento de urgência.

Fontes verificadas: CPS — asplenia, reafirmado 2024

252. CINCA/NOMID

Fenótipo e urgência. CINCA/NOMID é a forma grave do espectro CAPS, associada à via NLRP3/IL-1. Urticária inflamatória desde cedo, meningite asséptica crônica, alterações auditivas/oculares e artropatia devem motivar investigação especializada. Confirmar atividade sistêmica, audição, visão, desenvolvimento, função renal e risco de amiloidose; teste genético negativo não encerra investigação de mosaicismo.

Tratamento dirigido. A bula FDA de anakinra para NOMID inicia 1–2 mg/kg SC uma vez ao dia e permite ajuste até 8 mg/kg/dia para controle da inflamação. Não aplicar teto adulto de artrite reumatoide a toda criança com NOMID. A duração é contínua, guiada por atividade e prevenção de dano; AINE ou corticoide isolados não substituem bloqueio eficaz da IL-1. Mudanças para outro inibidor requerem especialista.

Produto e segurança. Kineret contém 100 mg/0,67 mL em seringa graduada, com doses mensuráveis a partir de 20 mg. Dose abaixo desse limite exige solução farmacêutica validada; não estimar frações por gotas. Depuração de creatinina <30 mL/min exige considerar administração em dias alternados. Rastrear infecção e neutropenia; hemograma antes, mensal nos três primeiros meses e trimestral no primeiro ano. Evitar vacina viva e associação a bloqueador de TNF.

Cálculo. Para 20 kg e 2 mg/kg/dia: 40 mg/dia. Volume matemático=40×0,67/100=0,268 mL; utilizar a marca de 40 mg da seringa, não arredondar livremente uma medida microscópica. Fonte regulatória estrangeira não confirma acesso ou registro brasileiro.

Limitação delimitada: Disponibilidade brasileira e método para doses inferiores a 20 mg dependem do produto e serviço.

Fontes verificadas: FDA/DailyMed — Kineret, NOMID

253. Costocondrite em Pediatria

Avaliação. Dor reprodutível à palpação de junção costocondral, agravada por movimento ou inspiração, em criança com bom estado geral favorece causa musculoesquelética. Isso não dispensa avaliar dispneia, síncope, relação com esforço, febre, trauma, cardiopatia, história familiar de morte súbita e sinais de doença pulmonar. Alterações nesses elementos direcionam ECG, radiografia ou investigação adicional; exames extensos não são automáticos no quadro típico.

Manejo. Explicar o diagnóstico, reduzir temporariamente a atividade dolorosa, usar calor ou frio conforme alívio e planejar retorno gradual. Tosse persistente, sobrecarga esportiva e postura podem perpetuar a dor e

merecem abordagem. Costocondrite não é indicação habitual de antibiótico, corticoide sistêmico ou opioide.

Analgesia. Em criança maior de 6 meses, hidratada e sem contraindicação, uma opção é ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 400 mg/dose, por poucos dias. Reavaliar necessidade em vez de manter indefinidamente. Evitar na doença renal, sangramento digestivo, desidratação ou reação prévia; não associar outro AINE. Paracetamol é alternativa quando AINE não é apropriado, seguindo o esquema ponderal do tema 192.

Retorno. Alta depende de estabilidade, baixa suspeita de causa grave e entendimento do plano. Dor que passa a ocorrer no esforço, síncope, falta de ar, febre ou piora exige reavaliação. Persistência localizada, edema importante ou evolução atípica pode exigir investigação de outras condições da parede torácica.

Fontes verificadas: RCH — dor torácica · RCH — analgesia

254. CRMO

Confirmar osteíte não bacteriana. CRMO é um fenótipo recorrente/multifocal de osteomielite crônica não bacteriana. Excluir infecção, tumor e histiocitose; hemograma, PCR/VHS e ressonância, frequentemente de corpo inteiro, ajudam a mapear lesões. Biópsia é considerada quando a distribuição ou evolução não é típica. Lesão vertebral requer atenção ao risco de colapso e dano estrutural.

Primeira etapa. AINE em curso anti-inflamatório é uma estratégia inicial. O plano CARRA utiliza naproxeno 10–20 mg/kg/dia VO dividido de 12/12 h, máximo 1.000 mg/dia. A resposta é reavaliada por dor, função, atividade clínica e imagem; analgesia isolada não prova resolução da inflamação. Ajustar carga, manter fisioterapia e evitar imobilização prolongada desnecessária.

Doença refratária ou vertebral. O consenso organiza alternativas: metotrexato/sulfassalazina, bloqueador de TNF ou bisfosfonato. A escolha depende da distribuição, manifestações associadas e risco ósseo; não é uma associação obrigatória. Pamidronato é opção hospitalar, com cálcio, fósforo, vitamina D e função renal revistos; o preparo e intervalo pertencem ao protocolo de infusão escolhido. Antibiótico prolongado não é tratamento de osteíte estéril confirmada.

Cálculo e vigilância. Para 20 kg usando 10 mg/kg/dia, total 200 mg/dia=100 mg de 12/12 h; reverso 100×2/20=10 mg/kg/dia. Confirmar apresentação capaz de fornecer 100 mg, sem assumir que um comprimido grande possa ser fracionado. Evitar AINE na lesão renal e monitorar sintomas digestivos.

Limitação delimitada: Bisfosfonato exige protocolo de infusão e avaliação mineral específicos.

Fontes verificadas: CARRA — planos consensuais para CNO/CRMO · GKJR — consenso CNO 2026

255. Deficiência de Adenosina Deaminase 2

Suspeitar cedo. DADA2 pode causar vasculite semelhante à poliarterite nodosa, livedo, AVC recorrente, citopenias e imunodeficiência. Investigar atividade enzimática de ADA2 e variantes bialélicas, além de hemograma, imunoglobulinas, inflamação e órgãos acometidos. Considerar avaliação de familiares. Déficit neurológico agudo exige protocolo de AVC e avaliação especializada imediata.

Tratamento por manifestação. O consenso internacional recomenda bloqueio de TNF no fenótipo inflamatório/vasculítico e para prevenir recorrência vascular. Em série primária que incluiu crianças, etanercepte foi administrado em 0,8–1,2 mg/kg SC semanal, máximo 50 mg/semana. Um ponto inicial de 0,8 mg/kg/semana segue a extremidade inferior estudada; resposta e ajuste pertencem ao serviço de referência. É uso por indicação específica, frequentemente off-label conforme país/produto.

O que não é equivalente. Citopenia grave, falência medular ou imunodeficiência importante podem exigir transplante de células hematopoéticas; anti-TNF isolado não resolve todos os fenótipos. Antiagregação e anticoagulação podem aumentar preocupação com hemorragia intracraniana e não devem ser assumidas como prevenção habitual de AVC nessa doença.

Segurança e matemática. Antes do biológico, rastrear tuberculose/hepatites e revisar vacinação; monitorar infecção e hemograma. Para 20 kg ×0,8=16 mg/semana; para 80 kg, o cálculo 64 mg deve ser limitado a 50 mg. O volume depende da apresentação efetivamente fornecida. Tratamento é prolongado, com seguimento vascular, neurológico, imunológico e hematológico.

Fontes verificadas: Consenso internacional DADA2 2023 · NEJM — prevenção de AVC em DADA2

256. Dermatomiosite Juvenil (DMJ)

Reconhecer gravidade. Fraqueza proximal, sinal de Gowers, heliotropo e pápulas de Gottron sugerem DMJ. Disfagia, voz alterada, fraqueza respiratória, dor abdominal intensa, ulceração ou doença pulmonar exigem avaliação urgente. Documentar força/função, enzimas musculares, hemograma, função hepática, urina e atividade cutânea; ressonância e outros exames esclarecem apresentações duvidosas. CK normal não exclui atividade.

Indução da forma típica moderada. O plano CARRA usa prednisona 2 mg/kg/dia VO, máximo 60 mg/dia, nas primeiras quatro semanas, associada a metotrexato semanal. O esquema do consenso utiliza o menor valor entre 15 mg/m²/semana e 1 mg/kg/semana, máximo 40 mg/semana, preferencialmente SC. Não misturar automaticamente essa regra com a faixa de 15–20 mg/m² de outro consenso. Redução do corticoide depende de melhora objetiva; retirada abrupta após uso prolongado é inadequada.

Alternativas e suporte. Doença grave pode exigir pulsoterapia e/ou imunoglobulina, com escolha conforme órgão e velocidade de evolução. Doença refratária pode requerer outro imunossupressor. Fotoproteção, fisioterapia progressiva, prevenção de contraturas e atenção nutricional/óssea são essenciais. Folato acompanha metotrexato conforme o tema 250.

Checagem. Para 20 kg e SC 0,8 m²: prednisona inicial 40 mg/dia; metotrexato=min(12,20,40)=12 mg/semana. Monitorar hemograma, transaminases e infecção. Reavaliar deglutição, força, pele e calcinoses; não usar exclusivamente normalização laboratorial para declarar remissão.

Fontes verificadas: CARRA — planos iniciais de DMJ moderada · SHARE — recomendações de DMJ

257. Doença de Behçet em Pediatria

Estratificar por órgão. Aftas recorrentes isoladas não confirmam Behçet. Investigar úlceras genitais, uveíte, pele, artrite, comprometimento vascular, intestinal e neurológico; considerar doenças monogênicas em início muito precoce. Baixa visual, cefaleia intensa diferente do habitual, déficit focal, hemoptise ou suspeita de aneurisma exigem avaliação urgente.

Forma mucocutânea/articular. Cuidado local, higiene oral e tratamento tópico das úlceras acompanham a terapia sistêmica. A atualização EULAR publicada em 2026 mantém colchicina como primeira linha para recorrência mucocutânea e articular. Em coorte pediátrica primária foi usada faixa de 0,5–2 mg/dia VO; essa é uma faixa observacional total diária, **não uma dose universal para toda idade/peso**. Para criança maior/adolescente elegível, o especialista pode iniciar no limite inferior de 0,5 mg/dia e titular conforme resposta, tolerância, função renal/hepática e produto. Não extrapolar 2 mg/dia para crianças pequenas.

Órgão ameaçado. Uveíte posterior/vasculite retiniana demanda imunossupressão sistêmica com oftalmologia; corticoide isolado não é estratégia de manutenção adequada. Anti-TNF, azatioprina e outras opções são selecionados pelo órgão. Anticoagulação em trombose requer avaliar inflamação e aneurisma arterial, especialmente pulmonar.

Monitorização. Colchicina pode causar diarreia, citopenia e neuromiopatia. Rever inibidores de CYP3A4/P-gp e evitar combinações perigosas, particularmente com insuficiência renal/hepática. Monitorar hemograma e funções renal/hepática. O tratamento é longitudinal; ausência de afta no dia da consulta não comprova controle dos demais órgãos.

Limitação delimitada: Faixa de colchicina observacional não fornece titulação universal por idade; doença ocular/vascular exige esquema específico.

Fontes verificadas: EULAR — Behçet, atualização publicada em 2026 · Coorte pediátrica primária de Behçet · PRINTO/PReS — Behçet

258. Doença Mista do Tecido Conjuntivo em Pediatria

Fenótipo de sobreposição. Doença mista do tecido conjuntivo combina características de lúpus, esclerose sistêmica, miosite e artrite, em associação a anti-U1-RNP. Esse anticorpo sozinho não define atividade nem tratamento. Documentar Raynaud, edema de mãos, fraqueza, artrite, pele e refluxo. Rastrear doença pulmonar intersticial e hipertensão pulmonar conforme avaliação especializada; dispneia, síncope ou dessaturação mudam a urgência.

Terapia guiada pelo órgão. Para manifestações cutâneo-articulares, hidroxicloroquina é frequentemente utilizada; coorte pediátrica recente confirma esse padrão de prática, sem estabelecer um regime universal. Como extrapolação explícita da segurança em doenças autoimunes, usar até 5 mg/kg/dia VO pelo peso real, usualmente sem ultrapassar 400 mg/dia. Não extrapolar essa monoterapia para miosite grave, nefrite ou doença pulmonar progressiva. Esses fenótipos exigem corticoide/imunossupressor selecionado e acompanhamento especializado.

Cuidados associados. Fotoproteção, exercício/fisioterapia adaptados, saúde óssea e medidas para Raynaud (tema 259). Corticoide deve ser limitado à necessidade, com redução planejada quando houver controle. Não combinar todos os fármacos de lúpus, miosite e esclerose sistêmica simplesmente pelo rótulo de sobreposição.

Conferência. Em 30 kg, o limite ponderal de hidroxicloroquina é 150 mg/dia; um comprimido inteiro de 400 mg ultrapassaria esse limite. A obtenção da dose requer apresentação/fracionamento ou manipulação validada. Realizar avaliação ocular e considerar função renal, interações e risco de QT. Evolução clínica e medidas de função de órgãos orientam a duração.

Limitação delimitada: Dose de hidroxicloroquina é extrapolação de segurança; não existe regime único validado para todos os órgãos na DMTC.

Fontes verificadas: Coorte pediátrica DMTC, publicação 2026 · SBR — uso seguro de hidroxicloroquina

259. Fenômeno de Raynaud em Pediatria

Primário ou secundário. Mudança episódica de cor dos dedos precipitada por frio/estresse pode representar Raynaud. Dor persistente, assimetria marcada, úlcera, necrose, alterações sistêmicas ou capilaroscopia anormal sugerem doença secundária. Investigar autoanticorpos e doença do tecido conjuntivo conforme exame. Isquemia fixa ou progressiva requer atendimento urgente, não apenas retorno ambulatorial.

Medidas iniciais. Aquecer o corpo e as mãos, evitar mudanças bruscas de temperatura, tabaco/nicotina e fatores vasoconstritores. Rever estimulantes, descongestionantes e outros fármacos que possam agravar crises. Orientar proteção cutânea e manejo de estresse, sem desvalorizar os sintomas.

Quando medicar. Crises frequentes, dolorosas ou que limitam a função podem justificar bloqueador de canal de cálcio. Nifedipino de liberação prolongada é uma opção extrapolada da experiência adulta; não há um regime ponderal pediátrico universal estabelecido nas fontes verificadas. A bula espanhola de OROS 30 mg descreve uso adulto em Raynaud, mas isso não valida 30 mg para qualquer criança. A formulação prolongada deve permanecer íntegra; não triturar para fabricar uma dose pediátrica. Evitar uso sublingual como estratégia doméstica de resgate.

Monitorização e escalonamento. Controlar pressão, tontura, cefaleia e edema; hipotensão limita titulação. Doença secundária com úlcera/isquemia pode exigir vasodilatador específico, como inibidor de PDE5 ou prostanoide, em serviço especializado. A ausência de dose universal é uma limitação da evidência pediátrica, e o tratamento deve ser construído para o peso, pressão e gravidade encontrados.

Limitação delimitada: Não foi estabelecido regime ponderal universal para Raynaud pediátrico; bula adulta não autoriza dose fixa para qualquer criança.

Fontes verificadas: NIAMS — Raynaud · AEMPS — nifedipino OROS, ficha técnica · AEP — nifedipino pediátrico

260. Lúpus Eritematoso Sistêmico Pediátrico

Avaliar atividade e dano. Lúpus pediátrico pode comprometer rins, sangue, pele, articulações e sistema nervoso. Pressão, hemograma, creatinina, urina/proteinúria, complemento e anti-DNA ajudam na avaliação; resultados isolados não substituem exame. Nefrite, alteração neurológica aguda, hemorragia pulmonar, hemólise grave ou suspeita de infecção exigem atendimento especializado urgente.

Tratamento de base. Hidroxicloroquina costuma integrar o tratamento, salvo contraindicação: dose alvo até 5 mg/kg/dia VO pelo peso real, usualmente máximo 400 mg/dia. O PCDT brasileiro e a diretriz BSR 2026 sustentam esse limite de segurança. O esquema deve ser construído com apresentação que permita a dose; não arredondar sistematicamente para cima. A BSR recomenda redução de 50% com filtração <30 mL/min/1,73 m².

Órgão e intensidade. Corticoide pode ser necessário para controle rápido, buscando menor exposição e redução planejada. Nefrite proliferativa ou outra doença ameaçadora exige indução específica, frequentemente com micofenolato ou ciclofosfamida e terapia associada. A escolha depende de biópsia, órgão, gravidade, fertilidade e risco infeccioso; não é intercambiável com o esquema de doença cutâneo-articular. Biológicos podem integrar tratamento selecionado.

Monitorização. Fotoproteção, exercício, vacinas, saúde óssea, adesão e transição para cuidado adulto. Avaliação oftalmológica de base; rastreio retinal periódico, antecipado em maior risco. Rever QT e função renal. Para 20 kg, limite de hidroxicloroquina=100 mg/dia; 400 mg/dia corresponderia a 20 mg/kg/dia e excederia quatro vezes o limite ponderal. Atividade persistente precisa de ajuste, não simples aumento indiscriminado de antimalárico.

Limitação delimitada: Indução de nefrite ou doença ameaçadora é definida pelo fenótipo/biópsia e não pelo diagnóstico genérico.

Fontes verificadas: Ministério da Saúde — PCDT lúpus · BSR — lúpus, diretriz 2026

261. Poliarterite Nodosa em Pediatria

Gravidade e confirmação. Poliarterite nodosa compromete artérias de médio calibre. Dor abdominal/isquemia, neuropatia, hipertensão, lesões cutâneas profundas e comprometimento renal vascular precisam de avaliação dirigida. Angiografia por método apropriado e/ou biópsia de tecido acometido podem confirmar. Investigar hepatites e diagnósticos alternativos; início precoce, AVC e citopenias devem levantar DADA2 (tema 255).

Doença grave. A diretriz ACR/VF recomenda indução com glicocorticoide e ciclofosfamida, em vez de corticoide isolado. Para pulsoterapia pediátrica, metilprednisolona 30 mg/kg/dia IV, máximo 1 g/dia, por 3–5 dias é uma referência. Corticoide oral em alta dose: prednisona 1–2 mg/kg/dia, máximo 60 mg/dia, com redução planejada após controle. Não administrar a infusão rápida como bolus sem protocolo; monitorar pressão, glicemia, eletrólitos e ritmo conforme risco.

Depois da indução. A ciclofosfamida requer plano de dose por SC, modalidade de administração, proteção urológica, hidratação e vigilância hematológica/renal definidos pelo serviço; não se converte em dose única universal para PAN pediátrica. Após remissão, migrar para manutenção menos tóxica quando apropriado. AINE, antiemético e diurético são adjuvantes apenas se houver indicação própria.

Cálculo e destino. Em 20 kg, metilprednisolona=600 mg por dia de pulso; em 40 kg, 1.200 mg calculados devem ser limitados a 1.000 mg. Indução de doença grave é hospitalar. Seguimento acompanha órgãos, pressão, efeitos cumulativos de corticoide e infecção; registrar prevenção reprodutiva quando pertinente.

Limitação delimitada: Dose/preparo de ciclofosfamida são vinculados ao protocolo de indução e à superfície corporal.

Fontes verificadas: ACR/VF — PAN, diretriz 2021

262. Síndrome de Amplificação Dolorosa

Diagnóstico positivo com vigilância. Amplificação dolorosa pode ser localizada, difusa ou associada a alterações autonômicas. Dor intensa e incapacidade são reais mesmo sem inflamação estrutural proporcional. Examinar cuidadosamente e investigar sinais que indiquem infecção, artrite, tumor, doença neurológica ou trauma. Exames repetidos sem nova hipótese podem prolongar afastamento e medo.

Tratamento principal. Programa interdisciplinar com exercício aeróbico progressivo, fisioterapia funcional, dessensibilização quando há alodinia e intervenção psicológica, frequentemente cognitivo-comportamental. A meta inicial é recuperar função, sono, escola e participação; melhora da dor pode acompanhar depois. Definir metas graduais e mensuráveis com criança e família, sem comunicar que a criança está inventando sintomas.

Papel de medicamentos. Tricíclicos, relaxantes musculares e analgésicos listados no inventário não constituem associação padrão. Não há esquema farmacológico universal comprovado para corrigir a amplificação. Opioides e escalada contínua de sedativos podem prejudicar reabilitação. Comorbidades como depressão, ansiedade ou enxaqueca recebem tratamento próprio quando diagnosticadas; isso não torna antidepressivo obrigatório para toda dor funcional.

Plano de acompanhamento. Organizar rotina de sono, frequência escolar, plano de atividade e participação familiar. Medir distância/capacidade funcional, tolerância à atividade e impacto emocional, além da escala de dor. Incapacidade importante ou falha ambulatorial pode demandar programa intensivo. Reavaliar se surgirem febre, perda ponderal, déficit neurológico, articulação objetivamente inflamada ou nova mudança do padrão; diagnóstico funcional prévio não impede outra doença.

Fontes verificadas: CHOP — síndrome de amplificação dolorosa

263. Síndrome de Sjögren em Pediatria

Reconhecer apresentação infantil. Em crianças, parotidite recorrente e manifestações sistêmicas podem ser mais evidentes que a secura clássica. Excluir infecção, obstrução, imunodeficiência e outras doenças autoimunes. Avaliar olhos, boca, glândulas salivares, hemograma, urina/função renal e autoanticorpos conforme contexto; critérios adultos de classificação não substituem o julgamento pediátrico.

Controle local. Lubrificantes oculares sem conservante são opção para secura, com frequência titulada aos sintomas e orientação oftalmológica. Produtos variam; gotas não são calculadas por kg. Dor ocular, fotofobia ou perda visual requerem avaliação rápida. Hidratação oral fracionada, medidas de estímulo salivar quando seguras, prevenção de cáries e acompanhamento odontológico com flúor são essenciais. Evitar carga anticolinérgica desnecessária.

Tratamento sistêmico. Artrite, fadiga incapacitante ou manifestações sistêmicas podem justificar ensaio de hidroxicloroquina conforme equipe. Como referência de segurança extrapolada, limite de 5 mg/kg/dia VO pelo peso real, usualmente máximo 400 mg/dia; essa dose não estabelece eficácia para toda parotidite infantil. O monitoramento ocular e renal segue o tema 260. Doença de órgão requer terapia específica, e não simplesmente doses crescentes de lubrificante ou antimalárico.

Seguimento. Monitorar crescimento, função glandular, dentes, rins, pulmões e manifestações neurológicas quando presentes. Aumento glandular persistente/assimétrico, linfonodos ou sintomas constitucionais exigem investigação. Reavaliar resposta ao ensaio terapêutico em prazo definido; evitar perpetuar imunossupressão sem objetivo mensurável ou indicação documentada.

Limitação delimitada: Evidência terapêutica pediátrica limitada; limite de hidroxicloroquina é extrapolação de segurança.

Fontes verificadas: BSR — Sjögren, diretriz · SBR — segurança de hidroxicloroquina

264. Síndrome SAPHO

Reconhecer o espectro. SAPHO reúne sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteíte, mas todas as características não precisam coexistir. Em pediatria há sobreposição com osteíte crônica não bacteriana. Confirmar que lesão óssea não represente infecção, tumor ou outra doença, e documentar pele, articulações e distribuição das lesões por imagem apropriada.

Tratar domínios separadamente. A componente óssea/articular segue princípios do tema 254: AINE inicialmente, com avaliação de resposta e escalonamento para imunomodulador, anti-TNF ou bisfosfonato conforme gravidade, coluna e refratariedade. O esquema ponderal de naproxeno e suas cautelas estão naquele tema; não duplicar AINE. Coorte pediátrica multicêntrica recente mostra heterogeneidade do fenótipo cutâneo e não estabelece uma receita única para toda SAPHO.

Pele. Acne grave e pustulose precisam de dermatologia. Tetraciclinas ou isotretinoína podem tratar indicações dermatológicas específicas, mas não se deve concluir que toda osteíte seja bacteriana. Retinoide sistêmico exige critérios por idade, gravidade, exames e prevenção rigorosa de gravidez quando pertinente. Tratamento dermatológico e tratamento da osteíte devem ser coordenados, inclusive porque efeitos musculoesqueléticos podem confundir a avaliação.

Reavaliação. Medir função, dor, atividade cutânea e inflamação; ressonância ajuda quando há doença axial ou discordância entre sintomas e exame. Fisioterapia e retorno gradual às atividades acompanham o controle inflamatório. Não iniciar simultaneamente todas as classes do índice. Lesão vertebral, dor incapacitante ou sinais sistêmicos atípicos requerem serviço especializado e revisão diagnóstica.

Limitação delimitada: Regimes dermatológicos dependem da manifestação; não existe receita única validada para SAPHO pediátrica.

Fontes verificadas: Estudo multicêntrico pediátrico SAPHO 2025 · CARRA — CNO, referência cruzada do tema 254

265. Vasculite por IgA (Púrpura de Henoch-Schönlein)

Avaliar além da pele. Púrpura palpável predominante em membros inferiores, artralgia e dor abdominal sugerem vasculite por IgA. Medir pressão e realizar urina mesmo sem queixa renal. Dor abdominal intensa, sangramento, vômitos persistentes, escroto doloroso ou redução de diurese exigem investigação urgente; considerar invaginação intestinal. Hemograma e função renal são necessários conforme apresentação e dúvida diagnóstica.

Tratamento. Quadros leves permitem suporte, hidratação adequada e analgesia. AINE pode ajudar artralgia se não houver comprometimento renal ou sangramento digestivo. Para dor abdominal/articular moderada a grave, RCH admite prednisolona 1–2 mg/kg/dia VO, máximo 60 mg/dia, por tempo guiado pelos sintomas, seguida de redução conforme duração/curso. Corticoide pode aliviar sintomas, mas não deve ser prescrito como prevenção comprovada de nefrite.

Rim. Proteinúria persistente, hipertensão, deterioração de filtração ou síndrome nefrítica/nefrótica exigem nefrologia. IECA/BRA pode ser usado para proteinúria selecionada, com monitorização de creatinina e potássio; não é automático para toda púrpura. Nefrite grave tem protocolo próprio e pode exigir biópsia.

Seguimento e cálculo. Mesmo após melhora cutânea, acompanhar pressão e urina seriadas, com vigilância de até 12 meses conforme evolução. Explicar retorno por urina escura, edema, dor crescente ou sangue nas fezes. Exemplo de 16 kg a 1 mg/kg/dia: 16 mg de prednisolona por dia; a 2 mg/kg/dia, 32 mg, abaixo do teto de 60 mg. Não confundir mg/kg/dia com mg/kg a cada administração.

Fontes verificadas: RCH — vasculite por IgA

266. Acidentes com Animais

Triagem por exposição. Mordedura, picada de inseto e acidente por animal peçonhento exigem caminhos distintos. Identificar horário, local, espécie por relato/foto segura e progressão; não capturar animal colocando outras pessoas em risco. Choque, dificuldade respiratória, ptose, fraqueza, sangramento sistêmico ou dor progressiva intensa exigem emergência e avaliação de soro específico.

ABCDE e cuidado local. Proteger via aérea/circulação, lavar feridas e retirar objetos constritivos. Não fazer torniquete, incisão, sucção, choque elétrico ou aplicar substâncias caseiras. Nas mordeduras, explorar lesões de tendão, articulação, nervo e osso; irrigação/desbridamento são parte essencial do tratamento.

Profilaxias. Rever tétano e risco de raiva conforme espécie, localização, profundidade, possibilidade de observação e epidemiologia. Vacina e imunoglobulina/soro antirrábico são decisões próprias do protocoloMS; não atrasar avaliação aguardando sinais de raiva. Acidente peçonhento requer classificação clínica para número de frascos de antiveneno, geralmente definido pela gravidade e não simplesmente mg/kg.

Antibiótico em mordedura selecionada. Profilaxia RCH: amoxicilina/clavulanato VO **22,5 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 875 mg/dose,5 dias** em ferida de alto risco. Ferida infectada exige duração maior e eventual IV. Em 16 kg: 360 mg de amoxicilina/dose; se formulação 400/57 mg por 5 mL,4,5 mL fornece 360 mg/51,3 mg. Confirmar marca/concentração; o regime não é o de sinusite.

Destino. Internar se repercussão sistêmica, necessidade de antiveneno ou lesão profunda/infecção grave. Anafilaxia por picada ou soro segue 269. Documentar evolução seriada e orientações de retorno, além das notificações pertinentes.

Limites de aplicação: Antivenenos e profilaxia antirrábica exigem espécie/classificação e protocolo específico; não há dose genérica única.

Fontes verificadas: RCH — mordeduras · Ministério da Saúde — profilaxia antirrábica · Ministério da Saúde — animais peçonhentos.

267. Acidose Metabólica em Pediatria

Ler o distúrbio. Acidose metabólica é consequência: verificar pH, HCO_3, Pa CO_2, lactato, Na, Cl, K, glicemia, cetonas e função renal. Calcular ânion gap=$Na-(Cl+HCO_3)$, interpretando albumina e referência laboratorial. A compensação esperada aproximada de Winter é Pa $CO_2=1,5\times HCO_3+8\pm2$; desvio sugere distúrbio respiratório associado.

ABCDE e causa. Choque exige restauração de perfusão e tratamento etiológico; cetoacidose requer protocolo próprio com líquidos/insulina e potássio. Perdas intestinais/renais, tóxicos, erro inato e insuficiência renal pedem investigação distinta. No lactente com encefalopatia, vômitos ou descompensação inexplicada, colher amônia/lactato e acionar metabolismo, sem prolongar jejum desnecessariamente.

Bicarbonato. Não é uma resposta automática a pH baixo: gera CO_2 e depende de ventilação adequada. Em cetoacidose, não usar rotineiramente; indicações excepcionais exigem especialista. Hipercalemia ameaçadora e intoxicação por bloqueador de sódio/salicilato têm objetivos próprios nos 273/279/284. Reposição em perda verdadeira de bicarbonato exige cálculo de déficit e correção gradual, sem tratar um número isolado.

Exemplo interpretativo. Na 140, Cl 110, $HCO_3$12=>gap 18 mmol/L. Winter: 26±2 mmHg; Pa $CO_2$40 mmHg sugere hipoventilação associada. Essas contas não quantificam, por si, a dose de bicarbonato. No preparado 8,4%,1 mL contém 1 mmol; diluição e via estão descritas no 284 para sua indicação específica.

Reavaliação/destino. Tendência de perfusão, consciência, diurese, lactato e eletrólitos. Acidose com choque, suspeita de tóxico, hiperamonemia ou falência respiratória requer UTI. Evitar normalização rápida às custas de hipernatremia, hipocalcemia ionizada ou sobrecarga.

Fontes verificadas: RCH — doenças metabólicas · RCH — cetoacidose diabética · RCH — monografia injetável bicarbonato.

268. Alcalose Metabólica em Pediatria

Reconhecimento. Alcalemia com bicarbonato elevado sugere alcalose metabólica; analisarPa CO_2 para identificar distúrbio misto. Vômitos, aspiração gástrica, diuréticos, hipovolemia, deficiência de cloro/potássio e causas mineralocorticoides são possibilidades. Alcalose intensa pode favorecer arritmia e hipoventilação.

Avaliação. Examinar volemia, PA, perdas e medicações; obterNa, K, Cl, Mg, creatinina, gasometria e ECG conforme gravidade. Cloro urinário pode ajudar a separar perdas/remotas e causas resistentes à reposição, mas diurético recente altera interpretação. Em lactente com vômitos progressivos não biliosos, investigar estenose pilórica.

Tratamento. Quando hipovolêmica e responsiva a cloro, corrigir volume com solução apropriada contendo cloreto e reporK conforme tema 275 após verificar função renal/diurese. Suspender causa evitável, ajustar diurético e repor perdas medidas. Não prescrever NaCl ouKCl em grande volume para toda alcalose, especialmente se congestão/cardiopatia.

Piloro. Reanimação hídrica/eletrolítica precede cirurgia; esperar correção do bicarbonato reduz risco de hipoventilação/apneia pós-operatória. A urgência cirúrgica não justifica operar uma criança ainda metabolicamente descompensada. A fonte RCH orienta acrescentarKsomente com diurese adequada.

Cálculo e monitorização. Se for escolhidoKCl 40 mmol/L, cada 100 mL contém 4 mmol; o limite de velocidade é independente da concentração e está no 275. Reavaliar eletrólitos e balanço em intervalos definidos pela gravidade. Acetazolamida, ácido IV ou diálise não são medidas rotineiras e exigem especialista/cenário específico. Encaminhar à UTI se arritmia, alteração neurológica, insuficiência respiratória ou correção complexa.

Limites de aplicação: Terapias de alcalose resistente/hipervolêmica dependem da causa; sem esquema genérico de acetazolamida ou ácido IV.

Fontes verificadas: RCH — estenose hipertrófica do piloro · RCH — hipocalemia · RCH — fluidos intravenosos.

269. Alergia e Anafilaxia na Criança

Reconhecer e agir. Anafilaxia pode ocorrer sem urticária. Comprometimento súbito respiratório/circulatório após provável exposição exige adrenalina; não esperar exames. Deitar com pernas elevadas se tolerado; não permitir levantar/caminhar. Acionar ajuda, oxigênio, monitorização e acesso IV/IO. Em choque, cristaloide isotônico com reavaliação; broncoespasmo pode precisar de resgate adicional.

Primeira linha. Adrenalina **0,01 mg/kg IM na face lateral da coxa, máximo 0,5 mg/dose**, repetir a cada 5 min se persistência. Ampola 1 mg/mL: 0,01 mL/kg, máximo 0,5 mL. Em 16 kg: 0,16 mg=0,16 mL. Anti-histamínico/corticoide não substituem adrenalina nem corrigem choque/obstrução; não atrasar tratamento para administrá-los.

Refratariedade e bomba. Persistência após doses IM adequadas e reposição exige equipe experiente e infusão IV titulada. Preparo hospitalar ASCIA: adrenalina 1 mg em **volume final 100 mL de SF 0,9%=10 mcg/mL**; retirar volume equivalente antes de adicionar 1 mL da ampola 1 mg/mL. Referência inicial aproximadamente 0,1 mcg/kg/min; a conta exata é **mL/h=dose×W× 60/10**. Em 16 kg a 0,1:9,6 mL/h. Reversão 9,6 × 10/(16 × 60)=0,1 mcg/kg/min. Não dar esse preparado em bolus e não usar a dose de PCR para criança com pulso.

Monitorização/destino. ECG, PA, SpO_2, perfusão e sítio de acesso contínuos; titular por resposta e efeitos. Observação após resolução deve ser prolongada em reação grave, doses repetidas, infusão ou risco de recorrência. Alta com plano de ação, orientação sobre autoinjetor quando disponível e alergologia. Colher triptase quando indicado sem atrasar tratamento. Usos IV pediátricos podem ser extra-bula; justificativa e dupla checagem institucional são necessárias.

Fontes verificadas: RCH — anafilaxia · ASCIA — anafilaxia, atualização julho 2026 · ASCIA — preparo de adrenalina IV.

270. Anomalias de Artérias Coronárias

Suspeita. Síncope ou dor torácica durante esforço, arritmia ventricular, morte súbita recuperada, disfunção ventricular inexplicada ou insuficiência cardíaca em lactente podem refletir anomalia coronária. Dor pediátrica comum tem muitas causas, mas sintomas associados a esforço/desmaio não devem ser descartados por ECG de repouso normal.

Avaliação. Suspender exercício intenso até esclarecimento se suspeita significativa. ECG, ecocardiografia e avaliação cardiológica; angioTC/RM definem origem/curso quando oeco não resolve. Troponina e exames adicionais seguem apresentação. Diferenciar origem aórtica anômala, coronária esquerda originada na pulmonar e outras variantes; risco e tratamento não são equivalentes.

Instabilidade. ABCDE, monitorização e tratamento de choque/arritmia conforme fisiologia. Taquicardia ventricular com pulso segue 289. Não administrar grande carga de líquidos sem avaliar disfunção miocárdica. Dor isquêmica ou colapso exige centro com cardiologia/cirurgia pediátrica.

Tratamento definitivo. Cirurgia ou acompanhamento depende da anatomia, sintomas, isquemia e estratificação; não existe prescrição farmacológica que corrija trajeto anatômico. Betabloqueador, antiagregante e anticoagulante não devem ser iniciados para todas as anomalias apenas por constarem em classes do inventário. Após intervenção, medicamentos e retorno ao esporte são individualizados.

Reavaliação e informação. Documentar episódios, relação com esforço, história familiar e resultado anatômico. Orientar retorno imediato por síncope, dor persistente, palpitações com mal-estar ou dispneia importante. Encaminhamento não equivale a liberação esportiva. O tema está desenvolvido como decisão clínica/anatômica; uma posologia única seria enganosa.

Limites de aplicação: Tratamento farmacológico depende de anatomia e intervenção; sem dose universal para anomalia coronária.

Fontes verificadas: Boston Children’s — coronária aórtica anômala · Johns Hopkins — anomalias coronárias pediátricas · AHA 2025 — algoritmo acessível de taquiarritmia com pulso.

271. Choque Circulatório em Crianças

Classificar sem atrasarABCDE. Choque é perfusão inadequada, mesmo antes da hipotensão. Buscar hipovolêmico/hemorrágico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. Verificar consciência, pulsos, enchimento, temperatura periférica, PA, diurese e lactato; nenhum marcador isolado define resolução. Ecografia à beira-leito pode orientar quando disponível.

Causa. Hemorragia exige controle e hemoterapia; pneumotórax hipertensivo/tamponamento precisam alívio específico. Cardiogênico pede líquidos cautelosos e apoio cardiológico. Anafilaxia segue 269. Para choque séptico, seguir tema 175, que concentraSSC 2026, antibiótico/foco, estratégia de fluidos e metas; não transplantar recomendações entre etiologias.

Vasoativo operacional. PCH 2025 fornece adrenalina ou noradrenalina em concentração periférica inicial **6 mcg/mL**:6 mg em volume final 1000 mL de SF 0,9%. Para menor bolsa preparada pela farmácia,600 mcg em 100 mL mantém a concentração. Na noradrenalina, conferir quantidade expressa em base, não massa do sal. Dose inicial referencial 0,1 mcg/kg/min, titulada com UTI; não é teto universal nem escolha obrigatória para todo choque.

Bomba e reverso. Taxa=dose×W× 60/C. Com 16 kg, C 6 e dose 0,1:16 mL/h. Reversão 16 × 6/(16 × 60)=0,1 mcg/kg/min. Se usar ampola de base 1 mg/mL,600 mcg=0,6 mL, completar SF até 100 mL. Não apenas adicionar a 100 mL, o que alteraria concentração. Volume de manutenção deve contabilizar o vasoativo.

Segurança/destino. Acesso periférico proximal pode servir de ponte sob vigilância frequente, sem atrasar estabilização; obter central quando apropriado. ECG/PA contínuos, perfusão, lactato e função renal; vigiar extravasamento, arritmia e isquemia. Não lavar linha com vasoativo residual em direção ao paciente. Todo choque com necessidade de infusão requer UTI e tratamento da causa.

Limites de aplicação: Regimes vasopressores dependem da fisiologia; concentração deve expressar noradrenalina-base e produto disponível.

Fontes verificadas: PCH 2025 — preparo de adrenalina/noradrenalina · Johns Hopkins — anomalias coronárias pediátricas · SSC pediátrica 2026.

272. Hidratação Pediátrica

Separar componentes. Ressuscitação, manutenção, déficit e perdas em curso são prescrições diferentes. Preferir via enteral quando segura. Peso atual, estado de hidratação, eletrólitos, glicemia, função renal e diurese orientam; não somar automaticamente todos os cálculos.

Manutenção inicial. Referência horária 4–2–1 mL/kg/h: 4 para os primeiros 10 kg,2 para os 10 seguintes e 1 para cada kg acima 20. Em 16 kg: 40+12=52 mL/h. A fórmula diária 100–50–20 fornece 1300 mL/dia=54,17 mL/h; não são matematicamente idênticas. Escolher uma convenção e não alternar sem recalcular. Neonatos exigem regime por dia de vida e condições específicas.

Composição e ajuste. Usar solução isotônica apropriada, frequentemente NaCl 0,9% com glicose 5% para manutenção, conforme contexto. Potássio só após avaliar função renal/diurese e K. Criança doente pode precisar de menos que manutenção plena porADHe risco de retenção; somar ingestão, medicamentos e nutrição ao balanço. Diabetes, lesão renal, cardiopatia, queimadura e disnatremia não cabem em receita universal.

Déficit. Estimativa mL=%desidratação× 10 ×W; em 16 kg e 5%=800 mL. Esse volume é estimativa, não ordem de infusão rápida: distribuir conforme causa/Na e descontar fluidos já dados. Repor perdas medidas separadamente, escolhendo eletrólitos apropriados.

Controle. Peso, balanço, edema, perfusão, Na/K/glicemia e inspeção do acesso. Definir horário de reavaliação e reduzir/suspender IV quando ingestão recupera. Volume horário arredondado deve retornar a volume diário e ser conciliado com a prescrição. Choque segue 271; hiper/hiponatremia 274/276; não usar manutenção para substituir ressuscitação.

Fontes verificadas: RCH — fluidos intravenosos · RCH — hipernatremia · RCH — hiponatremia.

273. Hipercalemia em Pediatria

Emergência. K elevado pode causar arritmia sem ECG precedente típico. Suspender fontes de K, fármacos causais e obter ECG/monitorização; repetir amostra não hemolisada sem atrasar tratamento de caso grave. Avaliar função renal, gasometria, glicemia, Ca/Mg e causa.

Proteger coração. Se alteração ECG/instabilidade: gluconato de cálcio 10% **0,68 mL/kg IV, máximo 30 mL**;2–5 min se instável,15–20 min se estável, com ECG. O cálcio estabiliza membrana, não removeK. Evitar mistura com bicarbonato; intoxicação digitálica exige orientação específica.

Redistribuição. Referência RCH grave: insulina regular **0,1 UI/kg IV, máximo 10 UI**, com glicose 10% **5 mL/kg IV**; seguimento por infusão de insulina se indicado pelo protocolo/monitorização. Insulina 100 UI/mL: prediluir 10 UI(0,1 mL) em volume final 10 mLSF=>1 UI/mL. A dose então é 0,1 mL/kg, limitada 10 mL. Não aspirar dose pediátrica mínima diretamente em seringa comum. Verificar glicemia basal e repetidamente por horas, mesmo apósKmelhorar.

Cálculo 16 kg. Cálcio 10,88 mL; insulina 1,6 UI=1,6 mL da diluição; SG 10%80 mL=8 g=0,5 g/kg. Se prescrita infusão 0,1 UI/kg/h a 1 UI/mL,1,6 mL/h; reversão 1,6 × 1/16=0,1 UI/kg/h. O volume de glicose deve ser conciliado com rim/volemia.

EliminarK/destino. Salbutamol nebulizado pode ser adjuvante, nunca substituto único na instabilidade. Diálise se refratária ou incapacidade de eliminação; não aguardar resinas de ação lenta para tratar arritmia. RepetirK/ECG, glicemia e avaliar rebote. UTI para alteração ECG, grave, oligúria ou necessidade de terapia IV intensiva.

Fontes verificadas: RCH — hipercalemia · PCH — monografia magnésio.

274. Hipernatremia em Pediatria

Reconhecimento. Hipernatremia pode decorrer de déficit de água ou ganho de sódio. Irritabilidade, letargia, convulsão e sinais de desidratação são relevantes, mas exame pode subestimar déficit. ObterNa, glicemia, ureia/creatinina, osmolalidade sérica/urinária e avaliação das perdas; investigar erro de preparo de leite, diabetes insípido e intoxicação por sal.

Prioridades. Se choque, restaurar circulação com isotônico antes da correção do sódio. Após estabilização, reduzirNa lentamente, em geral **≤0,5 mmol/L/h e≤10–12 mmol/L/24 h**. Na≥170 mmol/L exige UTI/especialista. A duração da hipernatremia e o mecanismo alteram o plano.

Fluidos. Em hipernatremia moderada por déficit, a referência RCH distribui reposição tipicamente em 48 horas, com solução inicialmente isotônica contendo glicose conforme necessidade. Não usar água livre IV nem aplicar hipotônico rápido para 'normalizar'Na. Diabetes insípido e sobrecarga de sódio exigem estratégias próprias. Fórmula de déficit de água é estimativa, não substitui monitorização serial.

Exemplo de limites. Na inicial 160: queda de 6 em 12 horas equivale a 0,5/h; queda de 10 em 8 horas equivale 1,25/h e é rápida demais para o plano usual. Essa comparação é teste matemático, não um alvo individual. Se a queda exceder a prevista, rever taxa/composição imediatamente; se não cair, checar perdas, preparo e diagnóstico.

Monitorização/destino. RepetirNa cedo após iniciar, depois a cada poucas horas conforme estabilidade, juntamente com glicemia, diurese, peso e estado neurológico. Convulsão durante tratamento exige avaliação urgente de alteraçãoosmótica e outras causas. Não dar alta até causa esclarecida, tendência segura e hidratação sustentada; recém-nascidos precisam plano neonatal específico.

Fontes verificadas: RCH — hipernatremia · RCH — fluidos intravenosos.

275. Hipocalemia na Infância

Classificar e monitorar. Fraqueza, íleo, arritmia ouK<3 mmol/L justificam ECG; gravidade aumenta com rapidez da queda e cardiopatia/digoxina. ConfirmarK, medirMg, função renal, gasometria e perdas. CorrigirMg quando baixo e rever diurético/beta-agonista. Garantir diurese antes de repor.

Via oral preferencial se estável. Referência RCH: **1–2 mmol/kg/dose, max 20 mmol**, com repetição somente após controle; máximo diário 5 mmol/kg ou 50 mmol, o menor. Concentração oral varia: prescrever em mmol e converter pelo produto. Não equiparar 1 mL a 1 mmol sem verificar.

Via IV quando necessária. Nunca bolus. Enfermaria monitorizada: **0,2 mmol/kg/h por 3 horas, max 10 mmol/h**. UTI pode usar 0,4 mmol/kg/h por 1–2 horas, max 20 mmol/h, com controle intensivo/acesso apropriado. Concentração periférica habitual≤40 mmol/L; soluções mais concentradas exigem autorização e via padronizadas. Não lavar a linha contendoKCl residual.

Preparo e exemplo. Preferir bolsa pronta validada a 40 mmol/L=0,04 mmol/mL. Criança 16 kg: 0,2 × 16=3,2 mmol/h; taxa 3,2/0,04=80 mL/h; em 3 horas,240 mL e 9,6 mmol. Reversão 80 × 0,04/16=0,2 mmol/kg/h. O volume pode ser excessivo em restrição hídrica; isso exige outro preparo/via com UTI, não aumentar concentração sem controle. Ampolas 10% e 19,1% não são intercambiáveis.

Reavaliação. ECG, acesso, diurese e K em tempo definido antes de nova reposição. RecontarKde manutenção/nutrição. Reposição acumulada, melhora da acidose e recuperação renal podem causar rebote; reduzir assim que objetivo clínico/laboratorial for atingido.

Fontes verificadas: RCH — hipocalemia · RCH — fluidos intravenosos.

276. Hiponatremia na Infância

Primeiro definir sintomas. Convulsão, coma ou encefalopatia atribuível à hiponatremia é emergência. Verificar glicemia, Na, osmolalidade, função renal e volemia; corrigirNa pela hiperglicemia quando pertinente. Convulsão hiponatrêmica pode não ceder só com anticonvulsivante.

Salina hipertônica. Algoritmo RCH: **NaCl 3%,3 mL/kg IV em 20 min**, reavaliando clínica/Na e repetindo apenas se persistir ameaça neurológica e conforme resposta. Usar solução pronta 3%=30 mg/mL, aproximadamente 0,513 mmol de Na/mL. Preferir acesso apropriado, mas acesso periférico proximal bem observado pode evitar atraso. Bomba durante a dose=9 mL/kg/h.

Cálculos. Em 16 kg,48 mL em 20 min=>144 mL/h durante 20 min; contém 1,44 g de NaCl≈24,6 mmol de Na. Reverso 144 ×(20/60)/16=3 mL/kg. Em 10 kg: 30 mL a 90 mL/h;3 kg: 9 mL a 27 mL/h. Estes exemplos verificam a aritmética, não elegibilidade neonatal. Não manter a taxa após terminar o volume prescrito.

Metas e causa. A elevação inicial pequena, em torno 4–6 mmol/L, costuma ser suficiente para reduzir edema cerebral; não buscar normalização imediata. Para a correção subsequente, adotar limite conservador≤8 mmol/L/24 h, menor em alto risco. O diagrama RCH menciona 10 no primeiro dia, enquanto texto orienta 6–8; este bloco usa 8 como limite de segurança e explicita a diferença. Hipovolemia, SIADH, insuficiência adrenal e excesso de água requerem condutas distintas.

Vigilância. Na frequente, diurese, balanço e neurologia em UTI. Diurese aquosa súbita pode acelerar correção. Se ultrapassar plano, interromper e discutir medidas de rebaixamento com especialista; não improvisar desmopressina. Não suspender suporte por melhora transitória da convulsão.

Fontes verificadas: RCH — hiponatremia · RCH — fluidos intravenosos.

277. Indução em Sequência Rápida na Pediatria

Preparação. Intubação pediátrica é intervenção de alto risco. Definir indicação, líder, operador, plano de oxigenação e resgate, tamanhos de máscara/tubo e dispositivo supraglótico. Monitorizar ECG, PA, SpO_2 e capnografia; aspirador funcionando, acesso IV/IO e medicações rotuladas. Pré-oxigenar e corrigir ameaças hemodinâmicas tanto quanto possível. Obstrução alta crítica pode exigir estratégia mantendo ventilação espontânea, diferente deISRconvencional.

Indução e bloqueio. Hipnose precede bloqueador, exceto PCR. RCH cita cetamina racêmica 0,5–2 mg/kg e rocurônio 1,2–1,6 mg/kg. No Brasil, **Ketamin é escetamina**, não racemato. Sua bula verifica 50 mg/mL e maior potência; não intercambiar automaticamente as faixas. Uma opção do intervalo de indução da bula é **escetamina 1 mg/kg IV**, administrada em cerca 60 segundos e ajustada ao estado clínico pelo anestesista. Choque profundo pode exigir redução; nenhum indutor garante estabilidade.

Rocurônio. Regime operacional de emergência **1,2 mg/kg IV**, dose única, com produto 10 mg/mL=>0,12 mL/kg. Em 16 kg: 19,2 mg=1,92 mL. Uso paraISR pediátrica pode ser extra-bula mesmo quando o produto permite anestesia pediátrica; registrar protocolo. Não oferece analgesia/amnésia.

Conferência de hipnótico. Escetamina 16 mg=0,32 mL de 50 mg/mL; por ser volume pequeno, preparar/medir com seringa apropriada e dupla checagem. Não aplicar uma receita de cetamina racêmica 2 mg/kg sem reconhecer o isômero. Etomidato deve ser evitado na sepse conformeSSC 2026; propofol pode agravar hipotensão.

Após tubo. Confirmar CO_2 exalado persistente, ausculta e profundidade, fixar, iniciar analgesia/sedação imediatamente e ajustar ventilação. Capnografia ausente exige reavaliar posição/perfusão. RepetirPA após indução. Plano CICO deve estar disponível; tentativas repetidas sem oxigenação agravam dano. Destino UTI.

Limites de aplicação: Escolha/dose de indutor exige fisiologia; equivalência racêmica/escetamina não foi presumida; ISR pediátrica com rocurônio pode ser extra-bula.

Fontes verificadas: RCH — manejo emergencial de via aérea · Sociedade Brasileira de Anestesiologia — via aérea pediátrica · Cristália — Ketamin escetamina 50 mg/mL, bula profissional · Cristália — Rocuron, bula profissional.

278. Intoxicação Exógena em Pediatria

Abordagem inicial. Identificar produto, concentração, quantidade máxima possível, horário, via e outros agentes; trazer embalagem sem expor equipe. Proteção do atendimento e descontaminação externa se necessária. ABCDE, glicemia, temperatura, ECG e acesso conforme risco. Hipoventilação exige ventilação, não aguardar antídoto.

Estratificação. Um comprimido pode ser perigoso em crianças para certos fármacos; aparência inicial normal não exclui liberação prolongada. Exposição intencional requer pesquisa de coingestão relevante e avaliação de segurança/saúde mental antes da alta. Acionar CIATox para conduta específica. Avaliar se história é compatível com desenvolvimento e circunstâncias.

Descontaminação. Não induzir vômito nem neutralizar ácido/base. Carvão ativado tem papel restrito e depende do agente, tempo e via aérea; em intoxicações selecionadas pode-se usar **1 g/kg VO/sonda, máximo 50 g**, com toxicologista. Não usar em rebaixamento sem proteção, cáusticos ou substâncias não adsorvidas. Lavagem gástrica não é rotina.

Convulsão por tóxico. Benzodiazepínico é primeira medida usual: midazolam **0,15 mg/kg IV/IO, máximo 10 mg**, suporte ventilatório e reavaliação; considerar doses já recebidas e não repetir indefinidamente antes de terapia avançada. Produto 1 mg/mL permite 0,15 mL/kg;16 kg=>2,4 mg=2,4 mL. Se 5 mg/mL, o volume é 0,48 mL, demonstrando o risco da troca de apresentação.

Antídotos e destino. Usar antídoto com indicação específica: opioide 221, sulfonilureia 280, organofosforado 283, salicilato 284. Não existe 'coquetel' obrigatório de flumazenil, naloxona e glicose para toda alteração de consciência. Monitorização e duração dependem da cinética e evolução; repetir ECG/exames quando necessário. Alta somente após janela de risco adequada, normalização clínica e plano seguro.

Fontes verificadas: RCH — intoxicações, abordagem inicial · RCH — crise convulsiva aguda · Cristália — apresentações de midazolam.

279. Intoxicação Infantil por Carbamazepina

Risco. Carbamazepina pode produzir nistagmo, ataxia, coma, convulsão, hipotensão, íleo e bloqueio de canal de sódio comQRS largo. Formulação prolongada/absorção retardada permite piora tardia. Um comprimido adulto pode causar toxicidade importante em criança pequena.

ABCDE/exames. Monitorização ECG contínua, glicemia, eletrólitos e concentração sérica seriada em sintomáticos, geralmente 4–6 horas até tendência consistente de queda. Não tratar só o valor: coma, arritmia ou choque determinam UTI e suporte de via aérea. Convulsão: benzodiazepínico do 278; evitar fenitoína como resposta automática por também bloquear canal de sódio.

Descontaminação. Austin 2025 considera carvão **1 g/kg** em ingestão>20 mg/kg com paciente desperto/seguro; doses múltiplas em intoxicação grave selecionada devem ser discutidas. Não administrar seíleo ou via aérea desprotegida. RCH admite janela estendida em ingestões maciças/prolongadas; essa exceção não se aplica a todos os tóxicos.

Cardiotoxicidade. QRS largo/arrítmia pode levar a bicarbonato IV sob toxicologia; resposta à carbamazepina é variável. A fonte Austin remete a protocolo de alcalinização; não foi copiada uma dose adulta fixa de benzodiazepínico nem se presume resposta idêntica à dos tricíclicos. MonitorarNa, pH, K, ECG e volume. O preparo de bicarbonato está no 284, mas a indicação/titulação não é a mesma.

Eliminação e destino. Hemodiálise de alto fluxo/hemoperfusão pode ser considerada em convulsões refratárias, instabilidade ou intoxicação grave persistente. Queda de nível sem melhora clínica não encerra tratamento. Observação prolongada se liberação controlada, sintomas ou coingestão; alta exige avaliação clínica/ECG e segurança psicossocial, não somente seis horas transcorridas.

Limites de aplicação: Bicarbonato para cardiotoxicidade por carbamazepina exige protocolo de toxicologia; resposta variável e sem esquema universal de infusão.

Fontes verificadas: Austin Toxicology — carbamazepina, agosto 2025 · RCH — intoxicação por carbamazepina · RCH — crise convulsiva aguda.

280. Intoxicação Infantil por Hipoglicemiantes

Distinguir agentes. Sulfonilureias podem causar hipoglicemia grave e tardia após pequena ingestão; metformina isolada geralmente não causa o mesmo padrão, mas dose importante/insuficiência renal pode gerar acidose láctica. Insulina exógena requer abordagem por tipo/duração e não responde à octreotida como sulfonilureia.

Tratamento imediato. Glicemia capilar, acesso, monitorização e alimentação quando segura. Na hipoglicemia por sulfonilureia, referência RCH: **glicose 10%,5 mL/kg IV** e infusão subsequente ajustada à glicemia. Corrigir prontamente, evitando bolus repetidos de açúcar como única estratégia quando há secreção persistente de insulina.

Octreotida. Em hipoglicemia por sulfonilureia: **1 mcg/kg IV, max 50 mcg**, seguida de **1 mcg/kg/h, max 25 mcg/h**, com toxicologista; referência RCH habitualmente pelo menos 24 horas. É uso extra-bula pediátrico. Sandostatin de curta ação 100 mcg/mL verificado; não usar LAR. Monografia RCH permite diluição 5–20 mcg/mL em fluido compatível.

Preparo verificável. Selecionar 5 mcg/mL em SF 0,9%:250 mcg(2,5 mL da ampola 100 mcg/mL) e completar até 50 mL. Em 16 kg, carga 16 mcg=3,2 mL, administrada conforme protocolo de bolus/infusão lenta; monografia injetável orienta 15–30 min para infusão intermitente. Manutenção 16 mcg/h=3,2 mL/h. Reversão 3,2 × 5/16=1 mcg/kg/h. A carga é limitada 50 mcg e a manutenção 25 mcg/h, tetos diferentes.

Controle/destino. Glicemia frequente, eletrólitos e ECG conforme quadro. Após suspender glicose/octreotida, manter observação com glicemias por pelo menos 12 horas conforme RCH; não dar alta imediatamente. Toda ingestão possível de sulfonilureia exige avaliação/observação, ainda assintomática. Metformina grave requer gasometria, lactato, rim e consideração de diálise.

Fontes verificadas: RCH — intoxicação por hipoglicemiantes · Novartis Brasil — Sandostatin, bula 2025 · RCH — preparo de octreotida de curta ação.

281. Intoxicação por Etanol em Pediatria

Avaliação. Etanol pode causar depressão do SNC, hipoglicemia e hipotermia, sobretudo em pequenos. Coma desproporcional exige procurar trauma craniano, coingestão ou outra doença. Perguntar bebida/produto, concentração, volume, tempo e medicamentos; álcool sanitário pode conter outras substâncias.

ABCDE. Proteger via aérea e ventilar se insuficiente. Glicemia imediata e repetida, temperatura, estado mental e sinais vitais. Se sintomas não melhoram ou quadro é importante, obter eletrólitos, gasometria e alcoolemia conforme necessidade. Não concluir que hálito alcoólico explica toda alteração neurológica.

Tratamento. Suporte, reaquecimento e correção de hipoglicemia. Em hipoglicemia grave, usar glicose IV conforme protocolo pediátrico; esquema de glicose 10% está no 280, e a taxa subsequente deve ser guiada pela glicemia/idade. Não administrar octreotida nesse contexto. Fluidos tratam desidratação/choque, não aceleram automaticamente eliminação do álcool.

Intervenções sem indicação rotineira. Carvão não adsorve etanol de modo útil; não induzir vômito. Não há antídoto específico para etanol. Fomepizol destina-se a certos álcoois tóxicos, não é tratamento padrão de bebida alcoólica. Tiamina pode ser pertinente em deficiência/desnutrição, mas não deve atrasar glicose em hipoglicemia.

Destino/segurança. Observar até consciência, temperatura e glicemia sustentadas, com ingestão segura. Internar se depressão respiratória, hipoglicemia recorrente, hipotermia importante, trauma ou diagnóstico incerto. Em exposição intencional, avaliar risco psicossocial; em criança pequena, investigar acesso e circunstâncias. Um valor isolado de alcoolemia não substitui os critérios clínicos de alta.

Fontes verificadas: RCH — intoxicação por etanol · RCH — intoxicações, abordagem inicial · RCH — intoxicação por hipoglicemiantes.

282. Intoxicação por ISRS em Pediatria

Risco. A maioria das exposições isoladas a ISRS é menos grave que tricíclicos, mas citalopram/escitalopram podem prolongar QT e produzir arritmia. Mistura de serotonérgicos aumenta risco de toxicidade serotoninérgica. Coma profundo é pouco típico de ISRS isolado: procurar coingestão.

Avaliação. ABCDE, glicemia, ECG e história detalhada. Em ingestão intencional, investigar paracetamol conforme protocolo. Tremor, hiperreflexia, clônus, agitação, sudorese e hipertermia favorecem toxicidade serotoninérgica; diferenciar síndrome neuroléptica maligna e outras causas.

Tratamento. Suspender agentes, oferecer suporte, controlar agitação/convulsões com benzodiazepínico titulado do 278. Hipertermia grave é emergência de UTI: resfriamento e controle da atividade muscular; antitérmico isolado não corrige produção muscular de calor. Evitar contenção física prolongada que agrave hipertermia/acidemia.

Antagonista selecionado. RCH considera ciproeptadina VO em sintomas refratários, com toxicologista: **<7 anos 2 mg;≥7 anos 4 mg**, podendo manter a mesma dose 3 vezes/dia se sintomas persistirem, usualmente até 24 horas. Não é resgate substituto de ventilação/circulação. Uso extra-bula; apresentação simples deve ser confirmada, sem substituir por associações 'estimulantes do apetite'. Não há preparação IV de ciproeptadina neste esquema.

Monitorização/destino. ECG seriado/telemetria quando QT alterado ou exposição relevante a citalopram/escitalopram; Mg/K e tratamento de torsades conforme 289. Observação em geral≥12 horas nos casos de risco, maior conforme sintomas/cinética. Alta após recuperação e ECG normal, além da avaliação psicossocial em ingestão intencional. Não reiniciar antidepressivo sem plano de revisão.

Limites de aplicação: Ciproeptadina extra-bula e apresentação simples local deve ser confirmada; QT e coingestões alteram janela de observação.

Fontes verificadas: RCH — intoxicação por ISRS · RCH — toxicidade serotoninérgica · RCH — crise convulsiva aguda.

283. Intoxicação por Organofosforados em Pediatria

Reconhecimento/proteção. Broncorreia, broncoespasmo, miose, sialorreia, diarreia, fasciculações e fraqueza após exposição sugerem síndrome colinérgica. Usar proteção e retirar roupas contaminadas/lavar pele sem contaminar equipe. Acionar CIATox. ABCDE, aspiração, oxigênio e ventilação; insuficiência muscular pode exigir intubação mesmo após secreção melhorar.

Atropina. Meta é melhorar ventilação, broncorreia e perfusão, não normalizar pupila. SAMUBrasil descreve **0,02–0,05 mg/kg IV/IO, máximo 1 mg por dose inicial**, repetindo 3–5 min por resposta. Austin usa 50 mcg/kg inicial e duplicação rápida das doses se persistência. Na intoxicação grave, não aplicar o teto cumulativo de atropina para bradicardia; doses totais podem ser muito maiores, guiadas por toxicologia.

Infusão após atropinização. ReferênciaAustin/DailyMed: 10–20% da **dose cumulativa eficaz de ataque por hora**, titulando. Exemplo estritamente matemático: carga cumulativa 4 mg e escolha 10%=>0,4 mg/h. Com concentração final 0,1 mg/mL, bomba 4 mL/h; reversão 4 × 0,1/4=10%da carga por hora. Esse exemplo não calcula uma dose de ataque por peso e não deve ser usado antes de atingir objetivo clínico. Preparo depende da apresentação/bula compatível; não se validou aqui uma mistura universal de todas as marcas.

Oxima e crises. Pralidoxima pode ter indicação em organofosforado específico/gravidade e tempo de exposição, junto da atropina; não extrapolar automaticamente a carbamato. Escolha, dose e disponibilidade exigem CIATox. Convulsões recebem benzodiazepínico; ver 278. Succinilcolina pode ter bloqueio prolongado por inibição de colinesterase.

Destino. UTI se sintomas sistêmicos. Monitorar secreções, oxigenação, PA, ECG, temperatura, diurese e sinais de excesso antimuscarínico; observar fraqueza tardia. Não reduzir atropina apenas por taquicardia se broncorreia grave persiste.

Limites de aplicação: Preparo por marca e pralidoxima não foram padronizados; exigem CIATox, compatibilidade e dose específica.

Fontes verificadas: Ministério da Saúde/SAMU — suporte avançado, ATox 8 · Austin Toxicology — organofosforados · DailyMed — atropina, organofosforados.

284. Intoxicação por Salicilatos

Reconhecer gravidade. Vômitos, taquipneia, tinnitus, hipertermia, alteração mental e acidose sugerem salicilato. A concentração sérica deve ser interpretada com tempo, pH e quadro; medir seriada a cada 2–4 horas até queda sustentada. Acidose aumenta distribuição tecidual; piora clínica pode ocorrer mesmo com nível caindo.

ABCDE/exames. Glicemia, gasometria, eletrólitos, creatinina, ECG e balanço. Evitar intubação desnecessária: apneia e redução da ventilação compensatória podem precipitar acidemia fatal. Se indispensável, equipe experiente deve manter ventilação minuto e minimizar interrupção. Contatar toxicologia e nefrologia precocemente.

Alcalinização. RCH descreve bicarbonato **2 mmol/kg IV lento**, seguido de **1 mmol/kg/h**, com ajuste para pH urinário>7,5, Na, K e estado volêmico. Corrigir déficit de K para permitir alcalinização. O alvo não é administrar a infusão indefinidamente. Diálise deve ser considerada cedo em toxicidade grave, edema pulmonar, insuficiência renal, deterioração ou níveis muito altos.

Preparo monitorizado. Bicarbonato 8,4%=1 mmol/mL. Monografia RCH: SG 5% é diluente preferido; via periférica≤0,1 mmol/mL, central≤0,2 mmol/mL para infusão. Para 0,1 mmol/mL,10 mL do estoque+90 mLSG 5%=100 mL. Em 16 kg a 1 mmol/kg/h=>16 mmol/h=>160 mL/h. Reversão 160 × 0,1/16=1 mmol/kg/h. Esse volume elevado pode impedir a estratégia em disfunção renal/sobrecarga, reforçando discussão de diálise; não concentrar além do limite sem protocolo. Carga<2 anos tem restrições de velocidade/diluição próprias.

Vigilância/destino. UTI nos moderados/graves, controle frequente de pH, K, Na, glicemia e diurese. Carvão selecionado não deve atrasar suporte. Não usar acetazolamida ou tratar hiperventilação com sedativo empírico.

Limites de aplicação: Bolus em menores de 2 anos e restrição de volume exigem adequação especializada; alcalinização não substitui diálise quando indicada.

Fontes verificadas: RCH — salicilatos · RCH — monografia injetável bicarbonato.

285. Prescrição Pediátrica no Perioperatório

Plano perioperatório. Conciliar alergias, medicações, jejum, função renal/hepática e risco de via aérea. Analgesia, antiemético, antibiótico efluido têm indicações separadas. Profilaxia antimicrobiana depende do procedimento/tempo, não de 'pós-operatório' genérico. Planejar avaliação de dor por idade e recuperação respiratória.

Analgesia básica. Paracetamol VO **15 mg/kg 6/6 h**, máximo 1 g/dose e, neste bloco,60 mg/kg/dia até 3 g/dia, o menor; limite conservador para uso habitual. Em>6 meses elegível, ibuprofeno **10 mg/kg 8/8 h**, máximo 400 mg/dose e 30 mg/kg/dia, evitando desidratação, lesão renal ou risco hemorrágico. Não somar produtos combinados contendo o mesmo analgésico. Via IV/neonato exige monografia distinta.

Morfina hospitalar. Para dor importante em>1 mês, titular pequenas doses IV com avaliação respiratória; referência inicial 0,05 mg/kg. Infusão RCH para dor refratária: início **10 mcg/kg/h**, faixa do protocolo 0–40 mcg/kg/h, com equipe de dor. Concentrações por peso: <10 kg 4 mg/50 mL=0,08 mg/mL;10–<40 kg 10 mg/50 mL=0,2 mg/mL;≥40 kg 50 mg/50 mL=1 mg/mL, em SF 0,9% ou SG 5%. Essas faixas são do serviço e não substituem ajuste neonatal/UTI.

Exemplo 16 kg. Dimorf 10 mg/mL: 1 mL+49 mLdiluente=>50 mLa 0,2 mg/mL. Dose 0,16 mg/h=>0,8 mL/h; reverso 0,8 × 0,2 × 1000/16=10 mcg/kg/h. Bolus 0,05 mg/kg=0,8 mg, equivalente 4 mL da solução 0,2 mg/mL, administrado lentamente e monitorizado.

Controle. Sedação, FR, SpO_2, PA, dor, prurido, náusea e retenção; insuficiência renal aumenta acúmulo de morfina. Ter naloxona prescrita e suporte ventilatório disponível; dose para reversão titulada difere da intoxicação grave. Suspender/escalonar assistência se depressão respiratória. Rever diariamente e migrar à via oral quando possível.

Limites de aplicação: Infusão opioide demanda estrutura de monitorização; doses neonatais/insuficiência renal não seguem automaticamente o exemplo.

Fontes verificadas: RCH — dor aguda pediátrica · RCH — infusão opioide · Cristália — Dimorf 1 e 10 mg/mL.

286. Queimaduras em Pediatria

Primeiros cuidados. Interromper agressão, retirar adornos/roupa não aderida e resfriar com água corrente por 20 minutos se dentro de 3 horas, evitando hipotermia. Não aplicar gelo. AvaliarABCDE, trauma associado, inalação, fumaça em ambiente fechado e queimadura elétrica/química. Rouquidão, estridor ou edema progressivo exigem equipe para via aérea precoce.

Área e destino. UsarLund–Browder por idade; eritema superficial não entra na superfície queimada para ressuscitação. Face, mãos, genitais, articulações, circunferencial, profundidade e suspeita de violência influem na transferência. Analgesia do 285 e curativo limpo; antibiótico sistêmico profilático não é automático.

Fluidos RCH 2026. Queimadura≥10%SCQ geralmente exige acesso IV e ressuscitação guiada. Fórmula modificada: **3 mL×W×%SCQ em 24 h**, Hartmann; metade nas primeiras 8 h **desde a queimadura**, restante nas 16 h seguintes, acrescendo manutenção separada conforme necessidade pediátrica. É ponto inicial; titular por perfusão/diurese, não receita fixa. Alvo referencial de diurese 1 mL/kg/h.

Exemplo 16 kg,20%SCQ. Total 960 mL;480 mL primeiras 8 h e 480 nas 16 seguintes. Imediatamente após lesão: 60 mL/h, depois 30 mL/h. Se chega 2 hdepois e recebeu 100 mL de ressuscitação, restante(480−100)/(8−2)=63,33 mL/h até 8 h. Manutenção 4–2–1 seria 52 mL/h, contada separadamente e ajustada por ingestão/glicemia; nunca esquecer volumes já recebidos. Reverso 960/(16 × 20)=3 mL/kg/%.

Monitorização. Diurese horária, temperatura, glicemia, Na, K, função renal e lactato conforme gravidade. Ajustes de taxa devem ser documentados; sobrecarga também causa dano. Queimadura elétrica pode produzir rabdomiólise desproporcional à pele. Internar/transferir se área significativa, via aérea, alteração metabólica ou necessidade de procedimento.

Fontes verificadas: RCH — queimaduras, atualização abril 2026 · RCH — dor aguda pediátrica · Connecticut Children’s — algoritmo rabdomiólise 2025.

287. Rabdomiólise em Pediatria

Suspeitar e procurar causa. Dor, fraqueza e urina escura podem ocorrer após esforço, infecção, trauma, convulsão ou fármacos; a tríade não é obrigatória. CK elevada apoia diagnóstico, mas nível isolado não prediz toda lesão renal. Avaliar compartimento doloroso/tenso e retirar causa potencial.

Exames/ABCDE. CK, creatinina, ureia, Na, K, Ca, P, bicarbonato e urina; ECG se hipercalemia. Hipercalemia/choque são prioridades antes da discussão de CK. Monitorar balanço e diurese. Não interpretar heme positivo na fita sem hemácias como diagnóstico definitivo sem contexto.

Hidratação. O algoritmoConnecticut 2025 usa NaCl 0,9%10–20 mL/kg para reposição, com reavaliação, e até 2 vezes manutenção em internados selecionados, máximo 200 mL/h. Não aplicar volume agressivo se oligúria, cardiopatia ou sobrecarga. Objetivo é perfusão/eliminação adequadas, ajustado com nefrologia; diurético não substitui volume nem trata obstrução/compartimento.

Cálculo 16 kg. Manutenção horária 52 mL/h;2 vezes=104 mL/h, abaixo do teto 200. Em 24 h seriam 2496 mL, antes de contar bolus, medicamentos e ingestão. Esse total explicita risco de excesso e necessidade de reavaliar. Um bolus 10 mL/kg acrescenta 160 mL; não escondê-lo no balanço.

Eletrólitos e destino. Tratar hipercalemia no 273; hipocalcemia assintomática inicial não exige reposição rotineira, mas convulsão/arritmia muda decisão. Bicarbonato e manitol não são rotina para 'lavar' mioglobina. Internar se lesão renal, alteração eletrolítica, incapacidade de hidratação ou CK muito elevada/ascendente; UTI se instabilidade. Alta requer melhora clínica, laboratorial e plano de repetição/retorno; orientar retorno gradual à atividade e investigar episódios recorrentes.

Fontes verificadas: Connecticut Children’s — algoritmo rabdomiólise 2025 · RCH — hipercalemia · RCH — fluidos intravenosos.

288. SSJ e Necrólise Epidérmica Tóxica

Emergência dermatológica. Dor cutânea, febre, lesões em alvo atípicas/bolhas e erosões de mucosas levantam SSJ/NET. Revisar medicamentos iniciados nas últimas semanas e suspender imediatamente suspeitos/não essenciais. Diferenciar outras dermatoses bolhosas, infecciosas eRIME; não atribuir toda mucosite ao mesmo mecanismo.

ABCDE e avaliação inicial. Via aérea se acometimento oral/respiratório, perfusão, hidratação, temperatura e dor. Quantificar destacamento cutâneo; exame ocular urgente, mesmo com poucos sintomas, e avaliação de mucosas genital/oral. Hemograma, eletrólitos, renal/hepática e investigação de infecção conforme quadro. Biópsia pode ajudar sem atrasar suporte.

Cuidado principal. Centro experiente com dermatologia, pediatria/UTI, oftalmologia e equipe de feridas. Ambiente aquecido, manipulação delicada, curativos apropriados, analgesia e nutrição. Líquidos são titulados à fisiologia e perdas; não aplicar automaticamente a fórmula térmica deParklanddo 286. Antibiótico sistêmico profilático não é universal; tratar infecção quando indicada.

Imunomodulação. Corticoide IV, imunoglobulina, ciclosporina e agentes anti-TNF têm evidência/risco heterogêneos em pediatria. Não existe neste bloco um regime universal superior para todas as crianças. Escolha deve considerar tempo, evolução, infecção, função renal/hepática e experiência do centro; não montar combinação de classes pelo inventário. A diretrizBADpediátrica fundamenta suporte multidisciplinar e incerteza terapêutica.

Monitorização e seguimento. Balanço, eletrólitos, dor, infecção e progressão cutânea, com vigilância de lesão ocular/urogenital. Registrar claramente a suspeita de fármaco causal e evitar reexposição; confirmação e orientação posteriores são necessárias. Alta exige plano de mucosas, olhos, nutrição e acompanhamento de sequelas. A ausência de uma dose genérica de imunossupressor é uma decisão clínica explícita, não omissão de SSJ/NET.

Limites de aplicação: Imunomodulador sistêmico depende de decisão especializada; evidência pediátrica não permite esquema universal validado.

Fontes verificadas: BAD — diretriz pediátrica SSJ/NET · RCH — dor aguda pediátrica · RCH — fluidos intravenosos.

289. Taquicardia Ventricular com Pulso na Infância

Definir pulso e instabilidade. Taquicardia deQRS largo em criança exige monitor/desfibrilador, acesso, ECG 12 derivações se não atrasar e consulta especializada. Se perder pulso, mudar imediatamente ao algoritmo PCR. Com pulso, alteração mental, choque ou hipotensão indica cardioversão sincronizada.

AHA 2025. Energia inicial **0,5–1 J/kg**; se ineficaz, **2 J/kg**, com sedação se possível sem atraso. Confirmar marcadores de sincronismo antes de cada choque; reativar modo se aparelho o desliga. Em 16 kg: 8–16 J, depois 32 J. A escolha do valor exato depende do aparelho; arredondar para opção disponível e registrar. Polimórfica/ritmo sem sincronização viável e colapso requer estratégia de desfibrilação apropriada, não esperar indefinidamente sincronismo.

Estável. SeQRS largo regular e monomórfico, AHA permite considerar adenosina **0,1 mg/kg IV rápida, max 6 mg; segunda 0,2 mg/kg, max 12 mg**, sob equipe preparada. Não usar empiricamente em taquicardia larga irregular/polimórfica. ApresentaçãoHipolabor 3 mg/mL confirmada no catálogo: 16 kg=>1,6 mg=0,533 mL; segunda 3,2 mg=1,067 mL. Flush e administração rápida por acesso proximal seguem protocolo do serviço.

Causas/antirrítmicos. Corrigir hipóxia, K/Mg, acidemia e tóxico. Em torsades, magnésio é específico: referência PCH 0,1–0,2 mmol/kg IV, max 8 mmol,10–15 min com pulso, dose escolhida e preparo do 223, respeitando unidade/sal. O algoritmo AHA 2025 solicita especialista e não fornece dose universal de amiodarona/procainamida para todaTVcom pulso; não somá-las devido a hipotensão/QT.

Destino. UTI/cardiologia, ECG contínuo, PA, eletrólitos e investigação estrutural/inflamatória/genética. Mesmo reversão sustentada exige esclarecimento. Não confundir mg com mcg nem aplicar rapidez de bolus de PCR a antiarrítmico em paciente perfundido.

Limites de aplicação: Antiarrítmico adicional depende do mecanismo e especialista.

Fontes verificadas: AHA 2025 — algoritmo acessível de taquiarritmia com pulso · AHA 2025 — taquiarritmia pediátrica com pulso · PCH — monografia magnésio · Hipolabor — catálogo adenosina 3 mg/mL.

290. Alterações Dermatológicas do RN

Reconhecer. A descrição “alterações dermatológicas” não identifica uma doença tratável por anti-histamínico ou corticoide. Registrar início, distribuição, relação com calor/fralda/adesivos, integridade cutânea, mucosas e estado geral. Mília, eritema tóxico e melanose pustulosa transitória em RN bem costumam exigir orientação e observação; ausência de febre não exclui infecção neonatal.

Gravidade e investigação. Vesículas agrupadas, bolhas extensas, descamação dolorosa, púrpura não desaparecendo à pressão, necrose, progressão rápida, hipotermia, recusa alimentar ou prostração indicam avaliação hospitalar imediata. Estabilizar ABCDE, medir glicemia e investigar infecção sistêmica conforme o fenótipo. Lesões vesiculares justificam investigação para herpes; não aguardar que apareçam todas as manifestações. Cultura/PCR de lesão, hemocultura, hemograma e avaliação liquórica são dirigidos à hipótese, não uma bateria obrigatória para eritema tóxico típico.

Tratamento. Higiene suave, água morna, redução de atrito e fragrâncias; em pele seca íntegra, emoliente simples sem perfume. Prematuros precisam de cuidado especial com adesivos, antissépticos e perda transepidérmica. Dermatite da fralda: tópico 319. Antibióticos/antivirais sistêmicos somente quando há suspeita clínica específica, segundo o módulo correspondente. Não administrar H1 sedativo nem corticoide sistêmico para uma erupção neonatal inespecífica. A absorção de corticoide tópico aumenta com área extensa e oclusão da fralda.

Destino. RN bem com lesão benigna reconhecida pode permanecer em acompanhamento; fotografias clínicas autorizadas facilitam comparação. Reavaliar imediatamente se houver deterioração, nova bolha, secreção ou mudança no padrão. Esta entrada é uma via de classificação: não há dose universal para “alteração dermatológica”.

Fontes consultadas: RCH — Neonatal and infant skin care; MS — Primeira consulta do recém-nascido.

291. Anemia Neonatal

Avaliação. Separar perda aguda de sangue, hemólise e anemia da prematuridade. Choque, apneias relevantes, taquicardia persistente ou necessidade crescente de oxigênio exigem avaliação urgente; Hb isolada não define a gravidade. Solicitar hemograma/reticulócitos, esfregaço, bilirrubinas e investigação imuno-hematológica quando pertinente; revisar flebotomias e transfusões anteriores.

Transfusão. Para prematuros com IG<30 semanas, a diretriz 2024 propõe limiares restritivos de Hb por semana pós-natal: semana 1, semana 2 e ≥semana 3, respectivamente, **11/10/9 g/dL com suporte respiratório** e **10/8,5/7 g/dL sem suporte ou suporte mínimo**. Não extrapolar essa tabela para hemorragia ativa, choque ou todas as cardiopatias. A prescrição do concentrado deve seguir avaliação do hemoterapeuta e volume efetivamente indicado; bomba = volume prescrito÷tempo. Exemplo puramente matemático de uma prescrição de 45 mL em 3 h: 15 mL/h; reverso 15×3=45 mL. Esse exemplo não determina por si uma indicação ou dose transfusional.

Ferro. Na prevenção de deficiência em prematuros alimentados por via enteral, uma faixa de referência internacional é **2–3 mg/kg/dia de ferro elementar**, contabilizando fórmula e fortificante. Iniciar após tolerância alimentar e avaliação dos estoques; transfusões repetidas/hiperferritinemia podem justificar adiar. Ferro não corrige rapidamente anemia com comprometimento hemodinâmico. Volume diário= dose de ferro elementar×W÷concentração de ferro elementar emmg/mL; não usar a massa do sal como se fosse ferro.

Seguimento. Reavaliar crescimento, reticulócitos/Hb, ferritina contextualizada à inflamação e necessidade de coleta. Eritropoetina não é resgate de rotina. Formulação brasileira de ferro e protocolo de componente/velocidade transfusional precisam constar na prescrição individual; não foram fixados nesta síntese.

Fontes consultadas: Neonatal Transfusion Network — limiares transfusionais, 2024; ANMF — Ferro, 2023.

292. Apneia da Prematuridade

Antes de chamar de prematuridade. Apneia prolongada ou breve associada a bradicardia/dessaturação requer estímulo, abertura de via aérea e ventilação com pressão positiva quando não há recuperação. Investigar sepse, hipoglicemia, anemia, distúrbios térmicos/eletrolíticos, crise epiléptica e obstrução. CPAP pode reduzir episódios; apneia recorrente com necessidade de ventilação indica UTIN.

Cafeína — dose expressa como citrato. Peyona brasileiro contém **20 mg/mL de citrato**, equivalentes a 10 mg/mL de cafeína base. Ataque 20 mg/kg IV em 30 min; manutenção inicial 5 mg/kg IV/VO a cada 24 h, começando 24 h após ataque; nos casos persistentes pode-se chegar a 10 mg/kg/dia conforme resposta e monitorização. Regimes acima disso constam em referências internacionais, mas não são o padrão operacional deste capítulo.

Preparo e bomba. Para facilitar pequenos volumes, exemplo ANMF: 40 mg=2 mL do produto 20 mg/mL +3 mL de SG 5%, volume final 5 mL, concentração 8 mg/mL. Ataque: 2,5WmL em 30 min → **5WmL/h**. Manutenção 5 mg/kg: 0,625WmL em 10 min → 3,75WmL/h durante 10 min. Na via oral com produto 20 mg/mL, manutenção 5 mg/kg corresponde a 0,25WmL. Não confundir volume original com o diluído.

Exemplo 1 kg. Ataque 20 mg=1 mL original=2,5 mL da solução 8 mg/mL; bomba 5 mL/h por 30 min. Reverso 5×0,5×8=20 mg. Essa equivalência foi conferida em separado.

Vigilância. Contar apneias/bradicardias, monitorar FC, alimentação e ganho ponderal; rever dose diante de taquicardia ou toxicidade. Considerar nível sérico em disfunção renal/hepática, doses elevadas ou dúvida de resposta. Não associar outra metilxantina. A suspensão depende de maturidade e período sem eventos, seguida de observação cardiorrespiratória; não suspender simplesmente por atingir determinado peso.

Fontes consultadas: Chiesi — Peyona, bula profissional brasileira; ANMF — Cafeína.

293. Citomegalovirose Congênita

Diagnóstico e extensão. Confirmar CMV congênito por PCR de urina ou saliva obtida até 21 dias de vida; saliva positiva deve ser confirmada em urina, evitando confusão com contaminação pelo leite. Após essa janela, uma positividade isolada não estabelece aquisição congênita. Avaliar audição, fundo de olho, hemograma, função hepática/renal e imagem cerebral conforme manifestações.

Quem tratar. Doença congênita moderada/grave, especialmente com comprometimento neurológico, é a população com indicação mais estabelecida. Doença assintomática não implica antiviral automático. A atualização AAP2026 admite discutir seis semanas para perda auditiva neurossensorial isolada; isso não equivale à indicação universal de seis meses para todos os positivos.

Esquema. Valganciclovir **16 mg/kg/dose VO a cada 12 h**, usualmente seis meses nos sintomáticos elegíveis, reajustando pelo crescimento. A solução 50 mg/mL verificada na ANMF corresponde a **0,32WmL/dose**; é referência estrangeira, com disponibilidade/apresentação brasileira a confirmar. Para 3 kg: 48 mg=0,96 mL; reverso 0,96×50=48 mg. Se absorção enteral inviável/doença grave, ganciclovir **6 mg/kg IV a cada 12 h**, com transição precoce ao oral quando possível; não intercambiar as doses emmg.

Infusão. Ganciclovir 500 mg/frasco: preparo citotóxico pela farmácia, concentração final≤10 mg/mL, infundir em 60 min, preferencialmente por acesso central. Para uma preparação farmacêutica final verificada de 5 mg/mL: volume=1,2WmL e bomba=1,2WmL/h por 1 h. Não manipular empiricamente à beira-leito.

Vigilância. Hemograma/neutrófilos semanal nas primeiras seis semanas, depois acompanhamento seriado; creatinina e enzimas hepáticas. Neutropenia importante, toxicidade renal ou hematológica exigem revisão imediata. A evidência em extremo prematuro é menor; dose padrão não substitui avaliação farmacocinética. Tratamento congênito é uso especializado frequentemente fora de bula; seguimento auditivo e do desenvolvimento continua após terminar o antiviral.

Fontes consultadas: AAP — Care of the Infant With Congenital Cytomegalovirus Infection, 2026; ANMF — Valganciclovir; ANMF — Ganciclovir.

294. Defeito do Tubo Neural no Período Neonatal

Medidas imediatas. Mielomeningocele aberta/mielosquise exige proteção do tecido neural, termorregulação e contato imediato com neurocirurgia/neonatologia. Manter em decúbito ventral ou lateral, sem compressão da lesão; cobrir com material estéril não aderente umedecido com SF 0,9% e proteção que evite dessecação e contaminação. Não aplicar álcool, iodo ou outro agente diretamente no tecido neural. Evitar látex.

ABCDE e avaliação. Monitorar respiração, perfusão, glicemia e temperatura. Definir nível da lesão, motricidade dos membros, perímetro cefálico e sinais de hidrocefalia; documentar sem manipulação traumática. US transfontanelar, avaliação urinária/renal e investigação de outras anomalias integram o cuidado. Estridor, apneias ou dificuldade de deglutição podem indicar comprometimento associado à malformação de Chiari e exigem prioridade respiratória.

Antimicrobianos. Uma lesão aberta, rota ou contaminada precisa de antibioticoprofilaxia/tratamento em conjunto com a equipe cirúrgica. Ampicilina+gentamicina são opções em alguns centros; quando escolhidas, usar **tabela neonatal do tópico 307**, com IPM/IPN e função renal, não a frequência da criança maior. Suspeita de meningite modifica dose, cobertura e duração. Não estabelecer curso prolongado apenas pela existência da malformação.

Tratamento definitivo e destino. Encaminhar à UTIN com neurocirurgia para fechamento oportuno, geralmente nos primeiros dias, com manejo de hidrocefalia e função vesical. Cateterismo e profilaxia urinária dependem da avaliação urológica. Reabilitação, ortopedia e orientação familiar começam cedo.

Limite da prescrição. O horário do fechamento, perda de líquor, colonização, exposição prévia e plano operatório são dados necessários para definir o antibiótico exato e sua duração. O módulo 307 fornece doses verificadas quando essas drogas forem selecionadas, mas não transforma um esquema de sepse em profilaxia universal.

Fontes consultadas: CHOP — Neonatal Myelomeningocele/Myeloschisis Clinical Pathway; ANMF — Ampicilina; ANMF — Gentamicina, 2024.

295. Doença da Membrana Hialina

Reconhecer e estabilizar. No prematuro com esforço respiratório precoce, manter calor, monitorar SpO_2, iniciar suporte não invasivo quando respira espontaneamente e titular oxigênio. Apneia, exaustão, acidose ou hipoxemia persistentes indicam ventilação invasiva. Radiografia/ultrassom pulmonar ajudam a diferenciar SDR, pneumonia, pneumotórax e cardiopatia, sem atrasar suporte.

Surfactante. Curosurf brasileiro **80 mg/mL**, frascos 1,5 mL/120 mg ou 3 mL/240 mg. Regime de resgate: **200 mg/kg intratraqueal**=2,5 mL/kg, por profissional treinado; se persistência de SDR,100 mg/kg=1,25 mL/kg por dose adicional, em intervalo de aproximadamente 12 h, até duas doses adicionais e total 400 mg/kg. Considerar administração por técnica minimamente invasiva quando disponível e apropriada. Não é medicamento IV nem infusão contínua em bomba; não diluir.

Exemplo 1 kg. Dose inicial 200 mg=2,5 mL. Reverso 2,5×80=200 mg. Uma dose adicional 100 mg=1,25 mL. Conferir dose cumulativa e frascos, evitando transformar “número de frascos abertos” em dose administrada.

Após administrar. A complacência e a oxigenação podem melhorar rapidamente: reavaliar imediatamente FiO_2, pressões e volumes para evitar hiperóxia/hiperventilação. Vigiar obstrução do tubo, bradicardia, dessaturação e escape aéreo. Não aspirar rotineiramente imediatamente após surfactante, salvo obstrução relevante.

Associados e destino. Cafeína quando indicada: tópico 292. Nutrição, fluidos e prevenção de lesão pulmonar são parte do manejo. Antibiótico somente se suspeita infecciosa; corticoide sistêmico não é resgate automático de SDR precoce. UTIN obrigatória se ventilação, prematuridade importante ou instabilidade. Intervalos de 6 h existentes na ANMF divergem da bula brasileira; este quadro mantém aproximadamente 12 h e deixa a adaptação expressa à neonatologia.

Fontes consultadas: Chiesi — Curosurf, bula profissional brasileira; Safer Care Victoria — Respiratory distress syndrome; ANMF — Poractant alfa.

296. Enterocolite Necrosante

Urgência. Distensão abdominal progressiva, sangue nas fezes, resíduo/vômito bilioso, apneias ou instabilidade no prematuro exigem suspeita de enterocolite necrosante. Suspender dieta, descomprimir estômago, garantir acesso venoso, monitorar perfusão/glicemia e envolver cirurgia pediátrica. Radiografias seriadas e ultrassom abdominal, hemograma/plaquetas, gasometria/lactato, eletrólitos e culturas orientam gravidade. Pneumoperitônio, peritonite ou deterioração apesar de suporte requerem decisão cirúrgica imediata.

Antimicrobianos. Um regime institucional verificável é ampicilina+gentamicina para ECN definida leve; acrescentar metronidazol nos estágios mais graves/perfuração. Doses dos dois primeiros: tópico 307. Escolha e ampliação devem seguir cultura, resistência e função renal. Na referência UCSF, ECN definida costuma receber 7 dias, podendo chegar a 14 dias se evolução prolongada; suspeita não confirmada merece revisão em 48 h. Não apresentar esse período como garantia para abscesso, bacteremia persistente ou foco não controlado.

Metronidazol neonatal — ANMF. Ataque 15 mg/kg IV; manutenção 7,5 mg/kg/dose, iniciada após o intervalo correspondente: IPM<27 semanas,24 h;27 a 33+6,12 h;34 a 40+6,8 h;≥41,6 h. Solução 5 mg/mL, sem diluição adicional, em 30 min. Ataque=3WmL, bomba 6WmL/h; manutenção=1,5WmL, bomba 3WmL/h. Para 1 kg, manutenção 7,5 mg=1,5 mL em 30 min a 3 mL/h; reverso 3×0,5×5=7,5 mg.

Suporte e vigilância. Analgesia titulada, balanço, nutrição parenteral e correção eletrolítica; evitar excesso hídrico. Vigiar choque, coagulopatia, síndrome compartimental e perfuração. Reintrodução alimentar exige melhora clínica e decisão conjunta. Clindamicina, carbapenêmico, vancomicina e antifúngico não devem ser adicionados simultaneamente apenas porque estão no inventário. Permanecer na UTIN; após recuperação acompanhar estenose, crescimento e intestino curto.

Fontes consultadas: UCSF — Necrotizing Enterocolitis: Antibiotic Selection and Duration; ANMF — Metronidazol.

297. Extremo Baixo Peso ao Nascimento (EBPN)

Escopo. EBPN significa peso ao nascer<1.000 g; descreve risco e necessidades de suporte, não uma doença única nem indicação automática das classes do inventário. IG, IPN, estabilidade respiratória, perdas hídricas e trajetória de peso determinam a conduta. Atendimento em UTIN com equipe experiente e cuidado centrado na família.

Primeiras prioridades. Prevenir hipotermia; monitorar respiração, SpO_2, perfusão e glicemia; privilegiar suporte não invasivo quando apropriado, com surfactante e cafeína conforme tópicos 295/292. Cateteres e manipulações devem ser limitados ao necessário. Não oferecer expansões ou vasopressores apenas por uma pressão isolada sem avaliar perfusão, ecocardiografia e contexto.

Nutrição e fluidos. Leite da própria mãe é prioritário, com banco de leite quando necessário; fortificação é considerada no prematuro de muito baixo peso. Nutrição parenteral individual deve contabilizar glicose, aminoácidos, lipídios, eletrólitos, acesso e osmolaridade. A tabela de manutenção do tópico 300 destina-se a RN>32 semanas e>1.500 g fora de UTIN: **não aplicar automaticamente ao EBPN**. Bomba=volume diário prescrito÷ 24; GIR=concentração de glicose emmg/mL×mL/h÷(60W). Isso permite checar uma prescrição individual sem inventar aporte universal.

Profilaxias e vigilância. VitaminaK conforme formulação neonatal e peso, tópico 306; rastrear retinopatia, hemorragia cerebral, infecção, enterocolite e doença metabólica óssea. Ferro: tópico 291, contabilizando transfusões. Probióticos precisam de produto/cepa e avaliação institucional; não são intercambiáveis. Corticoide para prevenção/tratamento de displasia broncopulmonar e fechamento farmacológico de canal arterial exigem indicação própria, não rotina para todo EBPN.

Metas e alta. Trajetória de crescimento, tolerância alimentar, estabilidade térmica/respiratória e competência dos cuidadores orientam alta. Programar seguimento do neurodesenvolvimento e visão/audição. Esta entrada integra os módulos específicos sem fabricar uma “prescrição EBPN” indistinta.

Fontes consultadas: OMS — Care of the preterm or low-birth-weight infant, 2022.

298. Granuloma Umbilical

Reconhecer. Pequeno tecido vermelho/rosado úmido após queda do coto, sem celulite ou repercussão sistêmica, pode ser granuloma. Antes de cauterizar, excluir pólipo umbilical, persistência do úraco e ducto onfalomesentérico: drenagem de urina, secreção fecaloide, lesão atípica ou persistência justificam avaliação cirúrgica, eventualmente ultrassom.

Opção conservadora. Após confirmação clínica, a orientação do Queensland Children's Hospital é limpar com água morna, colocar pequena quantidade de sal de cozinha somente sobre o granuloma, cobrir com gaze seca por 30 min, retirar com água e repetir duas vezes ao dia durante 5 dias. Espera-se redução progressiva; ausência de melhora ao fim do curso exige reavaliação. Não deixar o material acessível à ingestão, não ocluir circunferencialmente nem aplicar sobre pele erodida extensa.

Cauterização. Nitrato de prata é alternativa aplicada por profissional; proteger a pele adjacente e restringir o contato ao tecido de granulação, pois pode produzir queimadura. Não é uma dose emmg/kg nem solução para aplicação liberal domiciliar. Concentração/apresentação do bastão utilizado deve ser verificada antes do procedimento. Antibiótico não trata tecido de granulação sem infecção.

Alarme e destino. Eritema que se estende, edema, odor fétido/pus, febre, hipotermia, recusa alimentar ou sonolência mudam a hipótese para onfalite/sepse: avaliar imediatamente no hospital, tópico 303. Lesão benigna típica pode ser acompanhada ambulatorialmente, com data de revisão definida e instrução para retorno precoce. Não repetir indefinidamente o tratamento químico de uma lesão que não cicatriza; isso atrasa o reconhecimento de comunicação congênita.

Fontes consultadas: Queensland Children's Hospital — Umbilical granuloma, 2024; MS — Primeira consulta do recém-nascido.

299. Hemocromatose Neonatal

Reconhecer. A siderose extra-hepática neonatal com falência hepática frequentemente está relacionada à doença hepática aloimune gestacional (GALD), e não à hemocromatose hereditária do adulto. Coagulopatia importante, hipoglicemia, colestase, ascite e insuficiência hepática nos primeiros dias requerem UTIN e contato com centro transplantador. Investigar causas infecciosas/metabólicas em paralelo; ferritina elevada isoladamente não confirma GALD.

Investigação. Função hepática, bilirrubinas, INR/fibrinogênio, hemograma, glicemia seriada, amônia e função renal; imagem para siderose e biópsia de glândula salivar menor quando indicada pelo centro. Coagulopatia pode contraindicar biópsia hepática. Corrigir hipoglicemia imediatamente e oferecer suporte hemodinâmico/respiratório.

Tratamento especializado. Exsanguineotransfusão seguida de imunoglobulina IV é estratégia baseada principalmente em séries/coortes. Estudos empregam **IVIG1 g/kg**; ANMF apresenta 1–2 g/kg/dia após troca na primeira semana, com repetição selecionada. Não transformar essa variação em curso diário automático; definir sequência e repetição com hepatologia.

Exemplo operacional estrangeiro. Privigen 10%=100 mg/mL: 1 g/kg corresponde a 10WmL. ANMF: iniciar 0,5 mL/kg/h por 1 h, depois 1 mL/kg/h por 1 h,2 mL/kg/h por 1 h e, se tolerado,4 mL/kg/h, teto 25 mL/h. Para 3 kg, dose 3 g=30 mL; etapas 1,5;3;6;12 mL/h. Após 3 h foram administrados 10,5 mL;19,5 mL restantes a 12 mL/h levam 1,625 h. Reverso 30×100=3.000 mg. Essa velocidade é específica da formulação citada, não de toda imunoglobulina.

Vigilância. Reação infusional, hemólise, trombose, sobrecarga e lesão renal; via exclusiva. Evitar produto com sorbitol no neonato pela possibilidade de intolerância hereditária à frutose. Uso especializado, geralmente fora de bula para GALD; confirmar formulação brasileira. Ausência de recuperação exige avaliação de transplante, sem esperar ciclos sucessivos ineficazes.

Fontes consultadas: Yeh et al. — IVIG/Exchange Transfusion for GALD, estudo original, 2021; ANMF — Imunoglobulina IV Privigen, 2024.

300. Hidratação Venosa Neonatal

Escopo operacional. Para RN>32 semanas e>1.500 g fora de UTIN, RCH orienta SG 10% nas primeiras 24–48 h quando alimentação enteral é insuficiente. Aporte hídrico diário de referência: 32–36 semanas,60/80/100/120 mL/kg nos dias 1/2/3/≥4; a termo>36 semanas,60/90/100–120/100–120 mL/kg. Ajustar por peso, diurese, sódio, perdas e doença; contabilizar dieta, drogas e lavagens. Não usar essa tabela em prematuro extremo como padrão automático.

Bomba e glicose. Volume diário=T×W; velocidade=T×W÷24 mL/h. SG 10%=100 mg/mL. GIR=100×velocidade÷(60W)mg/kg/min. Exemplo 3 kg, primeiro dia,60 mL/kg/dia: 180 mL/dia=7,5 mL/h; GIR4,17 mg/kg/min. Reverso 7,5×24÷3=60 mL/kg/dia;7,5×100÷180=4,17 mg/kg/min. Em6/12/24 h, consumo 45/90/180 mL. “Duração pelo volume” não estabelece validade da bolsa nem estabilidade.

Choque e perdas. Em hipovolemia verdadeira, SF 0,9%10 mL/kg seguido de reavaliação; isso é ressuscitação, separada da manutenção. Perdas digestivas precisam ser medidas e repostas individualmente. Sódio e potássio são introduzidos após avaliação da fase pós-natal, eletrólitos e diurese; não adicionar K em anúria ou hiperpotassemia.

Monitorização. Peso, balanço, glicemia e eletrólitos; procurar edema, taquipneia, hiponatremia e extravasamento. Glicose>12,5% geralmente exige acesso central na referência utilizada. Restrição hídrica não deve produzir oferta glicêmica inadequada: aumentar concentração com acesso apropriado pode ser necessário. Se alimentação adequada não será estabelecida até o quinto dia, ou em doença gastrointestinal importante, avaliar nutrição parenteral precocemente. Os cálculos fornecem auditoria dimensional; a decisão do aporte continua sendo clínica.

Fontes consultadas: RCH — Neonatal intravenous fluids.

301. Hipoglicemia Neonatal

Reconhecer e agir. Tremores, letargia, apneia, cianose ou convulsão podem representar hipoglicemia; estabilizar ABC, medir glicemia imediatamente e confirmar em laboratório sem atrasar correção. O limiar de intervenção depende das horas de vida, fatores de risco e sintomas; um único corte não serve a todas as situações. RN sintomático ou com glicose muito baixa precisa de acesso IV e unidade neonatal.

Correção. SG 10%=100 mg/mL: **2 mL/kg IV**, equivalentes a 200 mg/kg, lentamente, seguido imediatamente por infusão contínua; não administrar glicose 50% diretamente ao neonato. A referência inicia SG 10%60 mL/kg/dia, titulando pela glicemia. Rever em cerca de 30 min e aumentar a oferta se persistir baixa. Fórmula GIR=100×mL/h÷(60W). Para 3 kg: bolus 6 mL=600 mg; manutenção inicial 180 mL/dia=7,5 mL/h=4,17 mg/kg/min. Se clinicamente ajustado para 80 mL/kg/dia: 10 mL/h e5,56 mg/kg/min. O volume deve respeitar a condição cardíaca e renal; concentrações elevadas exigem acesso apropriado. Alimentação/gel bucal têm lugar em RN estável selecionado, mas não substituem IV no quadro sintomático grave.

Resgate especializado. Quando acesso/glicose não estão disponíveis ou há refratariedade, ANMF admite **glucagon 200 microgramas/kg IM/IV, máximo 1 mg**; IV em 3–5 min. Apresentação citada: frasco 1 mg reconstituído com 1 mL do diluente próprio → 1 mg/mL; dose 0,2WmL, máximo 1 mL. Para 3 kg: 0,6 mg=0,6 mL. Pode falhar com estoque hepático esgotado. Glicose IV deve ser estabelecida assim que possível. Infusão contínua, diazóxido ou octreotida dependem de investigação especializada e não são escalada empírica automática.

Persistência e alta. Antes da correção, se não causar atraso, obter amostra crítica orientada pelo endocrinologista em episódios persistentes; avaliar hiperinsulinismo, insuficiência hormonal e erros metabólicos. Monitorar glicemia, eletrólitos e recorrência durante redução gradual da oferta. Não dar alta apenas após uma medida normal. Apresentação brasileira de glucagon e protocolo etiológico de resgate precisam de confirmação local.

Fontes consultadas: Safer Care Victoria — Hypoglycaemia in neonates; ANMF — Glucagon neonatal.

302. Hipospádia

Avaliação inicial. Identificar posição do meato uretral, curvatura ventral, aspecto do prepúcio, qualidade do jato e posição dos testículos. Hipospádia isolada em criança estável não é emergência medicamentosa. **Não realizar circuncisão antes da avaliação urológica**, pois o tecido pode ser útil à reconstrução.

Quando ampliar investigação. Hipospádia proximal associada a testículos bilateralmente não palpáveis, genitália atípica ou outros sinais de diferença do desenvolvimento sexual exige avaliação neonatal especializada; distúrbio hidroeletrolítico, vômitos, hipoglicemia ou choque obrigam investigação urgente de insuficiência adrenal. Exames hormonais/genéticos e imagem devem seguir a hipótese construída pela equipe. Ultrassom de vias urinárias não é automático em toda hipospádia distal isolada.

Tratamento definitivo. Urologia pediátrica decide necessidade, técnica e momento da correção; em geral a reconstrução primária ocorre entre 6 e18 meses. Curvatura, função urinária, anatomia e perspectivas futuras importam mais do que o aspecto do meato isoladamente. Acompanhar complicações e fluxo urinário após a cirurgia.

Medicamentos. Nenhum antibiótico, anti-inflamatório ou antiemético corrige a malformação. Analgesia pós-operatória e manejo de espasmo vesical dependem da intervenção, cateter, idade e protocolo anestésico. Profilaxia antimicrobiana prolongada não deve ser prescrita para toda criança apenas porque haverá sonda. Não há dose ponderal ou BIC universal a apresentar nesta entrada; indicar um fármaco sem procedimento definido criaria uma prescrição fictícia.

Orientação. Explicar aos cuidadores que o diagnóstico exige planejamento, geralmente sem tratamento urgente. Retenção urinária, dor intensa, infecção ou deterioração sistêmica mudam o destino para avaliação hospitalar.

Fontes consultadas: EAU — Paediatric Urology, Hypospadias.

303. Onfalite

Urgência. Eritema progressivo, edema, pus ou odor fétido no coto sugerem onfalite; hipotermia, apneia, recusa alimentar ou má perfusão podem indicar sepse. ABCDE, glicemia, hemocultura sem atrasar antibiótico, cultura de secreção e investigação sistêmica dirigida. Necrose, bolhas ou progressão rápida exigem cirurgia para excluir fasciíte. Internar.

Antibióticos. Oxacilina+gentamicina é uma opção quando a epidemiologia permite; gentamicina está no tópico 307. Cobertura para MRSA/anaeróbios depende do quadro e das culturas. Não utilizar somente pomada. A tabelaHC-UFMG usa **peso ao nascer eIPN**, diferentemente da tabela ANMF de ampicilina porIPM:

Peso ao nascer	IPN	Oxacilina IV por dose	Intervalo
<1.200 g	0–4 semanas	25 mg/kg	12 h
1.200–2.000 g	≤7 dias	25 mg/kg	12 h
1.200–2.000 g	>7 dias	25 mg/kg	8 h
>2.000 g	≤7 dias	25 mg/kg	8 h
>2.000 g	>7 dias	25–50 mg/kg	6 h

Meningite: 50 mg/kg nos mesmos intervalos, com escolha de cobertura específica. Não inferir intervalo para peso<1.200 g após 4 semanas a partir de coluna inexistente; individualizar. Calcular dose pelo peso de dosagem atual definido pela equipe; peso ao nascer seleciona a coluna.

Produto/preparo brasileiro. Oxacilil 500 mg: para IV direto, adicionar 5 mL de água para injeção ou SF 0,9%; o volume final aproximado é5,37 mL, concentração 93,11 mg/mL, **não 100 mg/mL**. Administração IV lenta em aproximadamente 10 min. Para 3 kg a 25 mg/kg: 75 mg÷ 93,11≈0,8055 mL; arredondamento deve respeitar seringa e protocolo. Aritmeticamente,0,8055 mL em 10 min corresponde a 4,833 mL/h por 10 min; não prolongar por 1 h. Reverso usando concentração exata 500/5,37:0,8055×500/5,37=75 mg.

Vigilância. Não misturar com gentamicina; contabilizar lavagem/espaço morto sem bolus acidental. Monitorar acesso, alergia, hemograma/função renal/hepática e extensão da infecção. Duração depende de bacteremia, foco e resposta, sem curso único para toda onfalite. Diluição adicional para infusão contínua/intermitente segue bula/farmácia; não adaptar concentração automaticamente.

Fontes consultadas: HC-UFMG/Ebserh — Sepse neonatal, versão 04, 17/10/2024; FreseniusKabi — Oxacilil, bula profissional brasileira; MS — Primeira consulta do recém-nascido.

304. Onfalocele e Gastrosquise

Distinguir e estabilizar. Gastrosquise geralmente tem alças expostas ao lado do umbigo; onfalocele apresenta saco envolvendo vísceras na inserção do cordão. Ambas exigem equipe neonatal/cirurgia pediátrica. Aquecer, monitorar ABCDE, glicemia e perfusão; evitar lesão/torsão do mesentério. Não tentar redução forçada à beira do leito.

Proteção e transporte. Cobrir/proteger as vísceras com material estéril apropriado e barreira plástica, sem compressão; manter o saco da onfalocele íntegro. Posicionar sustentando o intestino e evitando tração. Suspender dieta, instalar sonda para descompressão, obter acesso venoso e iniciar aporte de glicose; medir e repor perdas conforme balanço e sódio. Se há hipovolemia, usar aliquotas cautelosas e reavaliar, sem aplicar uma fórmula de reposição fixa a toda gastrosquise. Registrar cor/perfusão intestinal e débito da sonda durante transferência.

Cirurgia e terapia associada. Fechamento primário ou redução gradual em silo depende da anatomia, edema e tolerância hemodinâmica/ventilatória. Antibiótico perioperatório é escolhido pelo cirurgião e protocolo; presença de perfuração, necrose ou sepse muda cobertura/duração. Quando ampicilina/gentamicina forem selecionadas, os intervalos neonatais encontram-se no tópico 307. Nutrição parenteral é frequentemente necessária; a composição exige prescrição da UTIN, não apenas um volume total.

Onfalocele. Avaliar malformações associadas, especialmente cardíacas, e necessidade de investigação genética. Onfalocele gigante pode exigir estratégia distinta e tratamento tardio; não presumir a mesma operação indicada na gastrosquise.

Segurança e destino. Observar piora ventilatória, oligúria ou hipoperfusão após redução, possíveis sinais de pressão intra-abdominal excessiva. Analgesia e ventilação devem acompanhar a intervenção. Alta somente após recuperação cirúrgica e plano nutricional; seguir crescimento e possíveis complicações intestinais. Não existe BIC de “tratamento da malformação”: as infusões são suporte individualizado.

Fontes consultadas: CHOP — Gastroschisis; RCH — Recognition of the seriously unwell neonate.

305. Policitemia Neonatal

Confirmar antes de tratar. Policitemia neonatal é definida por hematócrito venoso elevado; resultado capilar pode superestimar o venoso e deve ser confirmado se for motivar intervenção. Procurar hipoglicemia, dificuldade respiratória, letargia, má alimentação, cianose, trombose e outras causas desses sintomas. A orientação UCSF aqui utilizada aplica-se a RN com IG≥34 semanas.

Decisão de troca parcial. Em assintomáticos com hematócrito≤75%, a referência não recomenda troca. Acima de 75%, benefício permanece incerto e a decisão é individual. Com hematócrito>65% e sintomas atribuíveis à hiperviscosidade, discutir troca parcial com neonatologia. Evitar tratar apenas um número; alimentação/hidratação e acompanhamento podem ser suficientes em muitos casos.

Cálculo e solução. Volume de troca = **[(Hct inicial−Hct alvo)/Hct inicial]×W×90 mL/kg**, usando alvo 50% na referência. Solução de reposição: SF 0,9%. É procedimento isovolêmico com retirada e reposição controladas, não infusão líquida adicional de todo o volume calculado. Exemplo 3 kg, Hct 75%, alvo 50%:25÷75×3×90=**90 mL**. Conferência: volume sanguíneo estimado 270 mL; fração trocada 1/3, reduzindo teor estimado de 0,75 para 0,50 sob as premissas da fórmula. Aliquotas de 5 mL/kg seriam 15 mL, seis ciclos no exemplo.

Execução e vigilância. Equipe habilitada, monitorização contínua, técnica de acesso e trocas conforme protocolo, controle de glicose e perfusão; interromper diante de instabilidade. A fórmula não autoriza fixar velocidade universal de bomba. Repetir hematócrito por volta de 4 h após procedimento e seguir quadro clínico.

Limites. Não extrapolar esse algoritmo para prematuro<34 semanas, choque, cardiopatia complexa ou trombose sem discussão especializada. Procedimento tem riscos e não demonstrou benefício neurodesenvolvimental consistente no assintomático. Registrar justificativa e consentimento clínico segundo prática institucional.

Fontes consultadas: UCSF — Partial Exchange Transfusion for Polycythemia.

306. Sangramento no Neonato

Emergência e causas. Sangramento relevante no RN exige ABCDE, acesso, hemodinâmica e correção de choque; investigar deficiência de vitaminaK, consumo por sepse, doença hepática, plaquetopenia e distúrbio hereditário. Hemograma/plaquetas, TP/INR, TTPa, fibrinogênio, função hepática e tipagem; resultado neonatal deve usar referência etária. Sangue materno deglutido pode simular hemorragia digestiva em RN bem, mas não explica instabilidade.

Fitomenadiona no sangramento por deficiência. ANMF: **1 mg IV lentamente**, sem ultrapassar 1 mg/min; repetir após 4–6 h se necessário segundo resposta. A dose é fixa, não 1 mg/kg. Formulação neonatal citada: KonakionMM pediátrico 2 mg/0,2 mL=10 mg/mL. Para facilitar administração: 0,2 mL(2 mg)+1,8 mL de SF 0,9% ou SG 5% → 2 mL a 1 mg/mL; administrar 1 mL para 1 mg. Reverso 1×1=1 mg. Monitorar reação de hipersensibilidade e resposta da coagulação. Não trocar formulações adulta/neonatal sem conferir composição e autorização.

Profilaxia não é resgate. Na mesma referência, peso≥1.500 g: 1 mg IM; <1.500 g: 0,5 mg IM ao nascimento. No produto 10 mg/mL, volumes 0,1 e0,05 mL, respectivamente. Esses volumes pequenos exigem seringa apropriada e dupla conferência. Via IM não é a primeira escolha para corrigir sangramento ativo com coagulopatia importante.

Hemocomponentes. Hemorragia grave pode exigir concentrado de hemácias, plasma, plaquetas e/ou fibrinogênio, definidos pela causa e exames com hemoterapia. Não corrigir automaticamente um TTPa isoladamente prolongado com plasma em RN sem sangramento. O efeito da vitaminaK não substitui reposição urgente de fatores em hemorragia ameaçadora à vida.

Destino. Internação e investigação do sítio, inclusive intracraniano quando indicado. Reavaliar hemoglobina, coagulação e perfusão após intervenção. A apresentação brasileira efetivamente disponível e volumes/velocidades dos componentes permanecem itens de prescrição individual.

Fontes consultadas: ANMF — Vitamina K1; NHS Lothian — Neonatal Coagulation Guidelines, 2024.

307. Sepse Neonatal

Reconhecimento. RN com apneia, instabilidade térmica, prostração, má perfusão ou disfunção orgânica exige ABCDE, glicemia, hemocultura sem atraso terapêutico, investigação do foco e suporte em unidade neonatal. Punção lombar quando segura; suspeita meníngea muda drogas/dose. Hemograma/PCR isolados não confirmam nem excluem sepse.

Empírico precoce: ampicilina+gentamicina é opção habitual, adaptada ao antibiograma local. Ampicilina **50 mg/kg/dose IV**; meningite 100 mg/kg/dose, máximo 400 mg/kg/dia. Intervalos ANMF:

IPM	IPN	Intervalo
<30 semanas	0–28 dias / ≥29 dias	12 h / 8 h
30–36 semanas+6 dias	0–14 dias / ≥15 dias	12 h / 8 h
37–44 semanas+6 dias	0–7 dias / ≥8 dias	12 h / 8 h
≥45 semanas	qualquer	6 h

Ampicilina IV: concentração final de referência 50 mg/mL para dose usual,30 mg/mL na dose meníngea, diluída em SF 0,9%, infusão 30 min. A concentração após reconstituição depende do fabricante/deslocamento do pó. Dose usual 50Wmg= WmL a 50 mg/mL; bomba 2WmL/h por 30 min. Exemplo 3 kg: 150 mg=3 mL,6 mL/h por 30 min; reverso 6×0,5×50=150 mg.

Gentamicina: ANMF 5 mg/kg/dose IV; IPM<30 semanas a cada 48 h;30–34 semanas+6 dias a cada 36 h;≥35 semanas a cada 24 h. Ajustar por função renal, níveis e hipotermia terapêutica; não empilhar doses em anúria. Solução final 2 mg/mL: 5Wmg → 2,5WmL. Exemplo 3 kg: 15 mg=7,5 mL; se infusão 30 min,15 mL/h. ANMF permite 5–30 min e recomenda primeira dose em 5 min: o tempo deve estar explícito, sem atrasar o tratamento. Produto 10 ou 40 mg/mL precisa de diluições diferentes para chegar a 2 mg/mL. Não misturar aminoglicosídeo e betalactâmico na mesma seringa; lavar o acesso conforme compatibilidade.

Revisão. Dosagem sérica de gentamicina deve seguir horário definido pelo protocolo, sem confundir coleta de 22 h com vale. Sepse tardia exige cobertura conforme ambiente/foco; oxacilina é alternativa para MSSA, e vancomicina não é inclusão universal. Reavaliar indicação em 36–48 h se culturas negativas e evolução tranquilizadora. Infecção confirmada determina duração: bacteremia por GBS10 dias; meningite por Gram-negativo geralmente≥21 dias. Esses cursos não se aplicam a todo RN investigado.

Limites: tabelas pressupõem farmacocinética habitual; meningite, resistência, lesão renal e ECMO exigem individualização. Formulações brasileiras e compatibilidades da linha precisam de conferência farmacêutica local.

Fontes consultadas: HC-UFMG/Ebserh — Sepse neonatal, versão 04, 17/10/2024; ANMF — Ampicilina; ANMF — Gentamicina, 2024.

308. Sífilis Congênita

Classificar exposição e doença. Revisar tratamento materno documentado, intervalos e títulos; examinar RN e comparar teste não treponêmico quantitativo em sangue periférico com o materno. Exame normal não exclui infecção. Conforme cenário, solicitar hemograma/plaquetas, ossos longos, líquor com VDRL/celularidade/proteína, avaliação ocular/auditiva e hepática. Não usar sangue de cordão para a comparação sorológica.

Tratamento de sífilis congênita no período neonatal. Benzilpenicilina potássica/cristalina **50.000 UI/kg/dose IV a cada 12 h nos primeiros 7 dias de vida e a cada 8 h após o sétimo dia**, por 10 dias. É esquema que alcança o SNC; ajustar o intervalo quando a criança atravessa a faixa de IPN durante o curso. Exemplo 3 kg: 150.000 UI por dose; duas doses/dia correspondem a 300.000 UI/dia, três a 450.000 UI/dia. Dose permanece 50.000 UI/kg, não aumenta para 50.000 UI/kg/h.

Preparo. Usar a concentração final verificada na bula/protocolo institucional emUI/mL: volume=50.000×W÷C. Exemplo meramente dimensional, caso a farmácia tenha validado C=100.000 UI/mL: 150.000÷100.000=1,5 mL por dose. Não assumo essa concentração para qualquer frasco. Reconstituição, diluição e tempo de infusão devem acompanhar o produto real. Nunca converterUI para“mg” sem a equivalência específica.

Alternativas restritas. Penicilina procaína 50.000 UI/kg IM uma vez ao dia por 10 dias pode ser escolhida quando o cenário e a avaliação de SNC permitem. Penicilina benzatina 50.000 UI/kg IM em dose única é reservada a situações de menor risco que preencham todos os critérios do protocolo e tenham seguimento garantido; não trata adequadamente neurossífilis e não substitui o curso IV em avaliação incompleta/alterada.

Vigilância. Conferir continuidade das doses, reação alérgica/Jarisch–Herxheimer e evolução. Interrupções relevantes exigem revisão do curso completo conforme protocolo. Acompanhar títulos não treponêmicos e desenvolvimento, audição/visão; tratar e acompanhar a mãe/parceiros pela equipe assistente. Não dar alta sem plano de seguimento.

Fontes consultadas: MS — Protocolo brasileiro de sífilis congênita e criança exposta, 2020/2021.

309. Síndrome de Aspiração Meconial

Identificar gravidade. Líquido meconial com desconforto respiratório exige avaliar ventilação, oxigenação, pneumotórax, pneumonia e hipertensão pulmonar persistente. O diagnóstico não depende apenas da presença de mecônio. Monitorar saturação pré/pós-ductal, perfusão, gases e imagem de tórax; ecocardiograma ajuda a confirmar hipertensão pulmonar e excluir cardiopatia.

Suporte respiratório. Garantir ventilação eficaz, oxigênio titulado e pressão compatível com a mecânica heterogênea do pulmão; evitar hiperinsuflação. CPAP pode bastar em quadros selecionados, enquanto falência respiratória requer intubação e UTIN. Hipoxemia súbita ou assimetria da ausculta obriga excluir escape de ar. Não atrasar ventilação necessária para procedimentos de aspiração repetidos.

Surfactante e iNO. Em doença grave ventilada, surfactante de resgate pode ser considerado por inativação do surfactante endógeno. Poractantoalfa 80 mg/mL, dose inicial de referência 200 mg/kg=2,5 mL/kg intratraqueal; **uso em aspiração meconial difere da indicação brasileira usual de SDR** e requer decisão especializada, sem importar automaticamente todas as repetições do tópico 295. Para hipertensão pulmonar com insuficiência hipóxica em RN de termo/próximo do termo, CPS recomenda óxido nítrico inalatório inicialmente 20 ppm com avaliação da resposta. A concentração é emppm no circuito, não emmg/kg nem mL/h de bomba IV. Necessita equipamento próprio, monitorização deNO_2/metemoglobina e desmame gradual; interrupção abrupta pode causar rebote.

Outras classes. Antibiótico é dirigido à suspeita infecciosa e culturas, não tratamento da pneumonite química isolada. Corticoide, broncodilatador e diurético não são rotina para todo caso. Sedoanalgesia e vasoativo, quando indicados, devem ser titulados com hemodinâmica/ecocardiografia.

Destino. UTIN nos quadros moderados/graves, discussão de transporte/ECMO se hipoxemia refratária em centro habilitado. A alta depende de estabilidade sem suporte relevante e alimentação segura. Apresentação, repetição do surfactante e elegibilidade paraiNO requerem validação institucional.

Fontes consultadas: Safer Care Victoria — Meconium aspiration syndrome; Canadian Paediatric Society — Inhaled nitric oxide, 2023; ANMF — Poractant alfa.

310. Taquipneia Transitória do Recém-nascido

Hipótese de trabalho. Taquipneia transitória costuma iniciar nas primeiras horas, especialmente após cesariana sem trabalho de parto, e tende a melhorar em 48–72 h. É diagnóstico de exclusão: sepse/pneumonia, SDR, pneumotórax, cardiopatia e hipertensão pulmonar podem apresentar quadro semelhante. A palavra“transitória” não autoriza observação sem monitorização de um RN hipóxico.

Avaliar. ABCDE neonatal, frequência/esforço respiratório, saturação, temperatura, perfusão e glicemia. Radiografia pode mostrar estrias perihilares, volumes normais/aumentados e líquido em fissuras. Culturas e investigação infecciosa são direcionadas por fatores maternos e evolução. A diretrizQueensland citada concentra-se emIG≥32 semanas; prematuros menores precisam de protocolo próprio.

Tratamento. Ambiente térmico adequado, oxigênio titulado e CPAP quando esforço/oxigenação exigem. Não existe medicamento específico comprovado para toda TTN; furosemida, salbutamol e corticoide não integram uma prescrição automática. Suspeita de sepse deve ser tratada como tal, com reavaliação após culturas, sem manter antibiótico apenas pelo rótulo de TTN.

Alimentação e fluidos. Evitar alimentação oral quando há esforço incompatível com sucção segura. Suporte IV ou enteral por sonda depende da estabilidade. Para criança que se enquadre no escopo do tópico 300, usar aquele cálculo de SG 10% e balanço; não adicionar volume duplicado por coexistirem dois capítulos. Exemplo de auditoria: uma ordem total de 7,5 mL/h corresponde a 45 mL em 6 h, independentemente do nome da hipótese respiratória. A taxa apropriada continua dependente de glicemia e balanço.

Reavaliação e destino. Aumento rápido deFiO_2, apneia, acidose, má perfusão ou ausência de melhora esperada exige rever diagnóstico e transferir/escalar cuidados. Alta após estabilidade respiratória, alimentação eficaz e ausência de hipótese infecciosa/cardiovascular pendente.

Fontes consultadas: Queensland Health — Respiratory distress and CPAP, 2024.

311. Toxoplasmose Congênita

Investigar e acompanhar. Infecção congênita pode ser assintomática ao nascimento. Integrar sorologia materna/infantil, testes específicos, avaliação oftalmológica, neuroimagem, líquor, audição e hemograma; comparar resultados com contexto gestacional. Hidrocefalia, convulsão, retinocoroidite ou comprometimento sistêmico exigem especialistas e internação conforme gravidade. Não excluir doença porque a tríade clássica está ausente.

Esquema oral do fluxo MS. Sulfadiazina **100 mg/kg/dia em duas doses**, por 12 meses; pirimetamina **1 mg/kg uma vez ao dia por 2–6 meses**, conforme intensidade, depois 1 mg/kg em três dias da semana até completar 12 meses; ácido folínico **10 mg três vezes/semana**. O fluxo MS consultado não explicita ataque inicial de pirimetamina; esquemas com ataque em outras referências exigem escolha consciente do protocolo, sem sobreposição. Ácido fólico **não** substitui folínico.

Apresentações e volumes. MS cita comprimidos de sulfadiazina 500 mg, pirimetamina 25 mg e folínico 15 mg, com preparações farmacêuticas de 100 mg/mL,2 mg/mL e5 mg/mL, respectivamente. Não são soluções caseiras; estabilidade/validade devem constar do rótulo. Exemplo 3 kg: sulfadiazina 150 mg/dose=1,5 mL a cada 12 h; pirimetamina 3 mg=1,5 mL nos dias prescritos; folínico 10 mg=2 mL por administração. Reversos: 1,5×100=150;1,5×2=3;2×5=10 mg. Recalcular pelo crescimento.

Toxicidade e adjuvante. Hemograma seriado; neutrófilos<1.000/mm³: o fluxo orienta folínico 20 mg/dia; <500/mm³: suspender pirimetamina até recuperação, mantendo folínico por mais uma semana após interrupção. Monitorar bilirrubina e hidratação com sulfadiazina no RN. Prednisona/prednisolona 1 mg/kg/dia dividida em duas doses somente para retinocoroidite ativa e/ou proteína liquórica≥1.000 mg/dL, sempre junto aos antiparasitários, com retirada gradual orientada.

Continuidade. Infectologia/oftalmologia definem duração da fase diária e do corticoide; seguimento visual/neurológico é prolongado. Prematuridade extrema, disfunção renal/hepática e intolerância exigem individualização; não há teto adulto neonatal inventado neste regime.

Fontes consultadas: MS — Abordagem da toxoplasmose no recém-nascido; HC-UFMG/Ebserh — Toxoplasmose congênita, versão 03.

312. Transposição de Grandes Artérias (TGA)

Emergência. Cianose neonatal desproporcional ao achado pulmonar, hipoxemia refratária, acidose ou choque podem indicar circulação em paralelo por TGA. Estabilizar via aérea/ventilação, temperatura, glicemia e perfusão, medir saturação pré/pós-ductal e obter ecocardiograma urgente. Não esperar um“teste de hiperóxia” prolongado para chamar cardiologia. Transferência para centro cardiocirúrgico deve iniciar durante estabilização.

Manter comunicação ductal. Alprostadil/PGE_1IV contínuo: referência ANMF inicia **10 nanogramas/kg/min**, equivalentes a **0,01microgramа/kg/min**, com titulação à resposta. Em instabilidade podem ser necessários 20–50 nanogramas/kg/min; manutenção na menor dose eficaz, frequentemente 3–20. Doses maiores são decisão especializada. Ter material/equipe para apneia e hipotensão, especialmente no transporte.

Exemplo de preparo padronizado estrangeiro. Produto 500 microgramas/mL. Para 3 kg, concentração ANMF 5 microgramas/mL: retirar 0,2 mL(100 microgramas), completar com SF 0,9% até 20 mL. A10 nanogramas/kg/min: 0,01×3×60÷5=**0,36 mL/h**. Reverso 0,36×5÷60÷3=0,01microgramа/kg/min=10 nanogramas/kg/min. Consumo em 6/12/24 h: 2,16/4,32/8,64 mL. A duração aritmética de 20 mL não determina estabilidade; trocar segundo farmácia/protocolo. Não usar a concentração escolhida para 3 kg automaticamente em extremos de peso, nem confundir“nano” e“micro”, diferença de 1.000 vezes.

Tratamento definitivo. Ducto aberto pode não garantir mistura suficiente. Septostomia atrial de emergência é considerada quando comunicação atrial restritiva mantém hipoxemia; correção cirúrgica é definida pela anatomia. AINE para fechar canal seria inadequado nesta situação. Analgésico, antiemético e protetor gástrico não são tratamento da TGA por constarem de um inventário.

Destino e limites. UTIN/cardiologia, monitorização contínua da perfusão, lactato, PA e apneia; acesso e bomba confiáveis durante transferência. Apresentação brasileira e padronização local de alprostadil precisam ser verificadas antes do preparo.

Fontes consultadas: ANMF — Alprostadil, concentrações padronizadas, 2026; RCH — Recognition of the seriously unwell neonate.

313. Beribéri em Pediatria

Suspeitar. Lactente com insuficiência cardíaca de instalação rápida, taquicardia, acidose/lactato elevado, afonia, irritabilidade ou manifestações neurológicas, especialmente com risco nutricional materno, pode ter deficiência de tiamina. Não esperar ensaio laboratorial para tratar forte suspeita em criança instável. Avaliar ABCDE, glicemia, gases/lactato, eletrólitos, ECG/eco e causas infecciosas/cardiológicas concorrentes.

Reposição no beribéri infantil sintomático. MSF: **tiamina 25 mg IV inicialmente**, depois 25 mg IM uma ou duas vezes ao dia; quando houver melhora, passar a 10 mg VO uma vez ao dia. A transição e a duração dependem da recuperação e correção da causa. Essa dose é fixa de referência para beribéri infantil, não 25 mg/kg. Reposição preventiva/subclínica tem outro regime e não deve substituí-la na urgência. Corrigir magnésio se deficiente e garantir suporte nutricional; glicose urgente para hipoglicemia não deve ser atrasada esperando tiamina, que deve acompanhar o tratamento assim que disponível.

Preparo conferido na referência estrangeira. MSF cita 100 mg/2 mL=50 mg/mL;25 mg correspondem a 0,5 mL. IV deve ser muito lenta, cerca de 30 min, com diluição/compatibilidade segundo produto e farmácia. Se a farmácia validar volume final de 10 mL para essa dose, a conta é20 mL/h por 30 min; isso é exemplo de bomba, não declaração de compatibilidade de uma marca brasileira. Reverso 20×0,5=10 mL contendo 25 mg. Não usar um volume final sem validar sua composição.

Monitorização. Perfusão, FC, diurese, lactato, estado neurológico e reação à infusão; avaliar também a mãe e a alimentação. Falta de melhora exige rever diagnósticos/complicações, não apenas repetir vitaminas. Alta após estabilização e plano de reposição/alimentação e seguimento.

Limitação farmacêutica. A concentração citada não foi confirmada para produto brasileiro. Preparações de complexoB não são automaticamente equivalentes à tiamina isolada. Conferir concentração real evita erro de diluição, inclusive inconsistências aritméticas de manuais antigos.

Fontes consultadas: MSF — Tiamina injetável; RCH — Micronutrient deficiency.

314. Defeitos no Metabolismo da Fenilalanina

Confirmar o mecanismo. Fenilalanina elevada no teste do pezinho requer confirmação e encaminhamento imediato a centro metabólico. Diferenciar deficiência de fenilalanina-hidroxilase de distúrbios deBH4, que podem exigir tratamento de neurotransmissores além de controlar fenilalanina. Não esperar surgirem atraso do desenvolvimento ou convulsões. Avaliar crescimento, ingestão e níveis seriados conforme protocolo.

Base terapêutica. Dieta com oferta controlada de fenilalanina e fórmula metabólica apropriada, preservando energia, proteína equivalente e micronutrientes; acompanhamento por nutricionista especializado e ajustes frequentes no crescimento. Não suspender indiscriminadamente toda proteína ou aleitamento: o plano deve integrar fontes naturais medidas e fórmula, evitando deficiência essencial. Metas laboratoriais e frequência variam com idade e contexto reprodutivo; seguirPCDT/centro.

Sapropterina. Considerar somente em pacientes responsivos, sem abandonar a dieta. A indicação brasileira inclui pacientes a partir de 1 mês que respondam ao tratamento. Como referência posológica **estrangeira**, BioMarinEUA: 1 mês–6 anos iniciar 10 mg/kg VO uma vez/dia;≥7 anos 10–20 mg/kg/dia, ajuste pela resposta dentro de 5–20 mg/kg/dia. Conferir elegibilidade e bula brasileira antes de prescrever. Crianças menores têm risco de fenilalanina excessivamente baixa, especialmente na dose alta.

Cálculo. Exemplo de 10 kg a 10 mg/kg/dia: 100 mg/dia; a 20 mg/kg/dia: 200 mg/dia. Reverso 100÷10=10 mg/kg/dia. Isso não demonstra responsividade e não define o número de comprimidos de qualquer apresentação. A dispersão em água e volume a administrar devem seguir a apresentação autorizada; não foi adotada concentração líquida brasileira sem validação.

Seguimento. Níveis de fenilalanina, crescimento, neurodesenvolvimento, adesão e suficiência nutricional; ajustar pela ingestão e intercorrências. Ausência de resposta documentada implica reavaliar continuidade da droga. Crise neurológica ou descompensação exige serviço especializado. Tratamento é longitudinal, não um curso antibiótico nem BIC.

Fontes consultadas: MS — PCDT Fenilcetonúria, 2020; BioMarin Brasil — Kuvan; BioMarin — Kuvan, bula profissional EUA, 2026.

315. Deficiência de Biotina

Distinguir deficiência adquirida e enzimática. Dermatite, alopecia, convulsões, hipotonia e acidose podem ocorrer na deficiência de biotina/biotinidase. Triagem neonatal alterada exige confirmação enzimática e avaliação especializada; não atribuir convulsão exclusivamente à vitamina antes de estabilizar e excluir causas urgentes. Prematuridade, transfusão e fatores de coleta podem interferir na interpretação da triagem.

Biotinidase — tratamento oral. O protocolo públicoSES-BA atualizado em 2026 informa dose inicial **5 mg/dia na deficiência leve;10 mg/dia na grave ou caso suspeito**, independentemente do peso. Na ausência rara de resposta/exacerbação, até 20 mg/dia é reservado a centro de referência. O tratamento da doença genética é prolongado, em geral permanente; deficiência nutricional adquirida exige investigação e correção da causa, sem presumir o mesmo plano vitalício.

Apresentação e cálculo. A oferta pública citada usa cápsulas de 2,5 mg. Assim,5 mg correspondem ao conteúdo de duas cápsulas e10 mg ao de quatro;20 mg seriam oito, somente se formalmente indicado. Reverso 4×2,5=10 mg. Em lactente, a farmácia/equipe deve definir como administrar integralmente o conteúdo em pequeno volume; não dar cápsula inteira para quem não deglute nem misturar em mamadeira grande que pode não ser consumida. Não existe concentração emmg/mL universal nem equivalência confiável em“gotas” sem produto.

Monitorização. Resposta cutânea/neurológica, crescimento, audição e visão; lesões já estabelecidas podem não reverter integralmente. Biotina em doses terapêuticas interfere em alguns imunoensaios, inclusive resultados hormonais/cardiológicos; informar laboratório e assistência antes da coleta, seguindo orientação específica do método. Não suspender tratamento essencial por conta própria para um exame.

Destino. Crise, acidose ou deterioração: internação. Criança estável: centro de triagem/metabolismo, acompanhamento multidisciplinar e plano de fornecimento contínuo. Registrar unidade emmg, evitando confusão commicrogramas de suplementos comuns.

Fontes consultadas: SES-BA — Deficiência de biotinidase, atualização 11/08/2026; MS — Deficiência de biotinidase.

316. Desnutrição Energético-Proteica Infantil

Identificar gravidade. Em6–59 meses, emagrecimento grave e/ou edema nutricional exigem classificação completa; perímetro braquial<115mm, peso/comprimento muito reduzido ou edema bilateral são sinais relevantes. Crianças<6 meses precisam de avaliação própria da alimentação e do binômio, sem aplicar automaticamente os mesmos critérios. Edema pode ocultar baixo peso e não representa hidratação adequada.

Internar quando complicado. Falta de apetite, letargia, hipotermia, hipoglicemia, infecção grave, choque ou alterações eletrolíticas indicam cuidado hospitalar. ABCDE, glicemia, temperatura, hemograma/eletrólitos e avaliação infecciosa dirigida; observar fósforo, potássio e magnésio na recuperação nutricional. Evitar realimentação agressiva e grandes volumes IV padronizados para crianças bem nutridas.

Reabilitação. Estabilização e transição alimentar graduais com formulações terapêuticas apropriadas; F75 é utilizado na fase inicial em protocolos hospitalares, depois dieta de recuperação/RUTF conforme tolerância e idade. Tratar infecções e deficiências identificadas; ferro e outros suplementos não devem ser empilhados sobre fórmulas já enriquecidas sem conferir fase e aporte total. Antibiótico depende de idade, complicações e protocolo; não reutilizar intervalos neonatais em criança maior.

Reidratação sem choque. OMS orienta volumes lentos e monitorados; ReSoMal, quando indicado e disponível, pode ser administrado **5–10 mL/kg/h até 12 h**, com reavaliações. A diretriz 2023 admite SRO de baixa osmolaridade quando ReSoMal não está disponível; suspeita de cólera/perdas aquosas muito altas exige SRO padrão. Não fabricar ReSoMal diluindo aleatoriamente um sachê. Exemplo 8 kg: 40–80 mL/h; em 2 h,80–160 mL, antes de reavaliar. Isso não autoriza completar 12 h apesar de sinais de sobrecarga.

Vigiar e seguir. FC/FR, hepatomegalia, edema, diurese, peso e ingestão; piora respiratória durante hidratação exige revisão imediata. Choque tem protocolo hospitalar específico e não é tratado por esse esquema oral.

Alta/transição somente com estabilidade, alimentação eficaz e acompanhamento nutricional próximo; garantir acesso a alimento e monitorização de recaída.

Fontes consultadas: OMS — Wasting and nutritional oedema, 2023; OMS — Reidratação na desnutrição grave sem choque.

317. Pelagra em Pediatria

Reconhecer. Dermatite fotossensível simétrica, lesões cervicais, diarreia e alterações neurológicas/cognitivas sugerem pelagra em contexto de baixa oferta de niacina/triptofano ou má absorção. Procurar desnutrição e outras deficiências. A apresentação incompleta é possível; avaliar também reação medicamentosa, dermatose inflamatória e causas infecciosas. Desidratação, encefalopatia ou desnutrição complicada indicam hospital.

Reposição dirigida. MSF informa **nicotinamida 100 mg VO três vezes ao dia para crianças e adultos**, junto de alimentação rica em proteínas, até resolução clínica. A monografia consultada usa comprimidos de 100 mg. Preferir nicotinamida, evitando substituir automaticamente por ácido nicotínico de produtos para dislipidemia. Esse regime é fixo, não 100 mg/kg; a referência não estratifica neonatos/lactentes pequenos, para os quais a dose precisa de especialista em nutrição/metabolismo antes de aplicação.

Conferência. Comprimido 100 mg: uma unidade por administração, três/dia=300 mg/dia. Reverso 300÷3=100 mg/dose. Para criança sem deglutição de comprimidos, não existe mL ou gota calculável sem concentração e preparação farmacêutica definidas. A apresentação brasileira e possibilidade de manipulação devem ser confirmadas. Não triturar um produto de liberação modificada ou associação e presumir equivalência.

Cuidados associados. Corrigir ingestão energética/proteica e demais carências identificadas; proteger pele do sol e reduzir irritação local. Tratar causa da má absorção ou revisar fármaco associado. Sintomas digestivos/neurológicos e lesões devem ser reavaliados; ausência de resposta obriga rever hipótese, adesão e absorção.

Destino e limite. Caso estável: acompanhamento nutricional e clínico com data de revisão. Não há indicação de antibiótico, corticoide sistêmico ou BIC como terapia universal da pelagra. A posologia citada é de formulário humanitário primário, não validação de bula pediátrica brasileira; a faixa etária incompleta é uma limitação explícita, particularmente importante no primeiro ano.

Fontes consultadas: MSF — Nicotinamide oral; OMS — Pellagra and its prevention and control.

318. Síndromes de Dependência de Vitamina B6

Quando considerar. Convulsões neonatais refratárias podem representar epilepsia dependente de piridoxina ou outro distúrbio do metabolismo daB6. Corrigir primeiro glicose/eletrólitos e investigar infecção, lesão estrutural e outras causas; obterEEG e amostras metabólicas/genéticas conforme disponibilidade, sem atrasar estabilização. A resposta à vitamina não substitui a investigação etiológica.

Teste terapêutico monitorado. ANMF: em RN≥2 kg, **piridoxina 100 mg IV em 5 min**; em RN<2 kg,30 mg/kg inicialmente, podendo complementar até 100 mg totais após 10 min sob avaliação especializada. A dose inicial de 100 mg é por dose, não por kg. Pode causar apneia, depressão neurológica ou colapso: administrar exclusivamente onde háEEG/monitorização cardiorrespiratória e capacidade imediata de ventilação/reanimação. Não é teste domiciliar.

Preparo e matemática. Monografia estrangeira: 100 mg/2 mL=50 mg/mL. Para 3 kg,100 mg=2 mL; infundir esse volume em 5 min equivale a 24 mL/h **durante apenas 5 min**, se uso sem diluição for validado pelo produto/protocolo. Reverso 24×5/60×50=100 mg. Para 1 kg,30 mg=0,6 mL; no mesmo intervalo,7,2 mL/h por 5 min. Se houver diluição, recalcular pela concentração final, não manter a mesma velocidade.

Manutenção e diagnóstico. ANMF apresenta 15–30 mg/kg/dia, geralmente uma vez ao dia, máximo 200 mg/dia no neonato; confirmar formulação oral e ajustar ao diagnóstico/resposta. Exemplo 3 kg: 45–90 mg/dia, abaixo do teto. Distúrbios como PNPO podem necessitar piridoxal-fosfato, que não é intercambiável automaticamente. Intervenções dietéticas/genéticas específicas pertencem ao centro metabólico.

Vigilância. Controle clínico/eletrográfico, desenvolvimento, toxicidade e risco de neuropatia no uso prolongado. Não interromper tratamento comprovadamente necessário sem plano. Apresentação brasileira injetável isolada

e preparo precisam ser confirmados; associação de vitaminas não deve ser usada como substituto improvisado.

Fontes consultadas: ANMF — Piridoxina.

319. Dermatite das Fraldas

Classificar a lesão. Dermatite irritativa predomina nas superfícies em contato com fralda, frequentemente poupando dobras; candidíase costuma atingir dobras e apresentar lesões satélites. Examinar intensidade, erosões, dor, diarreia e sinais de infecção. Persistência atípica pode representar dermatose, deficiência nutricional ou outra doença, não“fungo resistente” por definição.

Primeira linha. Trocas frequentes, higiene suave com água, secagem sem atrito e períodos sem fralda. Aplicar barreira simples de óxido de zinco/petrolato a cada troca; retirar sujeira superficial sem esfregar toda a camada. Formulações mais concentradas de zinco podem ajudar quando a barreira inicial falha. Não misturar pomadas de composição desconhecida.

Tratamento dirigido. Inflamação persistente pode receber **hidrocortisona 1% em camada fina uma ou duas vezes/dia**, por período curto, até 1–2 semanas conforme revisão. Suspeita deCandida: **clotrimazol 1% ou miconazol 2% tópicos duas vezes/dia**, com reavaliação da resposta. Não adicionar corticoide potente sob oclusão; a fralda aumenta absorção. A aplicação é local, não uma dose sistêmica emmg/kg. Na presença de infecção bacteriana ou doença sistêmica, selecionar abordagem própria.

Conferência de concentração. Hidrocortisona 1%=10 mg/g; miconazol 2%=20 mg/g. Essa equivalência serve para identificar o produto, não para prescrever ingestão nem calcular uma quantidade oral. “Uma camada fina” precisa de orientação demonstrada pelo profissional; não preencher a fralda com medicamento.

Destino e revisão. RN febril/hipotérmico, com bolhas, erosões extensas, pus ou prostração exige avaliação urgente. Nos casos simples, combinar data de revisão e observar adesão aos cuidados de barreira. Se não melhora, reexaminar diagnóstico antes de prolongar antifúngico/corticoide. Não há indicação rotineira de antibiótico sistêmico ou anti-histamínico para dermatite irritativa.

Fontes consultadas: RCH — Nappy rash, 2024.

320. Diarreia em Pediatria

Classificar hidratação. Avaliar estado mental, sede/ingestão, perfusão, diurese e peso quando disponível. Choque, alteração de consciência, incapacidade de beber, vômito bilioso, dor importante ou sangue com repercussão exigem hospital. Exames não são rotina na diarreia simples; eletrólitos/renal e investigação de agente são dirigidos à gravidade, persistência e contexto.

SRO e alimentação. Manter aleitamento e alimentação apropriada. Sem desidratação, oferecer SRO após perdas em pequenas quantidades repetidas. PlanoB do MS: **50–100 mL/kg, média 75 mL/kg, em 4–6 h**, sob observação e reclassificação. Exemplo 10 kg: 750 mL em 4 h=187,5 mL/h como média, ajustando à tolerância; não é uma ordem de ingestão forçada contínua. Preparar cada sachê no volume exato da embalagem, sem açúcar/sal extra.

Desidratação grave. PlanoC utiliza SF 0,9% ouRinger lactato: <1 ano,30 mL/kg em 1 h e70 mL/kg nas 5 h seguintes;≥1 ano,30 mL/kg em 30 min e70 mL/kg em 2,5 h, com avaliações frequentes. RN, cardiopatia e desnutrição grave exigem protocolo específico, não aplicação automática. Em criança 10 kg≥1 ano: 300 mL/0,5 h=600 mL/h na primeira etapa;700 mL/2,5 h=280 mL/h na segunda. Rever sinais de perfusão/sobrecarga durante cada etapa.

Adjuvantes. MS: zinco 10 mg/dia até 6 meses e20 mg/dia acima de 6 meses até 5 anos, por 10–14 dias. CPS admite **ondansetrona 0,15 mg/kg VO, máximo 8 mg, dose única**, em≥6 meses com vômitos que dificultam SRO; aguardar 15–30 min para retomá-la. Exemplo 10 kg: 1,5 mg; concentração da solução define volume. Evitar em QT longo/risco arrítmico relevante e não usar rotineiramente se diarreia é o sintoma predominante.

Antimicrobianos e alta. Reservar antibiótico a etiologias/situações indicadas; sangue nas fezes não autoriza qualquer antibiótico, sobretudo se suspeita deSTEC/SHU. Não usar antimotilidade de rotina. Alta após hidratação/ingestão adequadas, orientação de perdas e sinais de retorno. Formulações de zinco/ondansetrona

precisam de rótulo brasileiro conferido.

Fontes consultadas: MS — Manejo do paciente com diarreia; CPS — Ondansetrona na gastroenterite.

321. Escabiose em Pediatria

Confirmar e examinar contatos. Prurido, pior à noite, sulcos e distribuição típica sugerem escabiose; lactentes podem ter couro cabeludo, palmas e plantas acometidos. Procurar impetiginização e escabiose crostosa, esta exigindo tratamento especializado e controle de transmissão. A persistência de coceira após tratamento não significa, isoladamente, ácaros vivos.

Permetrina. Creme **5%**, autorizado na referência CDC a partir de 2 meses: aplicar em toda a área recomendada, incluindo cabeça/pescoço no pequeno lactente conforme orientação, evitando olhos/boca; deixar 8–14 h e lavar. Repetição em cerca de 7 dias costuma ser necessária. Conferir a bula brasileira, pois loção 1% para piolhos não é equivalente ao creme 5%.

Alternativa oral selecionada. Ivermectina **200 microgramas/kg VO**, duas doses separadas por 7–14 dias; segurança em<15 kg não está estabelecida na referência. Exemplo 20 kg: 4.000 microgramas=4 mg por dose. Reverso 4 mg×1.000÷20=200 microgramas/kg. A dose calculada não autoriza fração inexata de comprimido não apropriado; verificar apresentação/preparo com farmácia. Na escabiose, CDC orienta tomar com alimento.

Faixas especiais e medidas. Enxofre 5–10% em petrolato é opção inclusive abaixo de 2 meses, mas formulação e cronograma devem ser definidos pelo serviço. Tratar contatos próximos simultaneamente quando indicado; higienizar roupas/roupa de cama e orientar medidas domiciliares.

Revisão. Conferir técnica, contatos não tratados e novas lesões antes de declarar falha. Criança com febre, celulite, doença extensa/crostosa ou imunossupressão precisa de avaliação específica. Anti-histamínico pode aliviar sintoma selecionado, mas não erradica infestação.

Fontes consultadas: CDC — Clinical care of scabies.

322. Infecções Fúngicas em Prematuros

Suspeitar de invasão. Prematuro com sepse persistente, plaquetopenia, cateter e exposição antimicrobiana pode ter candidíase invasiva. Colher culturas e investigar SNC/olhos; culturas persistentemente positivas justificam imagem de rins/vias urinárias e outros focos. Retirar/substituir cateter infectado quando possível. A espécie e suscetibilidade orientam a terapia.

AnfotericinaB desoxicolato. IDSA recomenda **1 mg/kg IV a cada 24 h** na candidíase disseminada neonatal. Formulações lipossomais/lipídicas têm doses diferentes e não são intercambiáveis. ANMF: frasco 50 mg+10 mL de água para injeção → 5 mg/mL; retirar 1 mL e adicionar 49 mL de SG 5% → 0,1 mg/mL. Infundir em 2–6 h; não diluir/lavar com SF 0,9%, incompatível. Exemplo 1 kg: 1 mg=10 mL; em 4 h,2,5 mL/h. Reverso 2,5×4×0,1=1 mg. Via central permite concentração especial sob farmácia; não improvisar para reduzir volume.

Alternativa. Fluconazol pode ser utilizado em isolado suscetível, especialmente sem profilaxia prévia. ANMF: ataque 25 mg/kg, depois 12 mg/kg IV/VO a cada 24 h, iniciando 24 h após ataque. IV2 mg/mL, sem diluição adicional, em 30 min. Para 1 kg: ataque 12,5 mL → 25 mL/h por 30 min; manutenção 6 mL → 12 mL/h por 30 min. Reverso 12×0,5×2=12 mg. Rever intervalo na disfunção renal, além de QT e interações; não usar manutenção diária indiferentemente em anúria.

Duração e vigilância. Candidemia sem foco profundo: em geral 14 dias após documentação de clearance e resolução de sintomas; SNC/endocardite/outros focos exigem curso específico. Monitorar creatinina, diurese, K/Mg, hemograma e função hepática. Profilaxia não é universal: depende de peso, incidência da UTIN e protocolo, não apenas do rótulo“prematuro”.

Destino e limite. UTIN/infectologia; doses/preparos apresentados são formulários internacionais e precisam de conciliação com fabricante brasileiro. Lesão renal importante, espécie resistente e foco profundo requerem plano próprio, sem duplicar anfotericinas ou somar antifúngicos indiscriminadamente.

Fontes consultadas: IDSA — Candidíase, diretriz 2016, seção neonatal; ANMF — Anfotericina B convencional; ANMF — Fluconazol.

323. Pediculose em Pediatria

Diagnosticar infestação ativa. Procurar piolho vivo com pente fino e boa iluminação; lêndeas isoladas, especialmente distantes do couro cabeludo, não provam infestação ativa. Prurido pode persistir e escoriação pode infectar.

Opção tópica. CDC informa **permetrina 1% a partir de 2 meses**, de acordo com aplicação/tempo da embalagem; usualmente o produto permanece 10 min antes de enxaguar, e pode-se repetir no nono dia para atingir eclosão residual. Não usar creme 5% de escabiose como substituto automático. Produtos com piretrinas têm outras restrições etárias/alérgicas.

Falha e alternativa. Antes de mudar fármaco, conferir uso, tempo de contato, reinfestação e presença de parasita vivo. Ivermectina oral é opção **fora de bula** em algumas referências para≥15 kg: 200 microgramas/kg, com repetição em 9–10 dias; requer prescrição individual e confirmação de apresentação. Exemplo 30 kg: 6 mg por dose; reverso 6.000 microgramas÷ 30=200 microgramas/kg. Não extrapolar para crianças pequenas nem confundir com dose veterinária. Alternativas tópicas estrangeiras não são anunciadas aqui como disponíveis noBrasil.

Cuidados. Pente fino e retirada cuidadosa auxiliam; limpar itens de contato e seguir medidas domiciliares dirigidas. Não pulverizar inseticida no ambiente/corpo, não usar querosene e não associar pediculicidas indiscriminadamente. Simeticona oral“antiflatulento” não é tratamento de piolho; formulações tópicas de dimeticona são produtos distintos.

Destino. Geralmente ambulatorial, com reavaliação após o intervalo do produto. Febre, pus, celulite ou falha confirmada após esquema corretamente realizado exigem avaliação. Não há indicação de BIC ou antibiótico sistêmico sem infecção bacteriana.

Fontes consultadas: CDC — Clinical care of head lice.

324. Urticária em Pediatria

Primeiro excluir anafilaxia. Urticas transitórias/pruriginosas sem comprometimento sistêmico podem ser tratadas ambulatorialmente. Dispneia, edema de via aérea, hipotensão, síncope ou envolvimento de múltiplos sistemas mudam a conduta para anafilaxia, com adrenalina IM imediata conforme módulo específico; anti-histamínico não substitui adrenalina. Lesões dolorosas fixas>24 h, púrpura, febre ou artralgia sugerem outro diagnóstico.

H1 de segunda geração. Cetirizina VO, referência RCH: 6–11 meses 0,25 mg/kg uma vez/dia, máximo 2,5 mg;1–2 anos 2,5 mg duas vezes/dia;2–6 anos 5 mg/dia ou 2,5 mg duas vezes/dia;6–12 anos 10 mg/dia ou 5 mg duas vezes/dia;≥12 anos 10 mg/dia. A bula brasileira Zyrtec confirma solução 1 mg/mL, uso a partir de 2 anos e contraindicação em<2 anos; não utilizar esse produto nessa faixa apenas por transpor a diretriz RCH. Evitar somar H1 sedativos sem propósito.

Cálculo com a concentração brasileira conferida. Para solução 1 mg/mL,2,5 mg=2,5 mL; não transpor esse volume para gotas 10 mg/mL. Exemplo lactente 8 kg: 0,25×8=2 mg, abaixo de 2,5 mg; nessa solução 1 mg/mL,2 mL. Reverso 2×1÷8=0,25 mg/kg. O exemplo no lactente demonstra somente a matemática de uma referência estrangeira; não autoriza usar Zyrtec contra a restrição etária da bula. Disfunção renal pediátrica exige ajuste individual.

Corticoide e investigação. Não é primeira linha rotineira. RCH admite prednisolona 0,5–1 mg/kg, máximo 60 mg, em dose única nos casos graves que não respondem ao anti-histamínico. Urticária aguda típica dispensa exames extensos; curso>6 semanas requer abordagem de urticária crônica e revisão diagnóstica. Aumentos deH1 acima da dose usual pertencem a plano especializado.

Orientação. Identificar desencadeante plausível sem impor dietas extensamente restritivas; calor/AINE podem agravar. Reavaliar recorrência, angioedema e resposta. Registrar sinais de anafilaxia que exigem retorno imediato e disponibilizar plano de emergência quando houver alergia sistêmica confirmada.

Fontes consultadas: RCH — Urticaria; GSK — Zyrtec solução oral, bula brasileira.

325. Agorafobia em Pediatria

Avaliação. Agorafobia envolve medo/evitação de situações em que escapar ou obter ajuda parece difícil, com prejuízo funcional. Investigar cenários concretos, duração, intensidade, presença de ataques de pânico, ansiedade de separação, bullying/trauma, depressão, substâncias e condições clínicas. Não diagnosticar apenas porque a criança evita sair de casa; dificuldades sensoriais, insegurança real ou outra condição podem explicar o comportamento.

Gravidade e exames. Ouvir jovem e responsáveis, inclusive entrevista reservada apropriada à idade; avaliar risco suicida e capacidade de frequentar escola, alimentar-se e manter autocuidado. Exames clínicos complementares são guiados por sintomas, sem bateria laboratorial obrigatória para ansiedade. Síncope, hipoxemia, arritmia ou uso de estimulantes exigem abordagem própria. Risco de autoagressão ou incapacidade importante de cuidado requer avaliação urgente.

Tratamento. Terapia cognitivo-comportamental com exposição gradual e planejada é base do manejo. Construir etapas viáveis com a família e reduzir acomodações que perpetuam evitação, sem confrontação forçada. Sono, rotina e retorno à escola devem fazer parte do plano. Exemplo de objetivo individual, não protocolo rígido: primeiro atravessar a entrada da escola acompanhado, depois permanecer em ambiente combinado, aumentando participação conforme tolerância e trabalho terapêutico.

Medicamentos. Casos persistentes/graves ou com comorbidade podem justificar ISRS com psiquiatria infantil. A monografia de sertralina e seus limites estão no tópico 327; a indicação pediátrica para agorafobia é fora de bula, e a evidência específica é menos direta que para TAG/ansiedade social. Não oferecer benzodiazepínico diário como solução para toda exposição nem iniciar múltiplos psicotrópicos pela lista de classes.

Seguimento. Medir ganhos funcionais, participação escolar, sofrimento e efeitos adversos se houver medicação. Ajustar o plano por semanas/meses; ausência de melhora exige reavaliar diagnóstico e acesso à terapia. Alta da urgência depende de segurança e seguimento concreto, não de desaparecer imediatamente todo medo.

Fontes consultadas: CPS — Anxiety in children and youth: Diagnosis; NIMH — Anxiety disorders; AACAP — Clinical guideline for childhood anxiety, 2020.

326. Quadros de Psiquiatria em Emergência Pediátrica

Segurança e causa antes da sedação. Agitação é manifestação, não diagnóstico. AvaliarABCDE, glicose, temperatura, dor, hipóxia, delirium, intoxicação/abstinência, crise neurológica e efeitos de medicamentos. História psiquiátrica não elimina doença clínica. Reduzir estímulos, chamar cuidador quando ajuda, usar linguagem curta e oferecer escolhas; intervenção menos restritiva que permita segurança.

Risco. Investigar ideação/plano suicida, acesso a meios, agressão, psicose e vulnerabilidade. Exames/toxicologia/ECG são dirigidos à hipótese e droga planejada. Se há perigo imediato que persiste apesar da abordagem, medicação pode ser necessária com equipe treinada, observação contínua e documentação; não é prescrição para o cuidador conter a criança em casa.

Exemplo farmacológico selecionado. No consensoBETA, lorazepam **0,05–0,1 mg/kg/dose VO**, máximo 2 mg/dose, é opção conforme etiologia; evitar uso indiscriminado no delirium e considerar desinibição paradoxal/depressão respiratória. Para 20 kg, faixa 1–2 mg; dose escolhida de 1 mg equivale a 0,05 mg/kg. A apresentação oral efetivamente disponível deve permitir dose exata; não se presume solução emmg/mL. Reavaliar efeito antes de repetir e contabilizar todas as doses/sedativos anteriores. Teto diário e necessidade de nova dose são decisões do protocolo/equipe, não ordem fixaPRN ilimitada.

Antipsicóticos e erro corrigido. Quando indicados por psicose/agitação grave, selecionar produto, via, QT e história de reação extrapiramidal. A publicaçãoBETA teve errata: haloperidol **0,05–0,1 mg/kg/dose**, não 0,55; o número errado não deve ser copiado. Esta observação não fornece uma ordem completa de haloperidol, pois via, teto e repetição precisam do protocolo. Não associar olanzapina IM e benzodiazepínico parenteral em intervalo<1 h pelo risco cardiorrespiratório.

Destino. Monitorar consciência, respiração, SpO_2, PA e ECG quando indicado; garantir equipamentos de resgate. Contenção física, se inevitável, deve ser breve, reavaliada e acompanhada conforme normas locais. Após estabilizar, encaminhar conforme risco clínico/psiquiátrico e elaborar plano de segurança com

família/equipe.

Fontes consultadas: AAEP/AACAP — ConsensoBETA, versão republicada; WestJEM — ErrataBETA, correção de dose de haloperidol.

327. Transtorno de Ansiedade Generalizada em Pediatria

Diagnóstico e plano. Preocupação persistente em vários domínios, com prejuízo e sintomas associados, precisa ser distinguida de estresse proporcional, depressão, TOC, TEA, TDAH e causas clínicas/substâncias. Entrevistar jovem e família; avaliar sono, escola, funcionamento e risco suicida. Escalas ajudam a acompanhar evolução, mas não substituem diagnóstico. Exames somente quando história/exame sugerirem causa orgânica.

Primeira linha. Psicoeducação e TCC, com família e escola. Para quadro moderado/grave, prejuízo relevante ou resposta insuficiente, ISRS pode ser combinado à terapia. O ensaio CAMS demonstrou benefício de TCC e sertralina em 7–17 anos com TAG/ansiedade social/separação; combinação teve melhor resposta. Isso não torna toda preocupação indicação medicamentosa.

Módulo de sertralina. Uso pediátrico em TAG/ansiedade social é **fora de bula noBrasil**; a bula Zoloft restringe indicação pediátrica aTOC. Regime de referência para 7–17 anos: **25 mg VO uma vez ao dia inicialmente**, com titulação gradual conforme tolerância/resposta, usualmente em passos de 25–50 mg e nunca em intervalos<1 semana; faixa 25–200 mg/dia, teto 200 mg/dia. O teto não é uma meta. Reavaliar nas primeiras semanas e após aumentos. Não converter emmg/kg para multiplicar por peso: 25 mg em criança 30 kg continuam 25 mg, não 750 mg.

Apresentação e ajustes. Bula brasileira confirma comprimidos 50 e100 mg;100 mg não deve ser partido. Dose 25 mg exige apresentação/fracionamento expressamente permitido ou preparação farmacêutica apropriada; não presumo solução oral brasileira. Insuficiência hepática leve requer redução; moderada/grave: bula não recomenda. Insuficiência renal isolada não impõe ajuste usual. Não associar IMAO e rever interações serotoninérgicas.

Monitorização e duração. Ativação, agitação, mania, piora do humor/ideação suicida, sintomasGI, sono e adesão. Benefício leva semanas; não escalar a cada crise. Após remissão, manter por período definido pelo especialista, frequentemente meses, e retirar gradualmente. Sintomas novos de mania ou risco suicida requerem avaliação imediata. A validação documental deste módulo não substitui decisão individual, consentimento informado e acompanhamento.

Fontes consultadas: CPS — Anxiety in children and youth: Diagnosis; CPS — Anxiety in children and youth: Management; Walkup et al. — Ensaio clínicoCAMS, NEJM2008; Viatris — Zoloft, bula profissional brasileira.

328. Transtorno de Ansiedade Social em Pediatria

Reconhecer. Medo persistente de avaliação negativa, exposição social ou desempenho, com evitação e prejuízo, pode representar transtorno de ansiedade social. Diferenciar timidez sem prejuízo, dificuldades de comunicação/TEA, bullying, depressão e mutismo seletivo. Ouvir criança e responsáveis; uma criança que fala pouco em consulta não deve ser rotulada apenas por essa observação.

Avaliação. Explorar participação em aula, alimentação com colegas, apresentações, amizades e atividades; avaliar risco suicida/comorbidades. História e exame orientam testes adicionais; não há biomarcador diagnóstico de ansiedade social. Agitação, intoxicação ou instabilidade clínica seguem o tópico 326, não o fluxo ambulatorial.

Psicoterapia específica. NICE recomenda TCC adaptada à ansiedade social infantil, individual ou em grupo, com psicoeducação, habilidades e exposição graduada; envolver cuidadores conforme maturidade. A escola pode pactuar passos de participação sem perpetuar exclusão. Exemplo original de meta mensurável: formular uma pergunta a um professor conhecido antes de evoluir para participação em pequeno grupo; a sequência deve ser construída com o paciente/terapeuta, não imposta como teste de coragem.

Divergência farmacológica relevante. NICE não recomenda oferecer medicamento rotineiramente a crianças/jovens com ansiedade social. Diretriz AACAP e evidência CAMS sustentam ISRS em ansiedade pediátrica selecionada, particularmente quando grave ou quando TCC é insuficiente/inacessível. Portanto, a decisão requer psiquiatria infantil, discussão da evidência e monitorização; não existe obrigação de medicar

todo caso. Quando escolhida sertralina, utilizar módulo 327 e registrar uso fora de bula para essa indicação noBrasil, sem repetir/escalar doses por conta própria.

Seguimento e destino. Acompanhar presença escolar, participação, relações e sofrimento, além de efeitos adversos se houver medicação. Revisar diagnóstico e barreiras de acesso quando não há progresso. Casos estáveis são ambulatoriais; autoagressão, grave retraimento com incapacidade de autocuidado ou comorbidade descompensada exigem avaliação urgente. Não usar benzodiazepínico pré-aula como estratégia universal.

Fontes consultadas: NICE — Social anxiety disorder, CG159; AACAP — Clinical guideline for childhood anxiety, 2020; Walkup et al. — Ensaio clínicoCAMS, NEJM2008.

329. Transtorno de Sintomas Somáticos em Pediatria

Diagnóstico com respeito. Sintomas somáticos são reais; esse diagnóstico não significa simulação. Pode coexistir doença orgânica. Fazer história/exame consistentes, reconhecer sinais de alarme e avaliar função, estressores e comorbidades. Explicar de modo positivo a interação entre processamento corporal, estresse e sintomas, sem dizer“não tem nada”.

Investigação proporcional. Selecionar exames pela hipótese clínica e pelos achados novos; não repetir baterias que já não responderão a uma pergunta relevante. Perda ponderal objetiva, sangramento, febre persistente, déficit neurológico ou mudança importante do padrão justificam reavaliação orgânica. Coordenar o acompanhamento em uma equipe.

Tratamento e metas. TCC, reabilitação gradual de atividade, rotina de sono e retorno funcional à escola, com família e equipe. Priorizar recuperação de participação mesmo quando algum sintoma persiste; afastamento indefinido pode ampliar incapacidade. Exemplo de plano individual original: pactuar uma atividade diária possível, registrar sua realização e ajustar progressivamente, sem exigir“dor zero” como condição para toda ação. A intensidade deve respeitar achados clínicos e tolerância.

Medicamentos. Não há fármaco universal para o transtorno de sintomas somáticos. Tratar comorbidades comprovadas ou indicação específica de dor segundo respectivos módulos, evitando opioide/benzodiazepínico e polifarmácia sem benefício demonstrado. Se há TAG com indicação de ISRS, o esquema é o do diagnóstico associado, tópico 327, não uma dose diferente por“somatização”. Não criar posologia/BIC sem alvo terapêutico definido.

Seguimento. Consultas programadas, medidas de função e revisão de medicações; acordar antecipadamente quais mudanças exigem avaliação urgente. Risco suicida, incapacidade de hidratar/alimentar-se ou deterioração clínica exigem assistência imediata.

Fontes consultadas: CPS — Somatic symptom and related disorders, 2025.

330. Transtorno do Pânico em Pediatria

Avaliar a crise sem pressupor ansiedade. Palpitações, dispneia, tremor, tontura e medo intenso podem ocorrer no pânico, mas primeiro episódio ou sinais atípicos exigem excluir causas clínicas relevantes. VerificarABCDE, sinais vitais, glicemia quando indicada, exame cardiopulmonar e história de estimulantes/substâncias. Hipoxemia, síncope, dor torácica de risco, arritmia ou déficit focal não devem ser atribuídos automaticamente ao transtorno.

Crise estável. Ambiente calmo, explicação breve, presença de pessoa de confiança quando útil e respiração lenta orientada. Não utilizar saco de papel, pois uma causa hipóxica não reconhecida pode piorar. Evitar repetição de exames sem indicação após avaliação consistente, mas oferecer revisão se o padrão mudar. Benzodiazepínico não é estratégia pediátrica rotineira para toda crise; sedação pode mascarar deterioração e exige indicação/monitorização próprias.

Confirmar transtorno e tratar. Ataques recorrentes e preocupação/evitação persistente justificam avaliação de saúde mental; investigar agorafobia, depressão e risco suicida. TCC adaptada, incluindo manejo de sensações e exposição terapêutica quando apropriada, é componente central. Em doença persistente/incapacitante, psiquiatria pode considerar ISRS, reconhecendo evidência pediátrica específica mais limitada. Sertralina possui indicação brasileira adulta para pânico, mas não pediátrica; módulo 327 traz dose de referência para ansiedade, cuja extrapolação ao pânico infantil deve ser registrada como fora de bula e

individualizada.

Plano concreto. Combinar com paciente/família ações de crise, contato de seguimento e critérios para nova urgência. Exemplo de registro útil: horário, duração, contexto, sinais objetivos, medidas realizadas e recuperação, evitando vigilância compulsiva a cada sensação corporal. Medicamento de manutenção não é dose de resgate e não deve ser tomado extra durante um ataque.

Destino. Alta apenas após estabilização, avaliação do risco e seguimento viável; risco de autoagressão, suspeita orgânica ou incapacidade de segurança em casa exige avaliação hospitalar. Não há BIC universal para transtorno do pânico.

Fontes consultadas: AACAP — Panic disorder in children and adolescents; NIMH — Anxiety disorders; Viatris — Zoloft, bula profissional brasileira.

Anexos dos blocos

Analgesia oral de apoio — situações selecionadas

Aplicável somente quando a via oral estiver liberada e a indicação permitir. Não usar estas linhas como analgesia neonatal ou como substituição do atendimento de uma urgência cirúrgica.

Medicamento	Esquema de referência selecionado	Conversão somente na concentração indicada	Limites
Paracetamol	**15 mg/kg/dose VO a cada 6 h se necessário**	**200 mg/mL:** 0,075 mL/kg/dose	Teto adotado: 1 g/dose e o menor entre 60 mg/kg/dia e 4 g/dia. Não combinar com outros produtos contendo paracetamol.
Ibuprofeno	A partir de 6 meses: **5–10 mg/kg/dose VO a cada 6–8 h se necessário**	**50 mg/mL:** 0,1–0,2 mL/kg/dose	Bula específica consultada: máximo 200 mg/dose e 800 mg/dia; também respeitar 40 mg/kg/dia. Evitar em desidratação, disfunção renal e risco de sangramento gastrointestinal.

Paracetamol: seleção conservadora dentro do intervalo da referência Anvisa; crianças abaixo de 2 anos/11 kg exigem orientação médica específica, e recém-nascidos não estão abrangidos pela tabela operacional. Ibuprofeno: limites da apresentação Ibuvix consultada, que não devem ser substituídos por tetos de outra bula. [C18, C19] A duração depende do diagnóstico e da evolução; dor persistente ou crescente exige revisão. Não foi definido um curso universal.

Não converter mL em gotas sem conferir o gotejador do produto. Doença hepática, renal ou uso concomitante de medicamentos relevantes exigem ajuste/revisão específica, ausentes desta versão.

Cirurgia — Anexo A — Suporte neonatal: parâmetros de referência

Fluidos

Manutenção neonatal, ressuscitação, oferta de glicose e exemplo de bomba foram centralizados no **tema 300 — Hidratação Venosa Neonatal**. Aplicar o escopo gestacional e de peso desse tema; o suporte do prematuro extremo está no tema 297.

Morfina IV contínua — apenas quando indicada, com monitorização hospitalar

ANMF: início de referência **10 microgramas/kg/h nos dias 0–7**, **15 nos dias 8–30**, **20 nos dias 31–90**; faixa descrita 5–40 microgramas/kg/h, titulada por dor e efeitos adversos. Não é sedação obrigatória de todo ventilado. Monitorar continuamente respiração, saturação, frequência cardíaca, pressão e sedação; disfunção renal/hepática exige individualização. Após cirurgia cardíaca, considerar início menor. Encefalopatia hipóxico-isquêmica com hipotermia aumenta o risco de acúmulo, especialmente acima de 10 microgramas/kg/h. [C20]

Diluição por peso: 1 mg/kg em **volume final de 50 mL**. Para peso W kg, concentração = 20W microgramas/mL; velocidade = dose desejada em microgramas/kg/h ÷20. Essa seringa pertence exclusivamente ao peso usado no preparo. Não confundir mg e microgramas. [C20]

Apresentação brasileira: Dimorf injetável 1 mg/mL, ampola de 2 mL; a bula é de uso adulto. Uso neonatal é fora da bula e exige protocolo especializado. Não intercambiar com 10 mg/mL. [C21]

Exemplo calculado para 3 kg: retirar 3 mL da apresentação de 1 mg/mL e completar com NaCl 0,9% até 50 mL (47 mL de diluente). Resultado: 3 mg/50 mL = 60 microgramas/mL. Para 10 microgramas/kg/h: **0,5 mL/h**. Checagem reversa: 0,5 × 60 ÷3 = 10 microgramas/kg/h. Consumo em 6/12/24 h: 3/6/12 mL. Esses volumes **não definem validade da solução**; estabilidade, troca, assepsia e compatibilidade seguem

farmácia/protocolo. Dupla conferência de peso, concentração, via IV e programação antes de conectar. Não usar essa tabela como protocolo de bolus ou via neuraxial.

Cirurgia — Anexo B — Antimicrobianos: idade e preparo

As tabelas a seguir descrevem referências farmacológicas quando a indicação já foi estabelecida. Não validam automaticamente uma combinação para sepse, HAEC grave ou profilaxia cirúrgica.

Cefazolina neonatal e preparo

ANMF, tratamento de microrganismo suscetível, sem disfunção renal: [C22]

Idade pós-natal	Peso atual	Dose IV	Intervalo
<8 dias	<2 kg	25 mg/kg/dose	12 h
<8 dias	≥2 kg	50 mg/kg/dose	12 h
≥8 dias	<2 kg	25 mg/kg/dose	8 h
≥8 dias	≥2 kg	50 mg/kg/dose	8 h

A ANMF utiliza solução final de 25 mg/mL para infusão, habitualmente em 30 minutos. Insuficiência renal pode exigir extensão importante do intervalo; a tabela acima não incorpora esse ajuste. [C22]

Diferença entre produtos: para Fazolon 1 g, a bula brasileira consultada especifica 10 mL de água para injetáveis, volume final aproximado de 10,6 mL e concentração aproximada **94 mg/mL**. Não copiar a reconstituição ANMF de outro fabricante que resulta em 100 mg/mL. A bula brasileira descreve injeção IV em 3–5 minutos ou diluição para infusão em 30–60 minutos. A concentração final neonatal de 25 mg/mL é adaptação do protocolo ANMF, não instrução específica dessa bula brasileira. Confirmar a bula vigente do frasco efetivamente disponível. [C23]

Exemplo didático, 3 kg e dose de 50 mg/kg: 150 mg; solução reconstituída a aproximadamente 94 mg/mL → retirar **aproximadamente 1,60 mL**. Para 25 mg/mL, completar até 6 mL; infundir em 30 min → **12 mL/h**. O valor exato calculado antes de arredondar é 150/94 = 1,5957 mL. Medida de 1,60 mL fornece aproximadamente 150,4 mg; conferir precisão da seringa e tolerância de arredondamento institucional. Não confundir “completar até” com “adicionar”.

Metronidazol neonatal

ANMF: ataque **15 mg/kg IV**; manutenção **7,5 mg/kg/dose**, iniciada após o intervalo correspondente. Idade pós-menstrual = idade gestacional ao nascer + idade pós-natal. [C24]

Idade pós-menstrual	Intervalo da manutenção
<27 semanas	24 h
27 semanas a 33 semanas + 6 dias	12 h
34 semanas a 40 semanas + 6 dias	8 h
≥41 semanas	6 h

Solução 5 mg/mL, infusão em **30 minutos** no protocolo neonatal. Ataque: 3 mL/kg; manutenção: 1,5 mL/kg/dose. [C24] A apresentação Fresenius Kabi brasileira contém 500 mg/100 mL; o esquema neonatal acima deve ser distinguido da posologia pediátrica geral da bula. Após abertura, utilizar imediatamente; não guardar sobra como frasco multidose. [C25]

Exemplo, 3 kg: ataque 45 mg = 9 mL, velocidade 18 mL/h por 30 min; manutenção 22,5 mg = 4,5 mL, velocidade 9 mL/h por 30 min. Reverso: 4,5 ×5 ÷3 = 7,5 mg/kg. O intervalo depende da idade pós-menstrual, não do peso isoladamente. Revisar função hepática, interações e volume total diário antes de prescrever.

Aztreonam — alternativa selecionada em alergia

Aztreonam cobre gram-negativos aeróbios, **não anaeróbios nem gram-positivos**; não constitui monoterapia completa de HAEC. Conferir especialmente alergia à ceftazidima. Referência ChAMP 2025: ≥4 semanas a <2 anos, **30 mg/kg/dose IV a cada 6–8 h**, máximo 2 g; ≥2 anos, 30–50 mg/kg/dose no mesmo intervalo/teto. Ajustes: TFGe 10–<30 mL/min/1,73 m², 15–20 mg/kg a cada 8 h; <10, 7,5–10 mg/kg a cada 12 h. Neonatos têm tabela própria. Diluição final ≤20 mg/mL em fluido compatível, infusão em 20–60 min; NaCl 0,9% é compatível. Verificar o produto disponível antes de reconstituir. Monitorar função renal/hepática e hemograma em cursos prolongados. [C37]

Exemplo de cálculo, 16 kg, 30 mg/kg: 480 mg. Após reconstituição conforme fabricante, retirar 480/C mL da solução de concentração C mg/mL e completar com NaCl 0,9% até 24 mL para 20 mg/mL. Em 30 min: **48 mL/h**; reverso 48×0,5×20/16=30 mg/kg/dose. A escolha da cobertura complementar segue os microrganismos a tratar, e não apenas o relato genérico de alergia.

Cirurgia — Anexo C — Alternativas para profilaxia urinária selecionada

Referência NICE para ITU recorrente, com orientação especializada; a transposição para RVU depende do risco e da história de ITU. Escolha orientada por culturas e sensibilidade, com revisão pelo menos semestral. [C29]

Alternativa	Idade contemplada	Dose preventiva VO
Cefalexina	3 meses–15 anos	12,5 mg/kg à noite; máximo **125 mg/dose**
Nitrofurantoína	3 meses–11 anos	1 mg/kg à noite
Nitrofurantoína	12–15 anos	50–100 mg à noite

NICE condiciona nitrofurantoína a função renal adequada (limiar informado: eGFR ≥45 mL/min); em pediatria, confirmar método e unidade da estimativa. Vigiar toxicidade pulmonar/hepática. Cefalexina profilática é uso fora da indicação de bula apontado pela diretriz britânica. **Apresentações:** cefalexina 250 mg/5 mL (Teuto, apresentação divulgada pelo fabricante) e nitrofurantoína 5 mg/mL (padronização SUS) estão documentadas. A padronização não comprova estoque nem estabilidade de um produto manipulado. Conferir concentração/rótulo do produto dispensado, sem abrir cápsulas para estimar uma fração. [C29, C35, C36]

Exemplo matemático de teto: cefalexina, 16 kg → 12,5 ×16 = 200 mg; aplicar máximo da fonte → **125 mg à noite**, e não 200 mg. Na suspensão de cefalexina 50 mg/mL, 125 mg = **2,5 mL**; reverso: 2,5 ×50 =125 mg. Nitrofurantoína 1 mg/kg, quando elegível e disponível suspensão 5 mg/mL, equivale a **0,2 mL/kg à noite**. Esses esquemas preventivos não tratam ITU ativa.

Cirurgia — Anexo D — Prevenção de cálculos: limites resolvidos e ainda abertos

D-penicilamina: a bula norte-americana de Cuprimine descreve, para cistinúria pediátrica, **30 mg/kg/dia VO em quatro doses**. Há toxicidade hematológica/renal relevante; recomenda hemograma e urina duas vezes por semana no primeiro mês, quinzenalmente nos cinco meses seguintes e mensalmente depois. Não é fármaco de início empírico. [C30] No Brasil foi confirmada cápsula Cuprimine 250 mg; isso não valida fracionar seu conteúdo para qualquer peso. [C31]

Exemplo aritmético, 20 kg: 30 ×20 = 600 mg/dia; ÷4 = 150 mg por tomada. A cápsula de 250 mg não corresponde a essa dose. Portanto, **a prescrição não fica operacional** sem formulação adequada validada pela farmácia; não arredondar para uma cápsula por tomada.

Alopurinol: para hiperuricosúria selecionada, a revisão pediátrica de Alon descreve **10 mg/kg/dia VO**, uma vez ao dia ou divididos em 2–3 tomadas; a EAU atual mantém o uso selecionado, embora seu texto não explicite o intervalo. A revisão é antiga e não sustenta um teto pediátrico universal. Não transportar o teto oncológico de 800 mg/dia para cálculos. Disfunção renal exige redução individual; monitorar função renal/hepática e hemograma, suspender diante de rash. A associação com azatioprina/mercaptopurina exige revisão especializada. A fórmula de volume é dose total em mg ÷ concentração efetiva em mg/mL; não foi presumida

solução comercial. [C16, C32, C34]

Hidroclorotiazida: selecionar inicialmente **1 mg/kg/dia VO em duas tomadas (0,5 mg/kg/dose a cada 12 h)**, ponto comum entre a faixa inicial EAU e o fracionamento da revisão pediátrica. Ajustar à calciúria, pressão e eletrólitos; não escalar automaticamente ao esquema de hipertensão. A diretriz não fornece máximo absoluto específico para esta indicação; não foi inventado. [C16, C34]

Citrato: a referência inicial de 1 mEq/kg/dia dividida em duas tomadas corresponde a **0,5 mEq/kg/dose**. Para solução realmente dispensada a C mEq/mL: volume por dose = 0,5 × peso/C. Checagem reversa: volume ×C ×2/peso =1 mEq/kg/dia. Ajustar ao pH/citratúria e potássio, distinguindo ácido úrico de cistina. Não trocar mEq por mg nem triturar Litocit de liberação prolongada. Fórmula parametrizada não é instrução de manipulação; concentração e estabilidade dependem da formulação validada. [C16, C17]

Conferência matemática

Exemplos fictícios para testar as fórmulas, não prescrições para um paciente:

Operação	Cálculo direto	Conferência inversa
Paracetamol, 16 kg	15 × 16 = 240 mg; ÷ 200 = **1,2 mL/dose**	1,2 × 200 ÷ 16 = **15 mg/kg/dose**; quatro doses = 60 mg/kg/dia
Ibuprofeno, 16 kg, extremo de 10 mg/kg	10 × 16 = 160 mg; ÷ 50 = **3,2 mL/dose**	3,2 × 50 ÷ 16 = **10 mg/kg/dose**; quatro doses = 640 mg/dia, abaixo de 800
TMP-SMX preventivo, 16 kg	2 × 16 = 32 mg de TMP; ÷ 8 = **4 mL/dia**	4 × 8 ÷ 16 = **2 mg de TMP/kg/dia**; abaixo do teto de 10 mL

Conferência realizada: correspondência entre indicação e dose, unidade/concentração e cálculo direto/inverso dos exemplos. Isso não equivale a validação clínica independente nem elimina as pendências farmacotécnicas.

Fontes consultadas

Consulta em 25/09/2026. A data de consulta não significa publicação em 2026. Bulas informam condições regulatórias de produtos específicos; diretrizes informam recomendações clínicas; relatos de caso têm evidência limitada.

[C1] GOSH — Duodenal atresia. [C2] RCH — Neonatal intravenous fluids. [C3] RCH — Hirschsprung associated enterocolitis. [C4] ERNICA — atualização da diretriz de Hirschsprung. [C5] EAU — Acute scrotum. [C6] CDC — Epididymitis, STI Treatment Guidelines, página revisada em 2021. [C7] GOSH — Bladder exstrophy and epispadias. [C8] EAU — Phimosis and other abnormalities of the penile skin. [C9] Apsen — Postec, bula digital, texto com aprovação Anvisa em 16/12/2025. [C10] Relato de caso — Granuloma gluteale infantum e tacrolimo, 2021. [C11] RCH — Nappy rash, atualização de agosto de 2024. [C12] SBP — Micropênis: o que o pediatra precisa saber, 2024. [C13] EAU — Vesicoureteric reflux. [C14] RCH — Antimicrobial guidelines, seção de profilaxia de ITU. [C15] SBP — Manual de Uropediatria, 2019. [C16] EAU — Urinary stone disease. [C17] Apsen — Litocit, bula digital. [C18] Anvisa — IN 430/2026, texto de paracetamol. [C19] Geolab — Ibuvix, bula.

[C20] ANMF — Morphine intravenous, versão 5.1, 05/03/2026. [C21] Cristália — Dimorf, bula profissional; seção solução injetável. [C22] ANMF — Cefazolin, 2023. [C23] Blau — Fazolon, bula profissional disponível de 2019. Documento consultado; verificar versão do produto em uso. [C24] ANMF — Metronidazole, 2021. [C25] Fresenius Kabi — Metronidazol, bula profissional. [C26] Roche — Rocefin, bula do paciente, apresentação e reconstituição IM. [C27] EMS — Deposteron, bula profissional reproduzida pelo Consulta Remédios. [C28] Teuto — Sulfametoxazol + trimetoprima, bula profissional; seção suspensão. [C29] NICE NG112 — Resumo visual, atualizado em dezembro de 2024. [C30] DailyMed — Cuprimine, bula, seção cistinúria. [C31] Medquímica — Cuprimine 250 mg. [C32] DailyMed — Allopurinol tablets, bula e distinção entre indicações.

[C33] APSA — Guidelines for diagnosis and management of Hirschsprung-associated enterocolitis, 2017. [C34] Alon — Medical treatment of pediatric urolithiasis, revisão publicada em 2008/2009. Fonte complementar de fracionamento; não caracteriza recomendação nova em 2026. [C35] Teuto — apresentação cefalexina 250 mg/5 mL. [C36] SES-SC InfoSUS — Nitrofurantoína, apresentações padronizadas.

[C37] PCH ChAMP — Aztreonam, revisão setembro de 2025.

PedWB — Temas 10–64

Síntese clínica original. Fontes consultadas em 25/09/2026. Não reproduz o texto do Whitebook. Revisão documental e matemática automatizada; não representa aprovação clínica humana.

Módulos farmacológicos compartilhados dos temas 10–64

Estes módulos integram os temas que os referenciam. Pesos em kg, superfície corporal em m² e unidades de cada fármaco precisam ser explicitados. Concentrações estrangeiras são identificadas; não confirmam registro, disponibilidade ou estabilidade de uma preparação brasileira. O tempo de esvaziamento matemático de uma seringa não define seu prazo de uso. Cálculos demonstrativos não substituem prescrição, dupla conferência de preparo e monitorização à beira do leito.

Alprostadil (PGE1) — estabilização neonatal ducto-dependente

ANMF 2025: começar **10 nanogramas/kg/min IV contínuo** (faixa inicial 5–50), titular pela perfusão/oxigenação; manutenção 3–20, menor dose eficaz. Doses até 100 são exceção especializada. Ampola **500 microgramas/mL**: 1 mL +9 mL de SF fornece 50 microgramas/mL. Retirar **0,6 mL/kg** dessa solução e completar a **volume final de 50 mL** com SF ou D5: contém 30 microgramas/kg; concentração =0,6×peso microgramas/mL. **Bomba mL/h = dose em nanogramas/kg/min ÷10**. Para 3 kg: 1,8 mL da prediluição +48,2 mL diluente; 1 mL/h entrega 10 nanogramas/kg/min. Consumo em 6/12/24 h nessa taxa: 6/12/24 mL. Não administrar bolus. Monitorar ECG, pressão, saturação, diurese e apneia; manter capacidade de ventilação imediata. Via periférica bem perfundida ou acesso central conforme serviço. Reavaliar indicação pelo ecocardiograma.

Fonte: ANMF, 2025.

Milrinona — baixo débito selecionado, com pressão suficiente

Bula britânica pediátrica: **0,25–0,75 microgramas/kg/min IV**, experiência até 35 horas. Dose de ataque 50–75 microgramas/kg em 30–60 minutos é opcional pelo contexto; não realizar automaticamente no choque/hipotensão. Produto **1 mg/mL**: 10 mL +40 mL de SF/D5 =50 mL, **200 microgramas/mL**. **Bomba =0,3×dose×peso mL/h**. A 0,5 para 16 kg: 2,4 mL/h; reverso 2,4×200/(60×16)=0,5. Consumo 6/12/24 h: 14,4/28,8/57,6 mL; uma seringa de 50 mL duraria matematicamente 20,83 horas. Monitorar pressão, ritmo, eletrólitos, plaquetas e função renal; furosemida é incompatível na mesma linha. A bula não recomenda uso pediátrico com insuficiência renal por ausência de ajuste confiável; não transportar a tabela adulta.

Fonte: Milrinona — SmPC.

Insuficiência cardíaca crônica — regimes iniciais para paciente elegível

A ISHLT 2025 sustenta bloqueio neuro-hormonal na disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. A aplicabilidade não é automática no ventrículo sistêmico direito/Fontan. Iniciar após controle de choque/congestão importante, combinar gradualmente e rever pressão, frequência, função renal e potássio após introduções/aumentos.

Fármaco	Regime de referência e titulação	Limites e monitorização
Enalapril VO (Aqumeldi, bula britânica pediátrica)	Teste **0,01–0,04 mg/kg, máximo 2 mg**, uma vez; observar pressão por 1–2 h. Após 8 h, se tolerado, manutenção **0,15–0,3 mg/kg/dia**, em 1–2 tomadas, máximo **20 mg/dia**.	Não iniciar com pressão sistólica <P5 ou creatinina acima do limite etário. Menor dose nos <30 dias. TFG30–<50: iniciar 50% da dose a cada 12 h; TFG<30, contraindicado nesta bula. Pausar se K≥5,5 mmol/L. Contraindicado em angioedema hereditário/prévio por IECA; separar de sacubitril/valsartana por 36 h.
Carvedilol VO (IWK)	**0,05 mg/kg/dose a cada 12 h**, teto inicial 3,125 mg/dose. Dobrar aproximadamente a cada 2 semanas conforme tolerância; faixa 0,2–0,5 mg/kg/dose a cada 12 h; máximo **50 mg/dia**.	Não iniciar durante descompensação instável. Monitorar bradicardia, hipotensão, piora congestiva e hipoglicemia. Lactentes/crianças pequenas podem exigir intervalos individualizados; não somar esquemas de 8 e12 h.

Fármaco	Regime de referência e titulação	Limites e monitorização
Espironolactona VO (IWK)	Referência diurética **1–3,3 mg/kg/dia**, em 1–2 tomadas; máximo **100 mg/dia**. Início conservador possível de 1 mg/kg/dia quando elegível.	Titular à indicação, sem perseguir teto diurético como obrigação de bloqueio neuro-hormonal. Vigiar K/creatinina, sobretudo com IECA; evitar em hipercalemia ou falência renal descompensada.

Exemplos: 16 kg: enalapril teste a 0,01=0,16 mg; manutenção a 0,15=2,4 mg/dia (1,2 mg a cada 12 h). Apenas para o Aqumeldi 0,25 mg, a bula permite dispersar um comprimido em 10 mL de água para dose inicial pequena: 0,025 mg/mL;0,16 mg=6,4 mL, uso imediato conforme instrução do produto. Não é receita de manipulação de qualquer comprimido. Carvedilol inicial: 0,8 mg a cada 12 h; espironolactona a 1 mg/kg/dia: 16 mg/dia. Suspensões manipuladas precisam de fórmula validada própria, sem presumir concentração comercial brasileira.

Fontes: ISHLT2025; Aqumeldi; IWK carvedilol; IWK espironolactona.

Takayasu — metotrexato semanal e pulso de metilprednisolona

Opção poupadora: **metotrexato 10–15 mg/m² VO uma vez por semana**, teto selecionado **20 mg/semana** das recomendações francesas; uso fora de bula para Takayasu. Exemplo 0,8 m² a 15=12 mg/semana. Escrever dia fixo: administração diária por engano é tóxica. Ácido fólico **1 mg/dia**, exceto no dia do metotrexato, é opção de prevenção de toxicidade apoiada por consenso pediátrico. Hemograma, transaminases e creatinina antes e durante tratamento; evitar gravidez, rever infecção, hepatopatia, interações e ajuste renal. Persistência de atividade vascular requer reavaliar eficácia/alternativa, sem prolongar glicocorticoide isolado.

Pulso do tema 14: D=min(30×peso,1.000)mg. Produto do guia RCH **125 mg reconstituídos em 2 mL =62,5 mg/mL**. Para dose≥15 mg/kg ou>250 mg, guia limita concentração a≤20 mg/mL e infusão≥30 minutos. Exemplo operacional a **10 mg/mL, em 60 minutos**:16 kg=480 mg; retirar 7,68 mL reconstituídos e completar a 48 mL com diluente compatível (SF/D5), adicionando 40,32 mL; bomba 48 mL/h. Requer quatro frascos de 125 mg se essa for a apresentação. Monitorar pressão, ritmo, glicemia e eletrólitos; não presumir estabilidade ou reconstituição de outro fabricante.

Fontes: Takayasu francês; Consenso pediátrico 2025; MARAJIA; RCH injetáveis.

PedWB — Infectologia pediátrica: temas 124–184

Síntese clínica original. Revisão documental em 25/09/2026. Os títulos vêm do inventário; a terapêutica abaixo foi construída a partir das fontes identificadas, sem reprodução das prescrições do Whitebook. Não representa aprovação clínica humana independente.

Convenções e conversões compartilhadas

P = peso atual em kg; D = dose total em mg; C = concentração em mg/mL. Volume por dose = D/C. Dose diária deve ser dividida pelo número de administrações antes de converter em mL. Conferência reversa: mL × C ÷ P = mg/kg/dose. Para infusão: mL/h = D ÷ concentração final ÷ duração em horas. Não usar concentração da ampola como se fosse a concentração final.

Apresentações brasileiras verificadas para as conversões: amoxicilina 250 mg/5 mL = 50 mg/mL; cefalexina 250 mg/5 mL = 50 mg/mL; azitromicina 200 mg/5 mL = 40 mg/mL; albendazol 40 mg/mL. Reconstituir suspensões até a marca conforme cada fabricante, agitar e medir com seringa oral. Essas apresentações não são intercambiáveis por volume com outras concentrações. Referências: EMS, amoxicilina; Eurofarma, cefalexina; Eurofarma, azitromicina; Geolab, albendazol. A presença da apresentação no fabricante não confirma estoque local.

Suporte comum das viroses não complicadas: hidratação fracionada e manutenção da alimentação; antitérmico para desconforto, não apenas para normalizar temperatura. Paracetamol 10–15 mg/kg/dose VO a cada 6 horas se necessário, teto adotado 60 mg/kg/dia e 1 g/dose, sem superar 4 g/dia; não extrapolar automaticamente a neonatos ou hepatopatia. Para apresentação 200 mg/mL, o volume é 0,05–0,075 mL/kg/dose. O preparo/limites brasileiros foram detalhados no capítulo inicial. Não associar apresentações diferentes contendo paracetamol. Antibioticoterapia, corticoide, antiviral e antitussígeno não são componentes automáticos desse suporte.

Antimicrobianos EV: os esquemas abaixo são por indicação; prematuridade, período neonatal, insuficiência renal, obesidade extrema e terapia renal substitutiva exigem individualização. Não inferir compatibilidade em Y ou estabilidade a partir da dose. Para cefazolina, remeter ao preparo já validado no capítulo inicial: frasco brasileiro de 1 g com 10 mL de diluente produz aproximadamente 10,6 mL e 94 mg/mL, não 100 mg/mL. Regimes de 150 mg/kg/dia de cefazolina citados em diretrizes internacionais excedem a faixa usual da bula brasileira: identificar uso fora da bula.

PedWB — Nefrologia, neurologia, saúde mental e reumatologia

Revisão documental: 25/09/2026. Síntese original; títulos servem apenas de índice. As classes do inventário não representam uma associação de medicamentos. W = peso em kg; SC = superfície corporal em m². Concentrações estrangeiras são identificadas e não comprovam comercialização brasileira. Revisão clínica documental, farmacêutica e matemática automatizada não equivale a revisão médica independente.

PedWB — Doenças respiratórias e emergências pediátricas

Verificação documental: 25/09/2026. Conteúdo original, organizado pelos títulos do inventário. Não reproduz os textos do Whitebook. Esquemas são referências clínicas; não há paciente presumido. W = peso em kg. C = concentração final efetivamente preparada. A dose deve ser verificada quanto a indicação/idade, apresentação/via e cálculo/reversão. A revisão é documental e matemática, sem alegação de validação humana independente.

PedWB — Temas 290–330

Síntese clínica original. Verificação documental: 25/09/2026. Não reproduz prescrições do Whitebook. Os títulos funcionam como inventário; uma classe presente nesse inventário não constitui indicação de tratamento.

Premissas neonatais: W = peso de dosagem em kg; IG = idade gestacional ao nascimento; IPN = idade pós-natal; IPM = IG + IPN convertida em semanas. IPM não é sinônimo de idade cronológica. Função renal, alergias e estabilidade não são presumidas. Exemplos são matemáticos, não dados de um paciente. Regimes estrangeiros estão identificados; apresentação ou preparo brasileiro não confirmado não é anunciado como verificado. Valores de infusão exigem conferir peso, unidade, concentração final, via e bomba por duas pessoas.